ICOPE

دليل الرعاية المتكاملة للمسنين

إرشادات بشأن التقييم المتمركز على الشخص ومسارات الرعاية الأولية

الطبعة الثانية

منظمة الصحة العالمية

ICOPE

دليل الرعاية المتكاملة للمسنين

إرشادات بشأن التقييم المتمركز على الشخص ومسارات الرعاية الأولية

الطبعة الثانية

منظمة الصحة العالمية

الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات بشأن التقييم المتمركز على الشخص ومسارات الرعاية الأولية، الطبعة الثانية
[Integrated care for older people (ICOPE): guidance for person-centred assessment and pathways in primary care, second edition]

ISBN 978-92-4-011629-0 (نسخة إلكترونية)
ISBN 978-92-4-011630-6 (نسخة مطبوعة)

© منظمة الصحة العالمية 2025

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية" (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

الاقتباس المقترح. الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات بشأن التقييم المتمركز على الشخص ومسارات الرعاية الأولية، الطبعة الثانية
[Integrated care for older people (ICOPE): guidance for person-centred assessment and pathways in primary care, second edition]
جنيف: منظمة الصحة العالمية:2025. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط http://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

ترجمة Octopus Translations. قد لا تتوافق المصطلحات مع منشورات منظمة الصحة العالمية الأخرى. في حالة حدوث أي تعارض بين النسخة الإنكليزية والنسخة العربية تكون النسخة الأصلية بالإنكليزية هي النسخة الملزمة وذات الحجية.

المحتويات

	شكر وتقدير	iv
	الاختصارات	v
	مسرد المصطلحات	vi
1	الرعاية المتكاملة للمسنين	1
2	تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية	11
3	مسار الرعاية المتكاملة للمسنين المكوَّن من أربع خطوات في الرعاية الأولية	15
4	أصحاب المصلحة والخدمات المشتركة لمسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية	41
5	مسار الرعاية لتدبير التدهور المعرفي	53
6	مسار الرعاية لتحسين القدرة على الحركة	63
7	مسار الرعاية لتدبير سوء التغذية	73
8	مسار الرعاية لتدبير ضعف البصر	85
9	مسار الرعاية لتدبير فقدان السمع	95
10	مسار الرعاية لتدبير أعراض الاكتئاب	105
11	مسار الدعم والرعاية الإجتماعيين	115
12	مسار الرعاية لدعم مقدمي الرعاية	125
13	مسار الرعاية لتدبير السَّلَس البولي	133
14	اعتبارات تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين	143
	المراجع	149
	قائمة المصادر الإضافية	152
	الملحق: مثال على خطة رعاية مُبسَّطة	154

شكر وتقدير

هذا الدليل ثمرة جهود العديد من الأشخاص حول العالم الذين كرّسوا أنفسهم لرعاية المسنين ومساندتهم. واضطلعت Yuka Sumi و Rachel Albone من وحدة الشيخوخة والصحة في إدارة صحة الأم والوليد والطفل والمراهقين والشيخوخة بمنظمة الصحة العالمية بقيادة أنشطة إعداد الدليل، تحت قيادة Anshu Banerjee. وساهم زملاء آخرون في الوحدة بإسهامات لا تُقدَّر بثمن، من بينهم Matteo Cesari و Hyobum Jang و Jotheeswaran Amuthavalli و Thiyagarajan و YeJin Lee.

كما ساهم العديد من موظفي منظمة الصحة العالمية من المكاتب الإقليمية ومختلف الوحدات الفنية في إعداد هذا الدليل، وهم: Andrew Briggs (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا)، و Shelly Chadha (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Neerja Chowdhary (صحة الدماغ)، و Carolina Der Mussa (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Shalini Desai (البرنامج الأساسي للتمنيع)، و Laura Diaz (صحة الدماغ)، و Megan Doherty (الخدمات والنظم السريرية)، و Antony Duttine (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Samer Elfeky (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط)، و Mai Eltigany (الأمراض غير السارية)، و John Fogarty (الخدمات والنظم السريرية)، و Maria Nieves Garcia-Casal (الإجراءات المتعلقة بالغذاء والتغذية في النظم الصحية)، و Shoshanna Goldin (برنامج الطوارئ الصحية)، و Yuriko Harada (برنامج صحة الفم)، و Thiago Herick De Sa (التغير الديموغرافي والشيخوخة الصحية)، و Stefania Ilinca (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا)، و Mikiko Kanda (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ)، و Catherine Kane (القوى العاملة الصحية)، و Amrita Kansal (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا)، و Stuart Keel (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Pauline Kleinitz (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و April Siwon Lee (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ)، و Silvio Paolo Mariotti (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Chris Mikton (التغير الديموغرافي والشيخوخة الصحية)، و Patricia Morsch (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين)، و Andreas Mueller (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Triphonie Nkurunziza (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا)، و Asiya Ismail Odugleh-Kolev (جودة الرعاية)، و Alana Officer (التغير الديموغرافي والشيخوخة الصحية)، و Roberta Ortiz (الأمراض غير السارية)، و Alexandra Rauch (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Nicole Rendell (برنامج صحة الفم)، و Katrin Seeher (صحة الدماغ)، و Kylie Shae (المنتجات الصحية، السياسات والمعايير)، و Sangeeta Singh (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ)، و Shamsuzzoha Syed (البرنامج الخاص للرعاية الصحية الأولية)، و Abena Tannor (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Emma Tebbutt (المنتجات الصحية، السياسات والمعايير)، و Benoit Varenne (برنامج صحة الفم)، و Enrique Vega (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين)، و Inka Weissbecker (صحة الدماغ)، و Kazuki Yamada (التغير الديموغرافي والشيخوخة الصحية)، و Yongjie Yon (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا)، و Mitasha Yu (وظائف الحواس، الإعاقة والتأهيل)، و Patrick Zuber (البرنامج الخاص للرعاية الصحية الأولية).

وأثري الدليل بمساهمات عدد من الخبراء في مجال الشيخوخة والصحة ورعاية ودعم المسنين، التالية أسماؤهم: Hanadi Alhamad (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف، جامعة قطر، قطر)، و Márlon JR Aliberti (كلية الطب بجامعة ساو باولو، البرازيل)، و Hidenori Arai (المركز الوطني لطب الشيخوخة وطب الأعصاب، اليابان)، و Prasert Assantachai (جامعة ماهيدول، تايلاند)، و Liat Ayalon (جامعة بار إيلان، إسرائيل)، و Paola Barbarino (منظمة الزهايمر الدولية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية [المملكة المتحدة])، و Jane Barratt (الاتحاد الدولي للشيخوخة، كندا)، و Ivan Bautmans (جامعة فريجي بروكسل، بلجيكا)، و John Beard (جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، و Fatemah Bendhafari (وزارة الصحة، الكويت)، و Caroline Berbon (مستشفى جامعة تولوز؛ المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للضعف، والبحوث السريرية وعلوم الشيخوخة، والتدريب في طب الشيخوخة، فرنسا)، و Heikea Bischoff-Ferrari (جامعة زيورخ، سويسرا)، و Marco Canevelli (المعهد الوطني للصحة، إيطاليا)، و Jagadish Chhetri (المركز الوطني للبحوث السريرية لاضطرابات الشيخوخة، الصين)، و Stephen Connor (تحالف الرعاية التلطيفية والرعاية في نهاية الحياة العالمي، المملكة المتحدة)، و Eduardo Ferriolli (جامعة ساو باولو، البرازيل)، و Roger Fielding (جامعة تافتس، الولايات المتحدة الأمريكية)، و Leon Geffen (معهد سامسون لبحوث الشيخوخة، جنوب أفريقيا)، و Celia Gregson (جامعة بريستول، المملكة المتحدة)، و Eva Heras Muxella (النظام الصحي الأندوري، أندورا)، و Lee Hooper (جامعة إيست أنجليا، المملكة المتحدة)، و Yun-Hee Jeon (جامعة سيدني، أستراليا)، و Javier Jerez (جامعة فيك - الجامعة المركزية في كتالونيا، إسبانيا)، و Sebastiana Kalula (معهد ألبرتين ووالتر سيسولو للشيخوخة في أفريقيا، جنوب أفريقيا)، و Ramesh Kandel (أكاديمية رابتي للعلوم الصحية، نيبال)، و Hongsoo Kim (جامعة سيول الوطنية، جمهورية كوريا)، و Jan Kottner (جامعة شاريتيه للطب، برلين، ألمانيا)، و Christine Lafont (IHU HealthAge، مستشفى جامعة تولوز؛ المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للضعف، والبحوث السريرية وعلوم الشيخوخة، والتدريب في طب الشيخوخة، فرنسا)، و Caitlin Littleton (منظمة هلب إيج إنترناشونال، المملكة المتحدة)، و Peter Lloyd-Sherlock (جامعة نورثمبريا، المملكة المتحدة)، و Carol Ma Hok Ka (جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، سنغافورة)، و Shiromi Maduwage (وزارة الصحة، سريلانكا)، و Finbarr Martin (كلية كينجز لندن، المملكة المتحدة)، و Reshma Merchant (النظام الصحي الوطني بسنغافورة، سنغافورة)، و Jean-Pierre Michel (كلية الطب بجامعة جنيف، سويسرا)، و Colin Milner (المجلس الدولي للشيخوخة النشطة، كندا)، و Kenneth Edmund Mugayehwenkyi (منظمة Reach One Touch One Ministries، أوغندا)، و Cathy Murphy (جامعة ساوثهامبتون، المملكة المتحدة)، و Claudio Pedone (جامعة كامبوس بيو ميديكو بروما، إيطاليا)، و Ian Philp (جامعة كينت، المملكة المتحدة)، و Jean-Yves Reginster (جامعة لييج؛ المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلم الأوبئة المتعلق بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي والشيخوخة، بلجيكا)، و Leocadio Rodriguez Mañas (مستشفى جامعة خيتافي، إسبانيا)، و Catherine Takeda (مستشفى جامعة تولوز؛ المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للضعف، والبحوث السريرية وعلوم الشيخوخة، والتدريب في طب الشيخوخة، فرنسا)، و Hein Thet Ssoe (AGE Myanmar، ميانمار)، و Vira Tum (هلب إييج كمبوديا، كمبوديا)، و Prakash Tyagi (منظمة Gramin Vikas Vigyan Samiti [GRAVIS]، الهند)، و Adrian Wagg (جامعة ألبرتا، كندا)، و Poppy Walton (منظمة هلب إييج إنترناشونال، المملكة المتحدة)، و Sijiu Wang (جامعة تسينغهوا، الصين)، و Camilla Williamson (منظمة هلب إييج إنترناشونال، المملكة المتحدة)، و Jean Woo (الجامعة الصينية في هونغ كونغ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين)، و Gordon Wood (كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن، الولايات المتحدة)، و Anthony Woolf (التحالف العالمي لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، المملكة المتحدة).

وأثرت أيضًا مساهمات المشاركين في الاجتماع السنوي للاتحاد السريري العالمي المعني بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (CCHA) التابع لمنظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2023، هذا الدليل.

ويُعرب قسم صحة الأم والوليد والطفل والمراهق ومرحلة الشيخوخة في منظمة الصحة العالمية عن امتنانه للدعم المالي الذي قدمته حكومة اليابان، وحكومة ألمانيا، وحكومة محافظة كاناغاوا في اليابان.

الاختصارات

ADL	أنشطة الحياة اليومية
BADL	الأنشطة الأساسية في الحياة اليومية
BMI	مؤشر كتلة الجسم
CBT	العلاج المعرفي السلوكي
CCHA	الاتحاد السريري العالمي المعني بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
CVD	مرض قلبي وعائي
dBA	ديسيبل معدَّل
dBHL	ديسيبل مستوى السمع
FPG	جلوكوز البلازما أثناء الصيام
IADL	الأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية
ICOPE	نهج الرعاية المتكاملة للمسنين
LBP	آلام أسفل الظهر
LTC	الرعاية طويلة الأجل
MUAC	محيط الذراع العلوي المتوسط
OSN	التغذية التكميلية الفموية
PHC	الرعاية الصحية الأولية
PTA	مقياس سماع النغمات النقية
SDG	أهداف التنمية المستدامة
SPPB	مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير
TAP	التدريب على المنتجات المساعِدة (منظمة الصحة العالمية)
UHC	التغطية الصحية الشاملة
UI	السَّلَس البولي
UN	الأمم المتحدة
UTI	التهاب المسالك البولية
WHO	منظمة الصحة العالمية

مسرد المصطلحات

التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة: تَحيُّز اجتماعي يُعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على إعاقتهم، ويُصنِّفهم على أنهم أقل شأنًا من الأشخاص الذين لا يعانون من إعاقات.

بيئة صديقة للمسنين: البيئة، مثل المنزل أو المجتمع، التي تعزّز الشيخوخة الصحية من خلال بناء القدرة الذاتية وصونها طوال مراحل الحياة، وزيادة القدرة الوظيفية لدى الشخص محدود القدرة.

الشيخوخة في مكان الإقامة: القدرة على العيش في منزل الفرد ومجتمعه بأمان واستقلالية وراحة، بغض النظر عن العمر أو الدخل أو القُدرات. تُوسّع الشيخوخة في مكان الإقامة (المناسب) هذا المفهوم ليشمل القدرة على العيش في المكان الذي يتوافق بشكل أمثل مع احتياجات وتفضيلات الفرد، ويمكن أن يكون هذا المكان منزل الشخص أو مكان آخر.

المنتجات المساعِدة: تحافظ المنتجات المساعِدة على القدرة الوظيفية والاستقلالية أو تحسينها، وبالتالي تعزز الرفاه. يمكن أن تتنوع المنتجات المساعدة من منتجات مادية مثل الكراسي المتحركة، والنظارات، ومنظِّمات الأدوية، وكراسي المرحاض، ومساعِدات السمع، إلى الحلول الرقمية مثل أجهزة إنذار السقوط، وبرامج إدارة الوقت وأنظمة الترجمة النصية. التكنولوجيا المساعِدة هي المصطلح الشامل للمنتجات المساعِدة والأنظمة والخدمات المرتبطة بها.

الأنشطة الأساسية في الحياة اليومية: الأنشطة الأساسية اللازمة للحياة اليومية: الاستحمام في الحوض أو الدُّش، وارتداء الملابس، وتناول الطعام، والصعود والنزول من السرير أو الكراسي، واستخدام المرحاض، والتحرُّك داخل المنزل.

صحة الدماغ: حالة وظائف الدماغ عبر المجالات المعرفية والحسيّة والاجتماعية والعاطفية والسلوكية والحركية، التي تمكّن الفرد من تحقيق إمكاناته الكاملة على مدار حياته، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اضطرابات.

مُنسِّق الرعاية: عامل صحي يضمن التواصل والتنسيق الكافيَين للقرارات والمعلومات بين الفِرق والخدمات، ويُسهّل تنقل المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين عبر الأنظمة المختلفة، ويضمن تقديم الرعاية المتكاملة. غالبًا ما يعمل مديرو الحالات كمنسقي رعاية. وغالبًا ما يتم اختيار منسق الرعاية من بين أعضاء الفريق متعدد التخصُّصات.

مقدم الرعاية: عامل صحي يقدم خدمات رعاية شخصية مباشرة في المنزل، وفي مؤسسات الرعاية الصحية والمرافق السكنية، ويساعد في أداء المهام اليومية الروتينية، ولديه التدريب اللازم للقيام بذلك، ويتقاضى الأجر المناسب، ويحصل على الإشراف والتنظيم المطلوبين. وتشمل الأمثلة مقدمي الرعاية الرسميين، والأخصائيين الاجتماعيين، والممرضين.

مقدم الرعاية غير المأجور: فرد كأحد أفراد الأسرة أو شريك أو صديق أو جار يُقدم الرعاية داخل الأسر أو المجتمع، والذي يشترك عادة في الروابط العاطفية أو الاجتماعية مع متلقي الرعاية. وقد يقدم رعاية منتظمة، أو عَرَضية، أو روتينية، أو يشارك في تنظيم الرعاية التي يقدمها الآخرون. ويختلف مقدمو الرعاية غير المأجورين عن مقدمي الرعاية الآخرين، إذ إنهم ليسوا موظفين لدى المنظمات المخوَّلة بتنسيق وتقديم الخدمات. ودَورهم غير رسمي وغير مدفوع الأجر.

مدير الحالة: عامل صحي يدعم ويوجه وينسق رعاية المسنين، والأُسر ومقدمي الرعاية غير المأجورين. فهو حلقة وصل مركزية في التواصل، حيث يربط الأفراد بأعضاء الفريق متعدد التخصُّصات وأصحاب المصلحة في المجتمع. وغالبًا ما يتم اختيار مدير حالة من بين أعضاء الفريق متعدد التخصُّصات.

العلاج المعرفي السلوكي: علاج نفسي يجمع بين المكونات المعرفية التي تهدف إلى التفكير بطريقة مختلفة (على سبيل المثال، من خلال تحديد وتحدّي الأفكار السلبية غير الواقعية) والمكونات السلوكية التي تهدف إلى أداء مختلف (على سبيل المثال، من خلال مساعدة الشخص على الانخراط في أنشطة أكثر إشباعًا).

التدهور المعرفي: تدهور وظيفة أو أكثر من الوظائف المعرفية مثل الانتباه، وحل المشاكل، والقدرة على التعلم، والذاكرة.

الوظيفة المعرفية: العمليات التي تدخل في اكتساب المعرفة والاحتفاظ بها (بما في ذلك اللغة والأعراف الاجتماعية)، ومعالجة المعلومات، والاستدلال، وتنظيم المشاعر.

العلاج بالتنبيه المعرفي: تَدَخُّل غير دوائي يشمل مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك التوجه الواقعي، والتوكيد، و/أو استرجاع الذكريات من خلال الأنشطة الجماعية والتفاعل الاجتماعي.

التدريب المعرفي: مصطلح شامل يشير إلى مجموعة من التدخلات غير الدوائية تُطبَّق فيها مجموعة متنوعة من التقنيات لتحفيز التفكير والمعرفة بدرجات متفاوتة من الشمولية والدقة. ويستهدف هذا المصطلح الوظائف المعرفية المعزولة (مثل الذاكرة) من خلال ممارسة فردية متكررة لمهام معرفية معيارية.

الرعاية الصحية المجتمعية: الخدمات التي يقدمها مجموعة من العاملين الصحيين في المجتمع، وفقًا لتدريبهم وقدراتهم، سواء كانوا متطوعين أو محترفين، رسميين أو غير رسميين، مدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في المنشآت الصحية الذين يدعمونهم ويشرفون عليهم ويقدمون خدمات التوعية المجتمعية والحملات.

المشاركة المجتمعية: عملية إنشاء وصون العلاقات التي تمكّن أصحاب المصلحة الذين يتشاركون موقعًا جغرافيًا و/أو مجال تركيز موضوعي من العمل معًا لمعالجة القضايا الصحية وتعزيز الرفاه لتحقيق تأثير ونتائج صحية إيجابية ومستدامة.

عامل صحي مجتمعي: هم العاملون الصحيون الذين يقدمون خدمات صحية، بما في ذلك التثقيف الصحي، بالشراكة مع العاملين الصحيين في مرافق الرعاية الصحية، ويقومون بالإحالة إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات والأسر والأفراد. كما أنهم يوفرون تدابير صحية وقائية ويسهلون الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة، من خلال سد الفجوات بين مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والمجتمعية وبين المجتمعات التي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات. يُعرَف العامل الصحي المجتمعي أيضًا بأسماء أخرى، مثل العامل الصحي القروي، أو مساعِد أو مروّج الصحة المجتمعية، أو المثقِّف الصحي، أو أي مصطلح آخر مشابه.

أصحاب المصلحة في المجتمع: هم الأفراد أو الأسر أو المجموعات أو المنظمات التي لديها مصلحة أو استثمار في مجتمع معين وتتأثر بالقرارات والسياسات والعمليات داخل هذا المجتمع ويمكن أن تؤثر عليها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات المجتمع المدني (مثل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية)، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وجمعيات المسنين، والمجموعات أو الأندية، ومجموعات دعم الأقران، والمتطوعين ومقدمي الرعاية المنزلية غير المأجورين الذين يعملون ضمن برنامج منظم. ويُعتبر العاملون الصحيون المجتمعيون من بين أصحاب المصلحة في المجتمع، مع تضمينهم أيضًا ضمن تعريف العاملين الصحيين.

سلسلة الرعاية: النطاق الكامل للرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية الشخصية والسكانية اللازمة خلال جميع مراحل القدرة الذاتية، والقدرة الوظيفية، والمرض، والإصابة أو الحدث على مدار الحياة، بما في ذلك الترويج للصحة، والوقاية، والعلاج، والتأهيل، والرعاية التلطيفية، والرعاية طويلة الأجل.

القدرة الوظيفية: السمات المتعلقة بالصحة التي تمكّن الأفراد من أن يكونوا ويفعلوا ما لديهم سبب وجيه لتقييمه؛ وتتكون من القدرة الذاتية للفرد، والخصائص البيئية ذات الصلة، والتفاعلات بين الفرد وتلك الخصائص.

طب الشيخوخة: تخصص طبي يركز على تقديم رعاية متمركزة حول المريض للمسنين.

العاملون الصحيون: جميع الأشخاص المشاركين بشكل أساسي في أعمال تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الصحة (مثل العاملين في الصحة والرعاية، ومتخصصي الرعاية الصحية، ومديري البرامج الصحية).

الشيخوخة الصحية: عملية تطوير والحفاظ على القدرة الوظيفية التي تُمكّن الأشخاص من التمتع بالصحة والعافية في سن الشيخوخة.

دليل الرعاية المتكاملة للمسنين: الأداة التي تدعم العاملين الصحيين في تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية، بما في ذلك على مستوى المجتمع.

الأدوية غير المناسبة: تكون الأدوية غير مناسبة عندما يتم وصف دواء واحد أو أكثر دون حاجة إليه أو لم تعد هناك حاجة إليه، وذلك إما لأن: أ) لا يوجد دليل علمي يدعم استخدامه، أو انتهت الحاجة إليه، أو أن الجرعة أعلى من اللازم؛ ب) أحد الأدوية أو أكثر لا يحقق الأهداف العلاجية المرجوة؛ ج) يسبب أحد الأدوية أو مزيج من عدة أدوية تأثيرات جانبية ضارة أو قد يكون هناك خطر من حدوثها؛ د) أن المريض غير راغب أو غير قادر على تناول دواء أو أكثر وفقًا لما هو مقرر.

الأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية: أنشطة تسهّل العيش المستقل: كالقدرة على استخدام الهاتف، والتسوق، وإعداد الطعام، والأعمال المنزلية، والغسيل، ووسائل النقل، واستخدام الأدوية، وإدارة الشؤون المالية.

الرعاية المتكاملة: خدمات تُدار وتُقدَّم بطريقة تضمن حصول الأفراد على استمرارية الرعاية عبر الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال نهج متمركز على الشخص. ويشمل ذلك تعزيز الصحة، والوقاية، والتشخيص، والعلاج، والتأهيل، والرعاية التلطيفية، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل. ويتم دمج تقديم الخدمات عبر القطاعات والبيئات والمواقع طوال مسار الحياة.

نهج الرعاية المتكاملة للمسنين: نهج منظمة الصحة العالمية للاستمرارية في تقديم الرعاية المتكاملة التي تساعد على إعادة توجيه الخدمات الصحية والاجتماعية نحو رعاية أكثر تنسيقًا وتركيزًا على الأشخاص، مما يدعم تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى المسنين. ويُشار إلى هذا النهج بالاختصار "ICOPE".

القدرة الذاتية: مجموعة من جميع القدرات البدنية والنفسية التي يمكن أن يستعين بها الفرد.

الوِحدة: تجربة ذاتية تنشأ نتيجة عدم التطابق بين التوقعات والواقع فيما يتعلق بجودة وحجم الروابط الاجتماعية.

الرعاية طويلة الأجل: الأنشطة التي يقوم بها الآخرون لضمان أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان مستمر للقدرة الذاتية يمكنهم الحفاظ على مستوى من القدرة القدرة الوظيفية يتماشى مع حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.

الفريق متعدد التخصُّصات: مجموعة من العاملين في ميدان الصحة والرعاية من منظمات ومهن مختلفة (مثل الأطباء، والممرضين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والأخصائيين الاجتماعيين) يعملون معًا لاتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين، ويقدمون الرعاية بطريقة تعاونية ومنسقة.

التمرين متعدد الوسائط: تمرين مصمم لتطوير التوازن والقدرة الحيوائية وقوة العضلات والمرونة والتنسيق، بهدف الحفاظ على القدرة الذاتية وتعزيزها (مثل القدرة الحركية والمعرفية)، وتقليل خطر السقوط، والوقاية من الإصابات بما في ذلك الكسور.

الرعاية التلطيفية: نهج يُحسّن جودة حياة المرضى وأسرهم الذين يواجهون مشاكل مرتبطة بأمراض تهدد الحياة. يهدف إلى تجنب المعاناة وتخفيفها من خلال الاكتشاف المبكر والتقييم الصحيح وعلاج الألم والمشاكل الأخرى، سواء كانت جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو روحية.

الرعاية المتمركزة على الشخص: نهج رعاية يعتمد بشكل واعٍ على وجهات نظر الأفراد والأسر والمجتمعات، ويَنظر إليهم كمشاركين ومستفيدين من أنظمة الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل التي تستجيب لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم بطرق إنسانية وشمولية. ويتم تنظيم الرعاية المتمركزة على الشخص حول احتياجات الأفراد وقيمهم وتفضيلاتهم وتوقعاتهم بدلاً من التركيز على الأمراض.

النشاط البدني: أي حركة جسدية تنتجها العضلات الهيكلية وتتطلب استهلاكًا للطاقة، بما في ذلك الأنشطة التي يتم القيام بها أثناء العمل أو اللعب أو أداء الأعمال المنزلية أو التنقل أو الانخراط في الأنشطة الترفيهية.

التمارين البدنية: فئة فرعية من النشاط البدني يكون مخططًا لها، ومنظمة، ومتكررة، تهدف إلى تحسين أو صون واحد أو أكثر من مكونات القدرات البدنية.

تعدد الأدوية: الاستخدام المتزامن لعدة أدوية، وغالبًا ما يُعرَّف بأنه الاستخدام الروتيني لخمسة أدوية أو أكثر. ويشمل ذلك، الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، والأدوية الموصوفة، والأدوية التقليدية والتكميلية التي يستخدمها المريض.

الرعاية الأولية: عملية أساسية في النظام الصحي تدعم نقطة الاتصال الأولى للرعاية، وغالبًا ما يتم تقديمها في مرافق الرعاية الأولية، ومراكز الصحة المجتمعية، والنقاط الصحية، والعيادات المتنقلة، ومن خلال خدمات التوعية المجتمعية. وتتيح الرعاية الأولية الاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة المتركزة على الشخص بالقرب من حياة الناس اليومية.

الرعاية الصحية الأولية: نهج يشمل المجتمع بأسره لتنظيم وتعزيز النظم الصحية الوطنية بشكل فعَّال، بهدف تقريب خدمات الصحة والرفاه من المجتمعات المحلية. ويتكون هذا النهج من ثلاثة عناصر: تقديم خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات الأفراد الصحية طوال حياتهم، ومعالجة المحددات الأوسع للصحة من خلال سياسات وإجراءات متعددة القطاعات، وتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من تولي زمام الأمور فيما يتعلق بصحتهم.

التثقيف النفسي: تَدخُّل يهدف إلى تقديم المعلومات للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية ولمقدمي الرعاية غير المأجورين/أفراد الأسرة حول طبيعة الحالات، بما في ذلك أسبابها المحتملة، وتطورها، وعواقبها، وتوقعات سيرها، وطرق علاجها.

التأهيل: يشير التأهيل إلى مجموعة من التدخُّلات المصممة لتحسين الأداء الوظيفي وتقليل الإعاقة لدى الأفراد الذين يعانون من حالات صحية في تفاعلهم مع بيئتهم. ويساعد التأهيل المسنين على أن يكونوا مستقلين قدر الإمكان في الأنشطة اليومية، ويُمكِّنهم من المشاركة في التعليم والعمل والترفيه وأداء أدوار حياتية ذات معنى.

خدمات التأهيل: تقديم التدخُّلات الخاصة بالتأهيل (انظر التعريف أعلاه) من خلال عملية منظَّمة تشمل تحديد الاحتياجات وتعريف الأهداف، والتخطيط، وتقديم الرعاية، ومتابعتها، وذلك عادةً عبر سلسلة من الجلسات.

الرعاية الذاتية: قدرة الأفراد والأسر والمجتمعات على تعزيز صحتهم والمحافظة عليها، والوقاية من الأمراض، والتعامل مع المرض، سواء كان ذلك بدعم من عامل صحي أو مقدم رعاية أو بدونهم.

الإدارة الذاتية: القدرة على استخدام الأجهزة والأدوية والمعرفة للقيام بالتطبيب والعلاج والفحص والحقن الذاتي.

الرعاية الاجتماعية: تقديم المساعدة والدعم للأفراد وأسرهم في الأنشطة الأساسية واليومية للحياة (الرعاية الشخصية) لتعزيز جودة الحياة والرفاه.

العزلة الاجتماعية: تُشير إلى العدد الفعلي للروابط والتفاعلات الاجتماعية التي يختبرها الفرد. قد يكون الشخص معزولًا اجتماعيًا إذا كان لديه شبكة صغيرة من العلاقات الأُسرية وغير الأُسرية، وبالتالي تكون تفاعلاته مع الآخرين قليلة أو نادرة.

الحماية الاجتماعية: تُعد الحماية الاجتماعية حقًا من حقوق الإنسان، وهي مجموعة من السياسات والبرامج المصمَّمة للحد من الفقر والوقاية منه والتصدي لحالات الضعف طوال دورة الحياة. وتشمل الحماية الاجتماعية المنافع الخاصة بالأطفال والعائلات، والأمومة، والبطالة، وإصابات العمل، والمرض، والمسنين، والإعاقة، بالإضافة إلى الحماية الصحية.

الدعم الاجتماعي: الدعم النفسي والجسدي والمالي الذي يمكن للفرد الوصول إليه من خلال الروابط الاجتماعية مع الأفراد الآخرين أو المجموعات أو المجتمع الأوسع، والذي يمكن أن يوفر دِرعًا ضد الأحداث السلبية في الحياة، ويعزز القدرة على الصمود، ويكون موردًا إيجابيًا للصحة.

تقاسم المهام: نهج يهدف إلى تحسين استخدام القوى العاملة الصحية، خاصة في ظل نقص العاملين الصحيين، حيث يتم تقاسم مهام أو أدوار محددة مع العاملين الصحيين الأقل تخصصًا عند الاقتضاء، مما يحسن من كفاءة استخدام الموارد البشرية المتاحة. ينبغي أن يكون هذا النهج مصحوبًا بتدابير مناسبة في التعليم، والإشراف، والدعم الإداري، والترخيص، والتنظيم، والأجور.

التغطية الصحية الشاملة: ضمان حصول جميع الأفراد على مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، في الوقت والمكان المناسبين، دون أن يواجهوا مشقة مالية. وتشمل التغطية الصحية الشاملة جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءًا من تعزيز الصحة والوقاية، وصولًا إلى العلاج، والتأهيل، والرعاية التلطيفية، على مدار دورة الحياة.



x

١ الرعاية المتكاملة للمسنين

النقاط الرئيسية

- يكمُن مفتاح دعم الشيخوخة الصحية للجميع في تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى الأفراد طوال مسار حياتهم.
- يمكن الحد من الاعتماد على الرعاية، أو تأخيره، أو الوقاية منه، إذا ما جرى تحديد التدهور في القدرة الذاتية وتقييمه وتشخيصه والتعامل معه في الوقت المناسب، بما في ذلك من خلال تهيئة بيئة مادية واجتماعية ميسِّرة.
- إن التدهور عبر مجالات القدرة الذاتية مترابطة، وبالتالي تتطلب نهجًا متكاملاً ومتمركزا على الشخص في التقييم والإدارة.
- يُعَدُّ المسنون فاعلين رئيسيين في صحتهم، ويجب تمكينهم من فهم حالتهم الصحية، واتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وتحديد أهدافهم الشخصية. إن مشاركتهم المُثمرة، وكذلك مشاركة مقدمي الرعاية غير المأجورين، أمر بالغ الأهمية.
- يمكن للعاملين الصحيين في الرعاية الأولية وكذلك في المجتمع، تحديد المسنين الذين يعانون من فقدان القدرة الذاتية وتقديم التدخلات المبنية على البيّنات باستخدام هذه الإرشادات وتكييفها مع سياقهم.
- يلعب أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا هامًا في دعم تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين، وتمكينهم من المشاركة في الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية.

يُعرّف *التقرير العالمي عن الشيخوخة والصحة* لعام 2015 هدف الشيخوخة الصحية على أنه "مساعدة الأشخاص على تطوير والحفاظ على القدرة الوظيفية التي تمكنهم من تحقيق الرفاه في سن الشيخوخة". تُعرَّف القدرة الوظيفية على أنها "السمات المرتبطة بالصحة التي تمكّن الأشخاص من أن يكونوا ويفعلوا ما لديهم سبب وجيه لتقديره.". وتتألف القدرة الوظيفية من القدرة الذاتية للفرد، وبيئته، والتفاعلات بينهما. تشمل البيئات جميع العوامل الموجودة في العالم الخارجي (كالمنزل ومحيطه، والمجتمع، والمجتمع الأوسع) التي تُشكّل سياق حياة الفرد. وتتضمن هذه العوامل البيئة المبنية (المادية)، والأشخاص وعلاقاتهم، والمواقف والقِيَم، والسياسات والأنظمة والخدمات الصحية والاجتماعية. وتُعرَّف القدرة الذاتية على أنها "مجموعة القدرات البدنية والذهنية التي يمكن أن يستعين بها الفرد "*(1)*.

يُضفي هذا المفهوم للشيخوخة الصحية تركيزًا جديدًا على الرعاية الصحية للمسنين، يتمثّل في تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى الأفراد مع تقدمهم في السن. ومع تغير القدرة الذاتية للشخص المسن، ستتغير أيضًا احتياجاته وتفضيلاته فيما يخص الخدمات الصحية والرعاية والدعم الاجتماعيين. إن تقديم سلسلة متواصلة من الرعاية المتكاملة، التي تتابع مسار القدرة الذاتية والقدرة القدرة الوظيفية، أمر بالغ الأهمية لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة ودعم قدرة وظيفية مُثلى. تشمل سلسلة الرعاية مجموعة كاملة من الخدمات، بدءًا من الوقاية والتعزيز وصولًا إلى العلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، وتستجيب لاحتياجات الفرد المتغيرة وقدرته الذاتية وتطور المرض.

ولا يحتاج المسنون الذين يعانون من فقدان ملحوظ للقدرة الذاتية إلى الرعاية الصحية فقط، بل يحتاجون أيضًا إلى رعاية ودعم اجتماعيين مناسبين لتعويض ما فقدوه. يمكن لمقدمي الرعاية غير المأجورين توفير هذا الدعم، ويمكن تيسيره باستخدام المنتجات المساعِدة لخلق بيئة تمكينية. وتشمل الرعاية طويلة الأجل الأنشطة التي يقوم بها الآخرون لدعم الأشخاص الذين يعانون من فقدان ملحوظ للقدرة الذاتية، بهدف الحفاظ على مستوى معين من القدرة الوظيفية وضمان حياة كريمة تتماشى مع الحقوق والحريات الأساسية. يمكن تقديم الرعاية طويلة الأجل في بيئات مختلفة مثل المنزل، والمجتمع، والمرافق السكنية. كما يُقدَّم جزء كبير من الرعاية اليومية للمسنين من قبل مقدمي الرعاية غير المأجورين، وغالبًا ما يكونون من أفراد العائلة، والذين يحتاجون أيضًا إلى الدعم.

1.1
لماذا نحتاج إلى الرعاية المتكاملة للمسنين؟

يُشكِّل المسنون اليوم نسبة عالية من سكان العالم أكثر من أي وقت مضى. ففي عام 2024، كان هناك ما يقدر بنحو 1.18 مليار شخص ممن تصل أعمارهم إلى 60 عامًا فأكثر (أي ما يعادل نسبة 14.5% من السكان في العالم). وستشهد هذه النسبة ارتفاعًا سريعًا خلال العقود المقبلة، ولا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبحلول عام 2050، سيكون هناك 2.1 مليار شخص تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، مما يُشكّل 22% من سكان العالم *(2)* ، وسيتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا *(3)*. وهو يعكس الأثر التضافُري للوتائر السريعة لانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع مستويات متوسط العمر المتوقع في معظم أرجاء العالم، والمترافقة غالبًا مع التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

ويُعد الحفاظ على صحة المسنين استثمارًا في رأس المال البشري والاجتماعي، وهو يُساند أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وحق جميع الناس في كل مكان في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وفي الوقت ذاته، فإن رعاية الأعداد المتزايدة من المسنين يخلق تحديات في وجه النظم الصحية والاجتماعية. وتدعو الحاجة إلى إجراء تغيير جذري في مناهج الصحة العامة لمواجهة شيخوخة السكان.

تتطلب سلسلة الرعاية تنفيذ خدمات متكاملة للمسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين عبر جميع مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، بدءًا من منازل المسنين وعيادات الرعاية الأولية والمستشفيات وصولاً إلى مرافق الرعاية طويلة الأجل. وتلعب المجتمعات دورًا بالغ الأهمية في تمكين "قضاء المسنين شيخوختهم في أماكن إقامتهم".

وتركز النُهج التقليدية للرعاية الصحية للمسنين على الأمراض الفردية، غالبًا بمعزل عن غيرها، مما يجعل تشخيصها وإدارتها محور الاهتمام. ولا تزال معالجة هذه الأمراض أمرًا مهمًّا، لكن التركيز الزائد عليها قد يؤدي إلى إغفال الصعوبات الشائعة المصاحبة للتقدم في السن، مثل الصعوبات في السمع، والبصر، والتذكر، والحركة، وغيرها من حالات التدهور الشائعة في القدرة الذاتية.

ثمة حاجة إلى التحول نحو إطار متكامل ومتواصل من الرعاية يتّسم بالشمول ويُركّز على القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية إلى جانب الأمراض، ويستند إلى نهج الرعاية الصحية الأولية. وتجمع بينهما علاقة ذات اتجاهين، إذ يمكن أن تؤدي الأمراض التي لا تُعالَج على نحو جيد إلى بدء تدهور القدرة الذاتية أو تسريعها، كما أن حالات ضعف القدرة الذاتية يمكن أن تُغيّر من مسار المرض. إن إيلاء اهتمام بالقدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى كبار السن في جميع أنحاء النظام (أو النظم) الصحي والاجتماعي، من شأنه أن يُسهم على نطاق واسع في رفاه هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من السكان.

يحتاج العاملون الصحيون، بمن فيهم مقدمو الرعاية، إلى إرشادات وتدريب على كيفية التعرف على تدهور القدرة الذاتية والتعامل معه بفعالية، والحفاظ على القدرة الوظيفية، وتقديم رعاية شاملة ومتكاملة تستجيب للاحتياجات الصحية والرعائية المتنوعة لكبار السن. ومع تقدم السكان في السن، تبرز حاجة ملحة إلى وضع نُهج مجتمعية محلية شاملة تشمل تدخلات ترمي إلى الوقاية من تدهور القدرة الذاتية أو تأخيرها، وتحسين القدرة الوظيفية من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية، ودعم مقدمي الرعاية لكبار السن.

1.2
ما هو النهج المتكامل للرعاية الصحية للمسنين؟

ICOPE

يهدف النهج المتكامل للرعاية الصحية للمسنين، المعروف بالاختصار ICOPE إلى تيسير إعادة توجيه خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية نحو رعاية منسَّقة وأكثر تركيزًا على الأشخاص، تدعم تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى المسنين. إن الرعاية المتكاملة للمسنين هو نهج منظمة الصحة العالمية لدعم تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين ضمن إطار نظام صحي يتمحور حول الرعاية الصحية الأولية.

إطار 1.1 التمييز على أساس السن

يشير التمييز على أساس السن إلى الصور النمطية (كيف نفكر)، والتحامل (كيف نشعر)، والتمييز (كيف نتصرف) الموجَّهة للأشخاص على أساس أعمارهم. إن التمييز على أساس السن موجود في مؤسساتنا، وفي علاقاتنا (الشخصية) وفي أنفسنا (الموجَّه نحو الذات). ويؤثر التمييز على أساس السن سلبًا على صحة المسنين ورفاههم *(4)*.

التمييز على أساس السن داخل أنظمة وخدمات الرعاية الصحية: على مستوى النظام، غالبًا ما تتجاهل الاستراتيجيات الصحية المسنين أو قد تتضمن سياسات متحيزة ضدهم، مثل رفض العلاج بناءً على العمر؛ وغالبًا ما يتم إهمال الرعاية الخاصة بالمسنين والخدمات المحددة التي تعالج المشاكل الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة؛ كما لا يُعطى التمويل الأولوية اللازمة، ولا تُصمَّم المرافق لتكون متاحة للمسنين. الافتقار إلى التدريب والدعم وعدم تحدي التصورات الثقافية الراسخة حول الشيخوخة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تبني العاملين الصحيين لمواقف سلبية تجاه المسنين أو عملية الشيخوخة، والانخراط في سلوكيات متعالية، والإخفاق في استشارة المسنين بشأن تفضيلاتهم في الرعاية، واستبعادهم من التجارب السريرية. كثيرًا ما يُغفل العاملون الصحيون تدهور القدرة الذاتية، إذ يعتبرونه "علامة طبيعية" من علامات التقدم في السن، وهو شكل من أشكال التمييز القائم على السن. وتؤثر مواقف العاملين الصحيين وتجارب المسنين داخل مؤسسات الرعاية الصحية على سلوكهم في طلب الرعاية الصحية. لا يزال مدى اتخاذ العاملون الصحيون مواقف تمييزية على أساس السن تجاه المسنين غير مؤكد، على الرغم من أن تصوره مرتفع. ويمكن أن تؤثر مجموعة من العوامل النظامية والفردية على هذه المواقف، بما في ذلك السياسات، والتعليم، ونقص الموارد، والجنس، وما إذا كان العامل الصحي قد اختار العمل بشكل خاص مع المسنين، وتجربة التواصل بين الأجيال والخلفية الثقافية.

التمييز على أساس السن الموجه نحو الذات: يشير التمييز على أساس السن الموجه نحو الذات إلى التمييز العمري الموجَّه ضد الفرد نفسه والذي يؤثر سلبًا على صحته. يتشرَّب الناس التحيزات القائمة على السن من ثقافتهم المحيطة بعد تعرُّضهم لها بشكل متكرر. وقد يعتقد الناس أن تدهور القدرة الذاتية أمر "طبيعي" مع التقدم في السن، ولا يمكن الوقاية منه أو تغييره، وقد يشعرون بأنه لا سبيل أمامهم لتحسين صحتهم ورفاههم.

يوفر نهج الرعاية المتكاملة للمسنين فرصة لمواجهة التمييز على أساس السن من خلال تعزيز كفاءات العاملين الصحيين في مجال صحة المسنين والرعاية المتكاملة، ودعم المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين. ويمكن أن يلعب أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا من خلال زيادة الوعي، بما في ذلك بين المسنين أنفسهم، حول التمييز على أساس السن وحقهم في الصحة والرعاية، إضافةً إلى فعالية الترويج للصحة والوقاية في مرحلة الشيخوخة، وتدبير التدهور في القدرة الذاتية وتحسين القدرة الوظيفية إن أمكن ذلك.

يجب تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين وفقًا للمبادئ الإرشادية التالية:

- للمسنين الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
- يجب أن يتمتع المسنون بفرصة متساوية للوصول إلى الخدمات التي تعالج محددات الشيخوخة الصحية، وأن يُقدَّم لهم الدعم لتبني سلوكيات صحية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، أو مكان ولادتهم، أو إقامتهم، أو أعمارهم، أو جنسهم، أو العوامل الاجتماعية الأخرى.
- يجب إشراك المسنين كصناع قرار رئيسيين في رعايتهم الخاصة، مع احترام استقلاليتهم.
- يجب تقديم الرعاية بشكل متساوٍ لجميع الأفراد، دون أي تمييز، خاصةً التمييز على أساس الجنس أو ضد ذوي الإعاقة أو التمييز على أساس السن (**إطار 1.1**).

تحدّد إرشادات *الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات التدخلات على مستوى المجتمع لتدبير تدهور القدرة الذاتية* الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 13 توصية مُستندة إلى البيّنات وموجهة إلى العاملين الصحيين لتنفيذ الرعاية المتكاملة المتمركزة على المسنين في الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك على مستوى المجتمع. ولتطبيق توصيات نهج الرعاية المتكاملة للمسنين على أرض الواقع، نشرت منظمة الصحة العالمية *دليل الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات للتقييم المتمركز على الأشخاص ومسارات الرعاية الأولية* في عام 2019 *(5)* لمعالجة نقص الإرشادات وتدريب معظم العاملين الصحيين للتعرف على تدهور الذاتية والقدرة الوظيفية وإدارتها بفعالية وتقديم رعاية شاملة ومتكاملة. وقد قدّم مسارًا للرعاية يتألف من خطوات ينبغي للعاملين الصحيين اتخاذها أثناء تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين، بالإضافة إلى مسارات رعاية مفصلة لتدبير التدهور في الذاتية عبر ستة مجالات: التدهور المعرفي، وضعف الحركة، وسوء التغذية، وضعف البصر، وفقدان السمع، وأعراض الاكتئاب، فضلاً عن دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين وتمكين الرعاية والدعم الاجتماعيين.

1.3 نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الصحية الأولية

تُعرّف منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأولية على أنها نهج شامل يضم المجتمع بأكمله نحو الصحة، ويهدف إلى ضمان أعلى مستوى ممكن من الصحة والرفاه وتوزيعها بشكل عادل، وذلك من خلال التركيز على احتياجات الأفراد في أقرب وقت ممكن عبر سلسلة من الخدمات تبدأ بالترويج للصحة والوقاية وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، وبالقرب قدر الإمكان من البيئة اليومية للأشخاص.

كما هو موضح في إعلان أستانا، تشمل الرعاية الصحية الأولية ثلاثة مكونات لا يمكن فصلها وتتأثر ببعضها البعض:

- وضع الرعاية الصحية الأولية والوظائف الأساسية للصحة العامة معًا في صميم الخدمات الصحية المتكاملة؛
- والاستفادة من السياسات والإجراءات متعددة القطاعات؛
- وتمكين الأفراد والمجتمعات من أن يكونوا شركاء في تشكيل صحتهم.

تُشكِّل الرعاية الصحية الأولية جوهر مكون الخدمات في نظام الرعاية الصحية الأولية، حيث تدعم تقديم الرعاية عند نقطة الاتصال الأولى، والرعاية المتاحة، والمستمرة، والشاملة، والمنسَّقة، وغالبًا ما تُقدّم في مرافق الرعاية الصحية الأولية (كالعيادات متعددة التخصصات والعيادات المفتوحة للزيارة)، وفي المنازل، ومراكز الصحة المجتمعية، ونقاط الصحة، والعيادات المتنقلة، ومن خلال خدمات التوعية المجتمعية. وهي تتميز بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات الصحية المتكاملة، بالقرب من أماكن سكن الناس، من خلال نهج متمركز على الشخص. يمكن للرعاية الأولية أيضًا أن تعزز المكونات الأخرى لنهج الرعاية الصحية الأولية من خلال التواصل مع المجتمع وتمكين المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين.

تم تصميم مسار الرعاية الأصلي في الطبعة الأولى من دليل الرعاية المتكاملة للمسنين (2019)، لدعم العاملين الصحيين في الرعاية الأولية في تقديم رعاية متكاملة متمركزة على الشخص بالقرب من الحياة اليومية للشخص المسن. ومع ذلك، يمكن تطبيق خطوات مسار الرعاية الأصلي في بيئات مختلفة ومع مسنين ذوي مستويات متفاوتة من القدرة الذاتية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من فقدان كبير لهذه القدرات (الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل). يقدم هذا الدليل (الطبعة الثانية) مسار رعاية شامل يتألف من أربع خطوات (**الشكل 1.1**، الصفحة 5)، يجب أن يُرى ذلك ضمن نهج أوسع للرعاية الصحية الأولية على مستوى السكان، يدعم تحديد احتياجات السكان المسنين؛ والتخطيط والتصميم والتنظيم والإدارة ومتابعة الخدمات. ويمكن تكييفه وتوسيعه من خلال توفير إرشادات مفصَّلة لكل خطوة، لتمكين تنفيذه في سياقات وظروف مختلفة (على سبيل المثال، للمسنين في مرافق الرعاية السكنية طويلة الأجل).

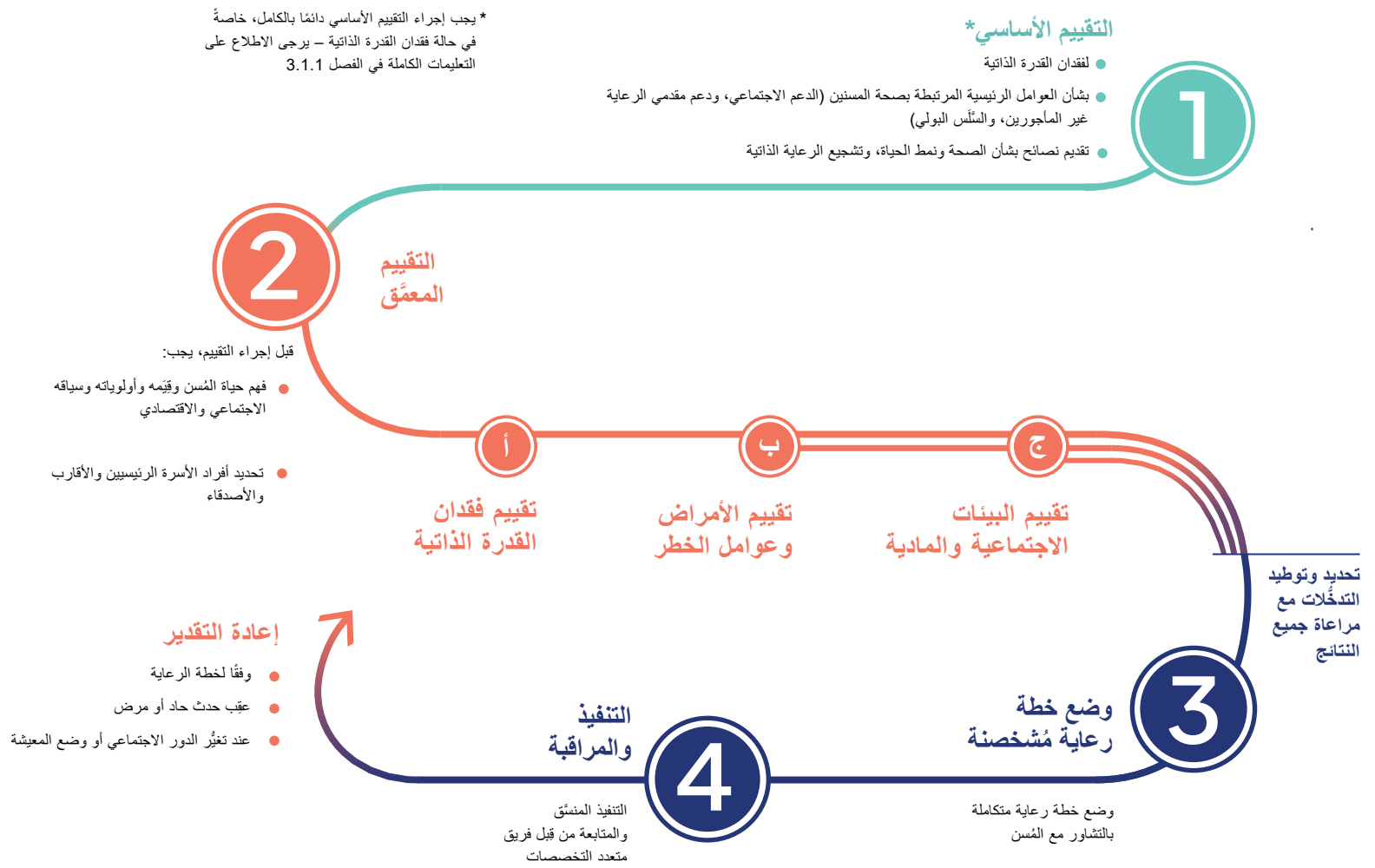
أي تكييف وتطوير لمسار الرعاية الشامل يجب أن يركز تركيزًا أساسيًا على:

- تقييم **الاحتياجات والتفضيلات والأهداف الفردية؛**
- وضع **خطة رعاية مُشخصنة؛**
- **تقديم الخدمات عبر فريق** متعدد التخصُّصات؛
- **توفير الرعاية الطويلة الأجل** تتبع مسار القدرة الذاتية؛
- **الخدمات الصحية والاجتماعية المنسَّقة،** موجَّهة نحو هدف واحد هو الحفاظ على القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية؛
- وإعادة التوجه نحو نهج الرعاية الصحية الأولية لتلبية احتياجات المسنين، مع تقديم الخدمات عبر **الرعاية الأولية** بما في ذلك على مستوى المجتمع.

يمكن أن يساهم مسار الرعاية الشامل هذا في توجيه السياسات والإجراءات متعددة القطاعات، مع الاعتراف بالأدوار المهمة للقطاعات التي تتجاوز الصحة مثل الإسكان والنقل والرعاية الاجتماعية، وذلك بما يتماشى مع رؤية عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية (2021-2030) (**المربع 1.2**، الصفحة 6). ويمكن استخدام مسار الرعاية الشامل إلى جانب مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية للتأثير على قرارات السياسات المتخذة فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمسنين. سيساهم ذلك في تعزيز أنظمة الصحة الموجهة للرعاية الصحية الأولية اللازمة لتمكين تقديم سلسلة متواصلة من الرعاية المتكاملة للمسنين (الفصل 14). ويمكن أن يدعم تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين أيضًا تحقيق نتائج صحية أفضل، وتحسين العدالة، وزيادة الأمن الصحي، وتحقيق كفاءة أفضل من حيث التكلفة؛ وجميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرعاية الصحية الأولية.

تركز مسارات الرعاية المفصَّلة (في الفصول 13-3) بشكل صريح على تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الصحية الأولية.

الشكل 1.1
مسار الرعاية المتكاملة للمسنين



إطار 1.2 الرعاية المتكاملة للمسنين في سياقها

يركز **عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية**، 2021-2030 على دور النظم الصحية في تعزيز الشيخوخة الصحية من خلال تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية، وهو ما ورد لأول مرة في *الاستراتيجية العالمية وخطة العمل لمنظمة الصحة العالمية حول الشيخوخة والصحة (2016–2020) (6)*. وتتمثل رؤية عقد الأمم المتحدة في عالم يعيش فيه جميع الأفراد حياة طويلة وصحية، من خلال تعاون عالمي متعدد القطاعات يهدف إلى اتخاذ إجراءات منسقة ومحفزة لدعم الشيخوخة الصحية. وتركز على أربعة مجالات عمل تشمل: تقديم رعاية متكاملة متمركزة على الشخص وخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تستجيب لاحتياجات المسنين، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى الرعاية طويلة الأجل للمسنين الذين يحتاجون إليها. وتساهم الموارد الفنية الخاصة بالرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية، إلى جانب *الرعاية طويلة الأجل للمسنين: حزمة لتغطية صحية شاملة (7)* في تحقيق هذه الالتزامات.

التغطية الصحية الشاملة هي الأساس لتحقيق الأهداف الصحية لأهداف التنمية المستدامة، وتعني تمكين جميع الأفراد من الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها، في الوقت والمكان المناسبين، دون مواجهة مشقة مالية *(8)*. ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة، يجب معالجة احتياجات المسنين الصحية من خلال سلسلة رعاية متكاملة تُقدَّم عبر خدمات صحية مبنية على نظام صحي يركز على الرعاية الصحية الأولية.

لقد طورت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الموارد لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك منصة تخطيط وتقديم وتنفيذ خدمات التغطية الصحية الشاملة (SPDI) وملخص خدمات التغطية الصحية الشاملة (UHC Compendium). وتُعد منصة SPDI موردًا إلكترونيًا يدعم البلدان في تحسين ودمج تقديم الخدمات في كل أطوار الرعاية وعلى مدار الحياة. وتمكّن البلدان من بناء حزمة من الخدمات الصحية باستخدام أدوات وموارد محددة، بما في ذلك الموارد الفنية الخاصة بالرعاية المتكاملة للمسنين.

تحقيق الصحة للجميع هو هدف التغطية الصحية الشاملة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتمكن جميع الأفراد، بما في ذلك جميع المسنين، من الوصول إلى الخدمات الصحية. إن الإعاقة ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، لكن انتشار الإعاقة يزداد مع تقدم العُمر؛ إذ تبلغ نسبتها 5.8% بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 14 عامًا، وتصل إلى 34.4% بين الأفراد فوق سن 60 عامًا *(9)*. يتطلب تقديم الخدمات الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات لدعم وصولها إلى المسنين من ذوي الإعاقة، إلى جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد *التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العدالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة* 40 إجراءً رئيسيًا، يجب على الدول اتخاذها لتعزيز نظمها الصحية والحد من عدم المساواة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

1.4 الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات بشأن التقييم المتمركز على الأشخاص ومسارات الرعاية الأولية (دليل ICOPE)، الطبعة الثانية

تستند هذه الطبعة الثانية من دليل الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية إلى الدروس المستفادة من تنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين في سياقات متنوعة حول العالم والإرشادات التوجيهية الجديدة أو المحدثة ذات الصلة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية. تم تطوير دليل الرعاية المتكاملة للمسنين (الطبعة الثانية) بالتعاون مع خبراء في الشيخوخة الصحية ورعاية المسنين من خلال الاتحاد السريري العالمي المعني بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (CCHA) التابع لمنظمة الصحة العالمية ومع زملاء من مجموعة متنوعة من الوحدات الفنية والمناطق في منظمة الصحة العالمية.

تم جمع المُدخلات من خلال الخبرات الميدانية بالإضافة إلى اجتماعات الاتحاد السريري العالمي المعني بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وخاصة الاجتماع الذي عُقد في عام 2023، حيث كان تحديث مسارات الرعاية هو البند الرئيسي في جدول الأعمال. وراجع المشاركون في هذا الاجتماع وخبراء آخرون مسارات الرعاية المعدلة والإرشادات الواردة في هذا الدليل طوال فترة تطويره. كما طُلب من جميع المشاركين في تطوير ومراجعة الدليل الإفصاح عن أي تعارض في المصالح باستخدام نموذج منظمة الصحة العالمية للإفصاح عن المصالح من قبل خبرائها. ولم تُعتبر أي مصالح مصرح بها ذات أهمية.

التغييرات الرئيسية في الطبعة الثانية من الدليل

1. مسار الرعاية المكون من أربع خطوات

يتكون مسار الرعاية المتكاملة للمسنين (ICOPE) الآن من أربع خطوات بدلاً من خمس: التقييم الأساسي والتدخلات على مستوى المجتمع، والتقييم المعمَّق، ووضع خطة رعاية مُشخصنة، والتنفيذ والمراقبة. ولقد تم الاعتراف بالدور الحاسم لأصحاب المصلحة في المجتمع ومقدمي الرعاية غير المأجورين في جميع مراحل المسار. واستجابةً لذلك، تم إدراج مشاركة المجتمع ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين كعناصر رئيسية عبر الخطوات الأربع في المسار، مع التركيز بشكل خاص في الخطو الأولى، بدلاً من معالجتها كخطوة خامسة منفصلة.

2. توسيع الخطوة الأولى

تم توسيع نطاق الخطوة الأولى لضمان توفير المعلومات والخدمات والدعم الأساسي عند نقطة الاتصال الأولى مع المسن، وكذلك لتمكين تقديم الرعاية للمسنين داخل المجتمعات ومن قِبل أصحاب المصلحة في المجتمع في السياقات ذات الموارد المحدودة. إلى جانب التقييم الأساسي (الذي كان يُطلق عليه سابقًا "التحري")، يمكن تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة تدهور القدرة الذاتية. يعكس استخدام مصطلح "التقييم الأساسي" بدلاً من "التحري" الانتقال من التركيز الحصري على الفقدان المحتمل للقدرة الذاتية إلى تحديد احتياجات الدعم الاجتماعي، واحتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين للدعم، ووجود السَّلَس البولي، وهي عوامل رئيسية تؤثر في صحة المسنين. ويُعد توسيع الخطوة الأولى ليشمل تقديم الخدمات والدعم أمرًا بالغ الأهمية في السياقات التي قد لا يكون فيها تنفيذ الخطوات اللاحقة من مسار الرعاية المتكاملة للمسنين، بما في ذلك التقييم المعمَّق، ممكنًا، أو قد يكون هناك تأخير كبير بين التقييم الأساسي والتقييم المعمَّق.

3. المشاركة المجتمعية

يركز دليل الرعاية المتكاملة للمسنين (الطبعة الثانية) بشكل متزايد على المشاركة المجتمعية. فهو يقدّم أمثلة حول دور أصحاب المصلحة في المجتمع في كل خطوة من خطوات المسار، بما في ذلك تقديم الخطوة الأولى الموسعة، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير الدعم المباشر في المجتمع، وتمكين المسنين من اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم. ويشمل أصحاب المصلحة في المجتمع الأفراد والمجموعات والمنظمات، مثل المنظمات غير الحكومية، وأندية المسنين، والمنظمات المجتمعية، ومجموعات دعم الأقران، والمجموعات متعددة الأجيال، والمتطوعين، وغيرهم.

4. احتياجات دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين

نظرًا للاعتراف بدور مقدمي الرعاية غير المأجورين، ومعظمهم من النساء والفتيات، وعادةً ما يكونون من أفراد الأسرة أو الأصدقاء، وكذلك نقص الدعم الذي يواجهونه غالبًا، فقد تم إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين. يشمل ذلك توفير المعلومات والتدريب، بالإضافة إلى الحاجة إلى الدعم لضمان صحة ورفاه مقدمي الرعاية غير المأجورين أنفسهم. وقد تم تضمين هذه المسألة في الإصدار السابق من الدليل، ولكنها أصبحت الآن أكثر بروزًا مع إدراج أمثلة محددة في جميع الفصول. في الدليل، يُستخدم مصطلح "مقدم الرعاية غير المأجور" للإشارة إلى فرد، مثل أحد أفراد الأسرة أو صديق أو جار، يقدم رعاية غير رسمية للمسن.

5. العوامل الرئيسية في صحة المسنين

تم تضمين وإعطاء مزيد من التركيز على العوامل الإضافية المهمة لصحة المسنين وقدرتهم الوظيفية. ويتضمن ذلك التعرُّف المُبكر على احتياجات الدعم الاجتماعي واحتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين (عند الاقتضاء) في المجتمع، وتعزيز التطعيم باعتباره أحد أكثر تدخُّلات الصحة العامة فعاليةً من حيث التكلفة، وإدراج السَّلَس البولي، حيث تم وضع مسار رعاية جديد له.

1.5
كيفية استخدام دليل الرعاية المتكاملة للمسنين (الطبعة الثانية)

يوفر هذا الدليل إطارًا وتوجيهًا شاملًا لتنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، ويمكن للعاملين الصحيين استخدامه لتوجيه تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية وفقًا لسياقهم. ويهدف إلى توفير المرونة لضمان إمكانية تنفيذه عبر مختلف البلدان والسياقات والموارد المتاحة. ولهذا الغرض، ينبغي على مديري البرامج والنظم إجراء تقييم لاستعدادهم للتنفيذ قبل تطبيق نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية، وذلك لتوجيه عملية تكييف النهج بما يتناسب مع السياق. ويُعدّ هذا الأمر مهمًا نظرًا لاختلاف احتياجات الفئات السكانية المسنَّة، فضلًا عن تباين نظم الرعاية الصحية والاجتماعية وهياكل تقديم الخدمات وقدراتها. ويمكن للعاملين الصحيين إجراء تمارين مماثلة لتحديد الموارد المتاحة في بيئات الرعاية الصحية الخاصة بهم. ← **14.2**

يجب تنفيذ ذلك في الرعاية الأولية ضمن الخدمات الموجودة وبطريقة تتناسب مع الثقافة المحلية.

تفاصيل مسارات الرعاية المحددة (الفصول 13-5)، من حيث الأدوات والوسائل التي سيتم استخدامها، والتدخلات المستندة إلى الأدلة التي سيتم تقديمها، وأماكن تقديمها والجهات المسؤولة عنها، تتمتع بالمرونة ويجب أخذها في الاعتبار كجزء من عملية التكييف.

أمثلة على التكييف ضمن دليل الرعاية المتكاملة للمسنين (الطبعة الثانية) تشمل:

- يتم تقديم الأسئلة والاختبارات في التقييم الأساسي للرعاية المتكاملة للمسنين وللعوامل الرئيسية كأمثلة مستندة إلى الأدلة المتاحة ومشاورات الخبراء ويمكن تعديلها لضمان ملاءمتها للسياق المحلي. فعلى سبيل المثال، تهدف أسئلة الدعم الاجتماعي إلى تمكين فهم واسع لاحتياجات المسنين الاجتماعية. وينبغي تعديل طريقة طرح الأسئلة وصياغتها لضمان أن تكون ذات صلة وملائِمة ثقافيًا ودينيًا واجتماعيًا وأن يفهمها المسنون.

- من يقوم بكل خطوة، وأين، وكيف؟ على الرغم من أن المسار المُحدَّث يقترح أن يتولى أصحاب المصلحة في المجتمع تنفيذ الخطوة الأولى (← **4.1.3**)، فيمكن أيضًا أن يتولى العاملون الصحيون في مرفق الرعاية الصحية الأولية تنفيذها.

- وتُقدَّم الأدوات المستخدمة في التقييم المعمَّق أيضًا كأمثلة، استنادًا إلى عمليات التحقق والتوصيات العالمية. ومن المهم استخدام الأدوات المحلية التي تم التحقق من صحتها، إن وجدت.

- التدخلات المقترحة للإدراج في خطط الرعاية المُشخصنة هي توصيات تستند إلى الأدلة المتاحة. ويجب أن يضع العامل الصحي خطة رعاية مُشخصنة بمشاركة المسن ومقدمي الرعاية غير المأجورين، عند الاقتضاء، ويجب أن تستجيب الخطة لأهداف الشخص وتفضيلاته. ويجب أن تكون جميع التدخلات في خطة الرعاية قابلة للتنفيذ.

في بعض السياقات، قد تؤثر قدرة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية عفي تقييم القدرة الذاتية والحاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعيين، وكذلك على تقديم التدخُّلات. من المهم الإشارة إلى أن التحري للكشف عن الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والذي يُقترح كجزء من التقييم الأساسي، يُعتبر ممارسة غير أخلاقية إذا لم تكن هناك مسارات إحالة تُمكّن من الوصول إلى تقييم وعلاج إضافي. لذلك، قد تكون التوجيهات والإطار الشامل الواردة في هذا الدليل طَموحة في بعض السياقات، ويمكن أن تشكل هدفا يكمن السعي إليه.

هناك دائمًا إجراءات يمكن اتخاذها لدعم المسنين الذين يعانون من فقدان القدرة الذاتية مهما كان السياق أو الموارد المتاحة. من خلال توسيع الخطوة الأولى من مسار الرعاية، يقدّم هذا الدليل توصيات حول الإجراءات التي يمكن تنفيذها في المجتمع مباشرةً بعد إجراء التقييم الأساسي وفق نهج الرعاية المتكاملة للمسنين من قِبَل العاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع، وذلك في حال عدم إمكانية إجراء التقييم معمّق أو في حال التأخر الكبير في إجرائه. وتشمل هذه الإجراءات تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة للوقاية من تدهور القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية مجتمعية لمعالجة تدهور القدرة الذاتية.

إن الهدف من إدراج التدخلات على مستوى المجتمع في مرحلة التقييم الأساسي ليس التقليل من أهمية التقييم المعمّق أو وضع وتنفيذ خطة رعاية مُشخصنة، والتي ينبغي أن تظل الهدف الرئيسي لضمان تقديم رعاية متكاملة متمركزة على الشخص. بل إن الهدف هو توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها كنقطة انطلاق، وفي السياقات التي قد لا يكون من الممكن فيها تنفيذ المسار الكامل بعد. يمكن العثور على هذه المعلومات في بداية جميع الفصول، بعد مخطط مسار الرعاية، وهي مميّزة في كل من المخططات النصية والرسومية بخلفية ملوّنة أو مظللة.

1.6 مَن هو الجمهور الذي يستهدفه هذا الدليل؟

يستهدف هذا الدليل العاملين الصحيين المجتمعيين في الرعاية الأولية، بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والعاملون الصحيون المجتمعيون، والصيادلة، وأخصائيو التغذية، والأخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الرعاية، وأخصائيو العلاج الطبيعي وغيرهم. يستخدم الدليل لغة مبسطة عن قصد، حتى يكون متاحًا لأكبر عدد ممكن من العاملين الصحيين ذوي مستويات التدريب المختلفة في مجال صحة المسنين.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع الذين يقدمون الخدمات ونصائح والدعم للمسنين استخدام هذا الدليل لتعزيز المشاركة المجتمعية. وينبغي أن يزود الدليل العاملين الصحيين الذين ستُستدعى معرفتهم المتخصصة، عند الحاجة، لتقييم وتقديم الرعاية للمسنين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المسؤولة عن تطوير التدريب والمناهج الدراسية ومنح الاعتماد في الطب، والتمريض، والرعاية الاجتماعية، والصحة العامة، الاستفادة من المفاهيم والأساليب العملية الواردة في هذا الدليل. ومن بين الفئات المستهدَفة الأخرى، مديري الرعاية الصحية وصانعي السياسات، مثل مديري البرامج الوطنية والإقليمية والمحلية المسؤولين عن تخطيط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الجهات القائمة بتمويل وتنفيذ البرامج الصحية العامة، بما في ذلك برامج المدن والمجتمعات الصديقة للمسنين.

1.7
ما الذي يقدّمه هذا الدليل؟

WHO القدرة الأساسيةيسعى هذا الدليل إلى دعم العاملين الصحيين ذوي الخلفيات متعددة التخصُّصات في التعرف على تدهور القدرة الذاتية وتدبيره استنادا إلى التدخلات الموصى بها في *الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات التدخلات على مستوى المجتمع لتدبير تدهور القدرة الذاتية* والإرشادات الفنية ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. يسهّل الدليل تقديم رعاية متكاملة متمركزة على الشخص في الرعاية الأولية عن طريق معالجة احتياجات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين.

وتوضح هذه الإرشادات كيفية:

- تنفيذ مسار الرعاية المتكاملة للمسنين خطوة بخطوة في الرعاية الأولية، بما في ذلك تقديم التدخُّلات على مستوى المجتمع.
- ضمان المشاركة عبر أصحاب المصلحة والقطاعات، بما في ذلك مع الخدمات المتخصصة (الفصل 4).
- تقييم وتدبير فقدان القدرة الذاتية مع مراعاة الأمراض المصاحبة والعوامل البيئية (الفصول 5–10).
- تقييم الحاجة إلى الرعاية والدعم الاجتماعيين ووتوفيرهما (الفصل 11).
- تقييم الحاجة إلى دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين وتوفيره (الفصل 12).
- تقييم وتدبير السَّلَس البولي (الفصل 13).
- معالجة الاعتبارات الرئيسية في تنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين (الفصل 14).

مزيد من المعلومات

- ***ملخص التدخلات الصحية لتغطية صحية شاملة، الإصدار 1.3.***
  WHO; 2024 (https://www.who.int/universal-health-coverage/compendium)
- ***منصة تخطيط وتقديم وتنفيذ خدمات التغطية الصحية الشاملة (SPDI).***
  WHO; 2024 (https://www.who.int/universal-health-coverage/compendium/related-tools)
- ***عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية: خطة العمل، 2021-2030.***
  WHO; 2020 (https://www.who.int/publications/m/item/decade-of-healthy-ageing-plan-of-action)
- ***الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات التدخلات على مستوى المجتمع لتدبير تدهور القدرة الذاتية.***
  WHO; 2017 (https://iris.who.int/handle/10665/258981)
- ***تنفيذ نهج الرعاية الصحية الأولية: مقدمة.***
  WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376777)
- ***الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية: تحويل الرؤية إلى عمل.***
  WHO and UNICEF; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/337641)

2 تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية

يدعم هذا الدليل الحفاظ على القدرة الوظيفية من خلال معالجة تدهور القدرة الذاتية، وتمكين البيئات الاجتماعية والمادية (بما في ذلك الرعاية والدعم الاجتماعيين)، وتقديم الدعم لتلبية احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين، وتقييم سلس البول وإدارته.

المجالات الرئيسية للقدرة الذاتية

5 **القدرة المعرفية** | التدهور المعرفي

6 **القدرة على الحركة** | محدودية القدرة على الحركة

7 **الحيوية** | سوء التغذية

8 **الإبصار** | ضعف البصر

9 **السمع** | فقدان السمع

10 **القدرة النفسية** | أعراض الاكتئاب

العوامل الرئيسية في صحة المسنين

11 **الرعاية والدعم الاجتماعيين**

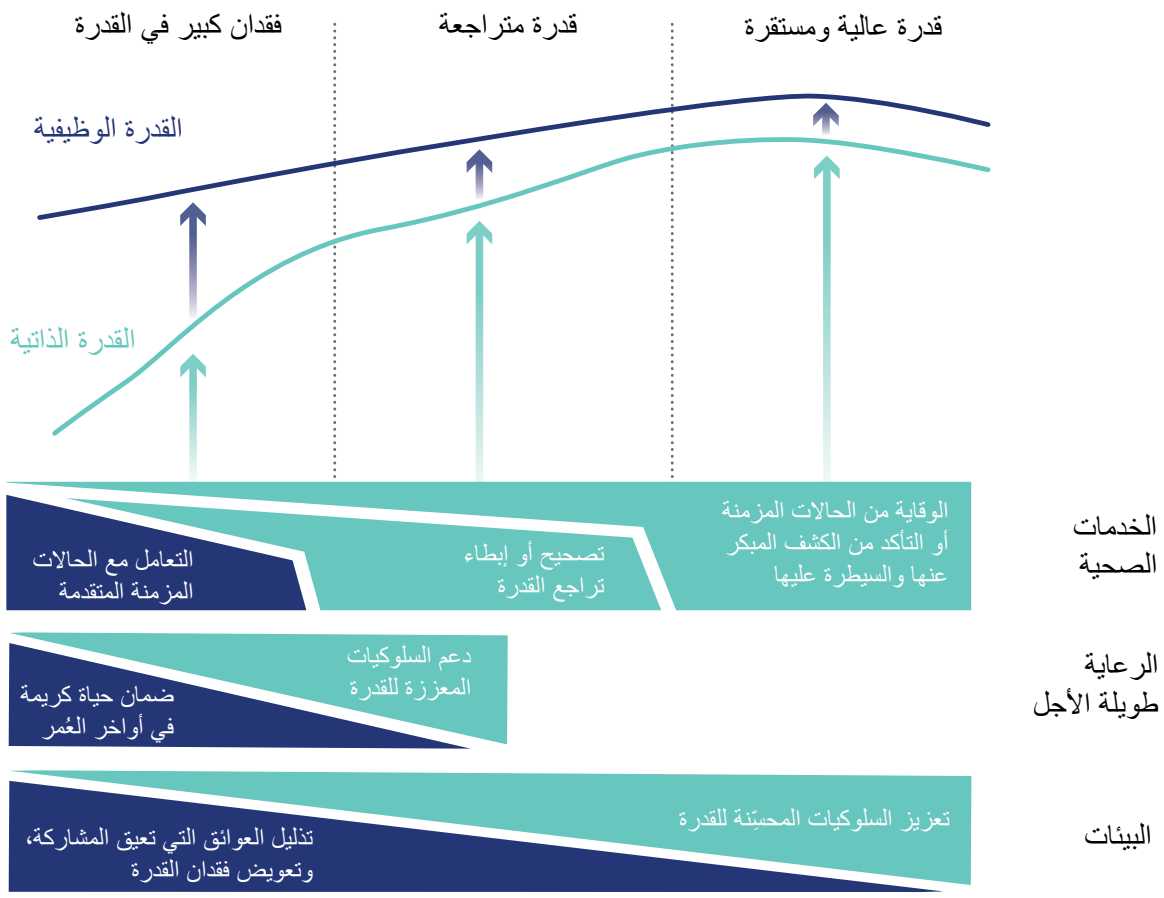
12 **دعم مقدمي الرعاية**

13 **السَّلَس البولي**

النقاط الرئيسية

- تميل القدرة الذاتية إلى التدهور مع التقدم في العمر؛ ومع ذلك، فإن التفاوت الواسع في القدرات حول النمط المتوسط، يُبرز أهمية وجود سلسلة رعاية متكاملة متمركزة على الشخص.
- إن تحديد حالات تدهور القدرة الذاتية بصورة استباقية في الرعاية الأولية يوفّر فرصة لإبطاء التراجع أو عكس مساره، والحفاظ على القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية.
- يمكن غالبًا تعديل الخصائص والسلوكيات التي تؤثر على القدرة الذاتية من خلال تبنّي أنماط حياة وسلوكيات صحية.
- تزداد أهمية التعديلات في البيئة المادية والاجتماعية للمسنين مع تدهور القدرة الذاتية، بهدف تحسين القدرة الوظيفية.
- يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم إنشاء بيئات يستطيع فيها المسنون تبني سلوكيات صحية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم المباشر.

شكل 2.1
إطار الصحة العامة للشيخوخة الصحية: فرص للعمل الصحي العام عبر مسار الحياة



المصدر: التقرير العالمي عن الشيخوخة والصحة. منظمة الصحة العالمية؛ 2015.

2.1
كيف تتغير القدرة الذاتية على مدار الحياة؟

يُظهر **الشكل 2.1** النمط النموذجي للقدرة الذاتية والقدرة الوظيفية خلال النصف الثاني من الحياة. حيث تتدهور القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية مع تقدم العمر نتيجة لعملية الشيخوخة والأمراض المستبطنة. ويمكن تقسيم هذا النمط إلى ثلاث فترات شائعة: فترة تتميز بقدرة عالية ومستقرة نسبيًا؛ وفترة يتراجع فيها الأداء؛ وفترة يحدث فيها فقدان كبير للقدرة، تُميَّز بالاعتماد على الرعاية. تهدف الرعاية المتكاملة للمسنين بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المسنين الذين يعانون من تراجع في القدرة أو فقدان ملحوظ لها، مع الأخذ في الاعتبار جوانب الرعاية طويلة الأجل والبيئات الصديقة للمسنين ذات الصلة بأهداف الفرد واحتياجاته في الرعاية. وبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بقدرة أساسية مستقرة وعالية، توفر الرعاية المتكاملة للمسنين فرصة لضمان تعزيز الصحة والوقاية.

هناك نطاق واسع من القدرات الأساسية حول النمط المتوسط، يظهر ذلك داخل البلدان وبينها. وينعكس هذا التنوع في الفروق المستمرة في متوسط أعمار البقاء، حيث تتراوح من 83 عامًا فما فوق في دول مثل أستراليا، وإيطاليا، واليابان، وجمهورية كوريا، والسويد، وسويسرا،
إلى أقل من 58 عامًا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وليسوتو، ونيجيريا، وجنوب السودان (10).

إن الاختلاف في القدرة الذاتية أكبر بكثير بين المسنين مقارنة بالمجموعات الأصغر سنًا. ويُعتبر هذا التنوع أحد سمات الشيخوخة، مما يشكل تحديات وفرص، بما في ذلك بالنسبة للنُهُج المتمركزة على الشخص. فقد يكون هناك أحد الأفراد أكبر بعشر سنوات من فرد آخر، لكنه يمتلك قدرة ذاتية و/أو قدرة وظيفية مشابهة، بينما قد يُظهر شخصان مُسنّان في نفس العمر فروقًا كبيرة في القدرة الذاتية. وهذا هو السبب في أن العمر الزمني يعد مؤشرًا ضعيفًا على الحالة الصحية للمسنين.

2.2
التدخُّل لتحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية

يوفّر التعرُّف على فقدان القدرة الذاتية فرصة للتدخل لإبطاء أو تصحيح هذا التدهور والحفاظ على القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية (**الشكل 2.1**، الصفحة 12). ويمكن للعاملين الصحيين في الرعاية الأولية، بمن فيهم أصحاب المصلحة في المجتمع، اكتشاف تدهور القدرة الذاتية.

يمكن أن يلعب أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا في محاسبة الحكومات والسلطات المحلية على الجهود المبذولة لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة وخلق بيئات يستطيع فيها المسنون تبني سلوكيات صحية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم بشكل مباشر.

ويمكن تعديل العديد من الخصائص والسلوكيات التي تحدد أو تؤثر على القدرة الذاتية. على سبيل المثال، يمكن تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة التي تؤكد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني وتجنب نمط الحياة الكسول، والحفاظ على التواصل الاجتماعي، والتطعيم، ومعرفة متى وأين يجب اللجوء إلى الخدمات الصحية. لا تساعد هذه السلوكيات في الحفاظ على القدرة الذاتية فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض التي قد تُسهم في فقدانها. يدعم نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية هذه السلوكيات الصحية والجهود الأوسع نحو تحسين القدرة الذاتية وإدارة عوامل الخطر في النصف الثاني من الحياة.

وتتيح التقييمات المتكررة على مدار الزمن والمتابعة المنتظمة، إمكانية مراقبة أي تغييرات في القدرة الذاتية مع إدارة الأمراض المزمنة. ويمكن تقديم تدخلات محددة لمعالجة التدهور في القدرة الذاتية بالإضافة إلى توفير الرعاية والدعم الاجتماعيين في الوقت المناسب. تُظهر التدخلات متعددة المكونات التي تعالج تراجعات مختلفة فعاليتها نتيجةً للتفاعل بين مجالات القدرة الذاتية.

وتزداد أهمية التعديلات في البيئة المادية والاجتماعية للمسنين مع تدهور القدرة الذاتية، بهدف تحسين القدرة الوظيفية. يمكن دعم خمسة مجالات من القدرة الوظيفية (**المربع 2.1**، الصفحة 14) من خلال أدخال تغييرات على منزل المسن ومحيطه والبيئات الخارجية الأخرى. على سبيل المثال، إدخال تعديلات على المنزل للحد من خطر السقوط، أو توفير المنتجات المساعِدة مثل مُعينات القدرة على الحركة يمكن أن يدعم المسنين على التنقل، بينما يمكن أن يشجع تقديم المعلومات عن فرص المشاركة في الفعاليات والمجموعات المجتمعية المحلية على الاستمرار في الإسهام الاجتماعي، كما يتضح من الأمثلة التي تقدمها الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات الصديقة للمسنين التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما يلعب مقدمي الرعاية غير المأجورين دورًا مهمًا؛ فهم غالبًا ما يكونون مسنون أنفسهم وقد يكون لديهم احتياجاتهم الخاصة للرعاية والدعم. يشمل مسار الرعاية المتكاملة للمسنين تقييم احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين وتقديم التدريب والدعم لهم.

ويستلزم اتباع نهج متكامل لتقييم وتدبير تدهور القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية، وتوفير سلسلة من الرعاية تجمع بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة والرعاية والدعم الاجتماعيين والخدمات، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل.

إطار 2.1 مجالات القدرة الوظيفية

- **تلبية الاحتياجات الأساسية** مثل الأمان المالي، والإسكان والأمان الشخصي، والوصول إلى الخدمات الصحية.
- **التثقيف والتطور واتخاذ القرارات**، بما في ذلك الاستمرار في التثقيف وتطبيق المعرفة، والمشاركة في حل المشاكل، والحفاظ على التطور الشخصي، والقدرة على اتخاذ الخيارات.
- **القدرة على التنقل**، للاستمرار في أداء الأنشطة المنزلية، والوصول إلى المتاجر، والخدمات والمرافق في المجتمع، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- **بناء مجموعة واسعة من العلاقات والحفاظ عليها**، بما في ذلك العلاقات مع الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، والعلاقات الاجتماعية غير الرسمية مع الأصدقاء والجيران، فضلاً عن العلاقات الرسمية مع العاملين الصحيين المجتمعيين.
- **القدرة على المساهمة**، وهو أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مثل مساعدة الأصدقاء والجيران، وتوجيه الأقران والشباب، والتطوُّع، ورعاية أفراد الأسرة والمجتمع.

3 مسار الرعاية المتكاملة للمسنين المكون من أربع خطوات في الرعاية الأولية

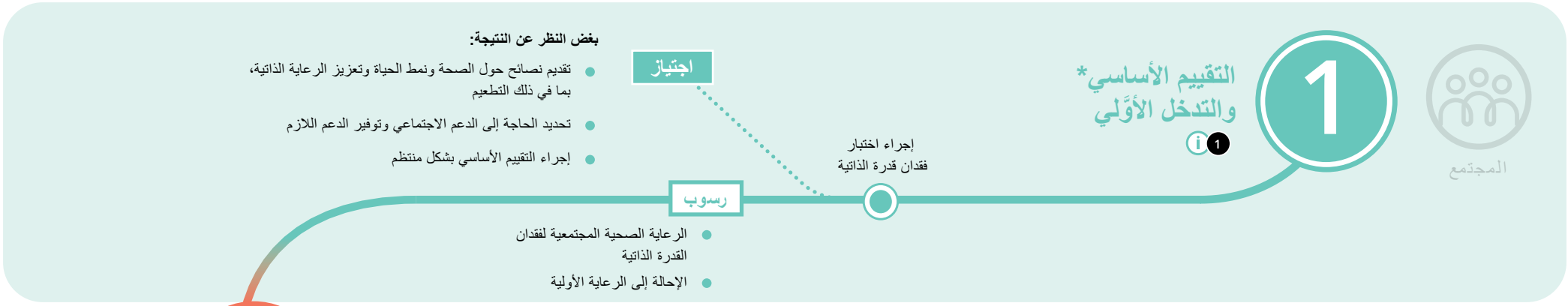
يتضمن مسار الرعاية المكوَّن من أربع خطوات في الرعاية الأولية التقييم الأساسي والتدخلات على مستوى المجتمع؛ والتقييم المعمَّق؛ ووضع خطة رعاية مُشخصنة؛ وتنفيذ ومتابعة الخطة. الرعاية الأولية هي عملية أساسية في النظام الصحي تدعم تقديم الرعاية عند نقطة الاتصال الأولى، وغالبًا ما تُقدَّم في منشآت الرعاية الأولية (مثل العيادات المفتوحة للزيارة والعيادات متعددة التخصُّصات)، وفي المنازل، ومراكز الصحة المجتمعية، ونقاط الصحة، والعيادات المتنقلة، ومن خلال خدمات التوعية المجتمعية. وتتيح الرعاية الأولية الاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة المتركزة على الشخص بالقرب من حياة الناس اليومية. ويمكن تنفيذ خطوات مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية في أي من هذه البيئات، وغالبًا ما يتم تقديمها بمشاركة أصحاب المصلحة في المجتمع.

تتبنى الرعاية المتمركزة على الشخص وجهة نظر تَعتبِر المسنين أفرادًا لديهم احتياجات وتفضيلات فريدة ضمن سياقاتهم الاجتماعية الخاصة. وتتجاوز رعايتهم مجرد إدارة أمراضهم أو حالاتهم الصحية لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بما في ذلك احتياجاتهم للرعاية طويلة الأجل، مع تبني اختياراتهم وتجاربهم. كما تأخذ في الاعتبار التأثير الذي تتركه حالات المسنين الصحية واحتياجات الرعاية عليهم وعلى أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية غير المأجورين.

النقاط الرئيسية

- يمكن تحديد التدهور المحتمل في القدرة الذاتية واحتياجات الدعم الاجتماعي في المجتمع.
- يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع المدرَّبين تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة للمسنين أثناء التقييم الأساسي، ودعمهم لاتخاذ إجراءات محددة، استجابةً لاحتمال فقدان القدرة الوظيفية الأساسية وللوقاية من عوامل الخطر.
- يجب إحالة الأفراد الذين تُظهر تقييماتهم فقدان محتمل في القدرة الذاتية إلى الرعاية الأولية لإجراء تقييم مُعمَّق، مما يُساهم في وضع خطة رعاية مُشخصنة، بما في ذلك الإحالة إلى الرعاية المتخصصة.
- قد تتضمن خطة الرعاية العديد من التدخلات، يتم الاتفاق عليها بعد مناقشتها مع المسن (ومقدمي الرعاية غير المأجورين)، لتدبير التدهورات والوقاية من المزيد من التدهور في القدرة الذاتية ولتحسين القدرة الوظيفية.
- يمكن توجيه تحديد أولويات وترتيب التدخلات بناءً على مدى إلحاح المشكلة، واحتمالية النجاح، والأثر الأوسع لمعالجة المشكلة، وما يشعر به المُسن هو الأهم بالنسبة لهم.
- يمكن أن يلعب أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا في كل مرحلة من مراحل مسار الرعاية، ويجب إشراكهم بشكل فعّال وتوفير الدعم المناسب لهم.

مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية



* يجب إجراء التقييم الذاتي دائما بالكامل، يرجى الاطلاع على التعليمات الكاملة في الفصل 3.1.1





1

التقييم الأساسي والتدخُّلات على مستوى المجتمع ← 3.1

لجميع المسنين:

- إجراء تقييم أساسي لفقدان القدرة الذاتية (الجدول 3.1)
- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة وتعزيز الرعاية الذاتية، بما في ذلك التطعيم والتعامل مع عوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية (3.1.3، 3.1.4)
- تحديد الحاجة إلى الدعم الاجتماعي (بيئة المنزل، الأمان المالي، الشعور بالوحدة والمشاركة الاجتماعية) وتحديد الحاجة إلى دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، وتوفير هذا الدعم (الجدول 3.2)

بالنسبة للمسنين الذين فشلوا في فحص الكشف عن فقدان القدرة الذاتية:

- بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يتم توفير رعاية صحية مجتمعية لمعالجة الفقدان المحدد في القدرة الذاتية (3.1.5)
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

المشاركة المجتمعية ← 4.1.3

يساهم أصحاب المصلحة في المجتمع بمن فيهم العاملون الصحيون المجتمعيون في تقديم الرعاية للمسنين وعائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم. ويُعدّ التفاعل المجتمعي الهادف والاستباقي ضروريًا لتنفيذ جميع خطوات مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية.

2

التقييم المُعمَّق المُعمَّق ← 3.2

أ. تقييم فقدان القدرة الذاتية

التأكد ضعف القدرة الذاتية في المجال أو المجالات التي لم تجتز اختبار الفحص

ب. تقييم الأمراض وعوامل الخطر

يجب تقييم ما يلي:

- التعامل مع الأمراض وعوامل الخطر
- مراجعة الأدوية
- التطعيم

ج. تقييم البيئات الاجتماعية والمادية

يجب تقييم ما يلي:

- تعديل البيئة
- المنتجات المساعِدة
- الدعم والرعاية الإجتماعيين، بما في ذلك خطر إساءة المعاملة والحاجة إلى الرعاية الشخصية والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية (11.2، 11.4، 11.5)
- احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين (12.3)

3

وضع خطة رعاية مُشخصنة ← 3.3

- الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية
- الخدمات والدعم المعتمد على المجتمع
- التدخُّلات متعددة المكونات للتعامل مع التراجع في القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية وتجنب تدهورها بشكل أكبر
- التعامل مع الأمراض وعوامل الخطر
- التطعيم
- مراجعة الأدوية
- توفير المنتجات المساعِدة وصيانتها
- الدعم والرعاية الإجتماعيين ← 11
- دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين ← 12
- الإحالة إلى الرعاية المتخصصة (مثل رعاية المسنين أو الرعاية التلطيفية أو خدمات التأهيل)

4

تنفيذ خطة الرعاية المشخصنة والاشراف عليها ← 3.4

- تنسيق الرعاية الصحية والاجتماعية عبر مختلف البيئات، بما في ذلك في المجتمع
- التنسيق مع الرعاية المتخصصة
- المتابعة المنتظمة والمستدامة
- رصد مدى الالتزام بالخطة العلاجية ومناقشة التعديلات اللازمة عند الضرورة
- التبادل المنتظم للمعلومات بين العاملين الصحيين في فريق متعدد التخصصات، بما في ذلك نتائج التدخُّلات والعوائق والمضاعفات

أيقونة المجتمع

تُستخدم هذه الأيقونة للإشارة إلى الإجراءات التي يمكن أن يتخذها العاملون الصحيون المجتمعيون وأصحاب المصلحة المجتمعيون المدربون الآخرون

أيقونة العامل الصحي

تُستخدم هذه الأيقونة للإشارة إلى الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها عامل صحي يقدم الرعاية الأساسية في المنشأة الصحية، مثل الطبيب أو الممرض أو الأخصائي الاجتماعي أو غيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية

هناك **أربع خطوات** يجب مراعاتها عند معالجة احتياجات المسنين من الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال نهج الرعاية المتكاملة في الرعاية الأولية (يرجى مراجعة الصفحة 16). خلال جميع الخطوات، يُعد إشراك المسنين والمجتمع الأوسع، وضمان تقديم الدعم لمقدمي الرعاية غير المأجورين أمرًا بالغ الأهمية. وعادةً ما يتطلب تنفيذ الخطوات الأربع لمسار الرعاية على مدى فترة زمنية، من خلال سلسلة من المناقشات مع المسنين، وقد يشمل ذلك إشراك عدة عاملين صحيين مختلفين. في معظم السياقات، يمكن تنفيذ الخطوة 1 داخل المجتمع من قِبَل أصحاب المصلحة في المجتمع (ولكن قد يُنفذها أيضًا العاملون الصحيون في مرافق الرعاية الأولية). ويجب أن يتولى إجراء التقييم المُعمَّق العاملون في مجال الرعاية الصحية في مرفق الرعاية الأولية. نظرًا لأن كل من التقييم المعمَّق ووضع خطة الرعاية المشخصنة قد يتطلبان وقتًا وتنسيقًا بين العاملين الصحيين المختلفين، فمن المحتمل أن يتم استكمال هذه الخطوات خلال اجتماعات مجدولة. وتتطلب الخطوتان 3 و4 مشاركة العاملين الصحيين، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية، وأصحاب المصلحة في المجتمع، ومقدمي الرعاية غير المأجورين.



3.1 التقييم الأساسي والتدخلات على مستوى المجتمع

توفر الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية فرصةً لإشراك المسنين، بمن فيهم أولئك الذين قد يواجهون وصولًا محدودًا إلى الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الصحة والرفاه، من خلال تحسين الثقافة الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي عند الحاجة، وزيادة سلوك البحث عن الصحة. من خلال عرض إجراء تقييم أساسي، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع الوصول إلى المسنين بالمعلومات والدعم وضمان فهم متزايد لأي تحديات قد يواجهونها.

في الطبعة الثانية من هذا الدليل، تركز الخطوة الأولى الموسَّعة من مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية على التقييم الأساسي، مع إمكانية تقديم تدخلات مجتمعية في الوقت المناسب، حسب الاقتضاء:

- يهدف التقييم الأساسي إلى تحديد:
  – فقدان القدرة الذاتية.
  – العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة المسنين، مثل السَّلَس البولي (عند الإمكان) والحاجة إلى الدعم الاجتماعي ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين.
- تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، بما في ذلك ما يتعلق بعوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية.
- تقديم الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة فقدان القدرة الذاتية، بما في ذلك دعم التعديلات في بيئة المسنين.
- الإحالة إلى الرعاية الأولية لإجراء تقييم معمَّق (الخطوة 2).

يهدف توسيع الخطوة 1 إلى الاستفادة القصوى من أول تواصل مع المسنين لتعزيز الصحة والوقاية. بالإضافة إلى فحص فقدان القدرة الذاتية، توفر الخطوة 1 فرصة لتقديم دعم ومعلومات محددة، وتقديم رعاية صحية مجتمعية في السياقات التي قد لا يكون فيها تنفيذ جميع خطوات مسار الرعاية المتكاملة للمسنين ممكنًا على الفور، أو حيث يختار المسنين عدم الحضور. لذلك، ينبغي إجراء التقييم الأساسي وتقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لجميع المسنين، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة قدر الإمكان. كما يجب إحالة المسنين الذين يُشتبه في وجود فقدان لديهم في القدرة الذاتية أو الذين يواجهون عوامل رئيسية تؤثر على صحتهم إلى خدمات الرعاية الأولية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المجتمعية عند الضرورة.

عند التقييم الأساسي لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين، تستخدم أسئلة واختبارات بسيطة لتحديد الاضطرابات المحتملة عبر ستة مجالات من القدرة الذاتية (**الجدول 3.1**، الصفحة 19)، بالإضافة إلى تحديد الحاجة إلى الدعم الاجتماعي ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، ورصد وجود السَّلَس البولي (**الجدول 3.2**، الصفحة 27).

الجدول 3.1
التقييم الأساسي لفقدان القدرة الذاتية

	سؤال التصفية إذا كانت الإجابة "نعم"، الانتقال إلى التقييم المعمَّق (الخطوة 2)	الاختبارات	إجراء تقييم كامل لأي مجال أمامه دائرة محددة بعلامة	اجتياز
5 **التراجع المعرفي** (القدرة المعرفية)	**هل لديك مشاكل في الذاكرة أو التوجُّه** (مثل عدم معرفة مكانك أو اليوم الذي نحن فيه)؟	1. **تذكّر ثلاث كلمات** (استخدم الأسماء، على سبيل المثال): زهرة، باب، أرز. 2. **التوجه في الزمان والمكان:** ما هو تاريخ اليوم بالكامل؟ أين أنت الآن (في المنزل، العيادة، إلخ)؟ 3. هل يتذكر الكلمات الثلاث؟	○ إجابة خاطئة على أي من السؤالين أو لا يعرف ○ لا يستطيع تذكُّر جميع الكلمات الثلاث	○ إجابة صحيحة على كِلا السؤالين
6 **محدودية القدرة على الحركة** (القدرة الحركية)		اختبار القيام من الكرسي القيام من الكرسي خمس مرات دون استخدام الذراعين. هل استطاع الشخص القيام من الكرسي خمس مرات خلال 14 ثانية؟	○ لا	○ نعم
7 **سوء التغذية** (الحيوية)		1. **فقدان الوزن** هل فقدت أكثر من 3 كغم بشكل غير مقصود خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ 2. **فقدان الشهية** هل شعرت بفقدان الشهية؟	○ نعم ○ نعم	○ **لا لكلا** السؤالين
8 **ضعف البصر** (الإبصار) * مع النظارات إذا كنت ترتديها عادةً	**هل لديك أي مشكلات في عينيك، مثل صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة أو القريبة*، أو ألم أو شعور بعدم الارتياح في العينين؟** **هل لديك داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو هل تستخدم حاليًا الستيرويدات أو أدوية للعينين؟**	1. **الفحص الخارجي للعينين** 2. **اختبار حدة البصر باستخدام** مخطط فحص الرؤية التابع لمنظمة الصحة العالمية*: • الرؤية البعيدة (12/6 لكل عين) • الرؤية القريبة (N6 لكلتا العينين)	○ رسوب ○ رسوب	○ اجتياز ○ اجتياز **اختباري** الرؤية البعيدة والقريبة
9 **فقدان السمع** (السمع)	**هل لديك مشكلة في السمع؟** بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون مساعدات السمع،إضافة: "حتى عند استخدام مساعدات السمع".	**اختبار الهمس** أو **قياس السمع الفحصي** أو **اختبار الأرقام الثلاثية في الضوضاء**	○ رسوب	○ اجتياز
10 **أعراض الاكتئاب** (القدرة النفسية)		**خلال الأسبوعين الماضيين، هل أزعجك أيٌّ مما يلي:** • الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو فقدان الأمل؟ • قلة الاهتمام أو الاستمتاع بالقيام بالأشياء؟	○ نعم ○ نعم	○ **لا لكلا** السؤالين

3.1.1
كيفية إجراء التقييم الأساسي لفقدان القدرة الذاتية

يمكن إجراء التقييم الأساسي لفقدان القدرة الذاتية والذي يستغرق عادةً من 8 إلى 12 دقيقة (**الجدول 3.1**، الصفحة 19)، من قِبل العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين، والمتطوعين في المجتمع، ومساعدي التمريض، والممرضين، والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين أو غيرهم من العاملين الصحيين.

يوصى بشدة بإجراء تقييم لجميع مجالات القدرة الذاتية في وقت واحد وليس بشكل منفصل. بالنسبة للمعرفة والرؤية والسمع، يُقترح استخدام سؤال تصفية. إذا كانت إجابة المُسن "نعم"، يمكن إحالته مباشرةً لإجراء تقييم معمَّق (الخطوة 2) ولا يكون هناك حاجة إلى مزيد من التقييم الأساسي لهذه المجالات. ويمكن تكييف التقييم الأساسي وفقًا لنظام الصحة المحلي وقدرات العاملين الصحيين.

التقييم الأساسي
التدهور المعرفي

سؤال التصفية

"هل لديك مشاكل في الذاكرة أو التوجُّه (مثل عدم معرفة مكانك أو اليوم الذي نحن فيه)؟"

إذا كانت الإجابة "نعم"، االانتقال مباشرة إلى الخطوة 2 – التقييم المُعمَّق. ← 5

اختبار بسيط للذاكرة والتوجُّه

1. **تذكَّر ثلاث كلمات:**
   طلب تذكُّر ثلاث كلمات ستنطق بها.
   استخدام أسماء بسيطة ومحددة مثل "زهرة" و"باب" و"أرز".

2. **التوجه في الزمان والمكان:**
   طرح الأسئلة التالية: "ما هو تاريخ اليوم بالكامل؟" و"أين أنت الآن؟" (في المنزل، العيادة، إلخ).

3. **تذكُّر الكلمات الثلاث:**
   الآن طلب تكرار الكلمات الثلاث المذكورة

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

- لم يتمكن الشخص من الإجابة على أحد السؤالين حول التوجّه؛ **أو**
- لم يتمكن من تذكّر جميع الكلمات الثلاث. ← 5

التقييم الأساسي
محدودية القدرة على الحركة

اختبار القيام من الكرسي

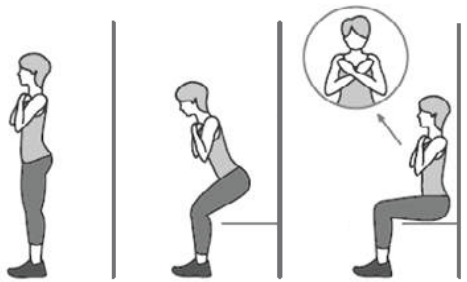
وضع كرسي متينٌ بجانب الحائط لضمان الأمان،، ويفضَّل استخدام كرسي بلا مساند للذراعين، ثم توضيح كيفية إجراء الاختبار. إذا كان الشخص الذي يستخدم عصا المشي يشعر بالاطمئنان لأداء اختبار القيام من الكرسي بها، فيُطلب منه القيام بذلك.

سؤال الشخص: "هل تعتقد أنه سيكون آمنًا لك أن تحاول القيام والجلوس على الكرسي خمس مرات بأسرع ما يمكن دون استخدام ذراعيك، ودون أن يسبب لك ذلك ألما أو انزعاجا؟"

إذا كانت الإجابة "نعم"، فاطلب منه القيام بما يلي:

- الجلوس في منتصف الكرسي.
- وضع ذراعيه بشكل متقاطع على صدره وإبقاءهما في تلك الوضعية.
- الوقوف بشكل كامل ثم الجلوس مرة أخرى.
- تكرار ذلك خمس مرات بأسرع ما يمكن دون توقف.

قياس الوقت الذي يستغرقه الشخص لإجراء الاختبار بالثواني.



يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

- كان الشخص غير قادر على أداء اختبار القيام من الكرسي؛ أو
- كان غير قادر على الوقوف خمس مرات خلال 14 ثانية. ← 6

التقييم الأساسي
سوء التغذية

طرح السؤالين التاليين:

- "هل فقدت أكثر من 3 كغم دون قصد خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟" (إذا كان الوزن غير معروف، يُطرح السؤال التالي: "هل لاحظت أن ملابسك أو حزامك أو ساعتك أصبحت أوسع؟").
- "هل شعرت بفقدان الشهية؟"

إذا كانت المعدات متوفرة، يتم وزن الشخص وتسجيل وزنه.

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

أجاب الشخص بـ "نعم" على أحد السؤالين. ← 7

التقييم الأساسي
ضعف البصر

سؤال التصفية

"هل لديك أي مشكلات في عينيك، مثل صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة أو القريبة (مع النظارات إذا كنت ترتديها عادةً)، أو ألم أو شعور بعدم الارتياح في العينين؟"

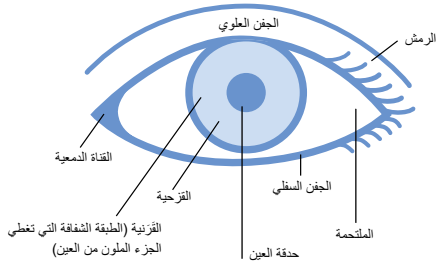
"هل لديك داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو هل تستخدم حاليًا الستيرويدات أو أدوية للعينين؟"

إذا كانت الإجابة "نعم" على أي من السؤالين، الانتقال مباشرة إلى الخطوة 2 – التقييم المعمَّق. ← 8

1. الفحص الخارجي للعينين

فحص مظهر العين الخارجية والجفون والرموش، ومراقبة كيفية فتح الجفون وإغلاقها..

العين الخارجية



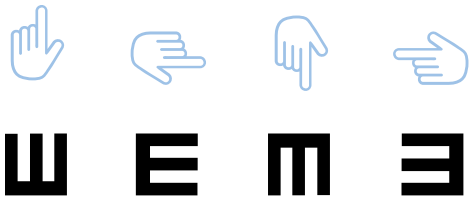
يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

في حال ملاحظة أي من التشوهات التالية في العين الخارجية: قشور أو صديد واضح على حافة الجفن، إفرازات مائية أو لزجة زائدة من العينين، انقلاب الرموش إلى الداخل، إغلاق غير طبيعي للجفن، احمرار غير طبيعي في الجزء الأبيض من العين، عتامة غير طبيعية أو احمرار في الجزء الملون من العين. ← 8

2. اختبار حدة البصر

عند إجراء اختبار حدة البصر، يجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار:

- يجب أن تكون مساحة الاختبار مضاءة جيدًا وتسمح بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار.
- وضّح كيفية إجراء اختبار E عن طريق الإشارة بأصابعك إلى الاتجاه الذي يشير إليه رمز E.



- البدئ **باختبار الرؤية البعيدة، ثم اختبار الرؤية القريبة** (مع النظارات إذا كان الشخص يرتديها عادةً).

يتوفر تطبيق WHOeyes مجانًا على الهواتف المحمولة لفحص النظر بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وعدة لغات إضافية (https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/whoeyes)

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

- كانت حدة بصر الشخص للمسافات أسوأ من 12/6 في أي من العينين؛ **أو**
- لم يتمكن الشخص من رؤية N6 باستخدام النظارات الجاهزة للقراءة. ← 8

اختبار الرؤية للمسافات

باستخدام مخطط فحص البصر التابع لمنظمة الصحة العالمية

- اختبار كل عين على حدة (الرؤية الأحادية)، بدءًا بالعين اليمنى ثم اليسرى.
- استخدام غطاء (أو اليد) لتغطية العين غير الخاضعة للاختبار.
- التأكد من أن الشخص ينظر مباشرة إلى المخطط دون تحريك أو إمالة رأسه.
- التحقق من أن المخطط يبعد 3 أمتار عن عيني الشخص.
- البدأ برموز E الكبيرة (60/6). إذا تمكن الشخص من رؤية اثنين على الأقل من رموز E الكبيرة (6/6)، الاستمرار في الاختبار باستخدام رموز E الصغيرة (12/6).
- تسجيل النتائج للعين اليمنى، ثم تكرار الخطوات للعين اليسرى.
- يكون الشخص قد اجتاز اختبار الرؤية البعيدة عندما تتمكن كل عين من رؤية ثلاثة على الأقل من رموز E الصغيرة (12/6).

اختبار الرؤية القريبة

باستخدام مخطط فحص الرؤية التابع لمنظمة الصحة العالمية

- اختبار الرؤية لكلتا العينين معًا (الرؤية الثنائية).
- يُمسك مخطط الرؤية القريبة على مسافة 40 سم من عيني الشخص.
- يكون الشخص قد اجتاز اختبار الرؤية القريبة عندما تتمكن كل عين من رؤية ثلاثة من رموز E على الأقل (N6).
- إذا كانت الرؤية القريبة أضعف من N6، يُتحقق مما إذا كان الشخص يستطيع رؤية N6 بوضوح عند استخدام نظارات القراءة الجاهزة التجريبية.

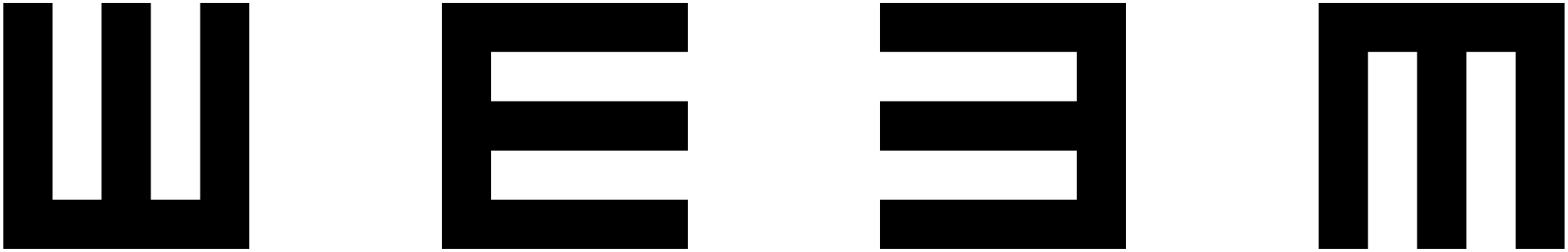
مزيد من المعلومات

- *دليل تنفيذ فحص البصر والعين*. WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/375590).
- *التدريب على نظارات القراءة*. منظمة الصحة العالمية؛ 2024 التدريب على المنتجات المساعِدة (gate-tap.org).

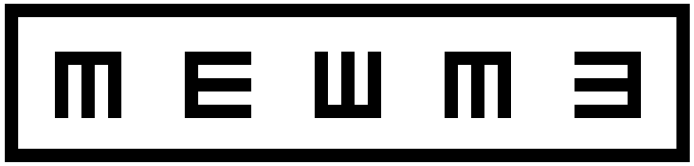
مخطط فحص الرؤية البعيدة الخاص بمنظمة الصحة العالمية

(مسافة الاختبار: 3 أمتار)

10 cm



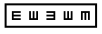
$\frac{6}{12}$



مخطط فحص الرؤية القريبة الخاص بمنظمة الصحة العالمية

(مسافة الاختبار: 40 سم)

N6



التقييم الأساسي
فقدان السمع

سؤال التصفية

"هل لديك مشكلة في السمع؟" (بالنسبة لمستخدمي مساعِدات السمع، إضافة: "حتى عند استخدام مساعِدات السمع").

إذا كانت الإجابة **"نعم"**، الانتقال مباشرة إلى الخطوة 2 – التقييم المعمَّق (قياس السمع التشخيصي). ← 9

اختبار السمع

يمكن استخدام أحد الاختبارات الثلاثة الممكنة لإجراء تقييم أساسي للسمع. تُستخدم سماعات الرأس في جميع الاختبارات، باستثناء اختبار الصوت الهامس. من المهم التأكد من أن مستوى الضوضاء في الخلفية لا يتجاوز 40 ديسيبل معدل (dBA). يمكن التحقق من ذلك من خلال الاختبار باستخدام مقياس مستوى الصوت أو عبر استخدام تطبيق هاتف ذكي موثوق (مثل NIOSH Sound Level Meter).

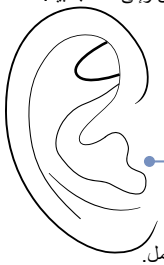
مزيد من المعلومات

فحص السمع: اعتبارات التنفيذ. WHO; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/344797).

1. اختبار الصوت الهامس

يُعد هذا الخيار الأبسط، لكنه يُستخدم فقط عند عدم توفر اختبارات أخرى. **يُفضَّل استخدام الاختبارين 2 و3 متى أمكن ذلك.**

- الوقوف على مسافة طول ذراع خلف الشخص وإلى أحد جانبيه.
- طلب تغطية الأذن غير الخاضعة للاختبار عن طريق الضغط بإصبع واحد على **الزَنَمة** (الغضروف الصغير المدبب أمام قناة الأذن). توضيح كيفية القيام بذلك.



- أخذ نفس عميق ثم الزفير مخرجًا الهواء بالكامل.
- يُهمس بأربع كلمات شائعة غير مترابطة (يجب أن تكون الكلمات مألوفة، مثل: أرز، سمكة، دراجة، حديقة، أصفر، سماء، كلب). تُنطق الكلمات واحدة تلو الأخرى، وانتظار تكرار الشخص كل كلمة في كل مرة.

  إذا كرَّر الشخص ثلاث كلمات أو أكثر والتأكد أنه يمكنه سماعك بوضوح، فإن الشخص على الأرجح لديه سمع طبيعي في هذه الأذن.
- الانتقال إلى الجانب الآخر للشخص واختبار الأذن الأخرى باستخدام كلمات مختلفة.

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

فشل الشخص في تكرار ثلاث أو أكثر من الأربع كلمات. ← 9

2. قياس السمع الفحصي

كشف النغمات النقية في كلا الأذنين (كل أذن على حدة) عند مستوى ديسيبل ثابت (35 ديسيبل HL \[ديسيبل مستوى السمع])، عند ثلاثة ترددات (1 كيلو هرتز، و2 كيلو هرتز، و4 كيلو هرتز). يتم تسجيل النتائج على أنها "اجتياز" (تم اجتياز الاختبار) أو "رسوب" (هناك حاجة إلى إجراء تقييم إضافي).

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

فشل الشخص في الاستجابة عند مستوى 35 ديسيبل (dBHL) في تردد واحد أو أكثر في أي من الأذنين. ← 9

3. اختبار الأرقام الثلاثية في الضوضاء

يتم اختبار كلتا الأذنين معًا باستخدام الاختبار المؤتمت للأرقام في الضجيج لتحديد مدى قدرة الشخص على التعرف على الأرقام رغم الضوضاء الموجودة في الخلفية.

- يستمع الشخص إلى مجموعات من ثلاثة أرقام (مثل 4–7–3) مع ضوضاء في الخلفية.
- تُنطق الأرقام واحدًا تلو الآخر.
- يجب على الشخص تكرار الأرقام التي يسمعها.
- يتم تسجيل النتيجة إما كـ "اجتياز" (التعرف بشكل صحيح على 50% على الأقل من مجموعات الأرقام الثلاثية) أو "رسوب" (درجة منخفضة).

يتوفر تطبيق **hearWHO** مجانًا على الهواتف المحمولة باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والروسية والهولندية والفرنسية (https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/hearwho)

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

فشل الشخص في الاستجابة عند مستوى 35 ديسيبل (dBHL) (يتم تقديمه كنتيجة منخفضة، على سبيل المثال، إذا كانت نتيجة تطبيق hearWHO أقل من 50). ← 9

التقييم الأساسي

أعراض الاكتئاب

طرح السؤالين التاليين:

"هل تأثَّرت خلال الأسبوعين الماضيين بأي من الأمور التالية:

- الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو فقدان الأمل؟
- قلة الاهتمام أو الاستمتاع بالقيام بالأشياء؟"

يلزم إجراء التقييم المُعمَّق إذا:

أجاب الشخص بـ **"نعم"** على أحد السؤالين. ← 10

بعد التقييم الأساسي لفقدان القدرة الذاتية

يتم شرح النتائج وأهمية إعادة التقييم المنتظم.

لجميع المسنين:

- يتم تحديد احتياجات الدعم وتقديمه. ← **3.1.2**
- يتم تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة. ← **3.1.3**
- عند الإمكان، يتم قياس ضغط الدم للكشف عن ارتفاع ضغط الدم وتمكين تدبير عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية والإحالة عند الضرورة. ← **3.1.4**

بالنسبة للمسن الذي تم التعرف على أنه يعاني من فقدان محتمل في القدرة الذاتية:

- تتم إحالته إلى الرعاية الأولية لإجراء تقييم معمَّق (**الخطوة 2**) إذا لم يتم التعامل مع الفقدان بالفعل.
- يتم توفير الرعاية الصحية المجتمعية في حالة فقدان القدرة الذاتية عند الاقتضاء.

3.1.2
العوامل الرئيسية المؤثرة على صحة المسنين

بعد إجراء التقييم الأساسي لفقدان القدرة الذاتية يمكن استخدام عنصر ثانٍ من التقييم الأساسي لتحديد العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على صحة المسنين، بما في ذلك احتياجات الدعم الاجتماعي، ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، والسَّلَس البولي. ويُعامل السَّلَس البولي بشكل منفصل عن مجالات القدرة الذاتية لأنه مرض (متلازمة الشيخوخة)، وليس جزءًا من القدرة الذاتية، ولكنه يؤثر ويتأثر بفقدان القدرة الذاتية.

الدعم الاجتماعي ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين: إن فهم احتياجات المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين من الدعم الاجتماعي لتمكين إدراج التدخلات المناسبة ضمن خطة رعاية مُشخصنة وتنفيذ هذه التدخلات، أمر بالغ الأهمية في تقديم الرعاية المتكاملة. واعترافًا بأهمية هذه القضايا وإمكانية عدم إعطائها الأولوية، يسلط هذا الدليل الضوء مبكرًا على الدعم الاجتماعي ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، من خلال إدراج أسئلة حول هذه المواضيع في وقت مبكر ضمن مسار الرعاية المتكاملة للمسنين.

يُعدّ التعامل مع المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والترابط الاجتماعي، والسكن، أمرًا أساسيًا لتحسين النتائج الصحية للمسنين وتعزيز قدرتهم على الأداء. ويُوصى بسؤال جميع المسنين عن احتياجاتهم من الدعم الاجتماعي، بغض النظر عن قدرتهم الأساسية. يمكن طرح هذه الأسئلة من قِبل الشخص الذي أجرى التقييم الأساسي، إما مباشرة بعد تقييم أساسي سلبي لمسار الرعاية المتكاملة للمسنين (بمعنى أنه لم يتم تحديد فقدان القدرة الوظيفية) أو في الحالات التي تم فيها تحديد فقدان القدرة الوظيفية ولكن مع انعدام إمكانية إجراء تقييم معمَّق (فوري). بدلًا من ذلك، يمكن أيضًا طرح هذه الأسئلة أثناء التقييم المعمَّق في منشأة الرعاية الأولية، كجزء من تقييم أوسع للبيئات الاجتماعية والمادية.

نظرًا للتنوع الاجتماعي والثقافي، ينبغي تعديل صياغة الأسئلة حول الدعم الاجتماعي ودعم مقدمي الرعاية غير المأجورين الواردة في الجدول 3.2 (الصفحة 27)، لضمان ملاءمتها وسياقها المناسب عند طرحها. ومن المهم التأكد من أن أي تعديل أو تكييف لهذه الأسئلة لا يؤدي إلى استخدام لغة تمييزية، بما في ذلك المصطلحات التي تنطوي على تحيز ضد المسنين.

إن تقديم الرعاية، لا سيما لشخص مسن يعاني من فقدان كبير في القدرة الذاتية، يمكن أن يكون مُرهقًا بدنيًا ونفسيًا، وقد يؤثر على صحة ورفاه مقدم الرعاية غير المأجور نفسه. ومن المهم تحديد احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين أثناء التقييم الأساسي أو التقييم المعمَّق حسب الاقتضاء، وضمان إدراج دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين في وضع وتنفيذ خطة رعاية مُشخصنة. يتضمن الجدول 3.2 (الصفحة 27) أسئلة ينبغي طرحها على مقدمي الرعاية غير المأجورين. ← 11 12

السَّلَس البولي: يُعد السَّلَس البولي حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص المسنين، خاصة النساء منهم *(11)* مما يؤثر على جودة حياتهم ورفاهيتهم *(12)*. ونظرًا لارتفاع معدلات عدم الإبلاغ عن السَّلَس البولي، والذي يُعزى على الأرجح إلى الوصمة الاجتماعية التي يشعر بها المصابون، وما يترتب على ذلك من نقص في إمكانية الحصول على الرعاية، يُوصى بطرح أسئلة حول السَّلَس البولي على المسنين أثناء التقييم الأساسي في المجتمع أو أثناء التقييم المعمَّق في مرافق الرعاية الأولية عند تقييم مجالات القدرة الذاتية ذات الصلة (مثل التدهور المعرفي، وفقدان القدرة على الحركة، وأعراض الاكتئاب). ومن المسلَّم به أن هناك تحديات محتملة عند إجراء مناقشات حساسة مع المسنين في البيئات المختلفة التي يُجرى فيها التقييم الأساسي لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين. ← 13

الجدول 3.2

التقييم الأساسي للعوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة المسنين

	الأسئلة/ التقييمات	يجب النظر في إجراء تقييم إضافي/ طرح أسئلة تكميلية	إعادة السؤال بانتظام
11 **الدعم والرعاية الإجتماعيين**	**البيئة المنزلية** هل لديك مشاكل في منزلك، مثل حالة المنزل، الموقع، أو السلامة؟	○ نعم	○ لا
	الوضع المالي هل غالبًا ما تجد صعوبة في دفع تكاليف الطعام، والإسكان، والرعاية الصحية؟	○ نعم	○ لا
	العزلة الاجتماعية والوحدة هل غالبًا ما تشعر بالوحدة؟	○ نعم	○ لا
	الانخراط والمشاركة في المجتمع هل تواجه صعوبة في ممارسة الأنشطة الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي تهمك؟	○ نعم	○ لا
12 **دعم مقدمي الرعاية** (سؤال مقدم الرعاية غير المأجور على انفراد)	هل تشعر أنك تحصل على الدعم الذي تحتاجه في دورك كمقدم رعاية؟	○ لا	○ نعم
	هل تشعر بالثقة في قدرتك على تقديم الرعاية والدعم؟	○ لا	○ نعم
	تقييم ما إذا كان هناك تأثير سلبي لدور مقدم الرعاية (بدنيًا، نفسيًا، ماليًا، اجتماعيًا).	○ نعم	○ لا
13 **السَّلَس البولي**	تقييم ما إذا كان هناك تأثير سلبي لدور مقدم الرعاية (بدنيًا، نفسيًا، ماليًا، اجتماعيًا).	○ نعم	○ لا

ملاحظة: يمكن تعديل صياغة أسئلة الدعم الاجتماعي، المعروضة كأمثلة، لضمان أن تكون الأسئلة ذات صلة ومناسبة للسياق المحلي.

التدخلات على مستوى المجتمع

يجب إحالة المسنين الذين يُكتشف أن لديهم ضعفًا محتملاً في القدرة الذاتية من خلال التقييم الأساسي إلى إجراء تقييم معمَّق في مرفق الرعاية الصحية الأولية (**الخطوة الثانية**) كلما أمكن ذلك. ويمكن للعامل الصحي المجتمعي أو أي من أصحاب المصلحة المدربين الذين أجروا التقييم الأساسي تسهيل الوصول إلى الخدمات لإجراء هذا التقييم الإضافي. وينبغي تشجيع المسنين على إجراء تقييمات أساسية منتظمة (على سبيل المثال، مرة واحدة على الأقل سنويًا)، باستثناء فحص البصر والسمع (على سبيل المثال، مرة كل سنة أو سنتين)، أو بعد حدوث أزمة صحية حادة أو مرض شديد، أو إذا تغير دورهم الاجتماعي أو وضعهم (مثل تغيير مكان الإقامة، أو وفاة الشريك). **يسمح التقييم الأساسي الدوري بالكشف المبكر عن تدهور القدرة الذاتية ويدعم التدخل العلاجي في الوقت المناسب.** كما ينبغي تشجيع المسنين على تحديد أهدافهم الخاصة للحفاظ على صحتهم.

بالإضافة إلى هذه الإحالة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المعنية، يمكن تقديم تدخلات أخرى على مستوى المجتمع المحلي أثناء التواصل مع المسن لإجراء التقييم الأساسي، مما يضمن تقديم أفضل نصائح ودعم ممكن في هذه المرحلة الأولى من الاتصال.

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع المدربين تقديم أنواع مختلفة من الدعم والرعاية المصممة حسب احتياجات المسنين، مثل تعزيز الصحة من خلال تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، والتحري عن عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم، وتوفير الرعاية الصحية المجتمعية التي تعالج فقدان القدرة الذاتية في مجالات محددة والعوامل الأخرى المؤثرة على صحة المسنين.

3.1.3
تعزيز أنماط الحياة الصحية

يمكن لجميع المسنين الاستفادة من نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، بغض النظر عن مستوى قدرتهم الأساسية، إذا كانوا قادرين على فهم هذه النصائح وتطبيقها لتغيير سلوكهم. ينبغي تقديم نصائح إلى جانب المعلومات لتعزيز الرعاية الذاتية وتوضيح متى وأين يجب طلب الرعاية الصحية. كما يجب سؤال المسنين عن أي أمراض أو حالات صحية موجودة لديهم، ودعمهم في الإدارة الذاتية لحالتهم الصحية.

من المهم ملاحظة أن الأشخاص يتعلمون ويستجيبون للمعلومات بطرق متنوعة. عادةً ما يحدث التعلُّم عبر ستة مسارات رئيسية: المحادثات المجتمعية، والفنون، والمواد المطبوعة، ووسائل الإعلام التقليدية، والوسائط الرقمية، والتواصل والتفاعل مع العاملين الصحيين *(13)*. لذلك، ينبغي على العاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع مراعاة الأساليب المختلفة لتقديم المعلومات ونصائح للمسنين. قد يشمل ذلك المحادثات الفردية، والمناقشات الجماعية، وحملات التوعية باستخدام مواد إعلامية متنوعة. كما يمكن إشراك المجموعات المجتمعية، مثل نوادي المسنين، لتنظيم فعاليات للمسنين، مثل المناقشات بين الأقران والعروض المسرحية المحلية التي تتضمن رسائل صحية وأنماط حياة صحية.

تشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، مَن يجب إشراكه وما المعلومات التي يجب تقديمها. نادرًا ما يتخذ الأفراد قراراتهم الصحية وسلوكياتهم المرتبطة بها بشكل منفصل، حيث يتأثرون غالبًا بأفراد الأسرة والمجتمع والقادة الدينيين. في بعض الحالات، يتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي. لذلك من المهم الوصول إلى مجموعة أوسع داخل مجتمع المسن. كما أن تقديم نصائح يكون أكثر فاعلية إذا كان مصحوبًا بمعلومات حول كيفية تنفيذها. على سبيل المثال، تقديم معلومات عن مكونات النظام الغذائي الصحي، إلى جانب نصائح حول أماكن شراء الأطعمة الصحية وكيفية تحضيرها.

يجب أن تشمل نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة المقدمة للمسنين في إطار **الخطوة الأولى** من مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية كلًّا من المعلومات العامة لدعم الصحة والرفاه، والإجراءات الأكثر تحديدًا المتعلقة بمجالات القدرة الذاتية. وينبغي، حيثما أمكن، أن تكون هذه نصائح موجهة ومُكيّفة لتتناسب مع احتياجات المسن الفردية وظروفه الخاصة.

نصائح بشأن نمط الحياة الصحي للمسنين

1. ممارسة النشاط البدني بانتظام ← 6.1

- كل نشاط بدني مفيد، وكل حركة لها قيمة.
- من الأفضل البدء بمستوى منخفض وزيادته بشكل تدريجي.
- تتوفر خيارات متنوعة تشمل المشي وركوب الدراجات والأعمال المنزلية والبستنة والرقص والرياضة، مع التركيز على الأنشطة التي يستمتع بها المسن.
- من المهم تجنب الأنشطة الخاملة.
- يمكن أن تتغير التصورات حول النشاط البدني نحو القبول الإيجابي والمشاركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والمواقف تجاه مشاركة النساء.

2. اتباع نظام غذائي صحي ← 7.1

- يجب على المسنين تناول كميات كافية من البروتين.
- يمكن أن يكون تناول الطعام نشاطًا اجتماعيًا عند تناول الطعام مع الآخرين.
- يُوصى بتقديم توصيات حول الأطعمة الصحية المتوفرة محليًا وبأسعار معقولة وشرح مكان الحصول عليها.
- يُنصح بتناول المسنين ما لا يقل عن 400 غرام (خمس حصص) من الخضروات والفواكه يوميًا وأقل من 5 غرامات أو ملعقة صغيرة من الملح.
- تُعد الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبقوليات (كمصادر للكربوهيدرات)، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والزيتون، والأسماك (كمصادر للدهون الصحية) من العناصر الغذائية المهمة.
- لا بأس من تناول وجبات صغيرة ومتكررة إذا كان من الصعب تناول وجبات كبيرة.
- يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في الوقاية من الإمساك.

3. الترطيب ← 7.1

- يُوصى بشرب ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب (1.6 إلى 2.0 لتر) يوميًا، ما لم تكن هناك قيود طبية، وزيادة الكمية عندما يكون الطقس حارا.
- تقليل تناول الكافيين، خاصة في حالة السَّلَس البولي.

4. صحة الفم والأسنان ← 7.1

- تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (1000-1500 جزء في المليون).

5. التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية ← 11.1

- قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.
- المشاركة الاجتماعية والتفاعل مع المجتمع بطرق ممتعة وذات مغزى.

6. الوقاية من الأمراض وإدارتها وعوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية ← 3.1.4

- الالتزام بالعلاج، بما في ذلك تناول الأدوية للسيطرة على الأمراض.
- تجنب استخدام الأدوية والمكملات الغذائية دون وصفة طبية أو استشارة العاملين الصحيين.
- إدارة الوزن للوقاية من السمنة، بما في ذلك تقليل تناول الدهون والسكريات الحرة.
- ضمان اتباع ممارسات النظافة والصرف الصحي الجيدة مثل شرب المياه الآمنة، ونظافة الغذاء، وغسل اليدين.

تابع ... ←

- تجنب أو تقليل تناول الكحول والموادذات التأثير النفساني:
  – الاستخدام الضار للكحول يؤثر على الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية والنفسية والمعرفية
  – اطلب الدعم لتجنب استهلاك الكحول.
- الإقلاع عن تعاطي التبغ:
  – تشجيع غير المدخنين على عدم البدء في التدخين.
  – تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتعاطي التبغ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والخرف، والأمراض القلبية الوعائية، وأمراض الفم، والسَّلَس البولي.
  – توفير معلومات حول أماكن الحصول على الدعم للإقلاع عن تعاطي التبغ.
- التوعية بعوامل خطر ضعف البصر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

7. التطعيم

- الحصول على التطعيمات الروتينية وفقًا للوائح اللقاحات المحلية *(14)*.
- من المهم الاحتفاظ بسجل التطعيمات التي تم أخذها.

8. تعزيز الصحة النفسية ← 10.1

- التقليل من التوتر عند الحاجة.
- أخذ فترات راحة منتظمة من تقديم الرعاية خاصةً لمقدمي الرعاية غير المأجورين.
- القيام بالأنشطة التي يستمتع بها الفرد (أو كان يستمتع بها سابقًا).

9. النوم الجيد المنتظم

- الحفاظ على روتين نوم صحي، بما في ذلك الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في وقت ثابت.
- الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يوميًا.

10. تحسين صحة الدماغ ← 5.1

- ممارسة الأنشطة التي تحفز القدرات المعرفية بانتظام، مثل القراءة، ولعب الألعاب، وتعلم شيء جديد، وعزف الموسيقى.

11. تعزيز صحة العين والإبصار ← 8.1

- إجراء فحوص منتظمة للعيون والبصر.
- اتباع نصائح بشأن كيفية ومتى يجب استخدام النظارات الطبية.
- الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية بارتداء النظارات الشمسية والقبعات.
- أخذ فترات راحة منتظمة عند القيام بأنشطة تتطلب التطلُّع عن قُرب (استخدام الوسائط الإلكترونية، والقراءة، والخياطة).

12. تعزيز صحة الأذن والسمع ← 9.1

- إجراء فحوص منتظمة للسمع.
- طلب نصائح إذا كان هناك شك في فقدان السمع.
- تنظيف **الجزء الخارجي** من الأذن باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- اتباع نصائح الخاصة بكيفية استخدام مساعِدات السمع.
- عدم إدخال أي أشياء **داخل** الأذن.
- تجنب السباحة أو الاستحمام في المياه الملوثة.
- تجنب الاستماع إلى الأصوات أو الموسيقى العالية، واستخدام سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة المتعلقة بمجالات القدرة الذاتية في الفصول ذات الصلة من هذا الدليل.

مزيد من المعلومات

المواضيع الصحية لمنظمة الصحة العالمية: الكحول، التبغ. WHO; 2024 (https://www.who.int/health-topics/alcohol; https://www.who.int/health-topics/tobacco)

3.1.4
التحري عن عوامل الخطر للأمراض القلبية الوعائية والوقاية منها

الأمراض القلبية الوعائية هي مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي وأمراض الأوعية الدموية الدماغية (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية). في عام 2021، كانت الأمراض القلبية الوعائية السبب الرئيسي للوفاة عالميًا *(15)*، مع ارتفاع نسبة انتشارها بين المسنين *(16)*. تشمل عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية عوامل سلوكية مثل استخدام التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والإفراط في تناول الكحول، والنشاط البدني غير الكافي؛ وعوامل أيضية مثل ارتفاع ضغط الدم (فرط الضغط)، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم (السكري).

نظرًا للانتشار الكبير للأمراض القلبية الوعائية بين المسنين، وارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم غير المشخص *(17)* في بعض السياقات، توفر الخطوة الأولى من مسار الرعاية المتكاملة للمسنين فرصةً هامة لزيادة الوعي بين المسنين، وفي حال كان ذلك ممكنًا، التعرف على عوامل الخطر (المربع 3.1). ويمكن للعاملين الصحيين تقديم نصائح والإرشادات بشكل فردي للمسنين الذين تبيَّن أنهم يعانون من عوامل الخطر السلوكية، بهدف تشجيع تغيير سلوكهم. يتضمن الإرشاد بشأن أنماط الحياة الصحية فيما يخص الأمراض القلبية الوعائية توجيه ودعم المسنين لإجراء تغييرات في بعض السلوكيات لتقليل خطر الإصابة بها، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل السكري، وأمراض الرئة، والسرطان، وكذلك التدهور في القدرة الذاتية مثل التدهور المعرفي وضعف البصر.

ويمكن إجراء تدخل إرشادي موجز بين العامل الصحي المجتمعي والمسن (ومقدمي الرعاية غير المأجورين، حيثما كان ذلك مناسبًا) خلال التقييم الأساسي، الذي من شأنه تحديد المشاكل المحتملة، وتوفير المعلومات، وتحفيز المسن ومساعدته على تغيير سلوكه. ويمكن استخدام الأداة As5 (السؤال، نصائح، والتقييم، المساعدة، والترتيب) لتحديد عوامل الخطر ودعم تغيير السلوك.

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين أن يفكروا في طرح الأسئلة التالية، أو أسئلة مماثلة:

- **هل دخَّنت أو استخدمت أي منتج تبغ آخر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية؟**
- **كم حصةً من الفواكه والخضروات تتناول يوميًا؟**
- **هل تستهلك الكحول بأي شكل من الأشكال؟**
- **خلال الأسبوع الماضي، كم عدد الأيام التي مارست فيها نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة أو أكثر؟ على سبيل المثال: المشي، ركوب الدراجة، التنظيف، البستنة، صعود الدرج، الرقص أو ممارسة التمارين الرياضية؟**

المربع 3.1 تحري ارتفاع ضغط الدم

إلى جانب تقديم المعلومات والدعم لتغيير السلوك، قد يتمكن العاملون الصحيون المجتمعيون من إجراء فحص للكشف عن ارتفاع ضغط الدم. ويمكن قياس ضغط الدم في المجتمع، شريطة أن يمتلك العاملون الصحيون المجتمعيون أو أصحاب المصلحة الآخرون التدريب والمعدات المناسبة، وأن يكونوا قادرين على إحالة الشخص إلى الرعاية الأولية لإجراء تقييم وعلاج إضافي. **إجراء تحرّي ارتفاع ضغط الدم في حال عدم توفر مسارات الإحالة وعدم إمكانية الوصول إلى العلاج يُعدّ ممارسة غير أخلاقية.**

إن قياس ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لتشخيص ارتفاع ضغط الدم، حيث إن معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا تظهر عليهم أعراض. لقياس ضغط الدم بشكل دقيق:

- يُستخدم حجم الكُم المناسب.
- يُطلب من الشخص الجلوس بحيث يكون ظهره مدعومًا وساقاه غير متقاطعتين، بعد إفراغ المثانة، والاسترخاء لمدة 5 دقائق دون تحدُّث.
- تُسجل قراءتين على الأقل واستخدم القراءة الثانية.

يُشخَّص ارتفاع ضغط الدم عمومًا خلال زيارتين منفصلتين في أيام مختلفة، إذا كانت قراءات ضغط الدم الانقباضي ≤ 140 مم زئبقي و/أو قراءات ضغط الدم الانبساطي ≤ 90 مم زئبقي. في حال تشخيص ارتفاع ضغط الدم، يجب إحالة الشخص إلى الرعاية الأولية لمزيد من التقييم والعلاج، بما في ذلك تقييم وعلاج عوامل الخطر الأيضية الأخرى، مثل السكري وارتفاع الكوليسترول. يجب تزويد الشخص بمعلومات حول المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وأهمية حضورهم لإجراء مزيد من التقييم.

مزيد من المعلومات

HEARTS: الحزمة التقنية لتدبير الأمراض القلبية الوعائية في الرعاية الصحية الأولية: نصائح حول نمط الحياة الصحي. WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/260422).

3.1.5
الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة فقدان القدرة الذاتية

عندما يكشف التقييم الأساسي للرعاية المتكاملة للمسنين عن فقدان محتمل في القدرة الوظيفية الأساسية، يمكن توفير الرعاية الصحية المجتمعية من قبل العاملين الصحيين المجتمعيين بدعم من أصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع، وبالشراكة مع العاملين الصحيين في المرافق الصحية، في بعض السياقات. تعتبر هذه التدخلات مهمة في البيئات التي قد يتعذَّر فيها إجراء تقييم معمَّق في مرفق الرعاية الأولية، أو عندما يستغرق تنظيم التقييم الكامل أو الوصول إليه وقتًا، أو عندما يُرجَّح أن يختار المسن عدم الحضور. وتشمل التدخلات الممكن تنفيذها عبر السياقات المختلفة ومستويات الموارد (انظر الفصل ذو الصلة للمزيد من التفاصيل):

- التحفيز المعرفي، والتمارين البدنية، وتقديم نصائح لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية غير المأجورين بشأن التدهور المعرفي. ← **5.2**
- تصميم برامج تمارين بدنية للأشخاص الذين يعانون من قدرة محدودة على الحركة مع مراعاة اعتبارات السلامة. ← **6.2**
- توفير نظام غذائي متوازن غني بالبروتين للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. ← **7.2**
- توفير نظارات القراءة وإجراء تحرٍّ عن ارتفاع ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من خلل بصري. ← **8.2**
- تقديم نصائح المتعلقة بالتواصل لمن يعانون من فقدان السمع. ← **9.2**
- تدبير التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب والألم. ← **10.2**, **6.5.2**
- تقديم نصائح والمعلومات حول الخدمات والأنشطة المجتمعية المتاحة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والدعم. ← **11.1**
- تقديم نصائح والمعلومات حول الخدمات المجتمعية المتاحة لدعم مقدمي الرعاية غير المأجورين. ← **12.2**
- تدريب المثانة لتدبير السَّلَس البولي. ← **13.2**

إذا كان هناك شك بشأن إمكانية تنفيذ التدخل بأمان أو حول كيفية تطبيقه، يجب إحالة الحالة إلى عامل رعاية صحية مختص.



3.2 إجراء تقييم معمَّق في مرفق الرعاية الأولية

يُعد إجراء تقييم معمَّق لاحتياجات الرعاية الصحية والاجتماعية في مرفق الرعاية الأولية أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الخدمات والدعم المناسبين. وهو بمثابة خطوة أولية لفهم أفضل لحياة المسن من خلال أخذ السجل الطبي، بما في ذلك الأدوية الحالية، والسؤال عن قِيَمه وأولوياته في حياته بما يشمل الصحة وإدارتها، وسياقه الاجتماعي، وتحديد أفراد الأسرة الرئيسيين، والأقارب الآخرين والأصدقاء.

إذا تم التعرُّف خلال هذا التقييم على مسن آخر، مثل الزوج أو الزوجة ضمن العائلة، فيجب أيضًا النظر في احتياجه إلى الرعاية المتكاملة وإجراء تقييم أساسي في إطار نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، حسب الاقتضاء.

قد يتطلب التقييم المعمَّق وجود عامل صحي مختص مثل ممرض أو طبيب، لإجراء زيارات أو مواعيد محددة. ويتضمن التقييم المعمَّق ثلاثة عناصر رئيسية: التحقُّق من تدهور القدرة الوظيفية الأساسية، وتقييم الأمراض المستبطنة وعوامل الخطر، وإجراء تقييم للبيئة الاجتماعية والمادية للشخص. ويمكن تنفيذ هذه العناصر الثلاثة بأي ترتيب (ما لم يُذكر خلاف ذلك). وبناءً على نتائج العناصر الثلاثة، يجب تحديد التدخلات المحتملة. يوفر كل مسار رعاية معلومات حول الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إجراء التقييم وتنفيذ التدخلات، مما يُسهم في وضع خطة رعاية مُشخصنة موحدة.

3.2.1 تقييم فقدان القدرة الذاتية

يجب تأكيد التدهور المحتمل في القدرة الذاتية باستخدام الأدوات أو الاختبارات المتاحة والمعتمدة محليًا. تم تقديم أمثلة على الأدوات والاختبارات في كل مسار رعاية (الفصول 5-10).

3.2.2 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر

مع تقدم الناس في السن، تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض مثل الأمراض القلبية الوعائية، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والسرطان، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والتهاب المفاصل التنكسي، وهشاشة العظام، والمياه البيضاء، والخرف، بالإضافة إلى المراضات المشتركة (تعايش حالتين أو أكثر من الحالات المزمنة).

في حين أن بعض عوامل الخطر، مثل التهاب المفاصل، قد تكون مصحوبة بأعراض، فإن عوامل أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، قد لا تُظهر أي أعراض لسنوات. لذا، فإن الكشف المبكر عنها في الرعاية الأولية يعد أمرًا بالغ الأهمية. تقدم منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات للكشف المبكر وتدبير الأمراض غير السارية، بما في ذلك إدارة الأمراض القلبية الوعائية والخرف بناءً على مستوى المخاطر. يجب إجراء قياسات ضغط الدم لجميع البالغين خلال الزيارات الروتينية إلى مرافق الرعاية الأولية، بما في ذلك عند الزيارة الأولى، وإذا كانت النتائج طبيعية، يتم القياس بشكل دوري بعد ذلك. ويجب متابعة الشخص الذي تظهر لديه قراءات ضغط دم مرتفعة على الفور وفقًا للبروتوكول المعتمد. وبالنسبة للكشف عن داء السكري، يُوصى بإجراء فحص للأفراد الذين يعانون من أعراض باستخدام قياس مستوى الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام (FPG) أو قياس مستوى الجلوكوز في البلازما بشكل عشوائي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي فحص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق والذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكبر من 25 باستخدام قياس مستوى الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام.

كما يميل جهاز المناعة إلى الضعف مع التقدم في العمر، مما يزيد من خطر إصابة المسنين ببعض الأمراض المُعدية. لذلك، يجب مراقبة الحالة التطعيمية لدى المسنين للوقاية من الأمراض التي يمكن تفاديها بالتطعيم.

وقد تتطلب بعض التشخيصات، بما في ذلك المراضات المشتركة أو تعدد الأدوية (←4.2.4) اختبارات تشخيصية محددة، ومعدات، ومهارات متخصصة قد لا تتوفر دائمًا في الرعاية الأولية. وبناءً على السياق، قد يكون من الضروري إحالة المريض إلى خدمات متخصصة على المستوى الثانوي أو الثالثي.

3.2.3
تقييم البيئات الاجتماعية والمادية

يتطلب إجراء تقييم معمَّق للبيئات الاجتماعية والبدنية (المبنية) في المنزل، وفي المجتمع، والمجتمع الأوسع، بالإضافة إلى تحديد أي احتياجات للرعاية والدعم الاجتماعيين.

وتشمل البيئات الاجتماعية ظروف المعيشة، والاستقرار المالي، والعلاقات الاجتماعية (الوحدة)، والوصول إلى الأنشطة المجتمعية والخدمات العامة، والحرية من إساءة المعاملة وغيرها من العوامل. عند تحديد احتياجات الدعم، ينبغي توفير الخدمات لتمكين المسنين من القيام بالأنشطة التي تهمهم. وقد يحتاج المسن إلى الدعم الاجتماعي بغض النظر عن مستوى قدرته الأساسية.

يمكن للعاملين الصحيين المدربين تقييم حاجة المسن إلى المنتجات المساعِدة التي تُستخدم على الجسم أو منه مباشرة مثل مساعِدات السمع، وعصي المشي، والكراسي المتحركة. ← **4.2.2** تقييم البيئة المادية في المنزل ومحيطه، والذي يتم من خلال طرح الأسئلة على المسن أو عبر الزيارات المنزلية، حيثما أمكن، مما يساعد في تحديد التعديلات البيئية الضرورية، مثل تحديد الحاجة إلى المنتجات المساعِدة، وخطر التعرض للسقوط، وكيفية جعل البيئة أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليها. ← **4.2.5**

إذا كان المسن يعاني من فقدان كبير في القدرة الذاتية، فقد يحتاج إلى الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل الرعاية الشخصية والمساعدة في الأنشطة اليومية. يمكن تحديد احتياجات الرعاية الاجتماعية من خلال سؤال المسن عما إذا كان يستطيع أداء مختلف المهام اليومية دون مساعدة الآخرين، وينبغي النظر في الاحتياجات والتفضيلات للرعاية في المنزل، وفي المجتمع، وفي المؤسسات، وكذلك من يمكنه تقديم تلك الرعاية. ويمكن أن يساهم ذلك في تحديد الاحتياجات المحددة لخدمات الرعاية طويلة الأجل (حيثما كانت متوفرة) وإدراجها في خطة رعاية مُشخصنة.

يقدم المسار في الفصل 11 مجموعة من الأسئلة لتقييم ومعالجة احتياجات الرعاية والدعم الاجتماعي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يشير كل مسار رعاية إلى الاحتياجات المحتملة للرعاية والدعم الاجتماعيين للقدرة الذاتية والظروف المرتبطة بها. ← 11

كما أنه من المهم النظر في الاحتياجات المحتملة للرعاية والدعم لعائلة المسن وغيرهم من مقدمي الرعاية غير المأجورين المشاركين في رعاية ودعم المسن. قد يشعر مقدمو الرعاية من العائلة، وخاصة أولئك الذين يعيشون مع الشخص الذي يعتنون به، بوجود مطالب دائمة. ومن غير المرجح أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا، كما قد لا يكون لديهم أي دعم متاح. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإرهاق، الذي يؤثر على الصحة النفسية والبدنية لمقدم الرعاية وعلى جودة الرعاية التي يمكنه تقديمها. يجب أخذ حاجتهم إلى الرعاية المؤقتة في الاعتبار.

يقدم المسار في الفصل 12 مجموعة من الأسئلة لتقييم وإدارة احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين. بالإضافة إلى ذلك، يشير كل مسار رعاية إلى الدعم المحدد الذي قد يحتاجه مقدمو الرعاية غير المأجورين فيما يتعلق بمجالات القدرة الذاتية والظروف المرتبطة بها. ← 12

مزيد من المعلومات

- *مبادئ توجيهية للعلاج الدوائي لارتفاع ضغط الدم لدى البالغين*. WHO; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/344424).
- ***HEARTS**: الحزمة التقنية لتدبير الأمراض القلبية الوعائية في الرعاية الصحية الأولية: بروتوكولات العلاج المستندة إلى الأدلة*. WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/260421).
- ***HEARTS**: الحزمة التقنية لإدارة الأمراض القلبية الوعائية في الرعاية الصحية الأولية: تدبير الأمراض القلبية الوعائية استنادا إلى مستوى الخطر*. WHO; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/333221).
- *حزمة منظمة الصحة العالمية للتدخلات الأساسية للأمراض غير السارية في الرعاية الأولية* ***(PEN)*** WHO; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/334186).
- *دليل منظمة الصحة العالمية الإرشادي العلاجي السريري للإقلاع عن التبغ لدى البالغين*. WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/377825).



3.3 وضع خطة رعاية مُشخصنة

يُعد التخطيط للرعاية الشخصية نهجًا إنسانيًا يبتعد عن الأساليب التقليدية الموجهة نحو الأمراض، ويركز بدلًا من ذلك على احتياجات المسنين وقيمهم وتفضيلاتهم. وتهتم هذه العملية بمهارات الفرد ونقاط قوته، وتجربته، والأشياء التي تهمه أكثر، وسياقه الاجتماعي. وتوجه خطة الرعاية المشخصنة جميع جوانب الصحة والرعاية والدعم الاجتماعيين، وهي أساسية لضمان دمج هذه الخدمات وكيفية وصول المسنين إليها. يجب تجميع نتائج التقييم المعمَّق عبر مجالات القدرة الذاتية وأي تدخلات محتملة تم تحديدها، كما هو موضح في الفصول 5–13، في خطة رعاية مُشخصنة موحدة، مع مراعاة النقاط التالية:

- يجب الاتفاق على التدخلات بناءً على أهداف المسنين، وفقدان القدرة الذاتية، والأمراض وعوامل الخطر، والفرص لتعزيز بيئة تمكينية.
- وينبغي أن تتضمن خطة الرعاية المشخصنة التدخلات المقدمة ضمن الرعاية الأولية، مع الإحالة إلى الرعاية التخصصية عند الحاجة. كما ينبغي أن تشمل الخدمات الاجتماعية، وأن تُكيَّف وفقًا للبيئات التي ستُقدَّم فيها (المنزل أو المجتمع أو المؤسسة) حسب الاقتضاء.
- إن المتابعة المنتظمة والمستمرة مع إعادة التقييم ضرورية لتقديم الرعاية المتكاملة بشكل فعال.
- كما ينبغي تضمين الخدمات المجتمعية، والتي يمكن أن يقدمها أصحاب المصلحة في المجتمع.

3.3.1 تحديد وتعيين الأهداف المتمركزة على الشخص

يجب أن تنطلق خطة الرعاية الشخصية من أهداف المسن نفسه، والتي يتم تحديدها من خلال مناقشة مع عامل صحي، ويفضل أن يكون طبيبًا أو ممرضًا، تحت إشراف مدير حالة أو منسق رعاية. كما يمكن للطبيب أو الممرض أن يقوم بدور مدير الحالة أو منسق الرعاية. يجب على العاملين الصحيين إشراك المسنين (ومقدمي الرعاية غير المأجورين، حيثما كان ذلك مناسبًا) في اتخاذ القرار بشأن رعايتهم الشخصية، مع احترام احتياجاتهم وقيمهم وتفضيلاتهم وأولوياتهم. ويمكن أن يمثل اتباع هذا النهج تحولًا جذريًا في طريقة تعامل العاملين الصحيين مع المسنين.

وبالنسبة للفريق متعدد التخصُّصات (**إطار 3.2**) الداعم للمسنين، فإن وجود هدف موحَّد يتمثل في تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية يمكن أن يكون مفيدًا لضمان دمج

المربع 3.2 الفريق متعدد التخصُّصات

يجمع الفريق متعدد التخصُّصات الأشخاص المشاركين في رعاية المسنين لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات من خلال نهج منسق ومتكامل. وتختلف تشكيلة الفريق متعدد التخصُّصات في الرعاية الأولية حسب السياق، لكنها قد تشمل الأطباء، والممرضين، والعاملين الصحيين المجتمعيين، والعاملين في الرعاية الاجتماعية، والمعالجين (العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والعلاج النفسي)، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية غير المأجورين، والعاملين في الرعاية، والصيادلة، والمتطوعين. وبناءً على قدرة أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية، يمكن تشكيل فريق أساسي يضم عددًا قليلًا من العاملين الصحيين المشاركين بشكل مباشر في تقديم الرعاية، مع إشراك الآخرين في المناقشات عند الإمكان.

تعد كيفية تفاعل أعضاء الفرق متعددة التخصصات معًا كفريق أمرًا بالغ الأهمية. وتوجد عدة عوامل يمكن أن تسهم في تيسير أساليب العمل الفعالة، ومنها: وجود منسق رعاية أو مدير حالة محدد يسهّل عمل الفريق، وعقد اجتماعات مشتركة لتبادل الرؤى والمخاوف، والتشارك في حفظ السجلات، وإشراك مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن التي تعكس احتياجات الشخص المتلقي للرعاية المتكاملة.

الرعاية ورصد التقدم. ينبغي أن تكون أهداف المسنين في صميم الخطة، وقد تتجاوز مجرد تقليل التأثير المباشر للأمراض، لتشمل أيضًا الجوانب التي تمكنهم من القيام بالأنشطة التي يقدرونها أكثر، مثل التقدم في العمر بشكل مستقل وآمن في مكان إقامتهم، والحفاظ على تطورهم الشخصي، والمشاركة والإسهام في مجتمعاتهم مع الاحتفاظ باستقلاليتهم وصحتهم.

يمكن وضع خطة رعاية مُشخصنة لأي مسن، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من فقدان كبير للقدرة الذاتية في عدة مجالات و قد يكون غير قابل للتصحيح، وأولئك الذين هم في مرحلة نهاية الحياة. ويجب أن تأخذ المناقشة بين العامل الصحي والمسن في الاعتبار أية مخاوف قد تكون لدى المسن فيما يتعلق بالموت والاحتضار، وتحديد أي علاجات طبية أو رعاية لا يرغب المسن فيها. وبالنسبة للمسن الذي يواجه مرضًا خطيرًا مع توقع محدود، يلزم إعطاء اهتمام خاص لتحديد هدف متمركز على الشخص ضمن سياق مسار المرض المتوقع.

يجب أن تتضمن خطة الرعاية المشخصنة أهدافًا محددة زمنيًا. بالإضافة إلى الأهداف المتوسطة إلى طويلة المدى، يُنصح بتضمين أهداف قصيرة المدى لتحقيق تحسينات أو منافع فورية، بهدف الحفاظ على دافع ومشاركة المسنين.

كيفية تحديد الأهداف المتمركزة على الشخص

فيما يلي مثال على كيفية قيام العامل الصحي بإجراء تمرين لتحديد الأهداف المتمركزة على الشخص مع مسن، وأفراد عائلته ومقدمي الرعاية غير المأجورين، حيثما كان ذلك مناسبًا. يجب أن تستند الخطة إلى نتائج التقييم المعمَّق والتدخلات التي يمكن تقديمها استجابةً لذلك. ويجب تكييف النهج مع السياق المحلي.

تحديد الأهداف، من خلال مناقشة ما يلي:

- الأمور التي تهم المسن أكثر من أي شيء في جميع جوانب حياته.
- بعض الأهداف المحددة التي لدى المسن في حياته.
- بعض الأهداف المحددة المتعلقة بصحته.
- ثلاثة أهداف يرغب في التركيز عليها على المدى القصير (على سبيل المثال، الأشهر الثلاثة القادمة) والمدى الأطول (على سبيل المثال، 6–12 شهرًا).

تحديد الأهداف – يمكن تكييفها مع احتياجات المسن وتعريفه الخاص للمشاكل من خلال مناقشة التالي:

- ما الذي يرغب بالتحديد في العمل عليه بشأن الهدف الأول أو الثاني أو الثالث على المدى القصير والطويل.
- ما الخطوات التي يقوم به حاليًا لتحقيق الأهداف.
- ما هو الهدف المثالي والقابل للتحقيق بالنسبة له في تحقيق الأهداف.

تحديد الأولويات للأهداف – إن الاتفاق على أولويات الرعاية بين المسن والعامل الصحي سيُظهر تحسين النتائج. يمكن توجيه تحديد الأولويات من خلال مناقشة ما يلي:

- أي من الأهداف هو الأكثر استعدادًا للعمل عليها على المدى القصير والطويل، سواء بمفرده أو بدعم من العامل الصحي أو منسق الرعاية.

المصدر: Javadi et al; 2018. مقتبس من النص الأصلي في Health Tapestry (http://healthtapestry.ca).

3.3.2
وضع خطة رعاية مُشخصنة متكاملة

يعد وضع خطة رعاية مُشخصنة متكاملة أمرًا ضروريًا لمعالجة جميع مجالات القدرة الذاتية التي تبيَّن فقدانها، حيث إن بعض حالات الفقدان تشترك في محددات فسيولوجية وسلوكية أساسية. ونتيجة لذلك، فإن التدخلات تحقق منافع عبر المجالات.

على سبيل المثال، يُعد تدريب تقوية العضلات التدخل الرئيسي لتجنب فقدان القدرة على الحركة وتدبيره، كما أنه يحمي بشكل غير مباشر من أعراض الاكتئاب والتدهور المعرفي، ويُسهم في تجنب السقوط.

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من فقدان كبير في القدرة الوظيفية الأساسية في عدة مجالات، قد يشير التقييم المعمَّق إلى أن إعاقاتهم من غير المرجح أن يتم تصحيحها. وقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، في وجود إعاقة ناتجة عن الإصابات أو الأمراض (مثل السكتة الدماغية) أو عن مرض تقدمي مثل الخرف أو مرض باركنسون. ستحتاج خطة الرعاية المشخصنة إلى مراعاة المسار المتوقع وكذلك التخطيط للمتابعة، والذي قد يستمر مدى الحياة. وسيتغير التوازن بين تعديل القدرة الذاتية وعلاج الأمراض، والرعاية التلطيفية، وتوفير الرعاية والدعم الاجتماعيين، بما في ذلك دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، مع مرور الوقت.

يمكن اتباع ثلاث خطوات رئيسية في وضع خطة رعاية مُشخصنة:

1. **استعراض النتائج ومناقشة الفرص لتحسين القدرة الذاتية، والقدرة الوظيفية، والصحة والرفاه**

عند مناقشة الأهداف، يجب عرض نتائج التقييم المعمَّق والتدخلات المقترحة لمختلف حالات فقدان القدرة الذاتية. يمكن توجيه تحديد الأولويات للتدخلات التي ستُدرج في خطة الرعاية استنادًا إلى مدى استعجال المشكلة من منظور سريري، واحتمالية نجاح التدخل، والتأثير الأوسع لمعالجة مسألة محددة، بما في ذلك كيف يمكن لمعالجة فقدان القدرة في مجال معين أن تؤثر على معالجة فقدان القدرة في مجال آخر، والعبء المتوقع للتدخلات، مع مراعاة ما يوليه المسن أهمية أكبر.

ولتحديد التدخلات المحتملة، سيحتاج العاملون الصحيون إلى معرفة شاملة بالخدمات والموارد المتاحة في كلا القطاعين الصحي والاجتماعي.

2. **الاتفاق على التدخلات**

ينبغي أن يحظى هذا الاتفاق بموافقة المسن، بناءً على الموافقة المستنيرة، وأن يتماشى مع أهدافه واحتياجاته وتفضيلاته وأولوياته؛ وأن يشمل مكونات الرعاية والإدارة الذاتية؛ وأن يتلاءم مع البيئات المادية والاجتماعية؛ وأن يشمل دعم مقدمي الرعاية غير المأجورين، حيثما يتم تحديد الاحتياجات. ويجب مناقشة كل تدخل محتمل على حدة مع المسن. يمكن العثور على أمثلة لمكونات محتملة لخطة رعاية مُشخصنة في **المربع 3.3** (الصفحة 38). في كثير من الحالات، ستتطلب التدخلات المقترحة مساهمات من العاملين الصحيين من مختلف القطاعات والتخصُّصات.

3,2 وبشكل مثالي، يقوم مدير حالة أو منسق رعاية بتنظيم الفريق متعدد التخصُّصات (**المربع 3.2**، الصفحة 35) الذي سيشارك في تقييم وتطوير وتنفيذ ومراقبة خطة الرعاية. إن وجود شراكة بين المسن ومقدمي الرعاية غير المأجورين والفريق متعدد التخصُّصات أمر مهم للحفاظ على رفاهيته في مكان إقامته.

3. **إنجاز وتقاسم خطة الرعاية**

يجب على العامل الصحي الذي تم تعيينه كمدير حالة أو منسق رعاية أن يقوم بتوثيق التدخلات المتفق عليها في خطة الرعاية ومشاركة الخطة مع المسن، وأفراد عائلته ومقدمي الرعاية غير المأجورين (حسب الاقتضاء) والفريق متعدد التخصُّصات المشترك في رعايته، وذلك بموافقة المسن. إذا استدعت التدخلات في خطة الرعاية الإحالة، فيجب تزويد المسن بإرشادات حول كيفية تحديد المواعيد وكيفية تلقي الدعم من العاملين الصحيين. يمكن العثور على مثال لخطة رعاية في **الملحق**.

المربع 3.3 المكونات المحتملة لخطة الرعاية المُشخصنة

- الأهداف المستنِدة إلى أولويات وتفضيلات المسن.
- الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية لتعزيز الصحة والرفاه.
- الخدمات والدعم المعتمد على المجتمع. توفر الوصفة الاجتماعية وسيلة لربط المسنين بمجموعة من الخدمات غير السريرية في المجتمع بهدف تحسين الصحة والرفاه (المربع 11.1، الصفحة 124).
- حزمة من التدخلات متعددة المكونات لتجنب فقدان القدرة الذاتية وتدبيرها. ستتضمن معظم خطط الرعاية تدخلات لتحسين التغذية وتعزيز ممارسة التمارين متعددة الأنماط.
- تدبير الأمراض المستبطنة، ومتلازمات الشيخوخة (مثل السقوط والسَّلَس البولي) وعوامل الخطر، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية.
- التطعيم الدوري، بما في ذلك التطعيم ضد كوفيد19- والتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا بالإضافة إلى لقاحات أخرى، اعتمادًا على جدول التطعيم في كل بلد.
- مراجعة الأدوية لتحديد الأدوية غير المناسبة، ومعالجة القضايا المتعلقة بإمكانية الحصول عليها، والالتزام بها، والجوانب العملية لاستخدامها. ← **4.2.4**
- عند الاقتضاء، يجب إدارة الحالات المزمنة المتقدمة والأمراض المهددة للحياة، بما في ذلك عبر الرعاية التلطيفية، لضمان قدرة المسنين على الاستمرار في حياة ذات معنى وكرامة، مع حماية حقوقهم. ← **4.2.3**
- الرعاية والدعم الاجتماعيين، بما في ذلك التعديلات البيئية، مثل تعديل المنازل وتوفير وصيانة المنتجات المساعِدة؛ والدعم الاجتماعي بمساعدة أفراد الأسرة والأصدقاء والمجتمع وغيرها من الخدمات؛ والرعاية الشخصية والمساعدة في الأنشطة اليومية، التي يمكن تقديمها في المنزل، أو في المجتمع، أو في المؤسسات (المراكز النهارية، دور الرعاية ومرافق الرعاية طويلة الأجل الأخرى).
- تقديم الدعم لمقدمي الرعاية غير المأجورين، بناءً على مناقشة معهم. قد يشمل ذلك نصائح حول كيفية تقديم أنواع معينة من الرعاية والدعم، ونصائح بشأن الرعاية الذاتية، وفرص للراحة المؤقتة، والدعم النفسي الاجتماعي، والوصول إلى الدعم المالي، والدعم في مواجهة الحزن والفجيعة.
- الإحالة إلى الرعاية المتخصصة، بما في ذلك خدمات التأهيل، والرعاية التلطيفية، ورعاية المسنين، عند توفرها والحاجة إليها، وذلك عبر آليات الإحالة المحلية.
- تحديد موعد متابعة متفق عليه لضمان رصد أي تغييرات أو فقدان إضافي، وإمكانية تعديل الرعاية تبعًا لذلك.



الإشراف على تنفيذ خطة الرعاية وإعادة التقييم الدوري مع المسن أمران أساسيان لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

3.4
تنفيذ خطة الرعاية المشخصنة والاشراف عليها

يعد التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات، الذين ينتمون إلى مستويات وأنواع مختلفة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحت إشراف منسق الرعاية أو مدير الحالة، أمرًا أساسيًا لتنفيذ التدخلات المتفق عليها في خطة الرعاية المُشخصنة. ويُعزز هذا النهج الكشف المبكر عن المضاعفات، بما في ذلك التأثيرات الضارة المحتملة للتدخلات، كما يسمح بتحديد أي تحديات تتعلق بالأحداث الصحية والأمراض الشديدة، والتغيرات في الأدوار الاجتماعية أو الوضع المعيشي. كما يسمح بتحديد حالات فقدان القدرة الذاتية في مجالات جديدة أو إضافية. وتساعد المتابعة الدورية في تجنب الحالات الطارئة غير الضرورية وتقليل التكاليف من خلال تمكين التدخل المبكر. كما تعزز المتابعة المنتظمة التواصل المستمر بين المسنين والعاملين الصحيين، مما يساعد في الحفاظ على علاقة ناجحة.

تستند وتيرة المتابعة إلى شدة الرعاية المطلوبة وأنواع التدخلات المقدمة والسياق الاجتماعي للشخص، ويجب تحديدها من قِبل منسق الرعاية أو مدير الحالة وبموافقة المسن. يمكن لمنسق الرعاية أو مدير الحالة تذكير المسنين بجميع المواعيد، بما في ذلك المواعيد المحددة لإعادة التقييم. ويمكن توفير المتابعة مع المسنين بطرق مختلفة، بما في ذلك اللقاءات الشخصية، أو عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو. ويجب على العامل الصحي تحديد الطريقة الأنسب لكل فرد، مع الحصول على موافقة المسن ومقدم الرعاية غير المأجور عند الاقتضاء.

تشمل عملية المتابعة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- ضمان التنفيذ الناجح لكل خطوة وتدخل في خطة الرعاية.
- استفسار استباقي لتحديد الآثار الجانبية المحتملة أو العواقب غير المتوقعة للتدخلات.
- تكرار التقييم الأساسي أو التقييم المعمَّق أو كليهما وتوثيق أي تغييرات.
- تلخيص النتائج والعقبات والمضاعفات الناتجة عن تنفيذ التدخلات.
- تحديد التغيرات والاحتياجات الجديدة.
- تعديل خطة الرعاية حسب الضرورة.

3.5 مهارات التواصل

على مدار جميع مراحل مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية، يُعد التواصل الفعال للعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة في المجتمع أمرًا أساسيًا لضمان تقديم رعاية متواصلة متمركزة على الشخص.

يحتاج العاملون الصحيون المكلفون بالتقييم المعمَّق ووضع خطة رعاية إلى أخذ الوقت الكافي للتفاعل بشكل صحيح مع المسن لبناء الثقة. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر بيئة مؤاتية تتيح للمسن الشعور بالقدرة على التعبير بصراحة عن أي تحديات قد يواجهها، بالإضافة إلى تفضيلاته وخياراته وأهدافه.

إلى جانب الانتباه إلى كيفية تحدُّث العاملين الصحيين واستماعهم للمسنين، يجب أن يكونوا على دراية بالأشكال غير اللفظية للتواصل، بما في ذلك لغة الجسد، وأهمية مراقبة سلوك المسن وأي من مقدمي الرعاية غير المأجورين أو الأقارب الحاضرين.

هناك عدد من النقاط التي ينبغي على العاملين الصحيين وأصحاب المصلحة في المجتمع مراعاتها عند التواصل مع المسنين. معظمها مفيد في المحادثات مع الجميع، ولكن يجب أخذها في الاعتبار بشكل خاص فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن داخل نظام الرعاية الصحية وآثاره.

- عند لقاء المسن للمرة الأولى، تأكد من استخدام الشكل المناسب ثقافيًا للتحية وتجنب استخدام المصطلحات المألوفة (مثل "عزيزي"). وبعد بناء علاقة ودية، اسأل الشخص كيف يفضل أن يُخاطب.
- كن محترمًا وتجنب المواقف أو الكلمات أو العبارات التي تحمل طابع التمييز العُمري. لا ينبغي افتراض أي شيء أو القيام بتعميمات عن المسن، بما في ذلك قدراته على التواصل دون اختبارها (مثل السمع والمعرفة) (**المربع 1.1**، الصفحة 3).
- أخذ البيئة المحيطة بالاعتبار، والحاجة إلى تحقيق توازن بين الخصوصية واستقلالية المسن مع الاستفادة من مساهمة مقدمي الرعاية غير المأجورين عند الضرورة أو الفائدة. لا يُطلب من مقدم الرعاية أو شخص آخر التحدث نيابة عن المسن إلا عندما يكون ذلك ضروريًا بسبب فقدان محدد للقدرة الذاتية، مثل التدهور المعرفي، ولا بد أن يتم ذلك وفقًا للأطر القانونية.
- أخذ البيئة المحيطة بالاعتبار من منظور تحرك المسن، مع التأكد من أنها متاحة بالكامل (على سبيل المثال، للكراسي المتحركة).
- الجلوس على مسافة مناسبة من المسن وبوضعية مفتوحة.
- وضع أي حساسيات محتملة تتعلق بالنوع الاجتماعي في الاعتبار، وحيثما كان ذلك مناسبًا وممكنًا، و توفير الخيار للمسن للقاء عامل صحي من نفس الجنس.
- اخبار قبل المسن عند بداية اللقاء بمدة اللقاء وتأكد من أنه راضٍ عن المتابعة. وضع أخذ فترات استراحة عند الضرورة في الاعتبار.
- تجنُّب التعجُّل عند طرح الأسئلة، وتجنب المقاطعة والتشتيت، والمحافظة على التواصل البصري وإظهار التعاطف. استخدام الأسئلة المفتوحة حيثما كان ذلك مناسبًا، والتي تشجع المسن على مشاركة تجاربه ومشاعره ووجهات نظره.
- تكييف أسلوب التواصل واللغة لضمان وضوح الفهم. بالنسبة لبعض المسنين، قد يعني ذلك الالتزام بموضوع واحد في كل مرة، وتجنُّب إعطاء معلومات كثيرة دفعة واحدة، واستخدام كلمات وجمل قصيرة وبسيطة، والتحدث ببطء ووضوح مع تجنُّب المصطلحات التقنية.
- ممارسة الاستماع النشط من خلال تلخيص ما يقوله المسن دوريًا، وإعادة صياغة بعض النقاط عند الحاجة، وتوضيح مشاعره من خلال التعبير عنها بالكلمات.
- استخدام استراتيجيات تواصل مناسبة عند التواصل مع مسن يعاني من فقدان السمع. ← 9.2.1
- التأكد من وجود إضاءة كافية عند التواصل مع مسن يعاني من ضعف البصر، والتحقق مما إذا كان قد أحضر نظارته واستخدامها، والتأكد من وضوح جميع التعليمات والمواد المكتوبة بخط كبير، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تسجيل التعليمات أو استخدام الرسوم البيانية أو الوسائل المساعِدة أو الأجهزة. ← 8.6
- التأكد من أن التوصيات واضحة ومفهومة للمسن (ولمقدم الرعاية عند الاقتضاء). تقديم ملاحظات مكتوبة بوضوح حول التوصيات، والوصفات، والجداول الزمنية المستقبلية، والإحالات.
- يجب توخي الحذر ومراقبة أي علامات تحذيرية على إساءة المعاملة أو الإهمال. ← 11.4

4 أصحاب المصلحة والخدمات المشتركة لمسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية

يتطلب تنفيذ مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والتعاون والتنسيق عبر القطاعات والخدمات. ويجب مراعاة عدد من العوامل عند التخطيط لتنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين، مع التركيز على من يجب أن يشارك، وما هي الخدمات المطلوبة وكيف يمكن تقديمها. ستُحدَّد هذه العوامل بناءً على السياق المحلي (← *14.2*)، بما في ذلك هيكل وآلية الرعاية الأولية، وتوفر الخدمات التخصصية، وقدرات أصحاب المصلحة في المجتمع. وفي بعض الحالات، قد يحتاج العاملون الصحيون في الرعاية الأولية إلى إحالة المرضى إلى الأخصائيين في مستويات أخرى من نظام الرعاية الصحية (الثانوية أو الثالثية) أو إلى النظام الاجتماعي، عندما لا تتوفر هذه الخبرة أو الخدمة ضمن الرعاية الأولية.

النقاط الرئيسية

- يتطلب التنفيذ الناجح لمسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الرعاية الصحية والاجتماعية والمجتمع.
- تُعدّ المشاركة الفعّالة للمسنين وتمكين مقدمي الرعاية غير المأجورين من العوامل الرئيسية المساعِدة عبر جميع مراحل مسار الرعاية المتكاملة للمسنين.
- ينبغي إشراك أصحاب المصلحة في المجتمع بفعالية، مع توفير الدعم المناسب لهم في سياق تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين.
- عند الحاجة إلى الإحالة إلى الرعاية التخصصية، يكون التنسيق والتعاون بين العاملين الصحيين أمرًا مهمًا.
- يجب تقديم الخدمات المشتركة والدعم استجابةً للتراجعات في عدة مجالات من القدرة الذاتية بطريقة شاملة ومتكاملة.

4.1
إشراك أصحاب المصلحة

4.1.1
المشاركة الفعّالة للمسنين

تُعد المشاركة الفعالة للمسنين ودعمهم للرعاية المتكاملة للمسنين، وللرعاية المتكاملة بشكل عام، عنصرًا أساسيًا في نجاحها، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الشعور بالتمكين وتحقيق الذات. ويمكن أن يتخذ هذا المشاركة شكلين: مشاركة المسنين في صحتهم ورفاههم من خلال مسار الرعاية المتكاملة للمسنين؛ والمشاركة الأوسع لدعم الشيخوخة الصحية في مجتمعاتهم، بما في ذلك من خلال نوادي وجمعيات المسنين. تساعد المدن والمجتمعات الصديقة للمسنين على ضمان المشاركة الفعّالة للمسنين. وتم تقديم أمثلة على الدور الذي يمكن أن تلعبه نوادي أو جمعيات المسنين في تقديم الرعاية المتكاملة. ← 4.1.3

تتمثل الخطوة الأولى الرئيسية لتحقيق هذه المشاركة في إعطاء الأولوية للتصميم المشترك للخدمات، وتحسينها بناءً على ملاحظات المسنين، واتخاذ القرارات المشتركة كأسس رئيسية عند تكييف جميع مراحل مسار الرعاية مع السياق المحلي. وينبغي بذل الجهود لزيادة وعي المسنين من خلال القنوات المتاحة والمناسبة محليًا، لتسليط الضوء على الفرصة التي يوفرها لهم نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، ليكونوا جزءًا أساسيًا من رعايتهم الخاصة والتعبير عن تفضيلاتهم وأهدافهم. ← 3.3.1 يجب أن تتضمن خطط الرعاية مكونات الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية لتمكين المسنين (**المربع 4.1**). ويمكن لحملات التوعية، إذا صُممت بشكل جيد، أن تُسهم أيضًا في زيادة الوعي حول التمييز على أساس السن، بما في ذلك التمييز الموجه نحو الذات (**المربع 1.1**، الصفحة 3)، وإساءة معاملة المسنين. ← 11.4

المربع 4.1 الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية للمسنين

يشمل دعم الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية تقديم المعلومات والمهارات والأدوات التي يحتاجها المسنون ومقدمو الرعاية غير المأجورين، بهدف تعزيز صحتهم ورفاههم، وتقليل عوامل الخطر، وإدارة أمراضهم، والوقاية من المضاعفات، وتعزيز قدرتهم الذاتية، والحفاظ على قدرتهم الوظيفية.

ولا يعني ذلك أنه من المتوقع أن يواجه المسنون كل شيء بمفردهم، أو أن تُفرض عليهم مطالب غير معقولة أو مفرطة. بل هو بمثابة اعتراف باستقلاليتهم وقدرتهم على توجيه رعايتهم الخاصة، بالتشاور والشراكة مع العاملين الصحيين وعائلاتهم ومقدمي الرعاية غير المأجورين الآخرين. يجب تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لجميع المسنين، بغض النظر عن مستويات قدرتهم الأساسية. ← 3.1.3

يمكن لمبادرة الصحة المتنقلة للمسنين (mAgeing) التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن تُكمل الرعاية الروتينية التي يقدمها العاملون الصحيون من خلال تعزيز الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية. فمن خلال تقديم المعلومات الصحية ونصائح والتذكيرات عبر الهواتف المحمولة، فإنها تشجع السلوكيات الصحية وتساعد المسنين على تحسين قدرتهم الأساسية والحفاظ عليها.

مزيد من المعلومات

- ***كن بصحة جيدة، داوم على الحركة: دليل حول تنفيذ الخدمات الصحية عبر الهواتف المتنقلة (mAgeing)***. WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/274576).
- ***الصوت والمشاركة الفعالة في عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية: ورقة نقاش***. منصة عقد الشيخوخة الصحية؛ 2023 (https://www.decadeofhealthyageing.org/find-knowledge/resources/publications/detail/voice-and-meaningful-engagement-in-the-un-decade-of-healthy-ageing-a-discussion-paper)

4.1.2
تمكين مقدمي الرعاية غير المأجورين ودعمهم

يؤدي مقدمو الرعاية غير المأجورين، الذين يشملون في الغالب النساء والفتيات، دورًا أساسيًا في رعاية المسنين ودعم التزامهم بخطة الرعاية المشخصنة، ويجب تمكينهم في هذا الدور. ويُعترف بمتطلبات تقديم الرعاية وبحاجة مقدمي الرعاية غير المأجورين إلى الدعم، لا سيما فيما يتعلق بتوفير التدريب ونصائح لهم، لضمان قدرتهم على تقديم أفضل رعاية ممكنة، فضلاً عن ضمان الدعم الكافي لحماية صحتهم ورفاههم. وتشمل المجالات الرئيسية للدعم، التي من المحتمل أن يستفيد منها مقدمو الرعاية غير المأجورين، ما يلي: الوصول إلى الرعاية المؤقتة، والدعم النفسي، والدعم المالي، والدعم المتعلق بصحتهم ورفاههم. ← 12 يُعد ذلك أمرًا مهمًا، لا سيما إذا كان مقدم الرعاية غير المأجور نفسه مسنًا، وفي هذه الحالة، يجب أن يُعرض عليه أيضًا إجراء تقييم أساسي في إطار نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

4.1.3
إشراك أصحاب المصلحة في المجتمع

في جميع أنحاء العالم، يؤدي أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا محوريًا في رعاية المسنين، كما تم تسليط الضوء عليه في العديد من مشاريع الرعاية المتكاملة للمسنين التجريبية *(19)*.

تعرّف منظمة الصحة العالمية المشاركة المجتمعية بأنها "عملية تطوير علاقات تمكّن أصحاب المصلحة من العمل معًا لمعالجة القضايا الصحية وتحقيق تأثير ونتائج صحية إيجابية" *(18)*.

يعتمد دور أصحاب المصلحة في المجتمع على السياق المحلي، بما في ذلك أنواع المنظمات، والبُنى التحتية القائمة، ومجالات تركيزها، وقدراتها، إضافةً إلى الموارد البشرية. فهم يمكنهم رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين واستحقاقاتهم، ودعم سماع آراء وتجارب وأفكار المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين في عمليات تخطيط البرامج وتقديم الخدمات. كما يمكنهم الدعوة إلى إدخال التغييرات اللازمة على الأنظمة والخدمات، بما في ذلك التعديلات السريعة استجابةً للاحتياجات المتطورة. ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم إنشاء وتنظيم آليات لمشاركة المسنين وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع. كما لهم دور في محاسبة مقدمي الخدمات وغيرهم، بما في ذلك من خلال المشاركة المباشرة في المتابعة والتقييم. إذا شارك أصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك العاملين الصحيين المجتمعيين، في تقديم الخدمات والدعم مباشرةً للمسنين، فيجب توفير التدريب والدعم والإشراف والمتابعة اللازمين لهم.

ويتحمل نظام الرعاية الصحية مسؤولية التعاون الفعّال مع شركائه ودعمهم، ولا سيما المنظمات المجتمعية، والمتطوعين، ومقدمي الرعاية غير المأجورين. بينما يعمل أصحاب المصلحة في المجتمع غالبًا كجسر بين المسنين والعاملين في الصحة، ويمكنهم سد بعض الفجوات في تقديم الخدمات الرسمية، ولا ينبغي توقع منهم تقديم الخدمات التي تقع ضمن مسؤولية أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.

ولا ينبغي المساس بحقوق ورفاه الأفراد المشاركين من المجتمع، سواء كانوا مقدمي رعاية غير مأجورين، أو في أدوار مدفوعة، أو غير مدفوعة، أو تطوعية، كما يجب ألا يتأثروا سلبًا نتيجةً لمشاركتهم. يجب حماية صحتهم ورفاههم. يوفر **المربع 4.2** (الصفحة 44) نصائح بشأن الرعاية الذاتية للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع.

وبناءً على قدراتهم، قد يتمكن أصحاب المصلحة في المجتمع من دعم كل مرحلة من مراحل مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الرعاية الأولية (الفصول 5–13). تشمل أمثلة المشاركة الممكنة ما يلي:

1 الخطوة الأولى: التقييم الأساسي والتدخُّلات على مستوى المجتمع

يمكن استخدام الأماكن أو الفضاءات المجتمعية (مثل قاعات المدينة، ومراكز الرعاية الاجتماعية، ومكاتب البريد، وأماكن اللقاءات الدينية والمجتمعية) لتنظيم فعاليات التقييمات الأساسية للرعاية المتكاملة للمسنين، وتعزيز الوعي حول الشيخوخة الصحية. على سبيل المثال، يمكن أن تسهم هذه الفعاليات في مكافحة التمييز على أساس السن، وكسر الصور النمطية حول "الشيخوخة الطبيعية"، وزيادة المعرفة والفهم بشأن الصحة في سن متقدمة، بالإضافة إلى توعية المسنين بحقوقهم وامتيازاتهم. يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تشجيع المسنين على الحضور. كما يمكن للعاملين الصحيين التعاون مع منظمات المجتمع لإجراء التقييمات الأساسية الميدانية من خلال أندية أو جمعيات المسنين، وتنظيم الزيارات المنزلية، حيث يمكن التعرف على المسنين المؤهلين لإجراء هذه التقييمات. وخلال التقييم الأساسي، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين، وغيرهم من أصحاب المصلحة المدربين، تقديم أنواع مختلفة ومخصَّصة من نصائح والدعم والرعاية الصحية المجتمعية. ← **3.1.3**

المربع 4.2 كيفية ممارسة الرعاية الذاتية لأصحاب المصلحة في المجتمع

ما يجب فعله

- ✔ فصل الحياتك الشخصية والعملية.
- ✔ وضع روتين منظم للأنشطة اليومية لتحقيق التوازن بين العمل، والأسرة، ووقت الفراغ.
- ✔ تخصيص وقت لتناول الطعام، وشرب الماء، والنوم، والراحة، والتأمل، والاسترخاء.
- ✔ اتباع عادات صحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الكحول، والتبغ، والمواد الضارة الأخرى.
- ✔ الوعي بالمشاعر والتعرف على المواقف التي قد تؤثر على العواطف.
- ✔ التواصَل مع العائلة والأصدقاء، وطلب الدعم عند الحاجة.
- ✔ التواصَل مع الزملاء، والبحث معًا عن طرق لدعم بعضكم البعض في العمل.
- ✔ عدم التردد في طلب المساعدة من مختص صحي عند الحاجة.

ما يجب تجنبه

- ✘ اجبار النفس على القيام بأشياء تسبب الشعور بعدم الارتياح.
- ✘ تكرار تجاوز ساعات العمل المعتادة.
- ✘ الشعور بالوحدة أو الاستغناء عن طلب المساعدة.
- ✘ اعتبار التحدث عن عدم الرضى علامة على الضعف

المصدر: أدوات mhGAP المجتمعية: البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP). منظمة الصحة العالمية؛ 2019.

2 الخطوة الثانية: التقييم المُعمَّق

في حين يجب أن يُجري العاملون الصحيون التقييمات المُعمَّقة في مرافق الرعاية الأولية، يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع أن يُسهموا في ضمان الوصول إلى تلك المرافق، من خلال تنظيم أو توفير وسائل نقل للمسنين، بالإضافة إلى دعم العاملين الصحيين في إجراء تقييم للبيئة الاجتماعية والمادية للمسنين. كما يمكنهم متابعة المسنين بعد إجراء التقييم الأساسي، لضمان فهمهم للنتائج، والتأكيد على أهمية إجراء تقييم معمَّق والمتابعة عند الضرورة.

3 الخطوة الثالثة: خطة الرعاية المشخصنة

يجب أن تتضمن خطط الرعاية، الرعاية والدعم الاجتماعيين والتي يمكن أن يقدمها أصحاب المصلحة في المجتمع. لذلك، يُوصى بالتعاون معهم أثناء وضع خطة الرعاية لفهم الخدمات التي يقدمونها. كما يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم عملية رسم خريطة أوسع، توضح الخدمات والدعم المتاح محليًا، سواء كانت مقدمة من منظمات مجتمعية، أو السلطات المحلية، أو الشركات والجهات الربحية. وبعد ذلك، يمكن تزويد العاملين الصحيين ومنسقي الرعاية أو مديري الحالات بهذه المعلومات، لدعم تطوير خطط الرعاية المُشخصنة.

4 الخطوة الرابعة: التنفيذ والرصد

توجد عدة طرق يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع من خلالها دعم هذه المرحلة من المسار:

- تنظيم وإدارة خدمات الرعاية والدعم الاجتماعيين، مثل المراكز النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية، ونوادي الغداء لتعزيز التفاعل الاجتماعي أثناء تناول الطعام، وخدمات توصيل الوجبات، والخدمات التي تقدم الدعم في المهام المنزلية.

- تنظيم أنشطة رياضية جماعية وفعاليات اجتماعية لتعزيز المشاركة والتخفيف من العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، على سبيل المثال، من خلال دعم المسنين في استخدام التكنولوجيا الرقمية للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع.

- تنظيم فعاليات وحملات توعوية لدعم الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية، سواء للمسنين أو لمقدمي الرعاية غير المأجورين.

- دعم الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية، من خلال توصيل الأدوية، وتوفير وسائل النقل، وتوفير أماكن وأوقات منتظمة لخدمات التوعية المجتمعية، بما في ذلك المخيمات الصحية وفعاليات التطعيم.

- تأسيس وتيسير مهام مجموعات الدعم، بما في ذلك الدعم بين الأقران للمسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين، والمجموعات التي تركز على قضايا محددة، لدعم الرفاه النفسي والاجتماعي.

- التنسيق مع الشركات والمرافق المحلية لرفع الوعي حول قضايا محددة، مثل تزويد المتاجر والمقاهي وبائعي الأسواق والأكشاك بإرشادات حول أفضل الطرق للتعامل مع الأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي، أو مطالبة المرافق المحلية بتوفير مراحيضها للمسنين.

- بناء بنك من الموارد المعلوماتية ونصائح بشأن كيفية الوصول إلى الخدمات الأخرى والدعم، مثل الدعم المالي، وتوصيل الوجبات المحلي، وخدمات إصلاح المنازل، والتنظيف أو خدمات البستنة. يعد هذا النوع من الدعم مهمًا بشكل خاص لمقدمي الرعاية غير المأجورين، الذين قد يواجهون صعوبة في تخصيص الوقت للقيام بهذه الأنشطة. يمكن أن يساعد الوصول إلى مثل هذه الخدمات في تقليل الطلب على وقت مقدمي الرعاية غير المأجورين وتقليل الضغوط الناتجة عن ذلك، مما يمكّنهم من منح الشخص الذي يقدمون له الرعاية تركيز أكبر مع أخذ فترات استراحة لأنفسهم.

- متابعة تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، ومساءلة مقدمي الخدمات (سواء كانوا غير ربحيين أو ربحيين) وصانعي السياسات عن الالتزامات التي تعهدوا بها بشأن تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين.

4.1.4 التعاون والتنسيق بين العاملين الصحيين متعددي التخصصات

إن التعاون والتنسيق بين العاملين في ميدان الصحة والرعاية الاجتماعية من مختلف مستويات وأنواع الرعاية الصحية والاجتماعية أمرٌ أساسيٌ لتقديم الرعاية المتكاملة للمسنين بنجاح. ← **3.4** على الرغم من أن العاملين الصحيين في منشآت الرعاية الأولية يمكنهم تقديم العديد من الخدمات وقد تتوفر الخدمات المتخصصة في الرعاية الأولية في بعض السياقات، إلا أن التعاون يعد أمرًا أساسيًا لضمان وجود مسارات إحالة تتيح الوصول إلى الخدمات المتخصصة في الوقت المناسب، بما في ذلك توفير الرعاية للحالات الخطرة وكذلك للقطاع الاجتماعي.

يمكن توجيه هذا التنسيق والتعاون بواسطة منسق الرعاية أو مدير الحالة، ويجب أن يحظى بالدعم من قبل فريق متعدد التخصُّصات (**المربع 3.2**، الصفحة 35). قد يكون من الضروري استقدام أخصائيين صحيين في الحالات التي تتطلب معرفة ومهارات أكثر تخصصًا مما يمكن للعاملين الصحيين المدربين في الرعاية الأولية تقديمه. ويشمل ذلك، وليس حصرًا، أطباء العيون، واختصاصيي السمعيات، والأطباء النفسيين، وأطباء الأسنان، والأخصائيين الصحيين في رعاية المسنين (**إطار 4.3**)، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والرعاية التلطيفية.

المربع 4.3 رعاية الشيخوخة

يلعب أخصائيو رعاية الشيخوخة دورًا مهمًا، عند توفرهم، في تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين، بما في ذلك خلال النوبات الحادة وإدارة الحالات المزمنة طويلة الأجل. يُقدّم أطباء الشيخوخة الرعاية للمسنين، بدعم من ممرضين متخصصين وغيرهم من المهنيين الصحيين. يتمتع أطباء الشيخوخة، وهم متخصصون في رعاية المسنين، بخبرة في تقييم وتدبير احتياجاتهم الصحية وتأثيراتها الاجتماعية، بما في ذلك المتلازمات المرتبطة بالشيخوخة، مثل السقوط، والسَّلَس البولي، وقرح الفراش، والهذيان، إلى جانب إدارة تعدد الأدوية. يعمل أطباء الشيخوخة والممرضون المتخصصون مع المسنين لتعزيز استقلاليتهم، وينبغي أن يكونوا جزءًا أساسيًا من الفريق متعدد التخصصات، حيث يمكنهم دعم باقي أعضائه.

4.2
التكامل عبر الخدمات والقطاعات

إلى جانب التنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تقديم مسار الرعاية المتكاملة للمسنين، والرعاية المتكاملة بشكل أوسع، يُعد التكامل عبر الخدمات والقطاعات عنصرًا أساسيًا. فعلى سبيل المثال، يؤدي فقدان القدرة الذاتية في عدة مجالات إلى زيادة خطر السقوط لدى المسنين. لذلك، ينبغي أن تعالج خدمات الدعم وتجنب السقوط فقدان القدرة في مجالات عدة وعوامل الخطر التي قد يتعرض لها المسنون. ومن المحتمل أن تكون الخدمات والدعم التاليان مطلوبين استجابةً لفقدان عدة وظائف وظروف مختلفة.

ينبغي دمج مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديمها بطريقة تلبي الاحتياجات الشاملة للمسن، بدلًا من معالجة تدهور القدرة الذاتية أو الحالات الصحية كلٌّ على حدة.

4.2.1
خدمات التأهيل

يُعرف التأهيل بأنه مجموعة من التدخلات المصممة لتحسين الأداء الوظيفي، حيث يُستخدم مصطلح " تأدية الوظائف أو الأداء" كمفهوم شامل يشمل وظائف الجسم وهياكله والأنشطة والمشاركة، إضافةً إلى تخفيف الألم والحد من الإعاقة. ويثبت التأهيل فعاليته في تسريع التعافي، والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحالات الحادة والمزمنة، وتعزيز القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية. تشمل تدخلات التأهيل التقنيات والإجراءات العلاجية، والتمارين والتدريبات، مثل تمارين تقوية العضلات، والتدريب المعرفي، وتمارين التنفس، والتدريب على أنشطة الحياة اليومية، إضافةً إلى تنمية مهارات التواصل الاجتماعي، واستخدام المنتجات المساعِدة والتدريب عليها، وإجراء تعديلات في البيئة المحيطة. كما تشمل تدخلات التأهيل تطوير مهارات الإدارة الذاتية، بما في ذلك تقديم التثقيف ونصائح بشأن الحالات الصحية أو التمارين الذاتية، وتدريب مقدمي الرعاية غير المأجورين وأفراد الأسرة على التقنيات والمهام المتعلقة بالرعاية.

عادةً ما تُقدَّم خدمات التأهيل من قِبَل فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية، يشمل ممرضي التأهيل، والأطباء، والأطباء النفسيين، وأخصائيي العلاج الوظيفي، وأخصائيي العلاج الطبيعي. ومع ذلك، يمكن تدريب العاملين الصحيين في مرافق الرعاية الأولية لتقديم مجموعة محدودة من تدخلات التأهيل. من الضروري تمكين الشخص الذي يتلقى خدمات التأهيل عبر التثقيف والإرشاد، والتحفيز والتوجيه، وتقديم الدعم. يجب دائمًا مراعاة اعتبارات السلامة لمعالجة أي مشاكل قد تنشأ أثناء تقديم تدخلات التأهيل.

قد تكون تدخلات التأهيل مطلوبة نتيجة لفقدان القدرة الذاتية، فيما يتعلق بالأمراض وعوامل الخطر ولدعم البيئات الاجتماعية والبدنية للمسنين. تُحدد حزمة *التدخلات التأهيلية* الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، التدخلات التأهيلية، إلى جانب معلومات حول احتياجات القوى العاملة، والمنتجات المساعِدة، والمعدات، والمواد المستهلَكة. وتشمل الأمثلة عبر مجالات القدرة الذاتية ما يلي:

- **التدهور المعرفي:** تهدف التدخلات التأهيلية إلى تحسين وظائف معرفية محددة، ومساعدة الأفراد على التكيف مع تراجع القدرات المعرفية. توجد عدة تدخلات يمكن استخدامها لتحفيز الذاكرة من خلال المنتجات المساعِدة، بما في ذلك أدوات دعم الذاكرة ومنظِّمات الأدوية. يُقدَّم العلاج بالتحفيز المعرفي، والعلاج المعرفي السلوكي، والتدريب المعرفي غالبًا من قِبَل الأطباء النفسيين أو أخصائيي العلاج الوظيفي كجزء من خدمات التأهيل، وذلك حسب قدرة نظام الرعاية الصحية. ← 5
- **محدودية القدرة على الحركة:** تشمل التدخلات التأهيلية تمارين وتدريبات موجَّهة، إضافةً إلى نصائح حول كيفية بدء واستمرار ممارسة التمارين الشخصية بشكل مستقل، بما يتناسب مع الروتين اليومي للفرد. كما ينبغي متابعة التقدم في التدخلات المقدمة. يمكن أن تستهدف التدخلات وظائف المفاصل والعضلات، وتعزيز قوة العضلات، والتخفيف من الألم والتورم المرتبط بالحالات العضلية الهيكلية مثل التهاب المفاصل العظمي، وهشاشة العظام، والساركوبينيا. كما يمكن أن تشمل التدخلات تدخلاً غذائيًا كعنصر أساسي للأشخاص ذوي التحرُّك المحدود. ← 6

- **سوء التغذية الناتج عن صعوبات البلع (عسر البلع):** تشمل التدخلات التأهيلية التثقيف والتدريب على تقنيات وتمارين مختلفة، مثل تقنيات الوضعية، والبلع فوق الحنجري، وتمارين تقوية عضلات الزفير، لتحسين عملية البلع، والمضغ، والتعامل مع الطعام في الفم، وإفراز اللعاب. كما تتضمن تقديم نصائح بشأن تعديل قوام الطعام. تُمارَس هذه التقنيات بشكل متكرر، وإذا أمكن، يتم أداؤها بشكل ذاتي. ← 7

- **ضعف البصر:** تشمل تدخلات التأهيل توفير المنتجات المساعِدة البصرية، وغير البصرية، والإلكترونية، إضافةً إلى تقديم نصائح لتحسين بيئة المعيشة، وتدريب التوجيه والتنقل، وتعزيز مهارات الرؤية، وتقديم الدعم النفسي. ← 8

- **فقدان السمع:** تشمل التدخلات التأهيلية توفير الأجهزة السمعية والمنتجات المساعِدة، مع التدريب على استخدامها، بالإضافة إلى علاج النطق واللغة لتعزيز المهارات المعرفية وتنمية القدرات التواصلية واللغوية. كما تشمل التدخلات التدريب على استخدام لغة الإشارة، ووسائل أخرى للتعويض الحسي، مثل قراءة الشفاه، والطباعة على الكف، أو طريقة تادوما، إضافةً إلى التواصل بالإشارة. وغالبًا ما يقدِّم هذه التدخلات أخصائيو السمعيات ومعالجو النطق واللغة. ← 9

مزيد من المعلومات

- *حزمة تدخلات التأهيل من منظمة الصحة العالمية.* WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/370502).
- *الوحدة 2: الحالات العضلية الهيكلية* (https://iris.who.int/handle/10665/370503).
- *الوحدة 3: الحالات العصبية* (https://iris.who.int/handle/10665/370504).
- *الوحدة 6: الحالات الحسية* (https://iris.who.int/handle/10665/370508).
- *التدريب على المنتجات المساعِدة (TAP).* TAP; 2024 (https://www.gate-tap.org/).

4.2.2 المنتجات المساعِدة

تشمل المنتجات المساعِدة (المعروفة أيضًا بالأجهزة المساعِدة أو الوسائل) المشايات، وأدوات المساعدة على الأكل والشرب، والنظارات، ومنظمات الأدوية، ومنتجات التحكم في السَّلَس البولي، والأجهزة الداعمة للذاكرة، ومساعِدات السمع. ويمكن لهذه المنتجات أن تساعد على الحفاظ على القدرة الوظيفية للفرد أو تحسينها، مما يعزز استقلاليته، من خلال معالجة فقدان القدرة الذاتية، والأمراض المرتبطة، و إدخال التعديلات المطلوبة في بيئة المسنين. كما يمكن استخدامها للوقاية من المضاعفات الثانوية، مثل الأحذية الخاصة بمرضى السكري، أو المراتب المصممة لتخفيف الضغط، إضافةً إلى تقليل العبء على مقدمي الرعاية غير المأجورين.

ينبغي على العاملين الصحيين المدربين مناقشة المنتجات المساعِدة المناسبة لتحديد ما هو مطلوب. ويجب مراعاة مواقف الوصمة الاجتماعية تجاه المنتجات المساعِدة، المرتبطة بالتمييز ضد ذوي الإعاقة، وقد يلزم التغلب عليها لضمان استخدام المسنين لهذه المنتجات. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي استخدامها غير الضروري إلى الاعتماد عليها، مما قد يقلل من مستوى الاستقلالية.

تُعد الخطوات التالية لتقديم الخدمة ضرورية لضمان الاستخدام المناسب للمنتجات المساعِدة:

1. اختيار أفضل منتج يلبي احتياجات الفرد.
2. تكييف المنتج ليناسب الفرد.
3. تعليم الفرد (ومقدمي الرعاية غير المأجورين) كيفية استخدام المنتج والعناية به.
4. المتابعة المستمرة لمراجعة ما إذا كانت احتياجات الفرد قد تغيرت، وإجراء أي صيانة وإصلاحات.

يمكن توفير المنتجات المساعِدة من قِبَل القطاع الصحي أو القطاع الاجتماعي، بواسطة موظفين ذوي كفاءة مناسبة. على سبيل المثال، من المحتمل أن يتم توفير جهاز السمع من قبل العامل في الصحة؛ بينما قد يكون القطاع الاجتماعي مسؤولاً عن تركيب وإدارة الأنظمة الصوتية. عادةً ما يوفر النظام الصحي الكراسي المتحركة وعصي وأطر المشي، وقد تقوم الخدمات الاجتماعية بتنظيم وتركيب حواجز الدعم والعوارض داخل منزل الفرد.

ستعتمد أنواع المنتجات المقدمة من قبل القطاعات المختلفة على الأنظمة الوطنية. ومن المهم تزويد كلٍّ من المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين بمعلومات حول المنتجات المساعِدة، ومكان الحصول عليها وفقًا لموقعهم، وكيفية استخدامها وصيانتها.

ويمكن توفير بعض المنتجات المساعِدة البسيطة من قبل العاملين الصحيين في الرعاية الأولية بعد تلقي تدريب إضافي. يمكن أن يحد ذلك من الحاجة إلى تعدد المواعيد في الخدمات التخصصية المختلفة. يتوفر برنامج التدريب على المنتجات المساعِدة(TAP) التابع لمنظمة الصحة العالمية لدعم تدريب العاملين الصحيين على تحديد وتوفير مجموعة من المنتجات المساعِدة البسيطة. وهو مورد إلكتروني يضم وحدات تدريبية منظمة في ستة مجالات، تشمل الرؤية، والسمع، والإدراك، والتواصل، و القدرة على الحركة، والرعاية الذاتية (الرعاية الشخصية).

وتشمل أقسام البيئات الاجتماعية والمادية في الفصول من 5 إلى 13 أمثلة على المنتجات المساعِدة في مختلف مجالات القدرة الذاتية.

4.2.3 الرعاية التلطيفية

الرعاية التلطيفية هي نهج يهدف إلى تحسين نوعية حياة المرضى وعائلاتهم الذين يواجهون مشاكل مرتبطة بالأمراض المهددة للحياة، كما يساعدهم على العيش بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية والنشاط. يهدف إلى تجنب المعاناة وتخفيفها من خلال الاكتشاف المبكر والتقييم الصحيح وعلاج الألم والمشاكل الأخرى، سواء كانت جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو روحية. كما تشمل الرعاية التلطيفية الخدمات التي تدعم العائلات في مواجهة الضغوط العاطفية، والاجتماعية، والروحية، سواء خلال مرض المريض أو أثناء فترات الفجيعة.

ينبغي أن تُقدَّم الرعاية التلطيفية من قِبَل فريق متعدد التخصصات في الرعاية الأولية، ويشمل ذلك تقديمها في منازل المسنين، وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، مع اتباع نهج متكامل يشمل العلاجات المخففة للأعراض أو العلاجات الشفائية عند الحاجة. ويجب على جميع العاملين في الصحة امتلاك مهارات أساسية في الرعاية التلطيفية لتدبير الأعراض، ووصف الأدوية الأساسية للرعاية التلطيفية (بما في ذلك المورفين وغيرها من المواد الأفيونية)، وإدماج الرعاية التلطيفية في خطة رعاية مُشخصنة. وعند توفرها، يمكن أن تساعد الرعاية التلطيفية المتخصصة في تدبير الألم المعقد والأعراض الأخرى، ومعالجة المعاناة متعددة الأبعاد.

ينبغي أن يكون التخطيط المسبق للرعاية جزءًا من الممارسة المعتادة. وتُعد المناقشة وتوثيق تعيين مفوَّض لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية وتفضيلات الفرد بشأن الرعاية المستقبلية أمرًا مهمًا. ينبغي أن تشمل هذه المناقشات معلومات عن مكان الرعاية المفضَّل ومكان الوفاة (على سبيل المثال، المنزل أو مرفق الرعاية طويلة الأجل)، والخيارات المتعلقة بالعلاجات الطبية بما في ذلك النقل إلى المستشفى والرعاية المكثفة التي قد تحافظ على الحياة لكنها تفرض عبئًا كبيرًا ومعاناة محتملة، إضافة إلى الممارسات الروحية الهامة والمسائل العملية المحيطة بالوفاة.

وبالنسبة للمسنين المتوقع أن يشهدوا تراجعًا كبيرًا، خصوصًا في قدراتهم المعرفية أو قدرتهم على التواصل، فإن مناقشة واتخاذ قرارات بشأن رعاية نهاية الحياة مبكرًا يُعد أمرًا ضروريًا. كما يجب إجراء هذه المحادثات بحساسية، مع مراعاة التصورات والمواقف الفردية والثقافية تجاه الموت والاحتضار، إضافةً إلى توضيح ماهية الرعاية التلطيفية والفوائد التي تقدمها.

مزيد من المعلومات

- ***الرعاية التلطيفية: تدبير الأعراض ورعاية نهاية الحياة.*** WHO; 2004 (https://iris.who.int/handle/10665/68535).
- ***إرشادات منظمة الصحة العالمية للتدبير الدوائي والشعاعي لآلام السرطان لدى البالغين والمراهقين.*** WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/279700).
- ***دمج الرعاية التلطيفية وتخفيف الأعراض في الرعاية الصحية الأولية.*** WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/274559).

4.2.4
الأدوية غير المناسبة وتعديد الأدوية

قد يكون المسنون الذين يعانون من أمراض متعددة أكثر عرضة للتغيرات في الحرائك والديناميات الدوائية. إلى جانب التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للشيخوخة، والتي تؤثر على المسارات الأيضية والتحليلية للأعضاء، بما في ذلك وظائف الكلى والكبد، يزداد خطر حدوث تفاعلات دوائية سلبية. ومن الضروري التأكد من ملاءمة الأدوية لكل فرد، بهدف تحقيق أقصى فائدة بأقل ضرر ممكن.

تُعتبر الأدوية غير مناسبة عندما يُوصف دواء غير ضروري أو لم يعد مطلوبًا، سواء بسبب:

- أنه لا يوجد مبرر طبي مستند إلى الأدلة، أو أن المبرر لم يعد ساريًا، أو أن الجرعة أعلى من اللازم؛
- أو عندما تفشل الأدوية في تحقيق أهدافها العلاجية؛
- أو عندما يتسبب أحد الأدوية أو مجموعة منها في حدوث تفاعلات دوائية سلبية، أو يشكل خطرًا على حدوثها؛
- وأيضًا عندما لا يكون المريض راغبًا أو قادرًا على تناول الأدوية كما هو مقصود.

يُعرَّف تعدد الأدوية عادةً بأنه الاستخدام اليومي لخمس أدوية أو أكثر، بما في ذلك الأدوية التي تُصرَف بدون وصفة طبية، والأدوية الموصوفة، والأدوية التقليدية والتكميلية. يرتبط استخدام هذه المجموعة المتعددة من الأدوية بحدوث تفاعلات دوائية سلبية ويزيد من خطر العواقب الصحية السلبية، مما يؤدي إلى احتمال فقدان القدرة الذاتية الذي يمكن تجنبه، وزيادة حالات الإدخال المفاجئ إلى المستشفيات.

إن المسنين الذين يتلقون رعاية غير متكاملة، أو الذين أُدخلوا إلى المستشفى مؤخرًا (فيما يُعرف بانتقال الرعاية)، وأولئك الذين يعانون من المراضات المشتركة، يكونون أكثر عرضة لتعدد الأدوية أو لاستخدام الأدوية غير المناسبة، مما يُبرز أهمية الرعاية المتكاملة المتمركزة على الشخص.

وتعد مراجعة الأدوية تقييمًا منهجيًا لأدوية المريض يهدف إلى تحسين استخدامها وتحقيق نتائج صحية أفضل. نظرًا لأن الأدوية غير المناسبة وتعدد الأدوية قد يسهمان في فقدان القدرة الذاتية عبر مجالات متعددة، فإنه ينبغي أن يتضمن التقييم المعمَّق مراجعة شاملًا للأدوية. يمكن تقليل المخاطر عن طريق التخلص من الأدوية غير الضرورية أو غير الفعالة، بالإضافة إلى الأدوية التي تحتوي على نفس المكون النشط، واستبدالها ببدائل عند الضرورة، إذا كان استمرار استخدام دواء معين مطلوبًا (**المربع 4.4**، الصفحة 50).

ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع أن يؤدوا دورًا في معالجة مشكلة الأدوية غير المناسبة وتعزيز الالتزام بالعلاجات. كما يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين التعاون مع الصيادلة المحليين لضمان حصول المسنين على الأدوية بما يتماشى مع الأنظمة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم دعم المسنين في تناول الأدوية بشكل صحيح، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية على مستوى المجتمع حول الاستخدام الآمن للأدوية، بما في ذلك الاستخدام الآمن لأدوية تخفيف الألم.

مزيد من المعلومات

سلامة الأدوية في حالات تعدد الأدوية: تقرير تقني. WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/325454).

4.2.5
تجنب السقوط

قد يؤدي التدهور في أي من مجالات القدرة الذاتية إلى زيادة خطر السقوط. كما قد تؤثر البيئة المادية وطريقة أداء المهام أو الأنشطة في خطر السقوط. لذا، من الضروري النظر في التدخلات التي تستهدف القدرة الذاتية والعوامل البيئية، ضمن الجهود الرامية إلى تقليل المخاطر وتجنب السقوط. من خلال التدريب، يمكن للعاملين الصحيين تقييم خطر السقوط. وإذا تعذَّر إجراء زيارة منزلية، يمكنهم تقديم إرشادات عامة للمسن أو لمقدمي الرعاية غير المأجورين حول كيفية التعرف على المخاطر المنزلية وتحسين أمان البيئة المنزلية.

المربع 4.4 كيفية وصف الأدوية بشكل مناسب وتقليل الأخطاء الدوائية

- الحصول على التاريخ الدوائي الكامل، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، والأدوية التقليدية، والتكميلية، والعشبية، وكذلك الأدوية التي تم إيقافها بسبب عدم الفعالية أو الآثار الجانبية.
- التحقق مما إذا كانت الأدوية تؤثر سلبًا على القدرة الذاتية.
- تجنُّب وصف الأدوية قبل إجراء تشخيص دقيق، إلا في حالات الألم الحاد الشديد.
- تجريب العلاج غير الدوائي أولاً، إذا كان ذلك مناسبًا.
- استعرض الأدوية بانتظام، خاصة بعد أي حدث صحي كبير أو الخروج من المستشفى (انتقال الرعاية) وقبل وصف دواء جديد.
- راقب أي تأثيرات ضارة أو تفاعلات دوائية أو سمية ناتجة عن الأدوية.
- تفضيل استخدام دواء واحد لعلاج حالتين أو أكثر (مثل استخدام مضادات الاكتئاب لتحسين المزاج وتدبير اضطرابات النوم)، مع البحث عن فرص لتقليل عدد الأدوية.
- توفير بطاقة للأدوية ومنظِمات الحبوب.
- تثقيف المسن ومقدمي الرعاية غير المأجورين حول كل دواء، بما في ذلك الأعراض الجانبية المحتملة، ومتى يجب تنبيه العاملين الصحيين، وأهمية التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية.
- التحقق مما إذا كان ظهور أعراض جديدة ناتجا عن تفاعل دوائي ضار.
- استخدام الصور أو الوسائل البصرية لتوضيح المعلومات، إذا كان المسن يعاني من مشاكل في القراءة أو صعوبات أخرى، والانتباه إلى أي فقدان للسمع قد يؤثر على التواصل والفهم.

ملاحظة: في حال الشك بشأن إمكانية التوقف عن تناول دواء بأمان، يُنصَح بالرجوع إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية من ذوي الخبرة (مثل، الصيدلي أو طبيب الشيخوخة).

قد يشمل ذلك تقليل الفوضى، وإزالة السجاد المفكوك والأسطح الزلقة، وتسوية المطبات في الأرضيات والدرجات، وإعادة ترتيب الأثاث لإنشاء مسار مشي واسع وغير معرقل، وتحسين الإضاءة وإمكانية الوصول إلى المرحاض، خاصة خلال الليل، إضافةً إلى تركيب درابزين على السلالم وقضبان إمساك في الحمام. وسوف يُسهِّل إنشاء منحدر عند المدخل الرئيسي وصول الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وغيرهم ممن يواجهون صعوبة في صعود الدرج.

يتضمن التقييم الشامل لخطر السقوط ما يلي:

- مراجعة سجل السقوط، بما في ذلك تفاصيل الأنشطة التي كان المسن يؤديها.
- تقييم ما يلي:
  - القدرة الذاتية: القدرة على الحركة الذي يشمل أداء العضلات والمفاصل، وطريقة المشي، والتوازن والمرونة؛ والرؤية؛ والمعرفة.
  - الحالة القلبية الوعائية والعصبية.
  - السَّلَس البولي الناتج عن العجلة أو التبول الليلي (الاستيقاظ للتبول أثناء الليل).
  - مشاكل القدمين بما في ذلك تشوهات القدم والاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن أمراض مستبطنة مثل السكري والتهاب المفاصل.
  - الخوف من السقوط.
- تقييم البيئة المادية داخل المنزل ومحيط المنزل لتحديد المخاطر المحتملة.
- مراجعة الأدوية مثل الأدوية النفسية.

سيحتاج بعض الأشخاص إلى تقييم إضافي وتدبير لحالات مثل الإغماء (فقدان الوعي)، والصرع، والاضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون. يتطلب التقييم الشامل وتدبير خطر السقوط لدى الفرد خبرة متخصصة.

يمكن الحد من خطر السقوط من خلال:

- تحسين توازن المسن وتناسق حركته عبر ممارسة تمارين متعددة الأنماط، مثل تمارين "تاي تشي".
- تحديد الحاجة إلى تعديلات في المنزل وتكييف البيئة المادية للمسنين. سيوجه فقدان القدرة الذاتية للفرد في مجالات محددة طبيعة التعديلات البيئية الأكثر أهمية.
- تحديد الحاجة إلى المنتجات المساعِدة، مثل النظارات لحالات ضعف البصر، والأحذية المناسبة، مع إحالة الفرد للتقييم والوصف المناسب. تشجيع المسنين على ارتداء أحذية مغلقة ومتينة داخل المنزل، بدلًا من الأحذية سهلة الارتداء.

- مراجعة الأدوية لتحديد الأدوية غير المناسبة، وسحب غير الضرورية أو الضارة منها.

- وبالنسبة لمن يعانون من ضعف البصر، يمكن إدخال تعديلات محددة في المنزل والمناطق التي يتحركون فيها عادةً، لجعل المهام اليومية والأنشطة الترفيهية أكثر أمانًا وسهولة، مما يقلل خطر السقوط. ← **8.6.2**

– **تحسين الإضاءة:** تُعد الإضاءة الجيدة مهمة بشكل خاص للرؤية القريبة. تركيب الأضواء في الممرات، والسلالم، والخزائن، والأماكن الصغيرة المظلمة لتوفير إضاءة مباشرة. يُفضَّل أن يكون مصدر الإضاءة من جانب الشخص، بحيث لا يُكوّن ظلالًا.

– **تقليل الوهج:** عادةً ما يكون الضوء الساطع مفيدًا. إلا أن الوهج الناتج عن الشمس أو الأضواء الساطعة قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص.

– **إنشاء تباين:** يساعد التباين الجيد داخل الأشياء وبينها على رؤيتها بسهولة، أو العثور عليها، أو تجنبها. استخدام علامات ذات تباين عالٍ على حواف درجات السلم (خصوصًا لمن لديهم رؤية في عين واحدة فقط)، واستخدام أطباق ملونة بحيث يبرز الطعام بوضوح، إضافةً إلى استخدام قلم أسود للكتابة، وتلوين مقابض الأدوات المنزلية والمطبخية لجعلها أكثر وضوحًا وأمانًا (مثل تغليف مقبض السكين بشريط لاصق ملون زاهٍ أو طلائه).

يمكن للعاملين الصحيين تقديم نصائح حول الجوانب التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالإسكان والمبادرات الصديقة للمسنين.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم الجهود المبذولة لتهيئة بيئات مناسبة للمسنين داخل المنزل وخارجه، وذلك من خلال برامج المنازل الصديقة للمسنين أو المبادرات الهادفة إلى رسم خرائط وتقييم المنطقة المحلية. يمكن أن يتم ذلك على شكل تدقيق للمساحات الخضراء، ومدى إمكانية الوصول إلى المقاعد والمراحيض العامة، إضافةً إلى تقييم الخدمات والمرافق المحلية. ويمكن أن يسهم رسم خرائط للمناطق المُشكِلة، بما في ذلك الأماكن التي تتداخل فيها الشجيرات والأعشاب المتضخمة مع الممرات، والعوائق الساقطة مثل الأشجار والصخور التي تعيق الحركة، إضافةً إلى الحُفر في الطرق، في توفير معلومات يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك أندية أو جمعيات المسنين، استخدامها للمطالبة السلطات المحلية بإجراء الإصلاحات وضمان الصيانة. كما يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع التعاون مع السلطات المحلية لتنفيذ هذا العمل، إذا توفرت لهم التدريب والدعم والتعويض المناسب.

مزيد من المعلومات

- ***اخُطُ بأمان: استراتيجيات تجنب السقوط وإدارته عبر مراحل الحياة.*** WHO; 2012 (https://iris.who.int/handle/10665/340962).
- ***برنامج التنفيذ التجريبي للرعاية المتكاملة للمسنين (ICOPE): نتائج مرحلة "الجاهزية".*** WHO; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/353553).
- ***قاعدة البيانات العالمية للممارسات الصديقة للمسنين.*** WHO; 2024 (https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-practices/).
- ***الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات الصديقة للمسنين التابعة لمنظمة الصحة العالمية.*** WHO; 2024 (https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/).



5

القدرة المعرفية

مسار الرعاية لتدبير التدهور المعرفي

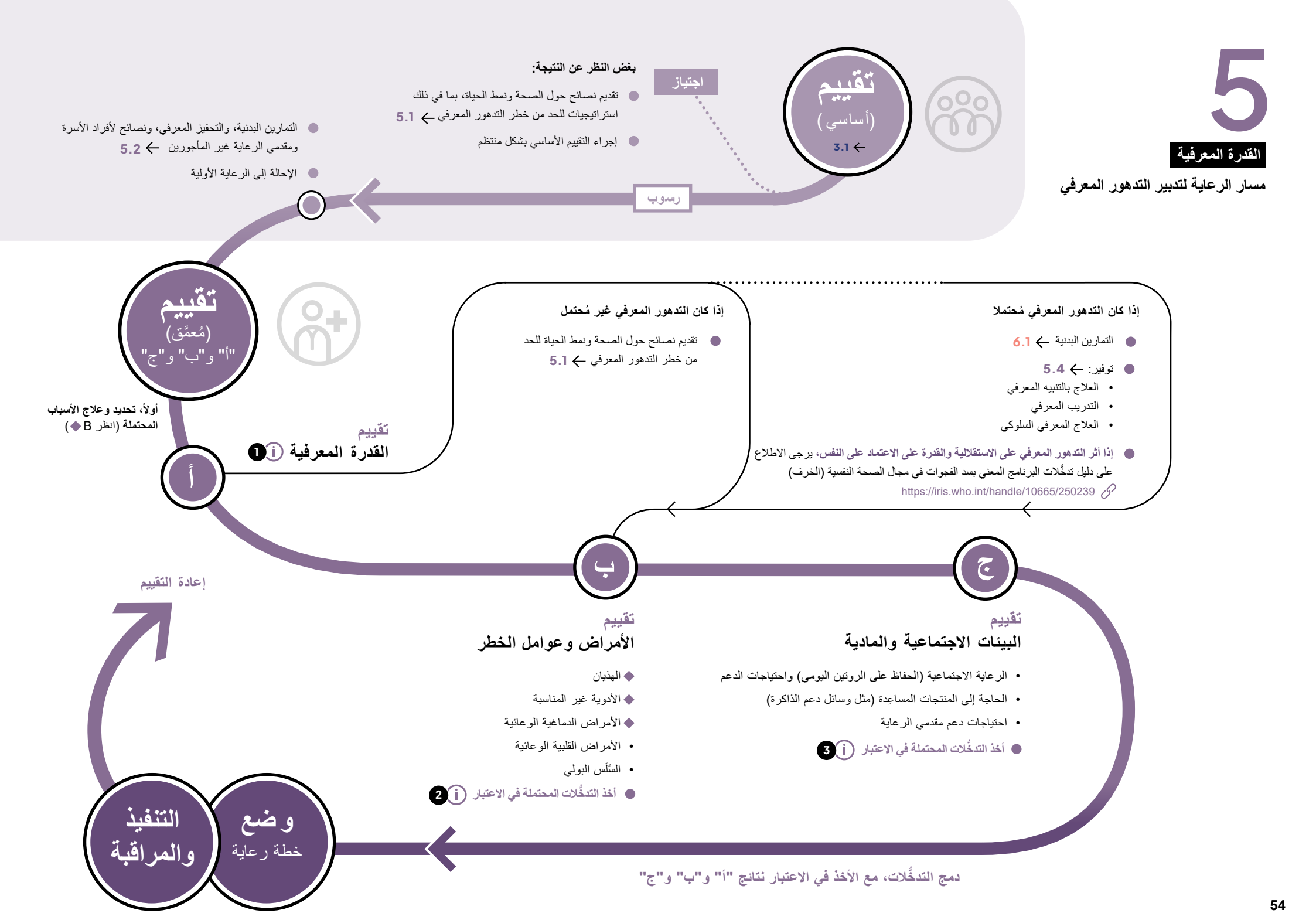


يظهر التدهور المعرفي بطرق مختلفة لدى كل شخص، وقد يشمل زيادة النسيان، وضعف الانتباه، وصعوبات في اللغة، وتغيرات في القدرة على إصدار الأحكام، وانخفاض القدرة على حل المشاكل. ويرتبط التدهور المعرفي بحالات مثل فقدان السمع، وبعض الأمراض غير السارية، مثل الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، ومرض الزهايمر، وأنواع أخرى من الخرف. وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر التدهور المعرفي قلة النشاط البدني، والعزلة الاجتماعية، وانخفاض مستوى التعليم.

غالبًا ما يصاحب التدهور المعرفي تغيرات في المزاج، والتحكم العاطفي، والسلوك، أو الدافعية، ويصبح مصدر قلق أكبر عندما يبدأ في التأثير على قدرة الشخص على الأداء بفعالية في بيئته، كما هو الحال في الخرف. يترتب على التدهور المعرفي والخرف آثار جسدية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، لا تؤثر فقط على الشخص المصاب، بل تمتد أيضًا إلى مقدمي الرعاية غير المأجورين، والأسر، والمجتمع ككل. التدهور المعرفي والخرف ليسا جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وكثير من الأشخاص لا يعانون منهما في سن متقدمة. في عام 2019، تراوحت التقييمات العالمية لانتشار الخرف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، من 2.9% في جنوب شرق آسيا إلى 6.5% في أوروبا. يرتفع معدل انتشار الخرف عالميًا بسرعة مع التقدم في العمر، حيث يبلغ 1.1% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا، ويصل إلى 35.9% بين من هم في عمر 90 عامًا فأكثر *(20)*.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع إجراء تقييم أساسي للتدهور المعرفي من خلال طرح مجموعة من الأسئلة.
- يُسهم تعزيز نمط حياة صحي، بما يشمل ممارسة النشاط البدني، والتحفيز المعرفي، والمشاركة الاجتماعية، في تحسين صحة الدماغ، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي.
- يحتاج مقدمو الرعاية غير المأجورين للأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي أو الخرف إلى نصائح حول كيفية تقديم الرعاية المناسبة، إضافةً إلى الدعم لصحتهم ورفاههم.
- يحتاج الأشخاص المصابون بالخرف إلى نهج أكثر تحديدًا واستهدافًا، أو تخصيصًا للرعاية.
- يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع العمل على رفع مستوى الوعي حول التدهور المعرفي، مع التأكيد على ضرورة عدم وصم الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي أو الخرف أو التمييز ضدهم، إضافةً إلى ضرورة حماية حقوقهم وكرامتهم. كما يمكنهم دعم الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي في البقاء على تواصل مع المجتمع.


تقييم
(أساسي)
3.1 ←
اجتياز
بغض النظر عن النتيجة:
تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة، بما في ذلك
استراتيجيات للحد من خطر التدهور المعرفي ← 5.1
إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم
رسوب
التمارين البدنية، والتحفيز المعرفي، ونصائح لأفراد الأسرة
ومقدمي الرعاية غير المأجورين ← 5.2
الإحالة إلى الرعاية الأولية
تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"
أولاً، تحديد وعلاج الأسباب
المحتملة (انظر B◆)
أ
تقييم
القدرة المعرفية 1
إذا كان التدهور المعرفي غير مُحتمل
تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة للحد
من خطر التدهور المعرفي ← 5.1
إذا كان التدهور المعرفي مُحتملا
التمارين البدنية ← 6.1
توفير: ← 5.4
العلاج بالتنبيه المعرفي
التدريب المعرفي
العلاج المعرفي السلوكي
إذا أثر التدهور المعرفي على الاستقلالية والقدرة على الاعتماد على النفس، يرجى الاطلاع
على دليل تدخُّلات البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (الخرف)
https://iris.who.int/handle/10665/250239
ب
تقييم
الأمراض وعوامل الخطر
◆ الهذيان
◆ الأدوية غير المناسبة
◆ الأمراض الدماغية الوعائية
• الأمراض القلبية الوعائية
• السَّلَس البولي
أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 2
ج
تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية
• الرعاية الاجتماعية (الحفاظ على الروتين اليومي) واحتياجات الدعم
• الحاجة إلى المنتجات المساعِدة (مثل وسائل دعم الذاكرة)
• احتياجات دعم مقدمي الرعاية
أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 3
دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"
وضع
خطة رعاية
التنفيذ
والمراقبة
إعادة التقييم

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض متعددة أو الهذيان، وكذلك في السياقات الاجتماعية، بما في ذلك العزلة الاجتماعية، التي تتطلب نهجًا أكثر شمولية
- التعامل مع السلوكيات والأعراض النفسية المرتبطة بالخرف، مثل التجول، واللامبالاة (يبدو الشخص أنه غير مهتم)، والهياج، والعدوانية، والأوهام، والهلوسة
- توفير العلاج المعرفي السلوكي (5.4.3)

1 تقييم القدرة المعرفية ← 5.3

يجب أن يتم التقييم المعمَّق للقدرة المعرفية باستخدام أداة موثوقة محليًا.

يوفر **الجدول 5.1** قائمة بالخيارات لتقييم القدرة المعرفية في مرافق الرعاية الأولية.

ما هو الخرف؟

الخرف هو متلازمة مزمنة وتقدمية نتيجة لتغيرات في الدماغ. وفي حين أن مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا، يمكن أن يحدث الخرف بسبب مجموعة متنوعة من الأمراض والإصابات في الدماغ. ينتج الخرف عن تراجع في الوظائف المعرفية، ويؤثر على الذاكرة والمهارات اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية مثل الاستحمام، وارتداء الملابس، والأكل، والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى إدارة الشؤون المالية والأمور الشخصية والأعمال المنزلية. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى التدهور في السيطرة العاطفية، والسلوك الاجتماعي، والتحفيز.

الجدول 5.1 مثال على أدوات التقييم المعرفي الموجزة للاستخدام في الرعاية الأولية

الأداة/ الاختبار	المزايا	العيوب	الوقت
Mini-Cog https://mini-cog.com/download-the-mini-cog-instrument/	موجز؛ ضآلة التحيز اللغوي والتعليمي والعرقي؛ يمكن أن تكون أداة تحري بديلة	استخدام قوائم كلمات مختلفة قد يؤثر على الدرجات	4-2 دقائق
Montreal cognitive assessment (MoCA) https://mocacognition.com/paper	يمكن أن يحدد الخلل المعرفي البسيط؛ متوافر بلغات متعددة	تحيز تعليمي وثقافي؛ قلة البيانات المنشورة؛ وتداعيات التدريب والتكلفة (مثل حقوق الطبع والنشر)	10–15 دقيقة
Mini mental state examination (MMSE) https://www.parinc.com/products/pkey/237	شائع الاستخدام والدراسة	خاضع للتحيز العمري والثقافي؛ تأثيرات الحدود القصوى، وتداعيات التدريب والتكلفة (مثل حقوق الطبع والنشر)	7–10 دقائق
General practitioner assessment of cognition (GPCOG) http://gpcog.com.au/index/downloads	ضآلة التحيز الثقافي والتعليمي؛ متوافر بلغات متعددة	قد يصعُب الحصول على تقارير المخبرين	5–6 دقائق
Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) https://www.dementia.org.au/professionals-assessment-and-diagnosis-dementia/rowland-universal-dementia-assessment-scale-rudas	ضآلة التحيز اللغوي والتعليمي والثقافي الاجتماعي	قلة البيانات المنشورة	10 دقائق

2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 5.5

- **الهذيان** ← تحديد السبب (الجفاف الشديد، العدوى، الأدوية، اضطرابات الشوارد والتمثيل الغذائي) وعلاجه (5.5.1)
- **الأدوية غير المناسبة** ← مراجعة الأدوية وسحبها أو وصف بدائل (5.5.2)
- **الأمراض الدماغية الوعائية والأمراض القلبية الوعائية** ← التعامل مع الأمراض والحد من عوامل الخطر (5.5.3، 5.5.4)
- **السَّلَس البولي** ← انظر مسار رعاية السَّلَس البولي ← 13

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 5.6

- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← تمكين المشاركة الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على الروتين اليومي (5.6.1)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← توفير الرعاية الشخصية والدعم في الأنشطة اليومية (11.6)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← تحديد خطر السقوط في المنزل ومحيطه وتدبيره (4.2.5)
- **الحاجة إلى المنتجات المساعِدة** ← تقديم الإرشادات حول وسائل دعم الذاكرة (الملاحظات، التذكيرات والتقويمات) (5.6.2)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← تقديم نصائح (5.2.3) والتدريب حول كيفية دعم شخص مسن يعاني من تراجع معرفي ودعم رفاه مقدمي الرعاية غير المأجورين (12.4)

5.1
نصائح حول الصحة ونمط الحياة للحد من خطر التدهور المعرفي

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم نصائح للمسنين ولمقدمي الرعاية غير المأجورين حول السلوكيات الصحية والاستراتيجيات التي تقلل من خطر التدهور المعرفي، إضافةً إلى تقديم توجيهات عامة أخرى. ← 3.1.3 تظل هذه نصائح ذات أهمية حتى للأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي، إذ يمكن منع المزيد من التدهور. قد تكون نصائح المحددة والموجهة مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي.

من المهم فيما يتعلق بالمسنين:

- إدارة عوامل الخطر للأمراض القلبية الوعائية.
- ممارسة التدريب المعرفي من خلال التكرار لتحسين الذاكرة.
- القيام بأنشطة التحفيز المعرفي المنتظمة، مثل القراءة، ولعب الألعاب، وتعلم أشياء جديدة، والعزف على الموسيقى.
- المحافظة على النشاط الاجتماعي والتفاعل مع المجتمع، على سبيل المثال، من خلال التواصل مع الأطفال والأحفاد، وممارسة الهوايات، والاستماع إلى الأخبار والشؤون الجارية ومناقشتها.
- إدارة فقدان السمع والاكتئاب. ← 9 10

من المهم فيما يتعلق بالمسنين الذين يعانون من التدهور المعرفي (أو يُحتمل أنهم يعانون منه)،:

- فهم طبيعة حالتهم، وخيارات العلاج المتاحة، والدعم المتوفر.

تقديم هذه المعلومات من خلال المحادثات الفردية، والاجتماعات الجماعية، والمناقشات، وحملات التوعية. تعد هذه الحملات واسعة النطاق مهمة في تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التدهور المعرفي. لا بد التثقيف المجتمع لفهم أن التدهور المعرفي ليس "جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة"، ولمكافحة المعتقدات الثقافية الضارة التي تعتبر التدهور المعرفي عقوبة أو سحرًا، إضافةً إلى التصدي للوصم وإساءة المعاملة التي قد تنتج عن ذلك. تؤدي الوصمة والتمييز إلى تفاقم التأثيرات النفسية، والاجتماعية، والعاطفية، والمالية الكبيرة التي يسببها الخرف، سواء على الأفراد، أو مقدمي الرعاية غير المأجورين، أو الأسر، أو المجتمعات.

5.2
الرعاية الصحية المجتمعية لدعم التعامل مع التدهور المعرفي

إذا تبيَّن أن المسن يعاني من تراجع معرفي مُحتمل من خلال التقييم الأساسي في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين، ولم يكن التقييم المُعمَّق متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم الدعم من خلال تعزيز النشاط البدني، والتحفيز المعرفي، وتقديم نصائح لأفراد الأسرة.

5.2.1
النشاط البدني

قد يساعد النشاط البدني في تقليل خطر التدهور المعرفي أو إبطاء تفاقمه. إذ تؤثر مجموعة متنوعة من التمارين البدنية، بما في ذلك التمارين الهوائية متوسطة الشدة، بالإضافة إلى تمارين التوازن وتقوية العضلات مثل "تاي تشي"، بشكل إيجابي على الوظيفة المعرفية والقدرة الوظيفية اليومي (21)(22)(23). ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم المسنين في ممارسة النشاط البدني (ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لمدة 30-45 دقيقة لأكثر من 12 أسبوعًا) من خلال إنشاء برامج رياضية وإدارتها، مع ضمان أن تكون هذه البرامج متاحة وميسورة التكلفة. ← 6.1

5.2.2
التحفيز المعرفي

من خلال التدريب، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع دعم المسنين عبر التحفيز المعرفي. وفقًا للبيئة المتاحة وقدرات أصحاب المصلحة في المجتمع، يمكن تنظيم جلسات فردية أو جماعية، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية، مثل إنشاء مجموعة للرقص الخَطّي، أو نادي شطرنج، أو صفوف لتعلم اللغات. تكون المجموعات أكثر فاعلية عندما يكون لأعضائها هدف مشترك.

5.2.3
نصائح لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية غير المأجورين

يمكن أن يكون تقديم نصائح عملية للحياة اليومية لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية غير المأجورين مفيدًا لدعمهم في رعاية المسنين الذين يعانون من التدهور المعرفي.

- مساعدة المسن في تسجيل المواعيد، وضبط التذكيرات، ووضع تقويم على الثلاجة أو الحائط يتضمن المواعيد وترتيب المهام اليومية.
- العمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمسن المصاب بالتدهور المعرفي، بما في ذلك وضع خطط للأنشطة اليومية الأساسية.
- توفير معلومات إرشادية مثل التاريخ، والأحداث المجتمعية الجارية، وهوية الزوّار، وأحوال الطقس، وأخبار أفراد الأسرة.
- تشجيع وتنظيم التواصل والأنشطة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة في المنزل والمجتمع.
- تهيئة المنزل ليكون بيئة آمنة للحد من مخاطر السقوط والإصابات. ← 4.2.5
- وضع لافتات إرشادية في المنزل لمساعدة المسن في العثور على طريقه، مثل لافتات تشير إلى الحمام، وغرفة النوم، وباب الخروج.
- ترتيب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وفقًا لقدرة الشخص. ← 9 10
- التعرف على طبيعة حالة الشخص الذي يتلقى الرعاية، وخيارات العلاج المتاحة، والدعم الممكن.
- إدراك أهمية العناية بصحتهم ورفاههم الشخصي. ← 12

مزيد من المعلومات

- *تقليل مخاطر التدهور المعرفي والخرف: الإرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية*. WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/312180).
- *الإصدار التجريبي الميداني: أدوات mhGAP المجتمعية: البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP)*. WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/328742).
- *نحو مجتمع محتوٍ للخرف: أدوات منظمة الصحة العالمية للمبادرات الصديقة للمصابين بالخرف*. WHO; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/343780).

5.3 تقييم القدرة المعرفية

القدرة المعرفية عملية عقلية مرتبطة بالتفكير وتشمل الاستدلال، والتذكر، وإصدار الأحكام، وحل المشاكل، والتخطيط. قبل إجراء أي اختبارات تشخيصية للمعرفة، من المهم تحديد ومعالجة أي أسباب قابلة للتصحيح (◆). ← 5.5

تفترض جميع التقييمات المعرفية القياسية المستخدمة في التقييم الأساسي أو لتشخيص التدهور المعرفي وجود حد أدنى من التعليم (الجدول 5.1، الصفحة 55). إذا كان الشخص ذا مستوى تعليمي منخفض أو أميًّا، فقد يكون تقييم المعرفة محدودًا *(24)*. *(25)*. يمكن أن تؤثر عوامل اجتماعية وثقافية أخرى، مثل اللغة المستخدمة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، على دقة التقييم. ويجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار، وعند الضرورة، يمكن استخدام المقابلات والحكم السريري بدلاً من ذلك. بالنسبة لهؤلاء الأفراد، يُوصى بشدة بالالتحاق ببرنامج لمحو الأمية للكبار (إن وُجد)، حيث يساهم ذلك في تعزيز صحة الدماغ.

يحدد مسار الرعاية مسارين مختلفين بناءً على نتائج التقييم المعرفي المعمَّق. الأشخاص الذين تبين أنهم يتمتعون بوظيفة معرفية طبيعية يجب أن يخضعوا لتقييم الأمراض، وعوامل الخطر، والبيئات الاجتماعية والمادية.

أما الأشخاص الذين يعانون من تدهور معرفي، فيجب أيضًا تقييم مدى صعوباتهم في أداء أنشطة الحياة اليومية أو الأنشطة المساعِدة لها. كما يجب التحقق من نتائج تقييمهم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل محدودية القدرة على الحركة، وفقدان السمع، وأعراض الاكتئاب، وإجراء تقييم معمَّق عند الضرورة. ← 6 9 10
وتعتبر هذه المعلومات مهمة لدمج التدخلات المتعلقة بالخسائر الأخرى في القدرة الجوهرية واحتياجات الرعاية الاجتماعية والدعم كجزء من خطة رعاية شخصية. ← 11

5.4 تدبير التدهور المعرفي

يجب دائمًا تقديم التدخلات لتدبير التدهور المعرفي كجزء من خطة رعاية مُشخصنة شاملة، تعالج الأمراض المستبطنة (مثل الأمراض القلبية الوعائية)، والأعراض مثل الهذيان، وعوامل الخطر، بالإضافة إلى التدخلات التي تستهدف المجالات الأخرى للقدرة الأساسية.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالخرف، هناك حاجة إلى نهج أكثر تحديدًا واستهدافًا، أو تخصيصًا للرعاية. وقد تكون هناك حاجة إلى إحالة إلى مختصين لديهم خبرة متخصصة في الحالات المصاحبة لعدة أمراض أو الهذيان، وكذلك في الحالات التي تتضمن أعراضًا سلوكية ونفسية، مثل التجوال، واللامبالاة، والتهيج، والعدوانية، والأوهام، والهلوسة.

بالإضافة إلى ممارسة التمارين البدنية والتحفيز المعرفي، اللذين يمكن تقديمهما في المجتمع، هناك العديد من الطرق الأخرى لتدبير التدهور المعرفي. يجب أخذ العلاج بالتحفيز المعرفي، والتدريب المعرفي، والعلاج المعرفي السلوكي، والإحالة إلى خدمات التأهيل (← **4.2.1**) بعين الاعتبار، بما يتماشى مع توجيهات *البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد*. غالبًا ما يقوم الأطباء النفسيون أو أخصائيو العلاج الوظيفي بتنفيذ هذه التدخلات، ولكن يمكن أيضًا تقديمها من قبل عامل صحي مدرَّب في مرفق الرعاية الأولية تحت الإشراف. ينبغي تطبيق البروتوكولات المحلية المتعلقة بالإحالة إلى المختصين.

لا يُوصى بوصف الأدوية المضادة للخرف لعلاج التدهور المعرفي دون تشخيص مؤكد للخرف. كما يجب تدريب العاملين الصحيين والإشراف عليهم لضمان الكفاءة في التشخيص والمراقبة عند وصف الأدوية المضادة للخرف.

5.4.1
العلاج بالتحفيز المعرفي

يتضمن العلاج بالتحفيز المعرفي مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل التوجيه الواقعي، والتحقق من المشاعر، والاستذكار. ويركز النهج الجماعي القياسي على التفاعل الاجتماعي من خلال تحفيز وظائف معرفية متعددة في وقت واحد، ويتألف من ما يصل إلى 14 جلسة موضوعية، تستمر كل منها حوالي 45 دقيقة، وتعقد مرتين في الأسبوع. عادةً ما تبدأ الجلسة بنشاط إحمائي غير معرفي، ثم تنتقل إلى مجموعة متنوعة من المهام المعرفية، مثل التوجيه الواقعي (مثل استخدام لوحة تعرض معلومات عن المكان، والتاريخ، والوقت)، تحت إشراف مُيسِّر. وتركز الجلسات على موضوعات متنوعة، مثل الطفولة، وإدارة المال، وألعاب الكلمات، والطهي، والموسيقى. وتتجنب هذه الأنشطة عمومًا استدعاء المعلومات الواقعية، وتركز بدلاً من ذلك على أسئلة تحفيزية مثل: "ما القاسم المشترك بين هذه (الكلمات أو الأشياء)؟"

5.4.2
التدريب المعرفي

يشير التدريب المعرفي إلى مجموعة من التقنيات المصممة لتحفيز التفكير والإدراك بدرجات متفاوتة من العمق والتخصص. ويستهدف هذا المصطلح الوظائف المعرفية المعزولة (مثل الذاكرة) من خلال ممارسة فردية متكررة لمهام معرفية معيارية. على سبيل المثال، يمكن وضع خمسة أشياء يومية، مثل كوب، وقلم، ومفتاح، على الطاولة، ودراستها لمدة دقيقة، ثم تغطيتها بقطعة قماش، ومحاولة تذكرها. لزيادة مستوى التحدي، يمكن استخدام عدد أكبر من الأشياء، أو تمديد الوقت بين تغطيتها واستدعائها. وتشمل الأهداف تحسين أو صون العمليات المعرفية، أو معالجة تأثير ضعفها على القدرة الوظيفية في الحياة اليومية.

ومن المهم تشجيع أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية غير المأجورين على تزويد المسن بالمعلومات بانتظام، مثل اليوم، والتاريخ، وحالة الطقس، والوقت، وأسماء الأشخاص، مما يساعده في الحفاظ على الإحساس بالزمان والمكان.

يمكن أن يسهم توفير مواد مثل الصحف، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وألبومات العائلة، والأدوات المنزلية في تعزيز التواصل، وربط المسنين بالأحداث الجارية، وتحفيز الذكريات، وتمكينهم من مشاركة خبراتهم وتقييمها.

5.4.3
العلاج المعرفي السلوكي

العلاج المعرفي السلوكي هو مصطلح شامل يشمل مجموعة واسعة من الأساليب النفسية التي تهدف إلى تحسين التكيف العاطفي. يركز العلاج المعرفي السلوكي على آلية التفكير بدلاً من محتواه، لمساعدة الأفراد على التعامل مع أفكارهم بمرونة. ويمكن أن يكون للعلاج المعرفي السلوكي تأثيرات إيجابية على الأداء اليومي وجودة الحياة، كما قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب المصاحبة. ← 10.4.2

مزيد من المعلومات

- *تعزيز صحة الدماغ عبر مراحل الحياة: ورقة موقف منظمة الصحة العالمية*. WHO; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/361251).
- *دليل البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) للاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد، [الطبعة الثالثة]*. WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/374250).
- *دليل التدخل للبرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) للاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد في مرافق الرعاية الصحية غير المتخصصة، الطبعة 2.0*. WHO; 2016 (https://iris.who.int/handle/10665/250239).

5.5 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر ومعالجتها

يجب أن يبدأ تقييم الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بالتدهور المعرفي بتحديد الأسباب المحتملة ومعالجتها (◆). وتشمل الحالات القابلة للتصحيح وعوامل الخطر الشائعة التي قد تؤدي إلى التدهور المعرفي: الهذيان، والأدوية، والأمراض الوعائية الدماغية. وفي بعض الحالات، قد يؤدي علاج هذه المشاكل إلى تحسن في الوظيفة المعرفية. وفي حال استمرار التدهور المعرفي، سيكون من الضروري إجراء تقييم إضافي.

يتطلب الكشف عن الأسباب القابلة للتصحيح للتراجع المعرفي فحصًا تشخيصيًا شاملًا، قد يشمل في بعض الأحيان إجراء تحاليل دم. وقد يكون من الضروري استكشاف عدة تفسيرات محتملة للأعراض لتحديد نهج دقيق لخطة الرعاية.

5.5.1 الهذيان ◆

الهذيان هو اضطراب حاد ومتذبذب يؤثر على القدرة على توجيه الانتباه، وتحويله، وصونه، وتركيزه. كما قد يعاني الشخص من ارتباك حول المكان والزمان. يتطور الهذيان خلال فترة زمنية قصيرة، ويكون عادةً متقلبًا على مدار اليوم. وقد يصاحبه اضطرابات أخرى في المعرفة والذاكرة والتفكير والعواطف والانتباه. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تراجع معرفي كبير، بما في ذلك الخرف، قد يؤدي أي تغيير مفاجئ في الظروف، مثل الانتقال إلى منزل جديد أو فقدان أحد الأحباء، إلى تفاقُم الارتباك أو الهذيان. في معظم الحالات، تشمل العوامل المحفزة الشائعة الأمراض، وخاصة العدوى، والتجفاف، وتناول أدوية جديدة، والاختلالات الأيضية (مثل نقص سكر الدم، ونقص صوديوم الدم، وقصور الغدة الدرقية، ونقص الفيتامينات)، والإصابات، والتسمم بالمواد أو الانسحاب من تعاطيها.

5.5.2 الأدوية غير المناسبة ◆

قد يتفاعل دواءان أو أكثر ويسببان آثارًا جانبية ضارة. ← **4.2.4** قد تفوق الأضرار المحتملة لهذه الأدوية فوائدها لدى بعض الأشخاص. وتشمل هذه الأدوية، على سبيل المثال لا الحصر: المواد الأفيونية، ومضادات الاكتئاب، والأدوية النفسية، وثنائيات هيدرو البيريدين، ومضادات الهيستامين، ومضادات المسكارين *(26)*.

5.5.3 الأمراض الوعائية الدماغية ◆

ترتبط أمراض الأوعية الدموية الدماغية ارتباطًا وثيقًا بالتدهور المعرفي. إذا كان المريض لديه سجل سابق من السكتات الدماغية أو نوبات نقص التروية العابرة، فإن الوقاية من تكرار هذه الحالات تُعد النهج الأساسي للحد من المزيد من التدهور المعرفي.

5.5.4 الأمراض القلبية الوعائية وعوامل الخطر

تُعد الأمراض القلبية الوعائية وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، من العوامل القابلة للتعديل التي تسهم في التدهور المعرفي. ويمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية من خلال تبني نمط حياة صحي. ويُعد التشخيص المبكر وعلاج الأمراض القلبية الوعائية ضروريين للوقاية من المضاعفات. ويمكن دمج تحري ارتفاع ضغط الدم في المجتمع من خلال قياس ضغط الدم، مع الإحالة السريعة عند الحاجة. ← **3.1.5**، **3.2.2** كما يُوصى بالكشف المبكر عن مرض السكري في مرافق الرعاية الأولية عبر فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض أو الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. أما بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض قلبية وعائية، فيجب توفير الدعم لضمان الالتزام بالعلاج، بما في ذلك تناول الأدوية الموصوفة.

5.5.5 السَّلَس البولي ← 13

يُعد السَّلَس البولي شائعًا بين الأشخاص الذين يعانون من تراجع معرفي، لذا يجب تقييمه وتدبيره بشكل مناسب.

5.6 تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

5.6.1 الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

بفضل التدريب والدعم من العاملين الصحيين، يمكن لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية غير المأجورين وضع خطط للأنشطة اليومية تساعد في تعزيز الاستقلالية، وتحسين القدرة الوظيفية، وتطوير المهارات، وتقليل الحاجة إلى المساعدة.

أما بالنسبة للأشخاص المصابين بالخرف، فقد تكون هناك حاجة إلى تدابير محددة لدعم أنشطتهم اليومية مع ضمان سلامتهم. يجب أن تكون هذه التدابير متناسبة مع قدراتهم وتتغير مع تقدم حالتهم الصحية. على سبيل المثال، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض متقدمة من الخرف تجنب القيادة، والامتناع عن استخدام الغاز للطهي، وعدم الطبخ إلا بحضور شخص آخر، وحمل بطاقة تحتوي على اسمهم وعنوانهم في حال فقدانهم الطريق.

ويمكن لمقدمي الرعاية غير المأجورين أيضًا إبلاغ الأصدقاء والجيران بحالة الشخص المصاب بالخرف ليكونوا على دراية بها، في حال أصبح مرتبكًا ووجوده في المجتمع. في بعض السياقات، قد تتوفر خدمات المساعدة عن بُعد، مثل أزرار الطوارئ والأجهزة الأخرى، التي تساعد المسنين المصابين بالخرف على البقاء آمنين في منازلهم وفي المجتمع، مما يوفر الطمأنينة لمقدمي الرعاية.

يمكن أن يساهم أصحاب المصلحة في المجتمع في إنشاء بيئات صديقة للمسنين ومتوافقة مع احتياجات مرضى الخرف، بدءًا من المساحات الخارجية ووصولًا إلى الخدمات العامة (مثل المكتبات والمقاهي) والأعمال التجارية.

5.6.2 المنتجات المساعِدة، بما في ذلك وسائل دعم الذاكرة

يمكن أن تساعد المنتجات المساعِدة، بما في ذلك وسائل دعم الذاكرة (مثل الملاحظات، والتذكيرات، والتقاويم)، الأشخاص الذين يعانون من تراجع معرفي على تذكر الأمور المهمة والحفاظ على درجة من الاستقلالية في حياتهم. ويمكن أن يكون وضع الملاحظات والتذكيرات الأخرى في أنحاء المنزل مفيدًا، مثل قائمة أو صور بالقرب من الباب لتذكير الشخص بما يجب أن يأخذه معه عند مغادرة المنزل. كما يمكن لصق ملصقات على الخزائن لتحديد أماكن الأشياء، ووضع علامات على الأدوات لشرح كيفية استخدامها، مما يسهل عليهم العثور على الأشياء الضرورية. إذا كان الهاتف الذكي متاحًا، فقد تكون التنبيهات، والتطبيقات، ووظائف التقويم أدوات مساعِدة مفيدة للذاكرة. كما يمكن أن تساعد صناديق الأدوية أو المنظِّمات الدوائية في تذكر مواعيد تناول الأدوية وفقًا للوصفات الطبية.

تشمل التذكيرات المحتملة ما يلي:

- الأعمال المنزلية
- الأدوية ومواعيد تناولها
- قوائم التسوق
- أرقام هواتف الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة وخدمات الطوارئ
- كيفية تنفيذ المهام المهمة.

5.6.3 تحسين البيئة المادية للحد من خطر السقوط

يمكن أن يساهم تقييم البيئة المادية وإجراء التعديلات المناسبة في تقليل خطر السقوط. ← 4.2.5

5.6.4

دعم مقدمي الرعاية ← 12

قد يكون تقديم الرعاية لشخص مسن يعاني من تراجع معرفي، بما في ذلك الخرف، تجربة مُرهِقة. ومع تفاقم التدهور المعرفي، قد يعاني الشخص من زيادة في النسيان ويحتاج إلى مساعدة متزايدة في المهام اليومية. قد لا يتعرف على أقاربه أو أصدقائه، وقد يواجه تغيرات سلوكية محزنة يصعُب على مقدمي الرعاية تدبيرها. وقد تؤثر هذه المتطلبات سلبًا على صحة مقدمي الرعاية ورفاههم.

من الضروري أن يحصل مقدمو الرعاية على الدعم اللازم للحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى تلقي المعلومات والتدريب اللازمين لمساعدتهم في تقديم الرعاية.

يمكن أن يشمل هذا الدعم التركيز على أهمية الحفاظ على روتين يومي ثابت، وتحديد عوامل الخطر البيئي المرتبطة بالسقوط وإجراء التعديلات المناسبة، بالإضافة إلى تسجيل تفاصيل حوادث السقوط بدقة (← **4.2.5**)، وتعليم كيفية استخدام المنتجات المساعِدة، وكيفية التعامل مع السلوكيات الصعبة، والاستجابة في حال نسي الشخص الذي يعتنون به هويتهم أو لم يعد يتعرف عليهم.

مزيد من المعلومات

- *دليل منظمة الصحة العالمية iSupport للخرف: دليل التدريب والدعم لمقدمي الرعاية غير المأجورين للأشخاص المصابين بالخرف*. WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/324794).



6

القدرة على الحركة

مسار الرعاية لتحسين القدرة على الحركة

تشير الصحة العضلية الهيكلية إلى كفاءة الجهاز الحركي، الذي يتألف من العضلات والعظام والمفاصل والأعصاب والأنسجة الضامة. تُعرَّف القدرة على الحركة بأنها حالة الجهاز العضلي الهيكلي للشخص، وتشمل التحمل، والتوازن، وقوة العضلات، ووظيفتها، وقوة المفاصل، وكيفية تغيرها مع مرور الوقت *(27)*. تعتمد الحركة على التفاعل بين القدرة على الحركة والبيئة المحيطة بالشخص. وتُعد القدرة على الحركة عاملاً حاسمًا في الحفاظ على الاستقلالية والاعتماد على الذات.

يرتبط الوضع التغذوي ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على الحركة. كما أن الألم يؤثر على القدرة على الحركة، والتوازن، والتنسيق، مما قد يزيد من خطر السقوط. توجد استراتيجيات فعالة لتحسين القدرة على الحركة والحفاظ عليها مع تقدم العمر.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع إجراء تقييم أساسي لمحدودية القدرة على الحركة عبر اختبار بسيط.
- يُعد برنامج التمارين متعددة الأنماط، المصمَّم وفقًا لقدرات واحتياجات الشخص، النهج الأكثر فعالية لتحسين القدرة على الحركة أو الحفاظ عليها، إلى جانب التدخلات التغذوية.
- يجب على العاملين الصحيين تقييم الألم ودمج استراتيجيات تدبيره ضمن خطة رعاية مُشخصنة.
- يمكن أن تساعد المنتجات المساعِدة المسنين في الحفاظ على قدرتهم على الحركة رغم التدهور في الأداء الحركي.
- كما يمكن أن تساهم التعديلات البيئية داخل المنزل وفي محيطه في دعم القدرة الوظيفية لدى المسنين الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة.
- يمكن للمنظمات المجتمعية، وكذلك المسنين أنفسهم، دعم الالتزام بممارسة النشاط البدني، بما في ذلك التمارين الرياضية، عبر إنشاء أنشطة خاصة بهم وتوفير الدعم المتبادل بين الأقران.

6

القدرة على الحركة

مسار الرعاية لتحسين القدرة على الحركة

تقييم
(أساسي)
3.1 ←

اجتياز

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة ومنها تقديم نصائح لتعزيز النشاط البدني ← 6.1
- إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم

رسوب

- تصميم برامج تمارين بدنية للأشخاص الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة ← 6.2
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"

(يمكن تقييم "أ" و"ب" و"ج" بأي ترتيب)

أ

تقييم
القدرة على الحركة

مثال: مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير (SPPB) 1

إذا كانت القدرة على الحركة طبيعية
(10-12 درجة لاختبارات SPPB)

- تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز النشاط البدني وتجنب السقوط ← 6.1، 4.2.5

إذا كانت القدرة على الحركة محدودة
(0–9 درجة لاختبارات SPPB)

- تقديم الدعم من أجل الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية
- توفير تمارين متعددة الأنماط تحت إشراف وثيق ← 6.4.2
- النظر في زيادة مدخول البروتين ← 7.2

التمرين متعدد الوسائط

يجمع برنامج التمرين متعدد الأنماط للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بين أنواع مختلفة من التمارين مع التركيز على مجموعات العضلات الأساسية مثل الظهر والفخذ والبطن وأسفل الجسم

ب

تقييم
الأمراض وعوامل الخطر

- الأدوية غير المناسبة
- الألم
- الحالات العضلية الهيكلية (مثل الفصال العظمي، وهشاشة العظام، والساركوبينيا)
- السَّلَس البولي
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 2

ج

تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية

- مخاطر السقوط في المنزل ومحيطه
- الحاجة إلى المنتجات المساعِدة على الحركة
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية بما فيها أنشطة الحياة اليومية
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية (التدريب على نقل المسن)
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 3

دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع
خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

إعادة التقدير

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من فقدان كبير في القدرة الذاتية والمراضات المشتركة (4.2.1)
- التعامل مع الألم المزمن الذي يحد من النشاط (6.5.2)
- التعامل مع الألم والمعاناة متعددة الأبعاد المرتبطة بالأمراض المهددة للحياة (4.2.3)
- تمارين مخصصة استنادًا إلى تقييم مخاطر السلامة (جدول 6.1)
- توفير وصيانة المنتجات المساعِدة على الحركة (6.6.2)

1 تقييم القدرة على الحركة ← 6.3

مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير (SPPB)

يقيس اختبار الأداء البدني القصير (SPPB) الأداء الزمني في ثلاث مهام، حيث يتم تقييم كل مهمة من أربع نقاط، مع إجمالي نقاط يتراوح من 0 (الأسوأ) إلى 12 (الأفضل).

وصف كل اختبار وسؤال الشخص إذا كان يشعر بأنه قادر على القيام به. وإذا لم يكن كذلك، وضع درجة لذلك والانتقال إلى الخطوة التالية.

1. **التوازن:** الوقوف لمدة 10 ثوانٍ على أن تكون القدمان في أحد الأوضاع الثلاثة في كل مرة. استخدام مجموع الدرجات الثلاث. إذا لم يتم محاولة أي منها، انهاء اختبارات التوازن.

2. **اختبار سرعة المشي:** الوقت اللازم لقطع 4 أمتار مشيًا

< 4.82 ثوانٍ	4 نقاط
6.20–4.82 ثوانٍ	3 نقاط
8.70–6.21 ثوانٍ	نقطتان
> 8.70 ثوانٍ	نقطة واحدة
العجز على الإكمال	0 نقطة

3. **القيام من الكرسي:** الوقت اللازم للقيام من الكرسي خمس مرات

< 11.19 ثانية	4 نقاط
13.69–11.2 ثانية	3 نقاط
16.69–13.7 ثانية	نقطتان
59.90–16.7 ثانية	نقطة واحدة
> 60 ثانية أو العجز عن الإكمال	0 نقطة

درجة SPPB النهائية = حاصل الدرجات من الاختبارات الثلاثة أعلاه.

الوقوف جنبا إلى جنب:		
	البقاء لمدة 10 ثوان	نقطة واحدة
	عدم البقاء لمدة 10 ثوان	0 نقطة
	عدم المحاولة	0 نقطة
الوقوف شبه الترادفي		
	البقاء لمدة 10 ثوان	نقطة واحدة
	عدم البقاء لمدة 10 ثوان	0 نقطة
	عدم المحاولة	0 نقطة
الوقوف الترادفي		
	البقاء لمدة 10 ثوان	نقطتان
	البقاء من 3 إلى < 10 ثوان	نقطة واحدة
	البقاء لمدة < 3 ثوان	0 نقطة
	عدم المحاولة	0 نقطة

في حال عدم محاولة أي من الاختبارات أعلاه، يجب إيقاف اختبارات التوازن

2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 6.5

- **الأدوية غير المناسبة** ← مراجعة الأدوية وسحبها أو وصف بدائل (6.5.1)
- **الألم** ← التعامل مع الألم بما في ذلك من خلال التمارين البدنية والتدخلات النفسية (6.5.2)
- **الحالات العضلية الهيكلية** ← التعامل مع الأمراض (6.5.3)
- **السَّلَس البولي** ← انظر مسار رعاية السَّلَس البولي ← 13

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 6.6

- **خطر السقوط** ← تعزيز البيئات المادية في المنزل ومحيطه (4.2.5)
- **الحاجة إلى المنتجات المساعِدة** ← توفير المنتجات المساعِدة على الحركة وتقديم نصائح حول استخدامها وصيانتها (6.6.2)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← توفير الرعاية الشخصية والدعم في الأنشطة اليومية (11.6)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← دعم الوصول إلى الرعاية الصحية والحصول على الأدوية (6.6.3)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← توفير تدريب على نقل المسن الذي يعاني من فقدان القدرة على الحركة ووضعه في الوضعية المناسبة (12.4)

كيف يؤثر الألم على القدرة على الحركة ← 6.5.2

الألم هو تجربة حسية وعاطفية فريدة وغير سارة يمكن أن تحد من الأنشطة وتُصعّب الحياة اليومية. قد يسبب عدم الراحة، ويحد من الحركة، ويؤثر على النوم والمشاركة الاجتماعية. يتأثر بظروف الشخص الجسدية والنفسية والاجتماعية والثقافية والروحية. يمكن أن يؤثر الألم أيضًا على الحالة المزاجية والدافعية والصحة العامة والأعراض الاكتئابية. يمكن أن يكون حادًا، لكنه غالبًا ما يكون مزمنًا (أطول من 3 أشهر) لدى المسنين. يمكن أن يحد الألم الشديد المرتبط بالحركة من ممارسة التمارين البدنية أو يسبب الإحجام عنها. وتشمل معالجة الألم إجراء تقييم شامل له، وفهم أهداف الشخص في التعامل مع الألم، واستخدام الأساليب غير الدوائية والدوائية لتحقيق السيطرة المثلى على الألم.

6.1
نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز النشاط البدني

يجب على الجميع ممارسة النشاط البدني بانتظام. إذ أن منافعه مثبتة، بما في ذلك للمسنين وللأشخاص الذين يعانون من الألم. وتشمل هذه المنافع الوقاية من عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية والسيطرة عليها، وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق، وتعزيز الوظائف المعرفية، وتحسين االقدرة على الحركة وتجنب السقوط، وتعزيز صحة العظام، مما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام *(28)*.

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة في المجتمع تقديم نصائح بشأن النشاط البدني لجميع المسنين، بما في ذلك أولئك الذين قد يواجهون فقدانًا محتملاً في القدرة على الحركة. يمكن تقديم هذه نصائح جنبًا إلى جنب مع النصائح العامة المتعلقة بالصحة ونمط الحياة. ← **3.1.3** يجب أن تراعي نصائح المتعلقة بالنشاط البدني القدرة الذاتية للشخص، وبيئته الاجتماعية والمادية، بالإضافة إلى التصورات الثقافية ومدى تقبل النشاط البدني في سياقه. كما يجب أن تتضمن التأكيد على أن الإفراط في النشاط البدني، بما في ذلك العمل البدني الشاق، قد لا يكون مفيدًا.

لكل المسنين ومقدمي الرعاية:

- يمكن لجميع المسنين الاستفادة من النشاط البدني، بغض النظر عن مستوى قدرتهم على الحركة.
- كل حركة لها أهمية. أي مقدار من النشاط البدني أفضل من عدمه. يمكن للمسنين البدء ببطء بممارسة نشاط بدني بسيط ثم زيادة التكرار والشدة تدريجيًا. تجريب المشي، ركوب الدراجة، الجري، السباحة، الأعمال المنزلية اليومية، البستنة، الرقص والرياضة.
- التقليل من السلوكيات الخاملة ضروري للحفاظ على الصحة. إن القدرة على الحركة واستبدال وقت الجلوس الطويل بأي نشاط بدني، بغض النظر عن شدته، يجلب منافع صحية.
- يجب أن يكون النشاط البدني متناسبًا مع القدرات الفردية لكل شخص.
- كما أن اتباع نظام غذائي صحي أمر ضروري أيضًا. ← **7.1**

يُعد النشاط البدني مهمًا أيضًا لمقدمي الرعاية، حيث يساهم في تعزيز صحتهم البدنية والعقلية، وزيادة قدرتهم على التكيّف. تزداد أهمية هذا الأمر إذا تراجعت قدرة المسن على الحركة، مما يضطر مقدمي الرعاية غير المأجورين إلى أداء مهام بدنية تتطلب مجهودًا أكبر، مثل المساعدة في التنقل والنقل والرفع.

كل أسبوع:

- كل أسبوع: ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني الهوائي معتدل الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني الهوائي عالي الشدة، أو مزيج مكافئ من الاثنين معًا.
- يُوصى باستهداف 300 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة أو 150 دقيقة من النشاط البدني عالي الشدة أسبوعيًا لتحقيق فوائد صحية أكبر.
- يُفضل أن تستمر كل جلسة تمرين لمدة 10 دقائق على الأقل.
- ممارسة تمارين تقوية العضلات التي تستهدف جميع مجموعات العضلات الرئيسية يومين أو أكثر أسبوعيًا.
- ممارسة تمارين لتحسين التوازن 3 أيام أو أكثر أسبوعيًا.
- ممارسة النشاط البدني متعدد الأنماط مما يجمع بين تمارين التوازن وتقوية العضلات 3 أيام أو أكثر أسبوعيًا.
- إذا لم يكن بالإمكان ممارسة التمارين بالمقدار الموصى به، فحاول أن تكون نشطًا بدنيًا قدر الإمكان.

النشاط البدني معتدل الشدة: يتميز بزيادة معدل ضربات القلب عن المعتاد وبدء التعرُّق. يكون التحدث أثناء التمرين صعبًا لكنه ليس مستحيلًا.

النشاط البدني عالي الشدة: يتميز بزيادة كبيرة في معدل ضربات القلب وصعوبة في التنفس. يصبح التحدث أثناء التمرين شبه مستحيل، ويكون التعرُّق شديدًا.

بالنسبة للمسنين الذين يحتمل أنهم يعانون من محدودية الحركة، يمكن اتخاذ التدابير التالية لتجنب السقوط:

- يمكن أن تساهم بعض الأنشطة في تجنب السقوط، مثل تمارين التوازن واليوغا.
- يجب تعديل البيئة المنزلية من خلال تحسين الإضاءة، وتعزيز التباين باستخدام الألوان، وتركيب الدرابزينات وقضبان الإمساك.
- الاهتمام بصحة القدمين، والحرص على النظافة الشخصية، وارتداء الأحذية المناسبة.

6.2
الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة محدودية القدرة على الحركة

6.2.1
النشاط البدني

إذا تبيَّن من خلال التقييم الأساسي للرعاية المتكاملة للمسنين أن المسن قد يعاني من محدودية القدرة على الحركة، ولم يكن التقييم المعمَّق متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة الآخرين تقديم نصائح أكثر تفصيلًا، وتيسير الوصول إلى الفرص المجتمعية لممارسة النشاط البدني. يمكن أن يشمل ذلك دروسًا منظمة للتمارين الرياضية، وكذلك مجموعات وأنشطة غير رسمية. ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك مجموعات المسنين، تنظيم أنشطة رياضية مثل مجموعات المشي السريع، ودروس "تاي تشي" المنتظمة في الحدائق المحلية، أو دروس اليوغا في القاعات المجتمعية، إلى جانب توفير مدربين مؤهلين لتوجيه هذه التمارين. يتيح هذا فرصًا لتعزيز المشاركة الاجتماعية وتوفير الدعم من الأقران، مما قد يحفز المسنين على الاستمرار في ممارسة النشاط البدني.

إذا كان هناك شك بشأن سلامة التمرين، فيجب إحالة الشخص إلى عامل رعاية صحية مؤهل وذو معرفة (المربع 6.1، الصفحة 69).

قد تكون الأنشطة المشتركة بين الأجيال خيارًا مناسبًا أيضًا، حيثما كان ذلك مرغوبًا ومفيدًا للمسنين. يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع التعاون مع السلطات المحلية ومقدمي الخدمات الآخرين (مثل التجمعات الدينية والصالات الرياضية) لتخصيص أوقات خاصة لتمارين المسنين، وتحسين البيئة المادية من خلال برامج المدن والمجتمعات الصديقة للمسنين.

مزيد من المعلومات

- *النشاط البدني*. WHO; 2024 (https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity)
- *تعزيز النشاط البدني للمسنين: مجموعة أدوات العمل*. WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/373332).
- *المبادئ التوجيهية العالمية بشأن النشاط البدني والسلوكيات المنطوية على قلة الحركة: لمحة سريعة*. WHO; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/337001).

6.3 تقييم القدرة على الحركة

يمكن تقييم القدرة على الحركة بمزيد من التفصيل باستخدام اختبار الأداء البدني. تُعد مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير (SPPB) *(29)* من أكثر الأدوات استخدامًا وتوصيةً بها على نطاق واسع. وتتمتع بخصائص قياس ممتازة، مما يجعلها مفيدة لمجموعة واسعة من القدرات. تتألف مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير من اختبار التوازن(SPPB) ، واختبار سرعة المشي، واختبار النهوض من الكرسي، حيث تُجمع الدرجات معًا لتحديد الأداء البدني للشخص، بما في ذلك القدرة على الحركة. وفي حال كان الشخص يستخدم منتجًا مساعِدًا، يمكن النظر في اختبارات بديلة أو معدلة، سواء مع المنتج أو بدونه.

مزيد من المعلومات حول مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير، وما تتضمنه وكيف يتم تقييمه يمكن العثور عليها في الصفحة 65. 1

يحدد مسار الرعاية هذا مسارين مختلفين استنادًا إلى النتيجة الإجمالية. يجب أن يخضع الأشخاص الذين تم تقييم قدرتهم على الحركة على أنها طبيعية لتقييم إضافي للأمراض وعوامل الخطر، بالإضافة إلى بيئتهم الاجتماعية والمادية.

كما يجب التحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل سوء التغذية، وإجراء تقييم إضافي عند الحاجة. ← 7

يجب إجراء تقييم حالة السَّلَس البولي وتدبيره بشكل مناسب. ← 13

6.4 تدبير محدودية القدرة على الحركة

يجب تقديم التدخلات لتدبير محدودية القدرة على الحركة دائمًا كجزء من خطة رعاية مُشخصنة شاملة، تشمل الأمراض المستبطنة (مثل الحالات العضلية الهيكلية) والعوامل المساهمة في محدودية القدرة على الحركة، مثل الألم أو مشاكل المفاصل، إضافةً إلى التدخلات في مجالات أخرى من القدرة الذاتية.

بالإضافة إلى تعزيز النشاط البدني، بما في ذلك التمارين الرياضية التي تُقدّم في المجتمع، هناك العديد من الطرق الأخرى تدبير محدودية القدرة على الحركة. ويجب النظر في برامج التمارين متعددة الأنماط، وزيادة تناول البروتين، والإحالة إلى خدمات التأهيل.

6.4.1 دعم الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية

يساهم دعم الرعاية الذاتية والإدارة الذاتية للنشاط البدني في تعزيز الالتزام وزيادة الفوائد، كما يساعد في تخفيف الألم. يمكن للأشخاص الذين تتراوح درجاتهم في مجموعة اختبارات الأداء البدني القصير (SPPB) بين 12-10، والذين يُعتبرون ذوي قدرة تحركية طبيعية، ممارسة التمارين بمفردهم في المنزل والمجتمع. كما يمكن للأشخاص الذين حصلوا على درجات أقل ممارسة التمارين، بشرط حصولهم على نصائح والدعم والمتابعة الدقيقة.

6.4.2 التمارين متعددة الأنماط

يجب تصميم برنامج تمارين متعددة الأنماط للأشخاص الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة، بحيث يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجاتهم وتفضيلاتهم، على أن يتم تقديمه تحت الإشراف لضمان سلامة التمارين (المربع 6.1، الصفحة 69). يجب إعطاء الأولوية لاستخدام المعدات الآمنة والمألوفة، مع التركيز على أداء تمارين الإحماء والتهدئة بعناية لتجنب الإصابات. كما يجب مراعاة التصورات الثقافية والعوامل المرتبطة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك مدى تقبل ممارسة التمارين. تساهم التمارين متعددة الأنماط أيضًا في تقليل خطر السقوط. ← 4.2.5

عندما يحدّ الألم من القدرة على الحركة، فإن تنظيم التمارين وفقًا لفترات زمنية ميسورة وزيادة الأنشطة البدنية بوتيرة تدريجية يساعدان على بناء قدرة الجسم على التحمل وتدبير الألم. يجب التفكير في تدبير الألم وتقديمها بشكل مناسب إلى جانب التمارين البدنية. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان كبير في القدرة على الحركة، فإن إجراء التدريبات البدنية في الفراش أو في وضع الجلوس على كرسي يمكن أن يشكل نقطة للبداية. أما بالنسبة للأشخاص المعانين من التدهور المعرفي أو الخرف، فإن برنامجًا بسيطًا للتمارين أقل انتظامًا قد يكون أكثر ملاءمة.

المربع 6.1 سلامة التمارين الرياضية

قبل تقديم نصائح بشأن التمارين الرياضية أو وضع برنامج التمارين، ينبغي الاستفسار عن الظروف الصحية التي قد تؤثر على نوع وشدة النشاط. إذا أجاب الشخص بنعم على أي من الأسئلة التالية، فيجب أن يقوم أخصائي صحي بوضع برنامج مخصص للتمارين.

- هل شعرت بألم في الصدر أو بخفقان في القلب خلال الشهر الماضي؟
- هل تعرَّضت لنوبة قلبية خلال الأشهر الستة الماضية؟
- هل فقدت الوعي أو أغمي عليك؟
- هل سقطت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية؟
- هل تعرضت لكسر في العظام خلال الشهر الماضي؟
- هل تشعر بضيق في التنفس أثناء أداء الأنشطة اليومية العادية في المنزل، مثل ارتداء الملابس؟
- عند المشي، هل تحتاج إلى الاستعانة بدعائم، مثل التمسك بالأثاث أو الاستناد إلى شخص آخر؟
- هل تعاني من مرض في المفاصل أو العضلات يعيق قدرتك على ممارسة التمارين الرياضية؟
- هل طلب منك مقدم الرعاية الصحية تقليل أو تجنب ممارسة التمارين الرياضية؟

إذا كان المسن يعاني من حالات مزمنة أو فقدان مهم للقدرة الذاتية، أو كان الألم يحدّ من قدرته على الحركة، فيجب استشارة المهنيين الصحيين للحصول على نصائح بشأن نوع ومقدار التمارين البدنية المناسبة.

يجب تصميم برنامج تمارين متعددة الأنماط للأشخاص الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي، بما في ذلك توفر المرافق وأجهزة التمرين. وهناك طرق متعددة يمكن أن يمارس بها الأشخاص التمرين، ويمكن تكييف أنواع محددة من التدريب. لا يشترط وجود صالة رياضية أو معدات متخصصة. يجب أن يتضمن البرنامج للمسنين الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة ما يلي:

- **تدريبات القوة/المقاومة**، تتطلب هذه التدريبات أن تعمل العضلات تحت الحمل، باستخدام الأوزان أو أحزمة المقاومة، أو تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء، والاندفاع، والجلوس والوقوف. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك البستنة الثقيلة وصعود السلالم. إذا لم تكن الأوزان الرياضية متاحة، يمكن استخدام أدوات منزلية، مثل علب الطعام أو أكياس الفاصولياء أو الأرز.

- **التدريبات الهوائية/القلبية الوعائية**، مثل المشي السريع، وركوب الدراجة أو الرقص الذي يزيد من معدل ضربات القلب حتى يصبح الشخص قريبًا قليلًا من انقطاع التنفس لكن لديه القدرة على تبادل الحديث؛ ومن المهم القيام بتمارين الإحماء والتهدئة بعد التمرين الهوائي من خلال القيام بتمارين إطالة خفيفة والمشي بوتيرة أبطأ.

- **تدريبات التوازن**، التي تتحدى التوازن والتنسيق الحركي، بما في ذلك التمارين الثابتة والديناميكية؛ يمكن أن تتقدم بحيث تُنفَّذ على سطوح مختلفة مع فتح العيون وإغماضها؛ من الأمثلة على ذلك الوقوف على ساق واحدة في كل مرة وممارسة مشية العقب ثم الأصابع في خط مستقيم.

- **تدريبات المرونة**، التي تحسن من سحوبية الأنسجة الرقيقة، مثل العضلات، ومدى حركة المفاصل؛ من الأمثلة على ذلك تمارين الإطالة، واليوغا، وتاي تشي، وتمارين بيلاتس.

يقدم مشروع Vivifrail دليلًا عمليًا لوضع برنامج مخصوص للتمارين، استنادًا إلى القدرة على الحركة ومخاطر السقوط *(30)*.

التدخلات التغذوية، بما في ذلك تقديم نصائح الغذائية مثل زيادة مدخول البروتين، يمكن أن تعزز فوائد برنامج التمارين البدنية. ← 7

6.5 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر ومعالجتها

6.5.1 الأدوية غير المناسبة

قد تؤدي بعض الأدوية إلى إضعاف القدرة الحركية أو التأثير عليها، ومع ذلك تُوصَف في بعض الأحيان. في بعض الحالات، قد تفوق الأضرار المحتملة لهذه الأدوية فوائدها لدى بعض الأشخاص *(31)*. ومن بين هذه الأدوية، تلك التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الأدوية ذات التأثيرات المضادة للكولين (مثل البنزوديازيبينات، الأفيونيات، ومضادات الاكتئاب). ← 4.2.4

6.5.2 الألم

قد يؤدي الألم إلى صعوبة في الحياة اليومية للمسن. لذا فإن تقييم الألم وتدبيره أمران مهمان.

مقياس التقييم العددي للألم
0 = لا يوجد ألم
2 = مؤلم قليلًا
4 = مؤلم أكثر قليلًا
6 = مؤلم أكثر
8 = مؤلم بشدة
10 = الألم أسوء مما يمكن تخيله

تقييم الألم

من المفيد تصنيف شدة الألم كجزء من التقييم المتمركز على الشخص، وذلك للمساعدة في تصميم برنامج تمارين بدنية ولإدارة الألم. يجب تحديد الألم مبكرًا (من حيث الشدة والسبب) لتيسير تدبير فقدان القدرة على الحركة وأعراض الاكتئاب. وهناك عدة مقاييس للألم مثل مقياس التقييم الرقمي وقائمة الألم المختصرة *(32)*. مقياس التقييم الرقمي هو مقياس مكون من 11 نقطة لتقرير المريض عن الألم. يجب سؤال الشخص عن شدة الألم، وتوقيته (في الصباح، أثناء النوم ليلًا، أو أثناء أو بعد التمرين)، ومدة استمراره.

تدبير الألم

الهدف من إدارة الألم *(33)* هو تخفيف الألم إلى مستوى يسمح بجودة حياة مقبولة. أخصائيي الرعاية الصحيةعندما يكون الألم حاجزًا كبيرًا أمام الحركة والنشاط، يجب على أخصائي صحي لديه معرفة متخصصة في تدبير الألم وضع استراتيجيات مناسبة، بما في ذلك وصف الأدوية مع المتابعة الدقيقة، وذلك لدمجها في خطة رعاية مُشخصنة. وقد تشمل الخطة أيضًا الإحالة إلى خدمات التأهيل أو تلقي الرعاية التلطيفية.← 4.2.1, 4.2.3

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك مجموعات المسنين، أيضًا تقديم نصائح والدعم للمسنين الذين يعانون من الألم، بما في ذلك من خلال إنشاء مجموعات دعم الأقران.

قد تشمل تدخلات علاج الألم ما يلي:

- الإدارة الذاتية، بما في ذلك الحفاظ على النشاط البدني، وتطبيق الحرارة والبرودة، وتغيير وضعية الجسم وتقليل فترات الخمول، وإدارة التوتر عبر تقنيات الاسترخاء، والنوم الجيد، وتعديل التفكير للتركيز بشكل أكبر على الأفكار الإيجابية؛
- والتمارين البدنية؛
- والعلاج اليدوي مثل التدليك والتلاعب بالمفاصل وتحريكها؛
- والعلاج النفسي، بما في ذلك العلاج المعرفي السلوكي؛ ← 10.4
- والوخز بالإبر؛
- والمنتجات المساعِدة لدعم القدرة على الحركة؛
- والأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ويجب استخدامها بحذر شديد نظرًا لخطر آثارها الجانبية على الجهاز الهضمي ووظائف الكلى. في الحالات الضرورية فقط، يتطلب استخدام هذه الأدوية مراجعة دقيقة للسجل الطبي، ومراجعة الأدوية المستخدمة، والمتابعة الدقيقة، وأقصر مدة علاج ممكنة.

الألم المرتبط بالأمراض الخطيرة

يُعد الألم أحد الأعراض الشائعة والخطيرة التي يعاني منها المرضى المصابون بأمراض خطيرة. يجب توفير الرعاية التلطيفية، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مهددة للحياة أو مزمنة تتفاقم تدريجيًا، مثل الخرف ومرض الانسداد الرئوي المزمن

وفشل القلب، وذلك لتجنب المعاناة وتخفيفها من خلال التعرف المبكر على الألم، وتقييمه بشكل صحيح، وعلاجه، بالإضافة إلى التعامل مع المشاكل الأخرى. وقد تكون هناك حاجة إلى تخفيف الألم في جميع مراحل المرض، وليس فقط في نهاية الحياة. يجب مراجعة حالة هؤلاء المرضى بانتظام، حيث قد يحتاجون إلى جرعات متزايدة من مسكنات الألم مع تقدم مرضهم. ← 4.2.3

يجب تحقيق توازن بين فائدة تخفيف الألم والمخاطر المحتملة، بما في ذلك التأثيرات الضارة والجرعة الزائدة التي قد تؤدي إلى تثبيط التنفس. ويعد الرصد المنتظم ضروريًا للحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المواد الأفيونية، إذ يساهم في التعرف المبكر على التأثيرات الضارة المحتملة.

الألم المرتبط بالاضطرابات العضلية الهيكلية

غالبًا ما تتسبب الاضطرابات العضلية الهيكلية التي تؤثر على القدرة على الحركة في التسبب بألم مزمن. ولا يمكن دائمًا اكتشاف سبب بيولوجي محدد للألم المستمر. لذلك، يعتمد التقييم الشامل والرعاية الشخصية على نهج بيولوجي-نفسي-اجتماعي، لمعالجة العوامل المتعددة المرتبطة بالألم، بما في ذلك العوامل الجسدية مثل قوة العضلات، ومدى الحركة، والقدرة على التحمل، إلى جانب العوامل النفسية مثل التكيف مع الألم، والعوامل الاجتماعية.

آلام أسفل الظهر المزمنة

يُعد ألم أسفل الظهر المزمن أو المتكرر (الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر) من الحالات الشائعة بين المسنين، بالإضافة إلى الألم الناتج عن اضطرابات عضلية هيكلية أخرى. ويؤدي ألم أسفل الظهر المزمن إلى مستويات عالية من العجز وتأثير واضح على جودة الحياة. نظرًا لأن العاملين الصحيين قد يحددون أمراضًا مستبطنة أو آفات هيكلية (مثل، التهاب المفاصل أو الكسور القديمة) لدى المسنين، فإن تقييمهم السريري والنهج الشامل، يعدَّان أمرًا بالغ الأهمية لتشخيص ألم أسفل الظهر المزمن الأولي. يوصي *الدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية حول الإدارة غير الجراحية لآلام أسفل الظهر المزمنة الأولية لدى البالغين في الرعاية الأولية* والمجتمعية بعشرة تدخلات تشمل التثقيف، والعلاج البدني، والعلاج النفسي، والأدوية، والتدخلات متعددة المكونات (**الجدول 6.1**). بالإضافة إلى هذه التدخلات، يجب أخذ المنتجات المساعِدة على الحركة بعين الاعتبار.

6.5.3
تدبير الاضطرابات العضلية الهيكلية

يمكن أن تؤدي الاضطرابات العضلية الهيكلية مثل الفُصال العظمي، وهشاشة العظام، والساركوبينيا إلى تراجع في القدرة على الحركة.

الفُصال العظمي هو حالة تنكسية تصيب المفاصل والأنسجة المحيطة بها. وتسبب الألم والتورم والتيبس، وقد تؤدي إلى فقدان كبير في القدرة على الحركة، وانخفاض المشاركة الاجتماعية وجودة الحياة، وزيادة الضغوط النفسية. وهي أكثر شيوعًا في الركبتين والوركين والعمود الفقري واليدين.

الجدول 6.1
التدخلات الموصى بها لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة الأولية لدى البالغين

فئة التدخُّل	التدخُّلات
التثقيف	• التثقيف أو الإرشاد المنظم والمُقنن
التدخلات الجسدية	• العلاجات أو البرامج الرياضية المنظمة • العلاجات المطلوبة • العلاج بالتلاعب بالعمود الفقري • التدليك • المنتجات المساعِدة على الحركة
التدخلات النفسية	• العلاج الإجرائي • العلاج المعرفي السلوكي
الأدوية	• مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDS)* • الفلفل الحار الموضعي *(كابسيكوم فروتيسينس)*
التدخلات متعددة المكونات	• الرعاية البيولوجية النفسية الاجتماعية متعددة المكونات

*هذه التوصية لا تشمل المسنين

مزيد من المعلومات

- *مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية للتدابير العلاجية غير الجراحية لآلام أسفل الظهر الأولية المزمنة لدى البالغين في مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية*. WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/374726).
- *الملخص التنفيذي: مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية للتدابير العلاجية غير الجراحية لآلام أسفل الظهر الأولية المزمنة لدى البالغين في مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية*. WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/374531).

هشاشة العظام تتميز بانخفاض كثافة العظام وتدهور بنيتها، مما يزيد من خطر التعرُّض للكسور، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم. وتعتبر هشاشة العظام أكثر شيوعًا لدى النساء، وغالبًا ما تكون ناجمة عن التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التدخين واستهلاك الكحول والاستخدام طويل الأمد للستيرويدات ونقص الكالسيوم وفيتامين دال وانخفاض الوزن.

الساركوبينيا هي حالة تنكسية تصيب العضلات الهيكلية، تتضمن فقدان كتلة العضلات وقوتها، وترتبط بزيادة في المخاطر السلبية مثل السقوط، تقييد القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية، وانخفاض المشاركة الاجتماعية، وفقدان الاستقلالية، وارتفاع معدلات الوفيات. ← 7.5.1

6.5.4
السَّلَس البولي ← 13

هناك أدلة تُثبت وجود علاقة بين السَّلَس البولي ومحدودية القدرة على الحركة *(34)*، مما قد يؤثر سلبًا على إمكانية الوصول إلى المرحاض. في حال تبيَّن وجود فقدان في القدرة على الحركة، يجب تقييم السَّلَس البولي وتدبيره وفقًا للحالة المناسبة.

6.6
تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

6.6.1
تحسين البيئة المادية للحد من خطر السقوط

يمكن أن يكون تقييم البيئة المادية وإجراء التعديلات المناسبة مفيدًا في تقليل خطر السقوط. ← 4.2.5

6.6.2
المنتجات المساعِدة

يمكن أن تعزز المنتجات المساعِدة على القدرة على الحركة استقلالية المسن وسلامته، ما يتيح له العيش في المنزل لأطول فترة ممكنة. وتشمل المنتجات المساعِدة على القدرة على الحركة أدوات المشي، والمزالق المحمولة، وقضبان الإمساك، وألواح النقل، والكراسي المتحركة. ← 4.2.2

يمكن للمنتجات المساعِدة أن:

- تساعد الشخص على الجلوس أو الوقوف أو المشي.
- تدعم الشخص ليكون أكثر استقلالية في أنشطة الحياة اليومية الأساسية.
- تقلل خطر السقوط أثناء المشي.
- توفر للأشخاص غير القادرين على المشي وسيلة بديلة للتنقل.
- تدعم الشخص في الوصول إلى بيئته (المنزل والمناطق المحيطة به)، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

6.6.3
الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

قد يحتاج المسن ذي القدرة المحدودو على الحركة إلى المساعدة في المهام اليومية، مثل الاستحمام، وارتداء الملابس، واستخدام المرحاض، والخروج من المنزل. كما قد يكون من الضروري التعامل مع التحديات المحتملة المرتبطة بالحصول على الرعاية الصحية والأدوية (مثل، الذهاب إلى الصيدلية) الناتجة عن ضعف القدرة على الحركة، حيث يمكن لمقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة في المجتمع استكشاف طرق بديلة لتيسير الوصول إلى هذه الخدمات.

6.6.4
دعم مقدمي الرعاية ← 12

يجب توفير التدريب لمقدمي الرعاية غير المأجورين حول كيفية مساعدة الشخص على القدرة على الحركة بأمان، مع ضمان حماية أنفسهم أيضًا من الإصابات.

مزيد من المعلومات

المنتجات المساعِدة على الحركة، وأدوات المشي، والمزالق المحمولة. التدريب على المنتجات المساعِدة (https://www.gate-tap.org) ***(TAP)***.



7

الحيوية

مسار الرعاية لتدبير سوء التغذية

تستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلح الحيوية لوصف العوامل الفسيولوجية التي تُسهم في قدرة الفرد الأساسية. قد تشمل هذه العوامل توازن الطاقة والاستقلاب، ووظائف الجهاز العصبي العضلي، ووظائف الاستجابة المناعية والتوتر في الجسم *(35)*.
تحدث تغيرات في تكوين الجسم مع التقدم في العمر، حيث تحل كتلة الدهون محل كتلة العضلات، كما أن التغذية غير الكافية تسهم أيضًا في فقدان كتلة العضلات والقوة (الساركوبينيا). وتؤثر الحالة التغذوية، بما في ذلك الترطيب، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية للحيوية، بشكل كبير على صحة المسن، وقدرته على الأداء وجودة حياته. وقد يؤدي ضعف وظائف الفم إلى تراجع القدرة على المضغ والبلع، وبالتالي التأثير على التغذية. ويتناول هذا الدليل سوء التغذية مع التركيز على نقص التغذية.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع إجراء تقييم أولي للحالة التغذوية بسهولة. ويتطلب التقييم الكامل معرفة متخصصة وعادةً ما يتضمن إجراء تحاليل دم.
- اتباع نظام غذائي غني بالبروتين من خلال الأطعمة المتاحة محليًا والغنية بالبروتين أمر مهم للمسنين.
- عدم شرب كمية كافية من السوائل يؤدي إلى التجفاف. يجب تشجيع المسنين ودعمهم على شرب كميات كافية من السوائل.
- يوفر النظام الغذائي المتوازن بالكميات المناسبة عادةً الفيتامينات والمعادن الضرورية للمسنين، ولكن هناك نقص شائع في فيتامين دال وفيتامين باء 12.
- يُعد فرط الوزن والسمنة من عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، لذا يجب الوقاية منهما وتدبيرهما عبر النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.
- تحويل تناول الطعام إلى نشاط اجتماعي، عبر تناول الطعام معًا في المنزل أو ضمن مجموعات مجتمعية، يمكن أن يشجع المسنين على اتباع نظام غذائي أكثر صحة وتجنُّب العزلة.

7

الحيوية

مسار الرعاية لتدبير سوء التغذية



تقييم
(أساسي)
3.1 ←

اجتياز

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة بما في ذلك نصائح للتغذية الجيدة، والترطيب، والأطعمة المتوفرة محليًا ← 7.1
- تعزيز صحة الفم (إطار 7.1)
- إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم

رسوب

- توفير نظام غذائي متوازن غني بالبروتين للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ← 7.2
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"

(يمكن تقييم "أ" و"ب" و"ج" بأي ترتيب)

أ

تقدير
الوضع التغذوي ❶

إذا كان طبيعيا
(أو خطر سوء التغذية منخفض)

- تقديم نصائح حول الترطيب والأطعمة المتوفرة محليًا ← 7.1
- تعزيز صحة الفم (إطار 7.1)

في حال التعرض لخطر سوء التغذية ← 7.4.2

- تقديم نصائح غذائية مشخصنة
- تسجيل أنماط الأكل وتكييفها
- مراقبة الوزن عن كثب
- أخذ التمارين متعددة الأنماط في الاعتبار ← 6.4.2
- النظر في **التغذية الفموية التكميلية***

إذا تعذَّر تحسين تناول الطعام

في حال سوء التغذية ← 7.4.1

- تقديم نصائح غذائية مشخصنة
- توفير **التغذية التكميلية الفموية*** مع زيادة مدخول البروتين (400-600 سعرة حرارية/اليوم) (إطار 7.2)
- مراقبة المدخول الغذائي والوزن عن كثب

ب

تقييم
الأمراض وعوامل الخطر

- الساركوبينيا
- الحالات الهضمية
- أمراض الفم والمشاكل المتعلقة بالمضغ أو البلع

أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار ❷

ج

تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية

- عادات الأكل الاجتماعية
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية مثل الوصول إلى الطعام والشراب، وتحضيره وتقديمه
- الحاجة إلى المنتجات المساعِدة مثل أدوات الأكل والشرب، أطقم الأسنان
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية

أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار ❸

إعادة التقدير

دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع
خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- التعامل مع الأعراض المَعِدية المعوية مثل القيء المزمن، الإسهال، ألم البطن (7.5.2)
- التعامل مع سوء التغذية في وجود أمراض تؤثر على التمثيل الغذائي مثل السرطان، وفشل القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، وخلل وظائف الكلى، وخلل وظائف الكبد، والسكري
- تقديم استشارات تغذوية مشخصنة للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
- أمراض الفم ومشاكل المضغ والبلع (7.5.3)

1 تقييم الوضع التغذوي ← 7.3

توجد عدة أدوات لتقييم خطر سوء التغذية (وضع تغذوي طبيعي، خطر منخفض أو متوسط لسوء التغذية، أو سوء تغذية مع خطر مرتفع) دون الحاجة إلى إجراء تحليل دم. على سبيل المثال:

Mini nutritional assessment (MNA)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900798001713

Malnutrition universal screening tool (MUST)
https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_full.pdf

Seniors in the community risk evaluation for eating and nutrition questionnaire, version II (SCREEN II)
https://olderadultnutritionscreening.com/screen-tools/

Short nutritional assessment questionnaire 65+ (SNAQ65+) https://clinicalnutrition.science/en/nrs/screenings/snaq-65-.html

2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 7.5

- **الساركوبينيا** ← النظر في إعادة التأهيل لتحسين وظيفة العضلات (7.5.1)
- **الحالات الهضمية** ← التعامل مع الأمراض (7.5.2)
- **أمراض الفم والمشاكل المتعلقة بالمضغ أو البلع** ← التعامل مع أمراض الفم (7.5.3)
- **أمراض الفم والمشاكل المتعلقة بالمضغ أو البلع** ← تقديم نصائح حول قوام الطعام والشراب (مفروم أو مطحون أو مهروس) (7.5.3)

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 7.6

- **عادات الأكل الاجتماعية** ← تشجيع تناول الطعام مع الأسرة وفي المجتمع (7.6.1)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← تنظيم تقديم المساعدة في الوصول إلى الطعام والشراب وإعدادهما وتوفيرهما (7.6.2)
- **الحاجة إلى المنتجات المساعِدة** ← تقديم نصائح حول الوضعية المناسبة للمسن وتوفير المساعدة في تناول الطعام (11.6)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← توفير أدوات المساعدة على الأكل والشرب وأطقم الأسنان (7.6.3)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← تقديم نصائح حول تحضير الطعام والتغذية والشرب (12.4)

ما هو التجفاف؟ ← 7.3.2

التجفاف "نقص كمية الماء في الجسم" وهو حالة شائعة بين المسنين (36). يعاني واحد من كل أربعة مسنين يعيشون في المجتمع أو في منشأة رعاية طويلة الأجل من التجفاف الناتج عن انخفاض مدخول السوائل (التجفاف بسبب شرب كمية قليلة جدًا من السوائل) (37). ومن الضروري تشجيع ودعم تناول كميات كافية من الماء بما يتناسب مع قدرة الفرد وسياقه الاجتماعي.

7.1
نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز التغذية الجيدة وصحة الفم

تتأثر نُظمنا الغذائية وعادات تناولنا للطعام بثقافتنا، وبالنسبة لكثير من الناس، يُعد تناول الطعام حدثًا اجتماعيًا. وبالتالي، يمكن للمجتمعات والعائلات، بما في ذلك مقدمو الرعاية غير المأجورين، أن يؤدوا دورًا رئيسيًا في دعم النظم الغذائية الصحية وتعزيز صحة الفم. ← 3.1.3

يمكن لجميع المسنين الاستفادة من نصائح المتعلقة بالنظام الغذائي الصحي، ولا سيما أولئك المعرضين لخطر سوء التغذية أو المتأثرين به. عند تقديم النصائح بشأن الأنظمة الغذائية الصحية، بما في ذلك الترطيب، من المهم الإشارة إلى أن على المسنين الالتزام بأي تعليمات طبية تلقوها، مثل الحاجة إلى تقييد بعض الأطعمة أو المشروبات بسبب الأمراض والحالات المستبطنة، بما في ذلك التداخلات بين الأدوية والأغذية.

تذكر: من المهم أن يتلقى أفراد العائلة ومقدمو الرعاية الآخرون، بالإضافة إلى المسن نفسه، هذه نصائح، إلى جانب معلومات حول أماكن توفر الأطعمة المحددة ذات التكلفة المناسبة، والتي توفر طاقة كافية (مثل الكربوهيدرات والبروتين)، إضافةً إلى المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن، والتي يمكن شراؤها أو الحصول عليها محليًا من المتاجر والأسواق.

من المهم فيما يتعلق بالمسنين:

- نظافة الغذاء: حافظ على نظافة اليدين ومناطق تحضير الطعام، وافصل بين الطعام النيء والمطبوخ، واطهُ الطعام جيدًا، وخزّنه بشكل صحيح، واستخدم مياه آمنة ونظيفة.
- تناول كميات كافية من الطعام: إذا كان تناول وجبات كبيرة أمرًا صعبًا، فتناول كميات صغيرة بشكل متكرر (5-6 مرات يوميًا).
- يمكن أن تساعد الوجبات العائلية والتجمعات الاجتماعية، خاصةً المسنين الذين يعيشون بمفردهم أو يعانون من العزلة الاجتماعية.
- يجب أن يكون مدخول الكربوهيدرات بشكل أساسي من الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبقوليات، وأن تأتي الدهون من الأطعمة الكاملة، مثل المكسرات، والبذور، والفول، والزيتون، والأسماك الدهنية.
- الترطيب: اشرب ما لا يقل عن 1.6 إلى 2 لتر (6-8 أكواب) من السوائل يوميًا، بانتظام على مدار اليوم. يمكن أن تشمل المشروبات الماء، الشاي، القهوة، عصير الفاكهة، المشروبات الغازية، والشوربات. وستحصل على سوائل إضافية من الطعام. يجب زيادة كمية السوائل المستهلكة عندما يكون الطقس حارا أو في الأماكن الحارة.
- يساعد النشاط البدني على دمج البروتين في العضلات، وزيادة الشهية، والمساهمة في تجنب فرط الوزن والسمنة وتدبيرهما. ← 6.1
- يعد التعرض الآمن لأشعة الشمس ضروريًا لتمكين الجلد من إنتاج فيتامين دال، حيث قد لا يكون فيتامين دال الموجود في الطعام كافيًا للمسنين للحفاظ على مستوياته المثلى في الجسم.
- تعزيز صحة الفم (المربع 7.1، الصفحة 77)
- ينبغي للمسنين الذين يعانون من فرط الوزن أو السمنة تقليل مدخول الطاقة من إجمالي الدهون والسكريات الحرة، وزيادة تناول الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والمكسرات.
- قد يستفيد بعض المسنين، بما في ذلك الذين يعانون من السَّلَس البولي ومحدودية القدرة على الحركة، من تجنب الذهاب المتكرر إلى المرحاض أثناء الليل. في مثل هذه الحالات، يمكن تقليل شرب السوائل في المساء.

بالنسبة للمسنين الذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطرها:

- تقديم نصائح حول ما يجب تناوله وكميته. يُنصح الأشخاص المصابون بداء السكري أو بضعف وظائف الكلى أو الكبد باستشارة أحد العاملين الصحيين للحصول على نصائح غذائية.

- تشجيع المسنين على تسجيل الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها يوميًا في جدول، سواء أثناء الوجبات أو بينها. يمكن أن يساعد ذلك في اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على الترطيب.

فضلًا عن تنظيم الاجتماعات المجتمعية لتقديم نصائح الغذائية، يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم التغذية الصحية من خلال تشجيع تناول الطعام كمناسبة اجتماعية، وتنظيم نوادي الغذاء واجتماعات مجتمعية منتظمة تتضمن تقديم وجبات. كما يمكنهم التعاون مع السلطات المحلية والجهات الأخرى لتخصيص مساحات صغيرة من الأراضي لاستخدامها كحدائق مجتمعية أو منزلية، ويمكن للمسنين والعائلات الذين يزرعون الطعام بالفعل تنظيم أنفسهم لتبادل الفوائض، مما يساهم في تحقيق تنوع غذائي أكبر.

مزيد من المعلومات

- *ملصق التغذية وسلامة الغذاء*. WHO; 2024 (https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/multisectoral-actions-in-food-systems/five-keys-to-safer-food-poster)

- *النظام الغذائي الصحي*. WHO; 2024 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet)

- *دورة تدريبية حول صحة الفم للعاملين الصحيين المجتمعيين في أفريقيا*. WHO Academy:2025 (https://whoacademy.org/coursewares/course-v1:WHOAcademy-Hosted+H0115EN+2025_Q1?source=edX)

المربع 7.1 تعزيز صحة الفم

تُعرِّف منظمة الصحة العالمية صحة الفم بأنها حالة الفم والأسنان والهياكل الفموية الوجهية التي تمكِّن الأفراد من أداء الوظائف الأساسية مثل الأكل والتنفس والتحدث. تشمل صحة الفم أيضًا الأبعاد النفسية والاجتماعية، مثل الثقة بالنفس، والرفاه، والقدرة على التفاعل الاجتماعي والعمل دون ألم أو انزعاج أو إحراج. يُعد سوء نظافة الفم أحد عوامل الخطر لأمراض الفم، مما يؤثر سلبًا على المدخول التغذوي. ترتبط أمراض الفم أيضًا بعوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية، لا سيما داء السكري. يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم نصائح التالية:

- تفريش الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (1000–1500 جزء في المليون) مع الماء الآمن بعد الإفطار وقبل النوم. يُنصح الأشخاص الذين ليس لديهم أسنان بتنظيف اللثة واللسان بفرشاة أسنان ناعمة مرتين يوميًا لإزالة بقايا الطعام والبكتيريا.

- تقديم إرشادات حول نظافة أطقم الأسنان في حال استخدامها.

- تقليل استهلاك السكريات الحرة.

- الإقلاع عن جميع أشكال تعاطي التبغ، بما في ذلك مضغ جوز الأريكا والتنباك.

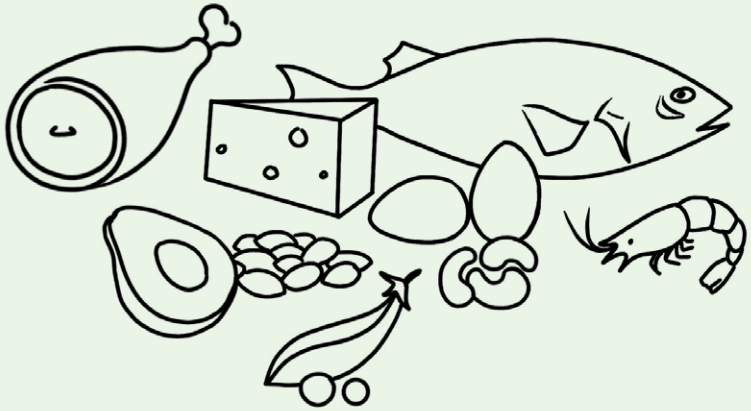
7.2
الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة سوء التغذية

7.2.1
النظام الغذائي الغني بالبروتين

إذا تبيَّن أن أحد المسنين يعاني من سوء التغذية من خلال التقييم الأساسي في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين، ولم يكن التقييم المُعمَّق متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين تقديم الدعم من خلال تقديم إرشادات حول نظام غذائي غني بالبروتين. تُعد البروتينات ضرورية لنمو الخلايا والأنسجة، كما تساهم في تقلص العضلات وحركتها، إضافةً إلى دعم وظائف الجهاز الهضمي والمناعي. ويُعد النظام الغذائي الغني بالبروتين ضروريًا للمسنين الذين يعانون من سوء التغذية، لأن قدرة الجسم على امتصاص البروتين تقل مع التقدم في العمر.

يُوصى للمسنين الذين يعانون من سوء التغذية بتناول 1.0–1.2 غرام من البروتين لكل كغم من وزن الجسم. وقد يحتاج الشخص الذي يتعافى من فقدان الوزن أو مرض حاد أو إصابة إلى تناول ما يصل إلى 1.5 غرام لكل كغم من وزن الجسم. ويجب تقديم إرشادات حول كيفية زيادة النشاط البدني بأمان، إذ يساعد ذلك في تعزيز امتصاص البروتين في العضلات وزيادة الشهية.

الأطعمة الغنية بالبروتينات (> 20 غرام لكل 100 غرام) تشمل البقوليات إضافةً إلى المكسرات، والفاصوليا، والعدس، والبازلاء، والحبوب البقولية المجففة، والبذور، والحبوب، والأجبان، واللحوم، والأسماك. يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين استخدام جداول تركيب الأغذية لتحديد الأطعمة المحلية الغنية بالبروتين والمغذيات الدقيقة (https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/). على الرغم من احتواء بعض البقوليات المجففة على نسبة بروتين مماثلة لمصادر البروتين الحيواني، إلا أنها عند الطهي لا تصبح مكافئة لها تمامًا. نظرًا لاختلاف توفر المجموعات الغذائية والأنواع والعادات الثقافية والتفضيلات الغذائية، قد يكون إعداد قائمة بالأطعمة المحلية مفيدًا للمسنين لتيسير الوصول إلى الأطعمة المتاحة محليًا والغنية بالبروتين.



7.3 تقييم الحالة التغذوية

يجب تحديد الحالة التغذوية وخطر سوء التغذية من خلال تقييم مُعمَّق باستخدام الأدوات المتاحة محليًا والمعتمدة.

توجد أمثلة على الأدوات
في الصفحة 75 1

في أغلب أدوات تقييم التغذية *(38)* يتم تقييم: (أو السؤال عن)

- مدخول الطعام والسوائل
- فقدان الوزن مؤخرًا
- القدرة على الحركة
- ضغط نفسي أو مرض حاد مؤخرًا
- الظروف النفسية
- الوضع المعيشي.

كما تسجل الأدوات ما يلي:

- الوزن
- الطول
- مؤشر كتلة الجسم (BMI – كغم/م^2)
- محيط العضد (MUAC) والرَّبلة.

يمكن أن يؤدي نقص المغذيات الدقيقة، مثل فيتامينات ألف وباء12 ودال؛ والمعادن مثل الحديد، وحمض الفوليك، والكالسيوم، إلى الإصابة بأمراض وحالات صحية مثل فقر الدم وهشاشة العظام *(39)*. يمكن أن يكشف تحليل الدم عن نقص معين في الفيتامينات والمعادن، مما يساعد في توجيه التدخلات التغذوية المناسبة. ويمكن معالجة حالات العوز تلك من خلال المكملات الغذائية الفموية أو الحقن.

يحدد هذا المسار من الرعاية ثلاثة مسارات مختلفة بناءً على مستوى خطر سوء التغذية. ينبغي تقييم الأشخاص الذين تبيّن أن حالتهم التغذوية طبيعية (أي أن مخاطر إصابتهم بسوء التغذية منخفضة)، للتأكد من خلوّهم من الأمراض وعوامل الخطر، وينبغي تقييم بيئاتهم الاجتماعية والمادية.

يجب أيضًا التحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل محدودية القدرة على الحركة أو أعراض الاكتئاب، وإجراء تقييم إضافي عند الحاجة.

← 6 10

7.3.1 تكوين كتلة الجسم والشيخوخة

تبدأ الكتلة العضلية عادةً في التناقص بعد سن 60 عامًا. يساهم كل من سوء التغذية وقلة النشاط البدني في فقدان كتلة العضلات والقوة. وقد ينخفض وزن الجسم أو يظل ثابتًا، مما قد يُخفي هذه التغيرات الضارة المحتملة.

يواجه استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) مع المسنين بعض القيود، إذ يمكن أن يؤدي انهيار الفقرات وتغيرات وضعية الجسم إلى فقدان الطول. وقد يعاني المسن المصاب بسوء التغذية من فقدان أنسجة الجسم الخالية من الدهون مع بقائه ضمن النطاق المقبول لمؤشر كتلة الجسم (BMI) أو حتى ضمن نطاق فرط الوزن، بسبب زيادة نسبة الدهون.

وتعد القياسات الأنثروبومترية البديلة لسوء التغذية، مثل محيط العضد والرَّبلة، أدوات بسيطة وعملية. تشير البيانات المتاحة إلى أن محيط العضد الذي يتراوح بين 23.5 و25.0 سم في الذراع غير المسيطرة يمكن استخدامه لتحديد خطر سوء التغذية لدى البالغين في المجتمع *(40) (41) (42)*.

يمكن للعامل الصحي المدرب تقييم قوة العضلات وأدائها وسوء التغذية باستخدام أداة مثل مقياس قوة قبضة اليد، إذا كان متاحًا. تقيس هذه الأداة مدى قوة الشخص عند الضغط عليها بيد واحدة. تشير قوة القبضة الضعيفة إلى الحاجة إلى ممارسة التمارين البدنية واتباع نظام غذائي غني بالبروتين.

7.3.2 الجفاف

الجفاف (*43*) يرتبط الجفاف بنتائج صحية سلبية مثل التهاب المسالك البولية، والفشل الكلوي، والإمساك، والهذيان، والتدهور المعرفي، وله عدة أسباب وعوامل مساهمة، بما في ذلك انخفاض الإحساس بالعطش، وانخفاض احتياطي السوائل المرتبط بالعمر، والسكري غير المنضبط، وضعف وظائف الكلى. وقد يؤدي التدهور المعرفي، وصعوبات البلع، وفقدان القدرة على الحركة، والسَّلَس البولي، وصعوبة تناول الطعام أيضًا إلى تقليل استهلاك المسن للماء. قد يختار بعض المسنين المصابين بالسَّلَس البولي تقليل استهلاكهم للسوائل اعتقادًا منهم أن ذلك سيساعدهم على تدبير السَّلَس البولي. ويمكن لبعض الأدوية، مثل مدرات البول والمليّنات، أن تؤدي إلى فقدان السوائل، كما أن المسنين أكثر عرضة للإصابة بالحمى، والإسهال، والتقيؤ، وجميعها تسبب الجفاف.

يمكن للعاملين الصحيين:

- البحث عن أعراض التجفاف، مثل جفاف الفم، الشفاه، واللسان، وغور العينين، والإمساك، قلة التبول (أو قلة معدل التبول)، وتسارع ضربات القلب، والصداع، والضعف، والتشوش، والدوار، على الرغم من أن المسن قد لا يُظهر الأعراض أو العلامات السريرية النموذجية (*44*).
- تقديم نصائح للمسنين ولمقدمي مقدمي الرعاية (carers) لمتابعة معدل استهلاك السوائل، بما في ذلك الماء، وعصائر الفواكه، والشوربات.
- تحديد هدف يومي لاستهلاك السوائل. يجب أن يكون الاستهلاك اليومي على الأقل 1.6-2 لتر (6-8 أكواب)، في حال عدم وجود حالات صحية تتطلب نهجًا مختلفًا، مع أخذ العوامل البيئية في الاعتبار، مثل الطقس الحار.
- تشجيع المسن ومقدمي الرعاية على الاحتفاظ بإمدادات من السوائل التي يفضلونها، محضّرة بالطريقة التي يفضلونها، واستخدام الوسائل المساعدة على الشرب، مثل الحاويات الخفيفة، والشفاطات، والملاعق، عند الحاجة.
- مناقشة ودعم المسنين في تدبير السَّلَس البولي لمساعدتهم على استهلاك كميات كافية من السوائل. ← 13

7.3.3 السمنة

يُسجل انتشار السمنة بين المسنين ارتفاعًا عالميًا (*45*). ترتبط السمنة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والسرطان، إضافةً إلى فقدان القدرة على الحركة وتراجع جودة الحياة. بالنسبة للمسنين، يجب الموازنة بين فوائد فقدان الوزن والمخاطر المحتملة، مثل فقدان الكتلة العضلية، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الساركوبينيا وزيادة خطر الكسور. ويُعد تبني أنماط حياة صحية، عبر التغذية السليمة والنشاط البدني، ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام أثناء أي تقييد للسعرات الحرارية. ← **3.1.3**

يجب على العاملين الصحيين في مرافق الرعاية الأولية:

- تقييم وزن وطول المسنين بصفة منتظمة.
- تقديم نصائح بشأن النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة.
- مراقبة وتدبير عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية (← **3.1.4**) وتقييم وجود أمراض مصاحبة، بما في ذلك الحالات الصحية النفسية.
- عند تشخيص شخص بزيادة الوزن أو السمنة:
  - تُقدَّم الخدمات الصحية لمعالجة السمنة، بما في ذلك التدخلات الغذائية، والتمارين البدنية، والتدابير الطبية عند الحاجة.
  - التحري عن وجود مرض السكري.
  - تتم إحالة الشخص إلى أخصائي تغذية عند توفره.

مزيد من المعلومات

السمنة وفرط الوزن. WHO; 2024 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/(obesity-and-overweight).

7.4 معالجة سوء التغذية

يجب تقديم التدخلات التغذوية دائمًا كجزء من خطة رعاية شاملة ومشخصنة تعالج الأمراض المستبطنة (مثل أمراض الجهاز الهضمي أو الفم، والأورام الخبيثة)، والعوامل المساهمة في سوء التغذية، إلى جانب التدخلات التي تستهدف مجالات أخرى من القدرة الذاتية. وتشمل هذه العوامل الاضطرابات الحسية (مثل ضعف حاسة التذوق والشم)، وسوء صحة الفم مثل مشاكل المضغ وصعوبات البلع، إضافةً إلى العزلة الاجتماعية، والشعور بالوحدة، وانخفاض الدخل، والأمراض المزمنة طويلة الأمد. كما يمكن أن تؤثر بعض الأدوية أيضًا على التذوق أو الشم أو تتسبب في الغثيان والقيء.

إلى جانب النظام الغذائي الغني بالبروتين، هناك العديد من الطرق الأخرى لتدبير سوء التغذية، مثل الإرشاد التغذوي مع مراقبة الوزن، والتمارين متعددة الأنماط، والتغذية التكميلية الفموية.

المربع 7.2 التغذية التكميلية الفموية: النقاط الأساسية

- الطعام يأتي أولًا. ما لم تكن الحاجة إلى التغذية التكميلية الفموية عاجلة، ينبغي تحسين النظام الغذائي وزيادة عدد الوجبات أولًا.
- تعد التغذية التكميلية مكملاً غذائيًا للطعام. ولا ينبغي أن تحل محله. يجب أن يفهم الشخص الذي يتناول التغذية التكميلية الفموية أهمية الاستمرار في تناول الطعام قدر الإمكان.
- يحتاج الأشخاص إلى إرشادات حول كيفية تحضير التغذية التكميلية الفموية، والكمية التي يجب تناولها في كل مرة، ومواعيد تناولها.
- يجب تناول التغذية التكميلية الفموية بين الوجبات، وليس خلالها.
- غالبًا ما يحتاج الأشخاص إلى الدعم المستمر والتشجيع من أفراد الأسرة، ومقدمي الرعاية، والعاملين الصحيين، للاستمرار في تناول التغذية التكميلية الفموية.
- قد يشعر بعض الأشخاص بالملل من طعم وقوام نوع واحد من التغذية التكميلية الفموية. لذلك، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من النكهات عند توفرها.
- يجب متابعة الوزن عن كثب وتسجيله بصفة منتظمة.
- يُفضَّل إيقاف التغذية التكميلية الفموية بمجرد زوال خطر سوء التغذية واستعادة النظام الغذائي قدرته على توفير التغذية الكافية.

7.4.1 خطر سوء التغذية

يمكن للعاملين الصحيين تقديم نصائح تغذوية مشخصنة مع المراقبة الدقيقة للوزن لمنع تطور سوء التغذية. ويجب أن يبدأوا بتسجيل أنماط الأكل، بما في ذلك أنواع وكميات الأطعمة والسوائل وتكرار تناولها، ثم تكييف هذه الأنماط الغذائية لتتناسب مع التفضيلات الثقافية أو المشخصنة للفرد، بهدف زيادة استهلاك البروتين والمغذيات الضرورية. إذا كان المسن غير قادر على زيادة مدخوله الغذائي، بما في ذلك البروتين، فيجب النظر في التغذية التكميلية الفموية (إطار 7.2).

عند تحديد خطر سوء التغذية، من المهم أيضًا مراعاة ممارسة التمارين متعددة الأنماط، حيث إن التغذية والتمارين البدنية عاملان أساسيان في الحفاظ على قوة العضلات ووظائفها وتحسينها. يجعل الاستهلاك الكافي للطاقة والبروتين برامج التمارين متعددة الأنماط أكثر فاعلية. ← 6.4.2

7.4.2 سوء التغذية

في حالات سوء التغذية، يجب على العاملين الصحيين تقديم نصائح تغذوية شخصية وفورية (الإرشاد التغذوي)، إضافةً إلى تقييم العوامل المساهمة وإدارتها. ويجب أن يقوم أخصائي تغذية أو عامل صحي ذو معرفة متخصصة بإجراء تقييم مُعمَّق للحالة التغذوية، وتقديم نصائح غذائية مخصَّصة، ووصف التغذية التكميلية الفموية للمسن عند الحاجة وعند توفرها.

ويمكن توفير بروتين إضافي عالٍ الجودة، وسعرات حرارية، وكميات كافية من الفيتامينات والمعادن من خلال التغذية التكميلية الفموية عند تحديد وجود نقص. تتطلب صياغة خطة للتغذية التكميلية الفموية معرفة متخصصة بحيث تكون مخصَّصة لاحتياجات الفرد وتتناسب مع إعاقاته الجسدية والنفسية. ويتيح التقييم اختيار أفضل طريقة للمكملات الغذائية، سواء من خلال الأطعمة الغنية بالمغذيات، أو المكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن، أو المنتجات الغذائية التجارية المتخصصة، أو التركيبات الغذائية غير التجارية *(46)(47)*. يجب وصف التغذية التكميلية الفموية فقط عندما يكون الشخص غير قادر على استهلاك كميات كافية من الأطعمة العادية الغنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية، أو عندما تكون استراتيجية مؤقتة إلى جانب الطعام العادي لزيادة السعرات الحرارية المتناولة. يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين دعم ومراقبة الأشخاص الذين يستخدمون التغذية التكميلية الفموية (إطار 7.2).

7.5 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر ومعالجتها

7.5.1 الساركوبينيا

الساركوبينيا هي فقدان كتلة العضلات وقوتها، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة العضلات، وقد تتطلب تدخلات تأهيلية تشمل تدبير التغذية مع التركيز على مدخول البروتين.

← 4.2.1, 6.5.3

7.5.2 الحالات الهضمية

يمكن أن تتأثر جميع وظائف الجهاز الهضمي، مثل حركة الأطعمة، وإفراز الإنزيمات والهرمونات، والهضم، والامتصاص، مع التقدم في العمر. وتُعد الأمراض الهضمية من بين الأسباب الشائعة لفقدان الوزن غير المقصود *(48)*. ويمكن أن يساعد الفحص الجسدي ومعرفة السجل المرضي في تحديد الأمراض الهضمية الشائعة مثل الإمساك، والإسهال، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والقرحة الهضمية، ويجب تقديم التدبير العلاجي المناسب.

7.5.3 أمراض الفم والمشاكل المتعلقة بالمضغ أو البلع

تؤثر أمراض الفم والمشاكل المتعلقة بالمضغ أو البلع بشكل كبير على الحالة التغذوية. وتشمل أمراض الفم الرئيسية: تسوس الأسنان (نخر الأسنان)، وأمراض اللثة (التهاب دواعم السن)، وفقدان الأسنان الكامل، وسرطان الفم *(49)*. يُنظر إلى فقدان الأسنان بشكل خاطئ على أنه جزء لا مفر منه من الشيخوخة، وهو مقبول اجتماعيًا في العديد من الثقافات. ومع ذلك، يمكن أن يكون له تأثير نفسي صادم، ويسبب ضررًا اجتماعيًا، ويؤثر سلبًا على القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية. ويمكن الوقاية من معظم أمراض الفم من خلال الرعاية الذاتية (المربع 7.1، الصفحة 77)، بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات صحة الفم المناسبة.

ويمكن للعاملين الصحيين في مرافق الرعاية الأولية تحديد أمراض الفم والمشاكل الصحية ذات الصلة من خلال طرح الأسئلة التالية:

- هل تجد صعوبة في تناول الطعام أو مضغه؟
- هل لديك صعوبة في بلع الطعام أو الشراب؟
- كم عدد الأسنان الطبيعية المتبقية لديك؟ (أقل من 20 سنًا طبيعيًا يرتبط بنتائج صحية أسوأ).
- هل تعاني من تسوس الأسنان؟
- هل تنزف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة؟
- هل تشعر بجفاف الفم؟
- هل لديك ألم أو تورم أو قرحة غير ملتئمة؟

يمكن علاج أمراض الفم من قبل عامل صحي مدرب في مرفق رعاية أولية، وفقًا للقواعد واللوائح المحلية، بما في ذلك إيقاف تسوس الأسنان، وإجراء الحشو بعد إزالة السن المتسوس، وإدارة أمراض اللثة باستخدام المحاليل الملحية أو غسول الفم المطهر. ومع ذلك، فإن التقييم الإضافي والتدبير يتطلبان الإحالة إلى متخصص في الرعاية الصحية ذي معرفة متخصصة (مثل طبيب الأسنان، مساعد طبيب الأسنان، اختصاصي صحة الفم).

وتشمل صعوبات البلع (عسر البلع) مشاكل تحدث أثناء انتقال الأطعمة الصلبة أو السوائل من الفم إلى المعدة، بما في ذلك الامتصاص، المضغ، العض، تحريك الطعام داخل الفم، إفراز اللعاب، والبلع. ومن المضاعفات الشديدة لعسر البلع: الشفط الرئوي، أو التجفاف أو فقدان الوزن. يمكن أن تحدث هذه الصعوبات نتيجة لعدد من الحالات الأكثر شيوعًا لدى المسنين، مثل وجود خلل وظيفي في المريء، والسكتة الدماغية، ومرض باركنسون، والخرف.

ويجب أن تتضمن نصائح مراعاة قوام الطعام والشراب لتسهيل البلع وتقليل خطر الاختناق أو الشفط الرئوي.

قد يستفيد بعض المسنين من تناول الطعام بعد فرمه ناعمًا، أو تقطيعه إلى قطع صغيرة، أو هرسه. يُوصى الأشخاص الذين يعانون من عسر البلع بتجنب الأطعمة ذات القوام المختلط، مثل الحساء الذي يحتوي على قطع صلبة، للحد من خطر الشفط الرئوي.

ويمكن توفير تمارين لتقوية عضلات البلع وتحسين تنسيق عملية البلع، بما في ذلك تمارين المضغ، والغناء، ونطق الكلمات بسرعة للحفاظ على عضلات الفم. يمكن تقديم إرشادات حول تدليك الغدد اللعابية لتحفيز إنتاج اللعاب. وإذا كان المسن يعاني من ضعف شديد في البلع، فيجب إحالته إلى خدمات التأهيل إذا كانت متاحة ويمكن الوصول إليها. ← 4.2.1

أطقم الأسنان

أطقم الأسنان هي أسنان صناعية قابلة للإزالة، تُركَّب فوق اللثة لاستبدال الأسنان المفقودة والقضاء على المشاكل المحتملة الناتجة عن الفجوات. يمكن أن تساعد أطقم الأسنان في منع مشاكل الأكل وسوء التغذية اللاحق ومشاكل النطق. ويمكنها أيضًا تحسين الثقة بالنفس من خلال تغيير مظهر الشخص. يمكن قياس وتركيب أطقم الأسنان بواسطة مختص صحي ذي معرفة متخصصة (مثل طبيب الأسنان أو فني الأسنان) والذي يمكنه أيضًا تقديم نصائح بشأن كيفية ارتدائها وتنظيفها والعناية بها. ويجب فحصها بانتظام، بما في ذلك التأكد من ملاءمتها، خصوصًا مع تغير وزن الشخص.

7.6 تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

7.6.1 عادات الأكل الاجتماعي

إن جعل تناول الطعام نشاطًا اجتماعيًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، ليس فقط على الحالة التغذوية وترطيب الجسم، ولكن أيضًا من الناحية النفسية، حيث يساعد على تعزيز الشعور بالانتماء وتقليل الشعور بالوحدة.

يمكن مقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة في المجتمع المساعدة في التغلب على العوائق التي تعيق عادات الأكل الاجتماعي لدى المسنين من خلال تنظيم فعاليات تناول الطعام الاجتماعية، بما في ذلك توفير الطعام في الاجتماعات أو الأنشطة، وتشجيع العائلات على تناول الوجبات معًا. ويمكن للمنظمات المجتمعية تيسير الوصول إلى خيارات غذائية أكثر صحة، مثل الحدائق وأسواق الطعام المجتمعية.

7.6.2 الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

قد تشمل الرعاية والدعم الاجتماعيين للمسنين الذين يعانون من سوء التغذية أو التجفاف أو المعرضين لخطرهما تيسير الوصول إلى وجبات جاهزة للأكل، والمساعدة في الطهي، وتوفير المشروبات، بما في ذلك جمع المياه.

إذا واجه المسن أو مقدّم الرعاية صعوبات في الوصول إلى الطعام، فقد يتمكن أصحاب المصلحة في المجتمع من المساعدة عن طريق تنظيم توصيل المواد الغذائية وتقديم نصائح والدعم المالي. وإذا واجه المسن صعوبات في تناول الطعام، فقد يتمكنون أيضًا من تقديم المساعدة في جلوسه بوضعية مناسبة على الطاولة وتقديم الطعام له.

7.6.3
المنتجات المساعِدة

يمكن أن تساعد أدوات الأكل والشرب البسيطة الأشخاص الذين يعانون من الضعف أو ضعف التنسيق الحركي على تناول الطعام والشراب بشكل مستقل.

ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين تحديد متى تكون هذه الأدوات المساعدة مفيدة. وقد تكون أطقم الأسنان ضرورية أيضًا للأشخاص الذين فقدوا أسنانهم، للمساعدة في التغلب على صعوبات تناول الطعام. ويتوفر تدريب بسيط حول كيفية تحديد وتوفير أدوات الأكل والشرب.

7.6.4
دعم مقدمي الرعاية ← 12

يجب أن تتاح لمقدمي الرعاية إمكانية الوصول إلى نصائح حول أهمية الترطيب وكيفية تحضير الطعام للمسنين، بما في ذلك الأطعمة اللينة في حال صعوبة المضغ أو البلع. يجب تزويدهم أيضًا بالمعلومات حول كيفية تقديم المساعدة في التغذية.

ويجب دعم مقدمي الرعاية عبر توفير المعلومات حول ما يمكن توقعه في مرحلة نهاية الحياة. يُعد انخفاض تناول الطعام والشراب جزءًا طبيعيًا من المراحل النهائية للأمراض الخطيرة. وقد يجد مقدمو الرعاية ذلك صعبًا، إذ يُعد الطعام وسيلة للتعبير عن المحبة بين الناس. يجب توفير المعلومات والدعم، بما في ذلك مساعدة مقدمي الرعاية على إيجاد طرق أخرى للتعبير عن محبتهم، مثل العناية بالفم والبشرة.

ويُعد اتباع نظام غذائي صحي أمرًا مهمًا لمقدمي الرعاية أيضًا، إلا أنهم قد يهملون تغذيتهم، خصوصًا إذا كانوا يشعرون بالإرهاق أو التوتر بسبب دورهم في تقديم الرعاية. إذا كان المسن بحاجة إلى المساعدة في التغذية، فقد يركز مقدم الرعاية على ذلك بدلاً من الاهتمام بتغذيته والاستمتاع بوجباته. قد تكون مشاركة الوجبات مع العائلة أو الأصدقاء مفيدة، إذ يكون الآخرون متاحين لتقديم الدعم.

مزيد من المعلومات

التدريب على مَعينات الأكل والشرب. TAP; 2024 (https://www.gate-tap.org/).

8

الإبصار

مسار الرعاية لمعالجة ضعف البصر



يعد الإبصار عنصرًا أساسيًا في القدرة الذاتية، حيث تمكّن الأشخاص من التنقل والتفاعل بأمان مع أقرانهم وبيئتهم المحيطة. يحدث حوالي 80% من حالات خلل الرؤية البعيدة و67% من حالات خلل الرؤية القريبة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر *(50)*. يُعد مدّ البصر (قصو البصر الشيخوخي)، وإعتام عدسة العين، والزرق، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر من أكثر أمراض العيون شيوعًا بين المسنين.

وقد يؤدي إلى صعوبات في التنقل الآمن، والحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية، والقدرة على العمل وكسب الدخل، والوصول إلى المعلومات.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع إجراء تقييم أساسي لضعف البصر باستخدام مخطط العين البسيط.
- يمكن الوقاية من معظم حالات ضعف البصر والعمى من خلال الاكتشاف المبكر والمعالجة الفعالة لأمراض العيون في الوقت المناسب.
- يمكن للنظارات غالبًا تصحيح فقدان الرؤية القريبة أو البعيدة.
- يمكن أن تعزز المنتجات المساعِدة مثل المكبرات والعصي البيضاء، للأشخاص الذين لا يمكن تصحيح ضعف البصر لديهم باستخدام النظارات.
- يمكن أن تعزز التعديلات البيئية مثل تحسين الإضاءة، القدرة الوظيفية لدى المسنين الذين يعانون من ضعف البصر وتساعد في تجنب السقوط.
- يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم المسنين الذين يعانون من ضعف البصر من خلال رسم خرائط للبيئات المحلية وتقييمها وإنشاء مجموعات دعم الأقران.

8

الإبصار

مسار الرعاية لمعالجة ضعف البصر

تقييم
(أساسي)
3.1 ←

اجتياز

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة بما في ذلك نصائح للعناية بالعينين وصحة البصر ← 8.1
- إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم

رسوب

- توفير نظارات القراءة وإجراء تحرّ عن ارتفاع ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من خلال بصري ← 8.2
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"

(يمكن تقييم "أ" و"ب" و"ج" بأي ترتيب)

أ

تقييم

ضعف البصر وأمراض العيون (1)

- معالجة الأمراض الشائعة التي تصيب العين ← 8.4.1
- الإحالة إلى الرعاية الشاملة للرؤية والعينين
  - علاج أمراض العيون
  - التعامل مع ضعف البصر
  - مراجعة وتحديث وصفة النظارات الطبية

ب

تقييم

الأمراض وعوامل الخطر

- ارتفاع ضغط الدم والسكري
- استخدام المنشطات
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (2)

ج

تقييم

البيئات الاجتماعية والمادية

- الحاجة إلى المنتجات المساعِدة لضعف البصر
- الحاجة إلى تعديل المنزل ومحيطه (خطر السقوط)
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية (أنشطة الحياة اليومية، المشاركة الاجتماعية)
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية

- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (3)

إعادة التقدير

دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع
خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

الحاجة إلى المعرفة والتدريب المتخصصين

- ضعف البصر المفاجئ أو سريع التفاقم
- توفير النظارات لتصحيح خلل الرؤية البعيدة
- التحكم في أمراض الشبكية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض العين الأخرى (مثل الزرق، وإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي) (8.5)
- مشكلات في العين الخارجية مثل الإفرازات الشديدة بما في ذلك الصديد، والاحمرار غير الطبيعي في الجزء الأبيض من العين، أو الغشاوة أو الاحمرار غير الطبيعي في الجزء الملون من العين

1 تقييم ضعف البصر وأمراض العيون الشائعة ← 8.3

قياس قدرة الشخص على تحديد أو تمييز جسم أو حرف بوضوح على مسافة معينة (حدة البصر) باستخدام مخطط E المتدرج. ويعد تقييم حدة البصر مقياسًا سريريًا مهمًا عند تقييم الخطأ الانكساري.

لإجراء هذا التقييم، يلزم وجود مساحة ذات إضاءة جيدة وكافية لضمان مسافة الاختبار الصحيحة (مثل 3 أمتار للرؤية البعيدة، و40 سم للرؤية القريبة).

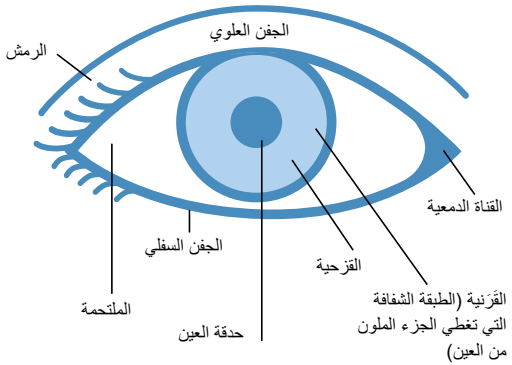
إذا كان الشخص يرتدي نظارات بالفعل، تُفحص حدة البصر أثناء ارتدائها.

يمكن تقييم أمراض العيون الشائعة مثل احمرار العين، والرموش غير الطبيعية، والتهاب الملتحمة، وجفاف العين بشكل أكثر تفصيلًا من خلال فحص مظهر العين الخارجية والجفون والرموش باستخدام مصباح يدوي.

خطأ الانكسار البصري

يُعد خطأ الانكسار غير المصحح السبب الأكثر شيوعًا للخلل البصري عالميًا. ويحدث خطأ الانكسار عندما تمنع بنية العين الضوء من التركيز مباشرة على الشبكية، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية. تشمل الأنواع الشائعة لعيوب الإبصار الانكسارية ما يلي: قصر النظر (خلل الرؤية البعيدة)، وطول النظر (خلل الرؤية القريبة)، وقصو البصر الشيخوخي (خلل الرؤية القريبة المرتبط بالتقدم في العمر)، واللابؤرية (ضبابية الإبصار على مختلف المسافات).

العين الخارجية



2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 8.5

ارتفاع ضغط الدم والسكري
- التعامل مع عوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية (8.5.1)
- فحص شبكية العين السنوي (8.5.1)

استخدام المنشطات
- المراجعة المنتظمة لوصفة المنشطات (8.5.2)
- إجراء فحوص منتظمة للعيون والبصر (8.5.2)

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 8.6

الحاجة إلى المنتجات المساعِدة
- توفير المنتجات المساعِدة (البصرية وغير البصرية) في حال ضعف البصر (8.6.1)

الحاجة إلى تعديل المنزل ومحيطه
- تحسين البيئات المادية (المنزل ومحيطه) لتقليل خطر السقوط (4.2.5)
- تقديم المشورة بشأن استخدام الأدوات المنزلية بوضع تعليمات عليها بخط أكبر وأكثر وضوحًا (8.6.2)

احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية
- دعم مهام الحياة اليومية وتوفير فرص للمشاركة الاجتماعية (8.6.3)
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي (8.6.3)

احتياجات دعم مقدمي الرعاية
- تقديم نصائح والتدريب، بما في ذلك تكييف أساليب التواصل (8.6.4)

8.1
نصائح حول الصحة ونمط الحياة لتعزيز العناية بالعين والإبصار

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة الآخرين تقديم نصائح لجميع المسنين، بمن فيهم الذين قد يعانون من ضعف البصر، لدعم العناية بالعين والإبصار ، بما في ذلك:

لجميع المسنين:

- تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل الاعتقاد بأن ضعف البصر يُعد جزءًا طبيعيًا من أعراض الشيخوخة.
- أهمية معالجة عوامل الخطر المرتبطة بضعف البصر، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم واستخدام المنشطات.
- إجراء فحوص منتظمة للعين لدى العاملين الصحيين وطلب نصائح عند مواجهة أي مشاكل.
- أخذ فترات راحة منتظمة عند القيام بأنشطة تتطلب التمعن بالنظر، مثل استخدام الوسائط الإلكترونية (الهواتف، الأجهزة اللوحية، إلخ)، والقراءة والخياطة.
- الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية بارتداء النظارات الشمسية والقبعات.
- غسل اليدين بانتظام، وتجنب فرك العينين أو لمسهما، واستخدام صابون لطيف لتنظيف الجفون.
- الإقلاع عن التدخين، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

للمسنين الذين يعانون من ضعف البصر أو المعرضين له:

- تعديل المنزل والمناطق المحيطة به لتقليل خطر السقوط، عبر استخدام الإضاءة والتباين والألوان.
- اتباع نصائح حول كيفية ومتى يجب استخدام النظارات الطبية، على سبيل المثال، إذا تم إبلاغك بالحاجة إليها للقراءة.

8.2
الرعاية الصحية المجتمعية للتعامل مع ضعف البصر

8.2.1
توفير النظارات الطبية للقراءة

إذا تبيَّن أن شخصًا مسنًا يعاني من ضعف البصر من خلال التقييم الأساسي في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين، ولم يكن التقييم المُعمَّق (لأمراض العيون، أو التشوهات الخارجية، أو ضعف البصر) متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين تقديم المساعدة. ويمكنهم تيسير الوصول إلى نظارات القراءة الجاهزة، حيثما توفرت، للأشخاص الذين يعانون من خلل الرؤية القريبة. يعاني العديد من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر من صعوبة في الرؤية أو القراءة عن قُرب. وتعد نظارات القراءة حلًا فعالًا وسريعًا لتصحيح قصو البصر الشيخوخي (خلل الرؤية القريبة) عن طريق تكبير الأشياء القريبة.

وقد تتوفر نظارات القراءة الجاهزة بتكلفة منخفضة بدرجات تكبير مختلفة (+1.00، +1.50، +2.00، +2.50، +3.00). هناك عدة طرق لوصف نظارات القراءة. ومن الأساليب الشائعة دمج عمر الشخص مع أسلوب التجربة والخطأ.

الفئة العمرية	قوة نظارات القراءة
40 إلى 50 سنة	+1.00 DS إلى +2.00 DS
50 سنة أو أكبر	+2.00 DS إلى +3.00 DS

يجب تجربة نظارات القراءة في غرفة مضاءة جيدًا باستخدام بطاقة فحص حدة الرؤية القريبة (الصفحة 23). ويجب أن يكون الإطار مريحًا ومناسبًا للشخص بشكل صحيح، مع التأكد من أنه ليس ليس ضيقاً أو واسع، وأنه يستقر فوق الأذنين دون الضغط على جانبي الرأس. إذا لم تحل نظارات القراءة البسيطة المشكلة، يُوصى بإجراء فحص شامل للعين والرؤية لدى أحد المتخصصين الصحيين، مثل ممرض العيون أو أخصائي البصريات أو طبيب العيون.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم معلومات حول أماكن توفر نظارات القراءة الجاهزة محليًا وآلية استخدامها. ويمكن للمجموعات المجتمعية، بما في ذلك منظمات المسنين، التعاون مع العاملين الصحيين لتيسير خدمات التوعية المتنقلة لتوفير وتجربة نظارات القراءة مع المسنين.

8.2.2 تحري ارتفاع ضغط الدم

يمكن أيضًا فحص المخاطر التي يشكلها ارتفاع ضغط الدم على أمراض العيون وضعف البصر. يجب على العاملين الصحيين في المجتمع قياس ضغط الدم، إذا كانوا مدربين وتوفرت لديهم المعدات المناسبة، لتحديد عوامل الخطر للأمراض القلبية الوعائية، وتقديم نصائح بشأن تدبير. ← **3.1.4** إذا تم تشخيص الشخص بالفعل بارتفاع ضغط الدم والسكري، فيجب إحالته إلى الرعاية الأولية للمتابعة، ويوصى بإجراء فحص منتظم للشبكية.

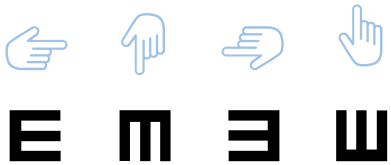
مزيد من المعلومات

- ***التدريب على توفير نظارات القراءة والمكبرات والتلسكوبات.*** TAP; 2024 (https://www.gate-tap.org).
- ***دليل تنفيذ فحص البصر والعين.*** WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/375590).

8.3 تقييم ضعف البصر وأمراض العيون

يمكن تقديم خدمات رعاية العيون داخل مرافق الرعاية الأولية من خلال الإشراف المناسب وتدريب العاملين الصحيين الحاليين، أو من خلال تبني خدمات رعاية عيون أولية مستقلة، سواء في مرافق ثابتة أو عبر وحدات متنقلة.

ويمكن للعاملين الصحيين في مرافق الرعاية الأولية إجراء فحوص العين والبصر. يمكنهم قياس قدرة الشخص على التعرف على كائن أو حرف بوضوح على مسافة معينة (حدة البصر). ويمكنهم أيضًا فحص أمراض العيون الشائعة، مثل احمرار العين، والرموش غير الطبيعية، والتهاب الملتحمة، وجفاف العين، والتهاب الجفن، باستخدام مصباح يدوي.



يُعد مخطط الحرف E المتدرج "Tumbling E" أداة واسعة الاستخدام، بينما يتطلب مخطط LogMAR (EDTRS) المعرفة بالأبجدية اللاتينية.

في بعض الحالات التي تتطلب معرفة متخصصة، يجب إحالة الشخص إلى أخصائي صحي مثل ممرض عيون أو أخصائي بصريات أو طبيب عيون. ويتضمن ذلك إجراء فحوص للعينين أكثر تفصيلًا، مثل الانكسار الذاتي، والتنظير المباشر لقاع العين، وتصوير الشبكية، إضافة إلى توفير النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة لتصحيح خلل الرؤية البعيدة (قصر النظر)، وتشخيص وعلاج أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين واعتلال الشبكية الناتج عن السكري وارتفاع ضغط الدم.

يجب أيضًا التحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل التدهور المعرفي وأعراض الاكتئاب، وإجراء تقييم مُعمَّق عند الضرورة. ← 5 10

المربع 8.1 الساد (المياه البيضاء)

الساد (المياه البيضاء) هو تَعَيُّم عدسة العين، مما يعيق الرؤية الواضحة، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بأعراض الشيخوخة. ويُعد السكري والسمنة من عوامل الخطر المسببة لإعتام عدسة العين. إلى جانب الأخطاء الانكسارية، يُعد إعتام عدسة العين السبب الرئيسي للخلل البصري والعمى القابلين للوقاية (51). قد يساعد الإقلاع عن التدخين وتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية في منع أو تأخير تطور الساد (المياه البيضاء). ويمكن أن يساهم الكشف المبكر والتصحيح الجراحي في استعادة الرؤية والوقاية من فقدان البصر لدى عدد كبير من الأشخاص. ويتضمن التدخل الجراحي إزالة الساد (المياه البيضاء) في العين وزراعة عدسة داخلية اصطناعية.

8.4 معالجة ضعف البصر وأمراض العيون

يجب تقديم التدخُّلات لمعالجة ضعف البصر وأمراض العين دائمًا كجزء من خطة رعاية شاملة ومشخصنة تعالج الأمراض المستبطنة (مثل، ارتفاع ضغط الدم والسكري) والعوامل الأخرى، إلى جانب التدخلات التي تستهدف المجالات الأخرى من القدرة الذاتية. بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية وتحري ارتفاع ضغط الدم، هناك عدة طرق أخرى لمعالجة ضعف البصر.

8.4.1 معالجة أمراض العيون الشائعة

يمكن للعاملين الصحيين تقديم العلاج أو الرعاية الإسعافية الأولية أو كليهما في مرافق الرعاية الأولية، مع تقديم نصائح بشأن المتابعة للأشخاص الذين يعانون من احمرار العين أو رموش غير طبيعية، والتهاب الملتحمة البكتيري أو التحسسي، وجفاف العين، والتهاب الجفون، ووجود جسم غريب في العين، والتهاب القرنية. وإذا لم يكن هناك تحسن أو كان التحسن ضئيلًا، فمن الضروري الإحالة في الوقت المناسب إلى مختص صحي ذي معرفة متخصصة.

8.4.2 معالجة الأخطاء الانكسارية

تشمل معالجة الأخطاء الانكسارية الفحص الدوري للعين والرعاية الشاملة للبصر والعين. ويمكن لتدابير التصحيح مثل النظارات الطبية، والعدسات اللاصقة، وجراحة تصحيح الانكسار معالجة الأخطاء الانكسارية بفعالية. تُعد هذه العلاجات آمنة، ويمكنها تحسين الرؤية بشكل كبير، مما يعزز جودة الحياة.

8.4.3 ضعف البصر غير القابل للتصحيح والعمى

يعاني العديد من الأشخاص من ضعف الرؤية الذي لا يمكن تصحيحه بشكل كافٍ باستخدام النظارات الطبية. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمكن أن تساعد المنتجات المساعِدة لضعف البصر في أداء المهام التي تتطلب الرؤية القريبة، مثل قراءة الكتب أو الصحف، والتعرف على النقود، وقراءة الملصقات، والخياطة، وفحص الأجسام الصغيرة أو أجزاء من الأشياء الكبيرة. ويجب إحالتهم إلى خدمات التأهيل، إذا كانت متاحة ويمكن الوصول إليها، للحصول على نصائح حول كيفية تحسين مشاركتهم في الحياة الاجتماعية من خلال تعظيم استخدام الرؤية المتبقية وإجراء تعديلات عملية للتعامل مع العواقب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للخلل البصري. ← 4.2.1

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان البصر في التنقل في مجتمعاتهم المحلية. يمكن أن يشمل ذلك مرافقة الشخص أثناء المشي أو أثناء رحلة على طريق يرغب في تعلمه، مثل الانتقال من المنزل إلى منزل أحد أفراد العائلة. سيساعد تكرار هذه الرحلة عدة مرات الشخص على التأقلم مع البيئة وبناء ثقته في التنقل بمفرده. وقد يكون من المفيد أيضًا، وضع خرائط صوتية للبيئات المحلية، تصف أماكن الأشياء وكيفية العثور على المرافق والخدمات المختلفة.

مزيد من المعلومات

حزمة تدخلات العناية بالعيون. WHO; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/354256).

8.5 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر ومعالجتها

8.5.1 ارتفاع ضغط الدم والسكري

يُعد ارتفاع ضغط الدم والسكري من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الشبكية والزرق، وهما من الأسباب الرئيسية للخلل البصري والعمى القابلين للوقاية. ويُعد اعتلال الشبكية السكري أكثر المضاعفات الوعائية الدقيقة شيوعًا لداء السكري. بالإضافة إلى إدارة عوامل الخطر القلبية الوعائية (← **3.1.4**)، يُوصى بإجراء فحص منتظم للشبكية (سنويًا أو كل سنتين، حسب الحالة) للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، متبوعًا بالعلاج عند الحاجة. يمكن اكتشاف اعتلال الشبكية ومراقبته باستخدام تنظير قاع العين من قبل مختص صحي مختص، أو من خلال التصوير الشبكي مع تفسير محلي أو عبر برامج الطب عن بعد التي تعتمد على التقييم المركزي.

8.5.2 استخدام المنشطات

في بعض الأشخاص، قد يؤدي العلاج طويل الأمد بالكورتيكوستيرويدات إلى زيادة الضغط داخل العين أو الإصابة بإعتام عدسة العين. ويمكن أن يؤدي هذا الضغط المرتفع (الزرق) إلى ضعف البصر والعمى عبر إتلاف العصب البصري إذا لم يتم علاجه. يحتاج أي شخص يتلقى علاجًا طويل الأمد بالمنشطات إلى فحص شامل ومنتظم للعين والرؤية، بما في ذلك قياس ضغط العين. ويجب مراجعة مدى ملاءمة وصف المنشطات، بما في ذلك الجرعة، بشكل منتظم.

8.6 تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

8.6.1 المنتجات المساعدة لضعف البصر

يمكن استخدام مجموعة من المنتجات المساعِدة لدعم المسنين الذين يعانون من ضعف البصر على الاستمرار في أداء أنشطتهم اليومية واهتماماتهم. وتشمل هذه المنتجات، المُعينات البصرية مثل المكبرات، والتلسكوبات، والنظارات الطبية، والمعينات غير البصرية مثل الكتب الصوتية والمشغلات الصوتية، والساعات الناطقة، والعصي البيضاء، وقارئات الشاشة، والهواتف المحمولة المعدلة. وتحتوي العديد من الهواتف المحمولة والبرامج الحاسوبية الآن على وظائف تحويل النص إلى كلام. وقد تكون منظمات الأدوية المزودة بنص بارز أو بلغة برايل مفيدة.

8.6.2 تعديل البيئة في المنزل والمناطق المحيطة به

بالإضافة إلى استخدام المنتجات المساعدة لضعف البصر، يمكن إجراء تعديلات بسيطة في المنزل والمناطق المحيطة به لتقليل خطر السقوط لدى المسنين الذين يعانون من ضعف البصر. ← **4.2.5** إلى جانب هذه التعديلات، يمكن إجراء تغييرات أخرى لتيسير المهام اليومية والأنشطة الترفيهية، مثل:

- **استخدام أنواع الخطوط الأكثر وضوحًا:** بالنسبة للمواد المطبوعة والشاشات الإلكترونية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، يُفضل استخدام الخط الكبير غير المزخرف (مثل المستخدم في هذا الدليل) الذي يتميز بتباين واضح مع لون الخلفية لأنه أسهل في القراءة.

- **اختيار الأدوات المنزلية ذات الحجم الكبير والتباين الجيد:** تتوفر منتجات شائعة تتميز بحروف وأرقام أكبر أو بتباين جيد، مثل الساعات، والساعات اليدوية، والكتب ذات الطباعة الكبيرة. ولأغراض الترفيه، يمكن شراء أو صنع لوحات ألعاب وقطع كبيرة، بالإضافة إلى أوراق لعب ذات طباعة ورموز كبيرة.

- **استخدام المنتجات المساعِدة الناطقة:** يمكن أخذ في الاعتبار، الساعات وموازين الحرارة والموازين الناطقة.

8.6.3

الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

قد يحتاج المسنون الذين يعانون من ضعف البصر إلى الدعم للقيام بالأنشطة اليومية. بالإضافة إلى المساعدة في الأنشطة اليومية مثل تناول الطعام وارتداء الملابس، يمكن دعم المسنين لتنظيم متعلقاتهم لتيسير العثور عليها والتمييز بينها.

على سبيل المثال، يمكن إبقاء الأشياء المتشابهة مثل أدوات المائدة معًا في الأدراج وعدم خلطها مع مفكَّات البراغي. ويمكن تنظيم الملابس في الأدراج أو الخزائن على هيئة ملابس متناسقة أو ترتيبها وفقًا للمناسبات التي تُرتدى فيها.

قد يشعر المسنون الذين يعانون من ضعف البصر بالبؤس أو الوحدة أو اليأس، ويكون لديهم خطر متزايد من الاكتئاب والقلق والتعب أو الحزن المرتبط بالفقدان التدريجي للرؤية. وقد يكونون عرضة للعُزلة الاجتماعية، لا سيما إذا واجهوا صعوبة في مغادرة المنزل للمشاركة في الفعاليات والتجمعات الاجتماعية، وقد يكون الدعم النفسي مفيدًا لهم.

يمكن لمقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم المساعدة عبر تنظيم الفعاليات المحلية ومرافقة الأشخاص لحضورها، ورسم خرائط البيئات المحلية وإنشاء مجموعات دعم الأقران. ويمكنهم أيضًا الدعوة إلى حلول لتحسين قابلية قراءة اللافتات في المرافق الخاصة والعامة (مثل المرافق الصحية، قوائم الطعام في المطاعم) وكذلك في المساحات الخارجية (مثل علامات المرور وعلامات الشوارع) وتنفيذ تلك الحلول.

8.6.4

دعم مقدمي الرعاية ← 12

يمكن أن يشمل تدريب مقدمي الرعاية للمسنين الذين يعانون من ضعف البصر، كيفية مساعدتهم على التنقل، بدءًا من تعديل البيئة المنزلية لجعلها أكثر أمانًا، وصولًا إلى كيفية المشي برفقة شخص يعاني من ضعف البصر. وقد يركز التدريب أيضًا على تكييف أساليب وطرق التواصل، بما في ذلك:

- الصبر – منح الشخص وقتًا كافيًا للتنقل في البيئة، خصوصًا إذا كانت غير مألوفة له.
- عرض المساعدة عند الحاجة، ولكن مع احترام استقلالية الشخص وذلك بإعطائه الفرصة للقيام بالأشياء بمفرده متى أمكن ذلك.
- وصف البيئة، مثل المحيط، والتخطيط، والأشياء والأشخاص الموجودين في الغرفة.
- التيقظ – المشي خطوتين أمام الشخص لتقديم إشارات وتنبيه الشخص إلى المخاطر المحتملة، مثل الدَرَج.
- تجنب افتراض ما يمكن أو لا يمكن للشخص الذي يعاني من ضعف البصر فعله. إعطاء الفرصة للشخص للتعبير عن احتياجاته وتفضيلاته.
- تشجيع الشخص على استخدام المنتجات المساعِدة للحفاظ على استقلاليته وتواصله مع الآخرين.

9

السمع

مسار الرعاية لمعالجة فقدان السمع



فقدان السمع المرتبط بالتشيخ هو أكثر أنواع الاضطرابات الحسية شيوعًا بين المسنين. ويعرقل فقدان السمع غير الخاضع للعلاج التواصل وقد يؤدي إلى العُزلة الاجتماعية. ويمكن أن تؤدي القيود على مجالات القدرة الذاتية الأخرى مثل التدهور المعرفي إلى تفاقم هذه العواقب الاجتماعية. يرتبط فقدان السمع بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، وضعف التوازن والسقوط. تم تحديد فقدان السمع كأحد عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالخرف والتي يمكن تعديلها *(52)*. ويمكن أن تؤدي معالجته من خلال استخدام الأجهزة السمعية إلى تقليل هذا الخطر بشكل فعال.

النقاط الرئيسية

- يمكن لمقدمي الرعاية في المجتمع إجراء تقييم أساسي لفقدان السمع باستخدام معدات محمولة بسيطة أو إجراء اختبار الصوت الهامس.
- يمكن أن تساهم الإجراءات البسيطة في المنزل والمجتمع في تقليل تأثير فقدان السمع، بما في ذلك تبني استراتيجيات التواصل.
- يمكن تركيب مساعِدات السمع من قِبل مقدم رعاية مدرب. ومع ذلك، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى توجيه من متخصص بشأن تركيب واستخدام جهاز مساعِد السمع لضمان تحقيق أقصى فائدة منه.
- يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع دعم المسنين الذين يعانون من فقدان السمع من خلال تقديم المعلومات ونصائح، وتكييف أساليب التواصل خلال الفعاليات والاجتماعات المجتمعية، وإنشاء مجموعات دعم الأقران.

9

السمع

مسار الرعاية لمعالجة فقدان السمع

تقييم
(أساسي)
3.1 ←

اجتياز

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة، بما في ذلك نصائح للعناية بالأذنين ومتى يُشتبه بوجود فقدان في السمع ← 9.1
- إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم

رسوب

- استراتيجيات التواصل في حال فقدان السمع ← 9.2
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"

أولًا، يتم فحص الأذن باستخدام منظار الأذن (i) 1
في حال وجود انسداد بالشمع، تُعالج المشكلة ويُعاد اختبار السمع

تقييم
القدرة السمعية
قياس السمع التشخيصي (i) 2

أ

في حالة الصمم
(قياس السمع: ≤ 80 ديسيبل)

- الإحالة إلى رعاية السمع المتخصصة
- تقييم وتوفير جهاز سمع (مساعِدات السمع أو زراعة قوقعة الأذن)

إذا لم تتوفر الأجهزة السمعية، تتم توعية الشخص

- باستراتيجيات التواصل ← 9.2

إذا كان فقدان السمع معتدلا أو حادا
(قياس السمع: -35 < 80 ديسيبل)

- الإحالة إلى العاملين الصحيين المدربين
  - توفير مساعِدات السمع
- إذا لم تتوفر مساعِدات السمع، تتم توعية الشخص باستراتيجيات التواصل ← 9.2

إذا كان السمع طبيعيا أو في حال فقدان خفيف للسمع
(قياس السمع: < 35 ديسيبل)

- تقديم نصائح حول العناية بالأذنين ومتى يُشتبه بوجود فقدان في السمع ← 9.1
- تشجيع إجراء فحوص منتظمة للسمع (كل 1-3 سنوات)

ب

ج

تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية

- الحاجة إلى إجراء تعديلات على المنزل
- الحاجة إلى المنتجات المساعِدة (المنبهات الاهتزازية أو الوامضة، أو مضخمات صوت)
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية (أنشطة الحياة اليومية، المشاركة الاجتماعية)
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (i) 4

تقييم مؤشرات الخطر

- الأدوية غير المناسبة (الأدوية السامة)
- التعرض للضوضاء
- تاريخ فقدان السمع المفاجئ أو المتسارع
- فقدان السمع الأحادي أو غير المتماثل
- الشكوى من ألم أو إفرازات في الأذن أو دوار
- وجود تاريخ من أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المتكرر أو المزمن
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (i) 3

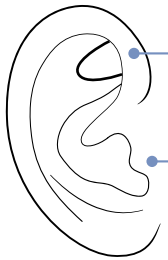
دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع
خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

إعادة التقدير

1 فحص الأذن باستخدام منظار الأذن



- استخدام يد واحدة لسحب **صيوان الأذن** بلطف للخلف وللأعلى لتقويم قناة الأذن.
- تُسحب **الزَنَمة** باليد الأخرى بلطف إلى الأمام باستخدام الإصبع لفتح قناة الأذن.
- تسليط الضوء داخل قناة الأذن (باستخدام منظار الأذن إذا كان متاحًا، أو اطلب المساعدة من شخص آخر بمصباح يدوي) للتحري عن وجود:
  - شمع الأذن أو القيح أو الإفرازات
  - التورم والاحمرار
  - جسم غريب داخل قناة الأذن

يمكن إزالة شمع الأذن عن طريق غسيل الأذن.

يُنصح بإعادة اختبار السمع بعد إزالة شمع الأذن.

شمع الأذن

يتم إنتاج الشمع بواسطة قناة الأذن لتنظيف الأذن، ويُطرد عادةً بشكل طبيعي من القناة بواسطة الأذن نفسها. يمكن أن يؤدي تراكم الشمع إلى الشعور بالألم وفقدان السمع، كما قد يؤثر على أداء مساعِدات السمع. إذا لم يجتَز الشخص المسن اختبار فحص السمع، فيجب التحري عن وجود تراكم للشمع ومعالجته إن وُجد.

ويمكن إزالة شمع الأذن عبر غسل الأذن باستخدام ماء نظيف بدرجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية). إذا تعذَّر إزالة الشمع بأمان، يُنصح بالإحالة إلى رعاية متخصصة.

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- تركيب مساعِدات السمع في حالات فقدان السمع المتوسط (9.4.3)
- تقييم فقدان السمع الشديد/الصمم والتعامل معه وتوفير الأجهزة السمعية واستخدامها
- التعامل مع المشكلة الأساسية التي تسبب أو تساهم في فقدان السمع
- في حال تحديد أي مؤشرات خطرة (9.5)

2 قياس السمع التشخيصي ← 9.3.2

اختبار غير جراحي لتقييم القدرة على سماع الأصوات بترددتها ونغماتها المختلفة. يستلزم الاختبار غرفة هادئة وسماعات أذن. هناك نوعان من الاختبارات: مقياس سماع النغمات النقية وقياس سماع الكلام.

3 التدخُّلات المتعلقة بمؤشرات الخطر ← 9.5

- **الأدوية غير المناسبة (الأدوية السامة)** ← مراجعة الأدوية وسحبها أو وصف بدائل (9.5.1)
- **التعرض للضوضاء** ← تقديم المشورة بشأن مستوى الصوت الآمن واستخدام سدادات الأذن (9.5.2)
- الإحالة إلى رعاية السمع المتخصصة
  - **تاريخ من فقدان السمع المفاجئ أو المتسارع**
  - **فقدان السمع الأحادي أو غير المتماثل**
  - **الشكوى من ألم أو إفرازات في الأذن أو دوار**
  - **وجود تاريخ من أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المتكرر أو المزمن**

4 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 9.6

- **الحاجة إلى إجراء تعديلات على المنزل** ← ترتيب المنزل بغرض تسهيل التواصل (9.6.1)
- **الحاجة إلى المنتجات المساعِدة** ← توفير المنتجات المساعِدة مثل الهواتف وأجراس الأبواب المهتزة أو الوامضة، ومضخمات الصوت المحمولة (9.6.2)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← دعم مهام الحياة اليومية وتوفير فرص للمشاركة الاجتماعية (11.6)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← تقديم المشورة لمقدمي الرعاية بشأن استراتيجيات التواصل (9.2)

9.1
نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز صحة الأذن والسمع

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع أن يلعبوا دورًا في تقديم الرعاية العامة للأذن والسمع، إضافةً إلى تقديم نصائح حول أنماط الحياة لجميع المسنين، بمن فيهم الذين يعانون من فقدان السمع. ويمكن مشاركة المعلومات التي تتعلق بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحفاظ على صحة الأذن، وأهمية الفحوص الدورية للسمع، ومتى يجب طلب الرعاية الصحية، بما في ذلك الحالات التي يُشتبه فيها بفقدان السمع.

نصائح لجميع المسنين:

- تنظيف الجزء الخارجي فقط من الأذن باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- عدم وضع أي شيء داخل الأذن، مثل النكاشات القطنية أو أعواد القطن، شموع الهوبي، الزيوت، السوائل مثل الكيروسين، العيدان، العلاجات المنزلية أو الأصابع المتسخة.
- عدم السباحة أو الاغتسال في مياه ملوثة.
- عدم مشاركة سماعات الأذن أو سدادات الأذن مع الآخرين.
- عدم الاستماع إلى الأصوات أو الموسيقى العالية، واستخدم سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة.
- إجراء فحوص منتظمة للسمع مع مقدم الرعاية الصحية وطلب نصائح في حالة الشعور بألم في الأذن، أو وجود إفرازات، أو أي صعوبة في السمع.
- مقابلة عامل صحي ***في حالة الاشتباه بفقدان السمع***، في حال:
  – طلب تكرار ما يقوله الآخرون.
  – رفع صوت الراديو أو التلفاز.
  – مواجهة صعوبة في متابعة المحادثات في الأماكن الصاخبة.
  – مواجهة صعوبة في فهم ما يُقال عبر الهاتف.
  – وجود الطنين في الأذن (الطنين).
  – مواجهة مشاكل في سماع الأصوات مثل جرس الباب أو المنبه أو الهاتف.
  – أخبرك الآخرون بأنك تتحدث بصوت عالٍ.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع أيضًا تنظيم جلسات إرشادية أو مناقشات حول كيفية التعامل مع فقدان السمع، بما في ذلك استخدام مساعِدات السمع والمنتجات المساعِدة الأخرى. كما يمكنهم المساعدة في معالجة الوصمة الاجتماعية المرتبطة باستخدام مساعِدات السمع. يمكن لحملات التوعية أن تعلم الناس أن فقدان السمع ليس أمرًا يستحق الخجل منه أو إخفاؤه. واحد من بين كل 20 شخصًا يعاني من فقدان سمع يتطلب التدخل والعناية *(53)*.

9.2 الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة فقدان السمع

9.2.1 استراتيجيات التواصل

إذا تبيَّن أن أحد المسنين قد يعاني من فقدان سمع محتمل من خلال التقييم الأساسي في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين، ولم يكن قياس السمع التشخيصي متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم إرشادات حول استراتيجيات التواصل، سواء كانت مساعِدات السمع متوفرة أم لا. ينبغي أن تشمل نصائح ما يلي:

- منح الشخص الانتباه الكامل، خاصة إذا كان يعاني أيضًا من صعوبة في النطق.
- كشف الوجه عند التحدث والمحافظة على التواصل البصري لتُظهر أنك تستمع باهتمام وأنك تقدِّر ما يقوله.
- التأكد من وجود إضاءة جيدة على وجهك لمساعدة المستمع على رؤية شفتيك وأنت تتحدث. عدم المبالغة في حركات الشفاه أو تشويهها.
- لفت انتباه الشخص قبل أن تبدأ في التحدث.
- تقليل الضوضاء الخلفية أو الانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا.
- التحدث بوضوح وببطء. عدم رفع الصوت.
- منح الشخص الوقت الكافي للتحدث. عدم المقاطعة أو إكمال الجمل نيابةً عنه.
- تذكُّر أن الشخص قد يحتاج إلى وقت إضافي للتواصل. التحلّي بالصبر والاحترام.
- استخدام الإشارات غير اللفظية مثل هز الرأس للإشارة إلى متابعة المحادثة.
- عدم تحدّث الجميع في وقتٍ واحد في المجموعات. تشجيع الأشخاص على التحدث واحدًا تلو الآخر.
- عدم التوقف عن التحدث مع شخص يعاني من فقدان السمع.
- استخدام الوسائل البصرية مثل الصور أو الملاحظات المكتوبة إذا واجه الشخص صعوبة في التحدث.
- الوعي والبحث عن أسباب أخرى قد تؤدي إلى صعوبات في التواصل ولا تتعلق بفقدان السمع، مثل التدهور المعرفي.

مزيد من المعلومات

- *نصائح لصحة الأذنين*. WHO; 2023 (https://www.who.int/publications/m/item/community-resource-5-tips-for-healthy-ears)
- *فقدان السمع عند البالغين*. WHO; 2023 (https://www.who.int/publications/m/item/community-resource-1a-when-to-suspect-hearing-loss-in-an-adult)
- *مصادر أساسية للعناية بالأذن والسمع*. WHO; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/331171).
- *نصائح لمستعملي وسائل تقوية السمع*. WHO; 2023 (https://www.who.int/publications/m/item/community-resource-4-tips-for-hearing-aid-users)

9.3 تقييم مشاكل الأذن والقدرة السمعية

يُعد تحديد ومعالجة شمع الأذن باستخدام الفحص بمنظار الأذن خطوة مهمة قبل إجراء أي اختبارات تشخيصية لقدرة السمع.

9.3.1 تنظير الأذن

يجب التأكد دائمًا من فحص كلا الأذنين، حتى إذا كانت الشكوى في أذن واحدة فقط.

تنظير الأذن هو إجراء يسمح بتحديد الحالات التي تسبب فقدان السمع، مثل تراكم شمع الأذن أو ثقب الغشاء الطبلي. وهناك أنواع عديدة من مناظير الأذن. بعضها يمكن أن يتصل بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ويقوم بتسجيل صور أو فيديوهات لما يتم مشاهدته. ويحتاج منظار الأذن إلى أنبوب فحص، وهو ملحق (مصنوع عادةً من البلاستيك) يُستخدم لفحص القناة السمعية.

9.3.2 التقييم المُعمَّق للسمع

يمكن أن يشتمل تقييم السمع على ثلاثة اختبارات باستخدام المعدات وهي: مقياس سماع النغمات النقية، ومقياس سماع الكلام، ومقياس الشق الطبلي الخُشائي لتقييم الأذن الوسطى. ويمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد الحاجة إلى الأجهزة السمعية والدعم المناسب. وتحتاج هذه الاختبارات إلى تدريب متخصص.

- **مقياس سماع النغمات النقية:** يختبر قدرة الشخص على سماع أصوات بترددات صوتية نقية مختلفة (الدرجات). وتتألف العملية من تشغيل أصوات مسبقة التسجيل بمستوى عال فأعلى وأعلى إلى أن يستطيع الشخص سماعها لتحديد عتبة السمع. وتختبر العملية توصيل الهواء وتوصيل العظام للأصوات لتقييم عتبات السمع عند ترددات تتراوح من 125 هيرتز (منخفضة جدًا) إلى 8000 هيرتز (مرتفعة جدًا). يساعد هذا الاختبار في تحديد درجة فقدان السمع ونوعه.
- **قياس سماع الكلام:** يستفيد المسنون من هذا الاختبار الإضافي. وفي اختبار قياس سماع الكلام، يتم تشغيل كلمات بسيطة مسبقة التسجيل بدرجات صوتية متزايدة، ويُطلب من الشخص تكرار الكلمات عند سماعها. ويعمل هذا الاختبار على التحقق من نتائج قياس سماع النغمات. ويساعد الاختبار على البَت فيما إذا كان التعرف على الكلام متسقًا مع نتائج قياس سماع النغمات، أو ما إذا كان هناك عدم تناظر في تمييز الكلام لم يتوقعه قياس سماع النغمات، ويحدد الأذن التي يجب تثبيت الجهاز المساعِد للسمع عليها إذا ما كان من المزمع تثبيت جهاز واحد فحسب.
- **قياس الشق الطبلي الخشائي:** يختبر هذا القياس امتثال (أو تحرك) طبلة الأذن، أو مدى فاعلية طبلة الأذن في نقل الصوت إلى تجويف الأذن الوسطى وبالتالي إلى الأذن الداخلية. ويمكن أن يدعم هذا الاختبار نتائج قياس سماع النغمات النقية وقياس سماع الكلام لتحديد نوع مشكلة السمع.

يوضح مسار الرعاية كيفية معالجة فقدان السمع وفقًا لثلاث فئات (السمع الطبيعي، فقدان السمع المعتدل إلى الشديد، والصمم). وحيثما تسمح قدرة النظام الصحي، وحيث يُعتبر ذلك أكثر ملاءمة، يمكن أيضًا تحديد فقدان السمع الخفيف (20 إلى < 35 ديسيبل) (الجدول 9.1، الصفحة 101). ينبغي تقييم الأشخاص الذين تبيّن أن قدراتهم السمعية طبيعية، للتحقق من وجود علامات تحذيرية، وتقييم بيئاتهم الاجتماعية والمادية.

وبالإضافة إلى اختبارات السمع، يجب أيضًا التحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل التدهور المعرفي وأعراض الاكتئاب، وإجراء تقييم مُعمَّق عند الضرورة. ← 5 10

الجدول 9.1
تصنيف فقدان السمع وفقًا للحِده

الدرجة	عتبة السمع في الأذن الأفضل (ديسيبل)	تجربة السمع في بيئة هادئة
سمع طبيعي	< 20 ديسيبل	لا مشكلة في سماع الأصوات
فقدان سمع خفيف	20 إلى < 35 ديسيبل	لا يعاني من مشاكل في سماع الكلام العادي في بيئة هادئة.
فقدان سمع متوسط إلى شديد	20 إلى < 80 ديسيبل	صعوبة في سماع الكلام العادي في بيئة هادئة؛ إذا كان فقدان السمع شديدًا، ستكون هناك صعوبة في السمع حتى عند رفع الأصوات
الصمم	≥ 80 ديسيبل	صعوبة شديدة في سماع الأصوات العالية

9.4
معالجة فقدان السمع

قد يُعبر الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع عن مشاعر الإحراج والقلق وضعف تقدير الذات، مما يؤدي إلى تقليل مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية، والشعور بالعزلة الاجتماعية والوحدة، وجميعها عوامل تسهم في الإصابة بالاكتئاب. ← 10

يجب تقديم تدخُّلات لمعالجة فقدان السمع دائمًا كجزء من خطة رعاية شاملة وشخصية تستجيب للعوامل المستبطنة، إلى جانب التدخلات التي تستهدف مجالات أخرى من القدرة الذاتية. بالإضافة إلى دعم استراتيجيات التواصل، هناك العديد من الطرق الأخرى لتدبير فقدان السمع، بما في ذلك توفير الأجهزة السمعية والإحالة إلى خدمات التأهيل. ← **4.2.1**

يجب تقديم التثقيف الأساسي والإرشاد حول فقدان السمع لتشجيع ودعم التقبُّل النفسي والتكيف مع الحالة. يشمل ذلك استراتيجيات التواصل، وتكييف البيئة، وكيفية استخدام مساعِدات السمع، والإرشاد من الأقران. وقد يستفيد المسنون وأفراد أسرهم ومقدمو الرعاية، من الإرشاد لمساعدتهم على تقبُّل فقدان السمع والتكيف معه، بما في ذلك تعلم كيفية التغلب على المواقف الوصمية من الآخرين.

9.4.1
فقدان السمع المعتدل إلى الشديد

من المهم أن يتلقى المسنون الذين يعانون من فقدان السمع المعتدل إلى الشديد المعلومات والدعم لمساعدتهم على التكيُّف والعيش مع فقدان السمع. ويجب شرح فوائد الأجهزة السمعية مثل مساعِدات السمع للشخص الذي يعاني من فقدان السمع ومقدم الرعاية، بالإضافة إلى توفير معلومات عن أماكن الحصول عليها وكيفية استخدامها. وبمجرد أن يحصل الشخص على أحد مساعِدات السمع، يمكن لمقدم الرعاية الصحية دعم وتشجيع استخدامه.

9.4.2 الصمم

يحتاج المسن الذي يعاني من فقدان سمع شديد أو صمم أو الذي لا يستفيد من التدخلات المذكورة أعلاه، إلى نهج آخر مثل زراعة قوقعة الأذن، إذا كانت متوفرة. يمكن تحديد ذلك فقط من خلال التشاور مع أخصائي سمعي.

9.4.3 الأجهزة السمعية

يجب توفير معظم الأجهزة السمعية من قِبل عامل صحي مدرّب ومخوّل، وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية. وإذا لم تكن الأجهزة السمعية متاحة، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم معلومات حول استراتيجيات التواصل.

مساعِدات السمع: مساعِد السمع هو جهاز إلكتروني يتم ارتداؤه على الأذن أو داخلها. يساعد في تضخيم الأصوات لتمكين الشخص الذي يعاني من فقدان السمع من سماع الكلام والأصوات الأخرى بشكل أفضل. وعادة ما يكون تلك التكنولوجيا هي الأكثر فائدة وملائمة للمسنين الذين يعانون من فقدان السمع. يجب ألا يكون قياس السمع وحدَه العامل المحدد لحاجة الشخص إلى جهاز مساعِد للسمع؛ يجب تقييم احتياجات الشخص بشكل شامل قبل اقتراح استخدام مساعِد للسمع. من المهم توضيح للناس أن مساعِدات السمع لا تعالج أو تشفي فقدان السمع. يجب تقديم نصائح حول استخدام مساعِدات السمع وصيانتها، بما في ذلك استبدال البطارية وقطعة الأذن بشكل منتظم.

بعض البلدان لديها تشريعات تتيح الوصول إلى مساعِدات السمع بدون وصفة طبية، مثل مساعِدات السمع المبرمجة مسبقًا ومساعِدات السمع ذات التركيب الذاتي. وتكون مساعِدات السمع تلك مناسبة عمومًا للأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع خفيف إلى معتدل، دون وجود أي مؤشرات خطرة. وتكون مساعِدات السمع المبرمجة مسبقًا مضبوطة بالفعل وفقًا لأنواع فقدان السمع الأكثر شيوعًا بين المسنين. ويمكن لأي عامل صحي مدرَّب، تحديد الجهاز المساعِد للسمع المبرمج مسبقًا، المناسب وتركيبه.

نصائح ومعلومات بشأن استخدام مساعِدات السمع:

- كيفية عمل مساعِدات السمع وأهمية استخدامها بانتظام خلال ساعات الاستيقاظ.
- العناية بمساعِدات السمع، تشمل:
  - الاحتفاظ بها في مكان آمن وبارد عند عدم استخدامها، وإبعادها عن الماء والحرارة في جميع الأوقات؛
  - إزالتها أثناء الاستحمام أو التعرض للمياه؛
  - فتح درج البطارية في الليل؛
  - التأكد من إيقاف تشغيلها عند عدم استخدامها؛
  - تنظيف قطعة الأذن باستخدام قطعة قماش جافة يوميًا.
- تغيير أو إعادة شحن البطاريات وأماكن الحصول على بطاريات بأسعار معقولة.
- المشاكل الشائعة عند استخدام مساعِدات السمع وكيفية التعامل معها.
- مدى فعالية مساعِدات السمع – لتحديد التوقعات.

زراعة قوقعة الأذن: قوقعة الأذن المزروعة هي جهاز طبي إلكتروني للأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع شديد والذين لا يستطيعون الاستفادة من مساعِدات السمع. وتتكون من جزئين، معالج خارجي يلتقط الأصوات ويوصلها إلى الجزء المزروع الذي يتم وضعه جراحيًا في الأذن. وهي تقوم بتحويل الأصوات إلى نبضات كهربائية وإرسالها إلى أعصاب الأذن. يجب تقييم حالة الشخص بعناية لمعرفة ما إذا كانت زراعة قوقعة الأذن ستفيد حالته. وإذا كانت زراعة قوقعة الأذن غير متاحة أو غير ممكن زراعتها، يجب إبلاغ المسن وعائلته عن استراتيجيات التواصل المختلفة.

مزيد من المعلومات

- *التدريب على المنتجات المساعِدة للسمع*. TAP; 2024. (https://www.gate-tap.org/).
- *نهج تقديم خدمات مساعِدات السمع في البيئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط*. WHO; 2023. (https://iris.who.int/handle/10665/376092).
- *دليل التدريب على رعاية الأذن والسمع الأولية*. WHO; 2023. (https://iris.who.int/handle/10665/366334).

9.5 تقييم المؤشرات الخطرة ومعالجتها

هناك عدد من "المؤشرات الخطرة" المرتبطة بفقدان السمع مثل الأسباب المحتملة والمشاكل التي يجب اعتبارها كحالات تستدعي الإحالة إلى مختص صحي ذو معرفة متخصصة (مثل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة).

9.5.1 الأدوية غير المناسبة

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في إلحاق الضرر بالأذن الداخلية، مما يؤدي إلى فقدان السمع أو فقدان التوازن أو كليهما (*54*)، على سبيل المثال:

- المضادات الحيوية مثل الستربتومايسين والجنتاميسين؛
- أدوية الملاريا مثل الكينين والكلوروكين؛
- علاج مرض السل بالحقن المقاوم للأدوية المتعددة؛
- مدرات البول مثل الفوروسيميد؛
- ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين.

يجب مراجعة الأدوية مراجعة شاملة وتعديلها وقد يتطلب ذلك معرفة متخصصة. عندما يكون استخدام علاج سام للأذن ضروريًا، من المهم فحص السمع بانتظام لاكتشاف فقدان السمع في مراحله المبكرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

9.5.2 التعرض للضوضاء

يمكن أن يحدث فقدان السمع الناجم عن الضوضاء بسبب مجموعة من البيئات والسلوكيات في العمل أو المنزل أو أثناء الأنشطة الترفيهية. حيث يؤثر مستوى الصوت، ومدة الاستماع، وتكرار التعرض للأصوات العالية على السمع. في حالة فقدان السمع الناجم عن الاستخدام غير الآمن للأجهزة الصوتية الشخصية، هناك ممارسات بسيطة وفعالة، مثل الحفاظ على مستوى الصوت ضمن حدود الاستماع الآمنة وتقليل الوقت المستغرق في الأنشطة الصاخبة.

9.5.3 مؤشرات خطرة أخرى

تحتاج الظروف التي قد تكمن وراء فقدان السمع إلى تشخيص وتدبير متخصصين، ويشمل ذلك ما يلي:

- تاريخ من فقدان السمع المفاجئ أو المتسارع؛
- فقدان السمع الأحادي أو غير المتماثل؛
- الشكوى من ألم في الأذن أو إفرازات من الأذن أو دوار مع فقدان سمع متوسط إلى شديد؛
- وجود تاريخ من أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المتكرر أو المزمن (عدوى الأذن الوسطى).

9.6 تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

9.6.1 تعديل المنزل

يمكن أن تساعد التعديلات البيئية في المنزل وفي محيطه في دعم الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. ومن الأمثلة على ذلك، إضافة إضاءة لضمان رؤية الأشخاص أثناء المحادثات، وترتيب الأثاث بحيث تواجه الكراسي بعضها البعض لتيسير التواصل، وتثبيت أجراس الأبواب في أماكن مختلفة داخل المنزل، وتركيب أجهزة إنذار وامضة.

9.6.2 المنتجات المساعِدة

بالإضافة إلى الأجهزة السمعية، تشمل المنتجات المساعِدة التي قد تُفيد الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع مكبرات الصوت للهواتف، ومكبرات الصوت المحمولة، وأجهزة المراسلة النصية، والتطبيقات والبرامج التي تتيح إضافة الترجمة والتعليق النصي على المحتوى الصوتي عبر مختلف القنوات الإعلامية، وتحويل الكلام إلى نص. ويمكن أن تكون الحلقات الحثية السمعية مفيدة أيضًا. وهي تتكون من سلك أو عدة أسلاك يتم وضعها حول مساحة معينة، مثل غرفة اجتماعات أو مكتب خدمة. تُرسِل الأسلاك الإشارات من ميكروفون ومضخم صوت إلى أنواع معينة من مساعِدات السمع.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع المساعدة في تحديد ما هو متاح محليًا وتقديم المعلومات والدعم اللازمين. ويمكن للمنظمات المجتمعية التي تنظم دورات لدعم المسنين في تعلم واستخدام التكنولوجيا الرقمية أن تشمل جلسات تركز على كيفية استخدام الترجمة التلقائية وتطبيقات تحويل الكلام إلى نص.

9.6.3 الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

يمكن أن يقلل التفاعل الاجتماعي المنتظم من خطر التدهور المعرفي، والاكتئاب، والعواقب النفسية والسلوكية الأخرى لفقدان السمع. ويمكن لشبكات الدعم الاجتماعي أن تكون مفيدة في أوقات الضيق الشديد.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع وأفراد الأسرة أن يلعبوا دورًا من خلال الاستمرار في التواصل مع الشخص الذي يعاني من فقدان السمع، وتنظيم أنشطة تضمن بقاءه مندمجًا في الشبكات الاجتماعية.

إلى جانب الدعم لتعزيز المشاركة الاجتماعية، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع إلى أشكال أخرى من المساعدة في حياتهم اليومية. على سبيل المثال، إذا كانت هناك صعوبة في التواصل، فقد يكون الدعم مطلوبًا لإجراء المكالمات الهاتفية أو تحديد المواعيد.

9.6.4 دعم مقدمي الرعاية ← 12

يمكن لمقدمي الرعاية دعم المسن الذي يعاني من فقدان السمع من خلال تبني استراتيجيات التواصل التي تم توضيحها أعلاه. وقد يحتاج مقدمو الرعاية أنفسهم أيضًا إلى الدعم.



10

القدرة النفسية

مسار الرعاية لمعالجة أعراض الاكتئاب

يظهر على الأشخاص الذين يعانون من "أعراض الاكتئاب" عرضان أو أكثر من أعراض الاكتئاب متزامنين معظم الوقت لمدة لا تقل عن أسبوعين، لكنهم لا يستوفون معايير تشخيص الاكتئاب. تشيع أعراض الاكتئاب بين المسنين الذين يعانون من حالات مرضية طويلة الأمد ومُعيقة، ويمكن أن ترتبط بالتدهور في جميع مجالات القدرة الذاتية الأخرى. كما أنه من الشائع أن يعاني الأشخاص المعزولون اجتماعيًا أو مقدمو الرعاية الذين يتحملون مسؤوليات رعاية مرهقة من هذه الأعراض. ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات مع العائلة والأصدقاء والمجتمع.

تمثل أعراض الاكتئاب بُعدًا واحدًا من عدة أبعاد تشكل القدرة النفسية مثل القلق، والسمات الشخصية، وآليات التكيف، والإحساس بالتمكن.

يقدم هذا الفصل إرشادات توجيهية حول الوقاية من أعراض الاكتئاب لدى المسنين وإدارتها. ويمكن العثور على مزيد من الإرشادات حول التدخلات الخاصة بالاكتئاب (المعتدل إلى الشديد) وكذلك القلق في *دليل تدخلات البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية والإرشادات التوجيهية للبرنامج*.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع تحديد الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب من خلال طرح الأسئلة.
- يمكن للعاملين الصحيين غير المتخصصين المدربين وتحت الإشراف مساعدة الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض، باستخدام التدخلات النفسية.
- بالنسبة لمن يعانون من الاكتئاب (المعتدل إلى الشديد)، فإنهم بحاجة إلى نهج أكثر تحديدًا واستهدافًا وتخصيصًا.
- في حالة تحديد خطر وشيك لإيذاء النفس أو الانتحار، يجب إحالة الشخص فورًا إلى رعاية متخصِّصة.
- يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع رفع مستوى الوعي بأعراض الاكتئاب وفهمها لمواجهة الوصمة المرتبطة بها. كما يمكنهم المساهمة في معالجة العزلة الاجتماعية.

10

القدرة النفسية

مسار الرعاية لمعالجة أعراض الاكتئاب

تقييم
(أساسي)
3.1 ←

اجتياز

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة بما في ذلك نصائح لتعزيز الصحة النفسية ← 10.1
- إجراء التقييم الأساسي بشكل منتظم

رسوب

- التعامل مع الضغط النفسي من خلال تقنيات الاسترخاء عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب ← 10.2
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم
(مُعمَّق)
"أ" و"ب" و"ج"

إذا كان الخطر وشيكًا:

- تتم الإحالة الفورية إلى أخصائيي الرعاية الصحية ذوي المعرفة والتدريب
- تضافر جهود الأسرة والأصدقاء والزملاء المعنيين أو أفراد آخرين لضمان المراقبة الدقيقة
- ربط الشخص بالموارد المجتمعية، بما في ذلك خطوط المساعدة للصحة النفسية أو منع الانتحار
- إزالة وسائل إيذاء النفس

في حالة وجود اكتئاب (معتدل إلى حاد)
(≤ 3 أعراض إضافية) ← 10.4.4

- تقييم خطر إيذاء النفس/الانتحار
- التعامل مع الاكتئاب
  يرجى الاطلاع على دليل تدخُّلات البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (الاكتئاب)
  https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239

في حالة وجود أعراض الاكتئاب
(0–2 أعراض إضافية) ← 10.4

- التعامل مع الضغط النفسي ← 10.2
- التثقيف النفسي
- التدخلات النفسية المنظمة الوجيزة

تقييم
أعراض الاكتئاب

أولاً، تحديد وعلاج الأسباب المحتملة (انظر ب ◆)

أ

ب

ج

تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية

- العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية (أنشطة الحياة اليومية، المشاركة الاجتماعية)
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 3

تقييم
الأمراض وعوامل الخطر

- ◆ الأدوية غير المناسبة
- ◆ فقر الدم، سوء التغذية، قصور الغدة الدرقية
- ◆ الألم
- فقدان كبير أو فجيعة خلال الأشهر الستة الماضية
- الإعاقة بسبب المرض أو الإصابة
- تاريخ الهوس
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار 2

إعادة التقدير

دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع
خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

1 تقييم أعراض الاكتئاب ← 10.3

إذا أبلغ الشخص عن **عرض أساسي واحد على الأقل**، مثل الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو فقدان الأمل، أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة، يجب إجراء تقييم إضافي.

اسأل: خلال الأسبوعين الماضيين، هل أزعجك أيٌّ من المشاكل التالية؟

- صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا، أو النوم لفترات طويلة جدًا
- شعور بالتعب أو نقص الطاقة
- ضعف الشهية أو الإفراط في الأكل
- الشعور بالسوء تجاه نفسك أو بأنك فاشل أو أنك خذلت نفسك أو عائلتك
- صعوبة في التركيز على أمور مثل قراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفاز
- التحرك أو التحدث ببطء شديد لدرجة أن الآخرين قد يلاحظون ذلك
- الشعور بالتململ أو الانفعال لدرجة أنك تتحرك أكثر من المعتاد
- تراودك أفكار بأنك ستكون أفضل حالًا لو كنت ميتًا أو أفكار بإيذاء نفسك بطريقة ما

إذا كان لدى الشخص **أكثر من عرضين إضافيين**، فقد يكون مصابًا بالاكتئاب (المتوسط إلى الوخيم). من المهم التمييز بين الأعراض الاكتئابية والاكتئاب، لأن علاجهما يختلف.

نصائح عند طرح الأسئلة:

- مقابلة الشخص في مكان خاص إذا أمكن.
- التفهم ومراعاة مشاعر الآخرين.
- مراعاة المشاعر بشكل أكبر عند التطرق إلى المواضيع الصعبة.
- تذكير الشخص بسرية الحديث وعدم البوح به ما لم يكن هناك خطر على إيذاء النفس أو الانتحار.
- تجنُّب الحكم على الأشخاص بناءً على سلوكهم أو مظهرهم.
- الإقرار بأن الشخص قد يواجه صعوبة في الإفصاح عن هذه المعلومات.
- اقتراح التحدث مع الشخص على انفراد إذا كان مقدمو الرعاية حاضرين.

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- خطر وشيك من إيذاء النفس أو الانتحار لمقدمي الرعاية (10.4.4)
- إدارة الاضطراب ثنائي القطب أو الذُّهان (الأوهام، الهلاوس، السلوك غير المنظم، اضطرابات المزاج) (10.5.4)
- توفير التدخلات النفسية المنظمة الوجيزة (10.4.2)
- إدارة الألم المزمن الذي يتطلب رعاية شاملة (6.5.2)

2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 10.5

- **الأدوية غير المناسبة** ← مراجعة الأدوية وسحبها أو وصف بدائل (10.5.1)
- **فقر الدم، سوء التغذية، قصور الغدة الدرقية** ← التعامل مع الأمراض (10.5.2)
- **الألم** ← تقييم الألم والتعامل معه (6.5.2)
- **الخسارة الكبيرة (الفجيعة) في الأشهر الستة الماضية** ← تقديم المشورة بشأن التكيف الثقافي المناسب وعمليات الحداد
- **الإعاقة بسبب المرض أو الإصابة** ← تقديم المشورة حول تقليل الضغط النفسي وتعزيز الدعم الاجتماعي
- **تاريخ الهوس** ← يرجى الاطلاع على دليل تدخُّلات البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (الذهان)

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 10.6

- **العزلة الاجتماعية والوحدة** ← تحديد الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية ومعالجته (11.3.3)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← دعم مهام الحياة اليومية، بما في ذلك أنشطة الحياة اليومية (11.6)
- تشجيع المشاركة في الأنشطة المجتمعية (11.3.4)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← تقديم التثقيف النفسي والدعم النفسي والاجتماعي (12.4)

10.1 نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز الصحة النفسية

يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم نصائح لجميع المسنين، بمن فيهم الذين يعانون من أعراض اكتئابية، حول أنماط الحياة الصحية لتعزيز الصحة النفسية وتدبير أعراض الاكتئاب.

تشمل نصائح لجميع المسنين أهمية:

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.
- الحصول على قسط جيد وعالٍ الجودة من النوم، بما في ذلك الحفاظ على روتين ثابت لأوقات النوم والاستيقاظ.
- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.
- الحفاظ على الروابط الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
- الاستفادة من تقنيات الحد من التوتر.
- تجنب وتقليل الإفراط في تناول الكحول والمواد المؤثرة نفسياً. يمكن أن تزيد اضطرابات تعاطي الكحول والاكتئاب من خطر الانتحار وتؤثر على جودة النوم.

إلى جانب نصائح بشأن أنماط الحياة الصحية، يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم معلومات إضافية حول أعراض الاكتئاب وغيرها من الحالات الصحية النفسية. ويمكن أن يُسهم رفع مستوى الوعي في تمكين المسنين ومقدمي الرعاية من فهم أعراض الاكتئاب وتدبيرها بشكل أفضل. كما أن تطبيع مناقشة الحالات النفسية يمكن أن يساعد في الحد من الوصمة والتمييز والإقصاء الاجتماعي، ويدعم الأشخاص ليكونوا أكثر انفتاحًا بشأن مشاعرهم. ومن المهم أيضًا توعية الناس بأن أعراض الاكتئاب ليست جزءًا طبيعيًا أو حتميًا من الشيخوخة، ولكن في حال حدوثها، يمكن معالجتها أو تدبيرها.

10.2 الرعاية الصحية المجتمعية لمعالجة أعراض الاكتئاب

10.2.1 معالجة التوتر

إذا تبيَّن أن أحد المسنين قد يعاني من أعراض الاكتئاب من خلال التقييم الأساسي في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين ولم يكن التقييم المُعمَّق متاحًا على الفور، يمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين تقديم إرشادات حول معالجة التوتر. يمكن تقديم هذه الإرشادات من خلال المساعدة الذاتية غير الموجَّهة أو في أشكال موجَّهة. ويمكن أيضًا تقديم هذه الإرشادات إلى مقدمي الرعاية. ← 12.1

تعد ممارسة التمارين البدنية، والنوم الجيد التصالحي، وقضاء وقت ممتع مع الأحباء، جميعها استراتيجيات مفيدة للمساعدة في معالجة التوتر. ويجب تشجيع ممارسة التمارين البدنية وتكييفها وفقًا لقدرة الشخص الحركية وتفضيلاته، نظرًا لتأثيرها الإيجابي في تقليل التوتر، وتخفيف أعراض القلق والحزن، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين النوم. ← 6.1

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء والمشاركة في أنشطة ممتعة ذات اهتمام مع الأصدقاء أو الأحباء مفيدة أيضًا. ويُعد التنفس العميق والتمدد واسترخاء العضلات من الطرق السريعة والفعالة لتقليل التأثيرات الجسدية والنفسية للتوتر. وقد يكون من المفيد ممارسة هذه التقنيات يوميًا للمساعدة في الحفاظ على القدرة على التكيف، ولتأسيس روتين يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة عند الحاجة الشديدة لهذه التقنيات.

مزيد من المعلومات

- *الإصدار التجريبي الميداني: أدوات mhGAP المجتمعية: البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP).* WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/328742).
- *القيام بما يهم في أوقات الضغط النفسي: دليل مصور.* WHO; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/331901).

10.3 تقييم أعراض الاكتئاب

يُعد تحديد وعلاج أي أسباب محتملة قابلة للتصحيح تُشبه أعراض معالجة الاكتئاب أو تفاقمها، خطوة أولى مهمة عند إجراء تقييم مُعمَّق لأعراض الاكتئاب (◆). ← 10.5

بعد ذلك، يمكن للعامل الصحي تحديد الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب والتمييز بين الأعراض الاكتئابية والاكتئاب (المعتدل إلى الشديد) في مرفق الرعاية الأولية، من خلال طرح سلسلة من الأسئلة. إذا أبلغ الشخص عن عرض أساسي واحد على الأقل، مثل الشعور بالحزن أو الاكتئاب أو فقدان الأمل، أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة، بالإضافة إلى واحد أو اثنين من الأعراض الإضافية، فقد يكون لديه أعراض اكتئابية. أما إذا كان لدى الشخص أكثر من عرضين إضافيين، فقد يستوفي معايير تشخيص الاكتئاب المعتدل إلى الشديد. وغالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب معتدل إلى شديد صعوبة كبيرة في الأداء اليومي على المستوى الشخصي أو العائلي أو الاجتماعي أو في سياقات أخرى.

يجب على العامل الصحي أيضًا تقييم الضغوطات النفسية مثل الفجيعة والأحداث المؤلمة التي يمكن أن تفسر أعراض الاكتئاب

بالإضافة إلى التقييم المُعمَّق لأعراض الاكتئاب، يجب أيضًا التحقق من نتائج التقييمات الأساسية للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل التدهور المعرفي، وضعف البصر، وفقدان السمع، وإجراء تقييمات مُعمَّقة عند الضرورة. ← 5 8 9

يمكن الاطلاع على قسم الاكتئاب في *دليل التدخلات للبرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية* للحصول على تفاصيل حول كيفية إجراء التقييم. ويمكن استخدام الأدوات لتقييم الاكتئاب، مثل *استبيان صحة المريض* (PHQ-9).

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الصفحة 107. ❶

10.4 معالجة أعراض الاكتئاب

يجب تقديم تدخُّلات لإدارة أعراض الاكتئاب دائمًا كجزء من خطة رعاية شاملة وشخصية تستجيب للعوامل المستبطنة، إلى جانب التدخلات التي تستهدف مجالات أخرى من القدرة الذاتية.

بالإضافة إلى الإرشادات حول إدارة التوتر، هناك العديد من الطرق الأخرى لمعالجة أعراض الاكتئاب، بما في ذلك التثقيف النفسي والتدخلات النفسية المنظمة الوجيزة. ويوصى بتطبيق **نهج رعاية متدرج**، بدءًا من تدخل منخفض الكثافة قائم على المساعدة الذاتية (مثل معالجة التوتر)، مع مراقبة الأعراض وتقديم تدخلات إضافية في حالة عدم التحسن أو التدهور.

10.4.1 التثقيف النفسي

يشير التثقيف النفسي إلى برامج تعليمية تستهدف المسنين الذين يعانون من أعراض الاكتئاب ومقدمي الرعاية، وتركز على تحسين فهم الأعراض، بما في ذلك الأسباب المحتملة، ومراقبة الأعراض، واستراتيجيات التكيف، مع مراعاة الصعوبات الخاصة بأنشطة الحياة اليومية وحل المشاكل. يهدف هذا التثقيف إلى:

- تعزيز معرفة الشخص بحالته وتمكينه من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العلاج.
- تحسين فهم كيفية تأثير العلاج وشرح فائدته، مما يشجع على الالتزام بالعلاج ووضع توقعات واقعية.
- زيادة الشعور بالتحكم والتمكين والسيطرة علي القلق.
- إعطاء الأمل في الشفاء.
- تحسين معرفة مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة، مما يساعدهم على تقديم دعم أفضل للشخص.

من المهم تقديم كميات مختصرة من المعلومات في كل مرة، واستخدام لغة بسيطة وأمثلة ذات صلة، والتحقق من فهم الشخص أو المجموعة للمعلومات المقدمة.

يمكن تقديم التثقيف النفسي بشكل فردي أو في جلسات جماعية، شريطةَ أن يتم تكييف مكوناته العلاجية بحيث تتناسب مع الأسلوب الهيكلي للتثقيف النفسي.

10.4.2 التدخلات النفسية المنظمة الوجيزة

تشير التدخلات النفسية إلى الاستخدام المقصود والمستنير للتقنيات السريرية المستمدة من المبادئ النفسية، لمساعدة الأفراد على تعديل مهاراتهم النفسية (مثل المهارات العاطفية والتفاعلية والسلوكية والمعرفية). وإذا لم يكن هناك تحسن في أعراض الاكتئاب بعد تقديم الإرشادات حول معالجة التوتر والتثقيف النفسي، يمكن النظر في التدخلات النفسية المنظمة الوجيزة، مثل العلاج بتنشيط السلوك، والعلاج المعرفي السلوكي، وعلاج حل المشاكل، ويمكن وضع علاجات الموجة الثالثة في الاعتبار.

يمكن تقديم التدخلات النفسية بطرق مختلفة، وتشمل عادةً 8-10 جلسات، ويمكن أن تكون فردية أو جماعية وجهًا لوجه. وعادةً ما يقوم المهنيون الصحيون المتخصصون في الصحة النفسية، مثل الأطباء النفسيون، بتقديم هذه التدخلات. ومع ذلك، يمكن للعاملين الصحيين في مرافق الرعاية الأولية تقديمها إذا كانوا مدربين ومؤهلين في مسائل الصحة النفسية لدى المسنين، وذلك عندما تفوق الفوائد المحتملة المخاطر.

وعلى الرغم من أن العلاج النفسي وجهًا لوجه غالبًا ما يحقق نتائج أفضل، إلا أن المساعدة الذاتية غير الموجهة قد تكون مناسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى العلاج النفسي المباشر أو الذين لا يرغبون في تلقيه.

- **العلاج بالتنشيط السلوكي:** يركز هذا النهج على تحسين الحالة المزاجية من خلال إعادة الانخراط في أنشطة هادفة وممتعة، حتى في ظل الحالة المزاجية المتدنية الحالية. ويمكن استخدام التنشيط السلوكي كعلاج مستقل، وهو أيضًا أحد مكونات العلاج المعرفي السلوكي.
- **العلاج المعرفي السلوكي:** قد يعاني الأشخاص الذين لديهم أعراض اكتئابية من أفكار سلبية غير واقعية ومشوَّهة قد تؤدي إلى سلوكٍ مؤذ. يجمع العلاج المعرفي السلوكي بين التفكير بطريقة مختلفة (مثل، التعرف على الأفكار السلبية غير الواقعية وتحديها) والتصرُّف بطريقة مختلفة (مثل: مساعدة الشخص على الانخراط في أنشطة أكثر إشباعًا ومكافأة)، مما يجعله نهجًا فعالًا.
- **علاج حل المشاكل:** يتضمن علاج حل المشاكل الاستخدام المنهجي لتقنيات تحديد المشاكل وحلها على مدار عدة جلسات. ويتيح هذا النوع من العلاج دعمًا مباشرًا وعمليًا؛ من خلال تفكيك المشاكل إلى مهام محددة يمكن معالجتها، ثم تطوير استراتيجيات تكيفية للتعامل مع كل مشكلة على حدة.
- **علاجات الموجة الثالثة:** تشمل هذه العلاجات: التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية، وعلاج القبول والالتزام، والعلاج فوق المعرفي، والعلاج السلوكي الجدلي. ويُستخدم مصطلح "التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية" هنا كمصطلح شامل يشمل التأمل الواعي، والتأمل وتقنيات اليوغا، بالإضافة إلي العلاج المعرفي وتقنيات الحد من التوتر القائم كلاهما علي اليقظة الذهنية. وتتمثل اليقظة الذهنية في التركيز على ما يحدث في اللحظة الحالية بدلًا من الانجراف مع الأفكار حول الماضي أو المستقبل أو الأمنيات أو المسؤوليات أو الندم.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم معلومات حول الخدمات المتاحة والدعم، والمساعدة في كسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية. ويمكن أن يكون هذا النهج فعالًا بشكل خاص عند مشاركة القادة المجتمعيين الموثوق بهم، بما في ذلك القيادات الدينية. ويمكن للمنظمات المجتمعية المساعدة في تحديد الأشخاص في مجتمعاتهم الذين قد يعانون من أعراض الاكتئاب ويحتاجون إلى دعم، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الذين قد يعانون من الأعراض نفسها. ويمكنهم المساعدة من خلال إحالة الأشخاص إلى الخدمات المناسبة، وإنشاء مجموعات دعم الأقران، وتنظيم فعاليات لتعزيز المشاركة الاجتماعية، وتقديم الدعم في المهام اليومية التي قد تكون مصدرًا للتوتر.

10.4.3
التدهور المعرفي ← 5

قد يرتبط التدهور المعرفي والخرف بظهور أعراض الاكتئاب. لذا، يجب التحقق من نتائج التقييم الأساسي للتدهور المعرفي، وإجراء تقييم مُعمَّق عند الضرورة. وتشمل الوظائف المعرفية التي قد تتأثر بالاكتئاب الانتباه والذاكرة، بالإضافة إلى الوظائف التنفيذية. وقد يكون الاكتئاب استجابة نفسية لوعي الشخص بوجود تدهور معرفي طفيف لم يبدأ بعد في التأثير على الأداء اليومي.

وغالبًا ما يشكو الأشخاص المصابون بالخرف من مشاكل مزاجية أو سلوكية، مثل فقدان الاهتمام، وفقدان السيطرة العاطفية، أو صعوبة تنفيذ الأنشطة اليومية المعتادة، سواء في العمل أو المنزل أو الحياة الاجتماعية. يجب النظر في تقديم التدخلات النفسية مثل العلاج المعرفي السلوكي، والعلاج النفسي التفاعلي، والإرشاد النفسي المنظم، والعلاج بتنشيط السلوك للأشخاص المصابين بالخرف والاكتئاب الخفيف إلى المتوسط (راجع *توجيهات البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP)*).

10.4.4
معالجة الاكتئاب المعتدل إلى الشديد

بالنسبة لمن يعانون من الاكتئاب (المعتدل إلى الشديد)، فإنهم بحاجة إلى نهج أكثر تحديدًا واستهدافًا وتخصيصًا. ويشمل ذلك إجراء تقييم للأفكار أو الخطط أو الأفعال المحتملة لإيذاء النفس أو الانتحار، مع تقديم تدخلات مستندة إلى البيّنات مثل مضادات الاكتئاب والتدخلات النفسية المنظمة الوجيزة.

إن سؤال الشخص عن أفكار أو نوايا إيذاء النفس أو الانتحار لا يؤدي إلى تحفيز هذه الأفعال. بل غالبًا ما يقلل من القلق المرتبط بهذه الأفكار ويمنح الشخص إحساسًا بالراحة. ومع ذلك، من المهم بناء علاقة ثقة مع الشخص قبل طرح مثل هذه الأسئلة. عند مناقشة موضوع الانتحار، يمكن الاعتراف بأن الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط الشديد أو فقدان الأمل قد تراودهم أفكار حول الموت أو إنهاء حياتهم، وأن هذه الأفكار جائزة حتى وإن كانت غير شائعة، ولا ينبغي أن يشعروا بالخجل منها.

وبعد التأكد من موافقة الشخص على مناقشة هذا الموضوع، يمكن طرح أسئلة مثل "خلال الشهر الماضي، هل راودتك أفكار جدية بشأن إنهاء حياتك أو وضعت خطة لذلك؟ أو هل قمت بأي تصرفات لإنهاء حياتك خلال السنة الماضية؟"

إذا تم تحديد خطر وشيك لإيذاء النفس أو الانتحار، يجب إحالة الشخص على الفور إلى العاملين الصحيين المدربين على الصحة النفسية أو إلى الرعاية المتخصصة، إذا كانت متاحة. ويجب أيضًا إشراك أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء أو الجيران لمراقبة الشخص، وإزالة أي وسائل محتملة قد يستخدمها الشخص لإيذاء نفسه. وربط الشخص ومقدمي الرعاية بالخدمات المجتمعية، مثل خطوط المساعدة في الصحة النفسية أو منع الانتحار التي توفر نصائح والدعم.

يتطلب وصف مضادات الاكتئاب معرفة متخصصة في إدارة الحالات النفسية. ويجب ألا يكون العلاج بمضادات الاكتئاب وحده الخيار الأساسي للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب (المعتدل إلى الشديد)، بل يُفضَّل اللجوء إليه عندما لا تكون التدخلات النفسية المنظمة متاحة.

مزيد من المعلومات

- ***دليل التدخل للبرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) للاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد في المرافق غير المتخصصة: البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP)، الطبعة 2.0.***
  WHO; 2016 (https://iris.who.int/handle/10665/250239).
- ***البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) للاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد، [الطبعة الثالثة].*** WHO; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/374250).
- ***دليل تنفيذ التدخلات النفسية: دمج التدخلات النفسية المستندة إلى البيّنات في الخدمات القائمة.*** WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376208).

10.5 تقييم الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة ومعالجتها

يجب أن يبدأ تقييم الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بأعراض الاكتئاب من خلال تحديد ومعالجة الأسباب المحتملة (◆).
تشمل الحالات الشائعة وعوامل الخطر التي يمكن أن تسبب أعراض الاكتئاب: الأدوية، وفقر الدم، وسوء التغذية، وقصور الغدة الدرقية، والألم. وفي بعض الحالات، يؤدي علاج هذه الحالات إلى تحسُّن في أعراض الاكتئاب. وإذا استمرت أعراض الاكتئاب، فسيكون من الضروري إجراء تقييم إضافي. ويتطلَّب كشف الأسباب المحتملة لأعراض الاكتئاب، إجراء فحص تشخيصي كامل، يشمل في بعض الأحيان تحاليل دم.

10.5.1 الأدوية غير المناسبة ◆

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى ظهور أعراض الاكتئاب. تشمل هذه الأدوية، ولكنها لا تقتصر على الأدوية التي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي، مثل مضادات الهيستامين، والأدوية النفسية، ومرخيات العضلات، وأدوية أخرى غير نفسية ذات خصائص مضادة للكولين، والمنشطات. ويمكن أن تفوق الأضرار المحتملة لهذه الأدوية فوائدها لدى بعض الأشخاص. ويمكن أن يساعد إزالة الأدوية غير الضرورية وغير الفعّالة بالإضافة إلى الأدوية التي تحتوي على مكونات نشطة مشتركة في تقليل تعدد الأدوية. ← 4.2.4

10.5.2 فقر الدم وسوء التغذية وقصور الغدة الدرقية ◆

تؤثر العديد من الأمراض على أعراض الاكتئاب مثل أمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، والسرطان، والأمراض المناعية الذاتية، وفقر الدم، وسوء التغذية، وقصور الغدة الدرقية. ومن المهم السيطرة على هذه الأمراض، حيث يمكن أن تُشبه أو تؤدي إلى تفاقُم أعراض الاكتئاب.

يمكن أن يؤدي فقر الدم وسوء التغذية إلى أعراض الاكتئاب بسبب نقص الحديد، والفيتامينات مثل حمض الفوليك، والفيتامين باء 6 وفيتامين باء 12. كما يمكن أن تلعب أعراض الاكتئاب دورًا في تفاقم فقر الدم. على سبيل المثال، فقدان الشهية وقلة الاهتمام في أداء الأنشطة اليومية (مثل التسوُّق والطهي)، كلاهما مرتبط بأعراض الاكتئاب، ويمكن أن يقلل ذلك من جودة وكمية التغذية، مما قد يؤدي إلى تطور فقر الدم وسوء التغذية. لمعالجة أعراض الاكتئاب، من الضروري إدارة فقر الدم وتحسين الحالة التغذوية. ← 7

يُعد قصور الغدة الدرقية اضطرابًا شائعًا بين المسنين، خاصة عند النساء. وقد تكون أعراض قصور الغدة الدرقية غير محدّدة للمرض مثل التعب وجفاف الجلد ويمكن أن تشمل أعراض الاكتئاب. لذا، يتطلب تشخيص قصور الغدة الدرقية عادة إجراء تحليل دم، ويجب أن يتم من خلال العاملين الصحيين ذوي المعرفة المتخصصة.

10.5.3 الألم ◆

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين الألم وأعراض الاكتئاب. إن الأفراد الذين يعانون من ألم مزمن غالبًا ما يكون لديهم أعراض اكتئابية، ويمكن أن تظهر أعراض الاكتئاب كأعراض جسدية مثل الآلام والأوجاع غير المحددة. ويعاني بعض الأشخاص من دائرة مفرغة حيث يُفاقم الألم من أعراض الاكتئاب، ويزيد الاكتئاب الناتج من مشاعر الألم. لذا، فمن المهم معالجة الألم وأعراض الاكتئاب بطريقة شاملة ومتنوعة. ← 6.5.2

10.5.4
حالات أخري مصاحبة

وجود الحالات المرتبطة التالية قد يشير إلى الحاجة إلى نهج مختلف في علاج أعراض الاكتئاب.

- **الخسارة الكبيرة (الفجيعة) في الأشهر الستة الماضية:** الفجيعة هي عملية طبيعية تتعلق بالفقدان، والحزن، والتعافي المرتبط بالموت. وللحزن تأثيرات نفسية وجسدية، يعبّر الناس عن حزنهم بطرق مختلفة مثل إظهار مشاعر قوية أو ردود فعل محدودة. في معظم الحالات يقل الحزن مع مرور الوقت. ويُعد النقاش والدعم للتكيف مع الحزن أو عمليات الحداد المناسبة ثقافيا أمر مهم لتدبير الحزن. إذا تضمنت أعراض الشخص صعوبة كبيرة في القيام بالأنشطة اليومية تستمر لأكثر من ستة أشهر وتشمل انشغالًا شديدًا أو اشتياقًا مكثفًا للشخص المتوفى ومشاعر عاطفية شديدة، فيجب الشك في وجود اضطراب الحزن. في هذه الحالة، يجب استشارة عامل صحي ذو معرفة متخصصة.

- **الإعاقة بسبب المرض أو الإصابة:** الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بسبب المرض أو الإصابة يواجهون ضغطًا نفسيًا؛ كما يجب عليهم التكيف مع التحولات في حياتهم. ومن مراحل التكيف مع شكل جديد من الإعاقة، الصدمة والإنكار والتكيف/التقبل. المسنون الذين يعانون من إعاقات جديدة معرضون لخطر تطور القلق والاكتئاب. وفي معظم الحالات، من المحتمل أن تتناقص الأعراض مع مرور الوقت، خاصةً إذا حصل الشخص على الدعم الاجتماعي وشارك في تقليل التوتر.

- **تاريخ الهوس:** الهوس هو نوبة من تحسن زائد في المزاج وزيادة الطاقة والنشاط. الأشخاص الذين يعانون من نوبات هوس يتم تصنيفهم على أنهم يعانون من اضطراب ثنائي القطب، الذي يتميز بتناوب نوبات هوس واكتئاب. ويمكن تحديد تاريخ الهوس من خلال فحص عدة أعراض، بما في ذلك قلة ساعات النوم، وزيادة الحديث أو الكلام بسرعة، والسلوكيات الاندفاعية أو المتهورة التي تحدث في نفس الوقت، وتستمر لمدة لا تقل عن أسبوع واحد، وتكون شديدة بما يكفي لتؤثر بشكل كبير على العمل والأنشطة الاجتماعية أو تتطلب دخول المستشفى أو الحجز. تتطلب معالجة الهوس أخصائيين في الرعاية الصحية مدربين في الصحة النفسية أو الرعاية المتخصصة، إذا كان ذلك متاحًا.

10.6
تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

10.6.1
العُزلة الاجتماعية والوحدة

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة أو شيقة هو أمر شائع بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي إلى العُزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة. من المهم محاولة فهم أي عوامل قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية والوحدة أو تفاقمها، بالإضافة إلى أعراض الاكتئاب، مثل العلاقات الشخصية المعقدة. ويمكن أن يكون سؤال المسن مفيدًا، عمّا إذا كانت هناك أنشطة يرغب في تجربتها والمشاركة فيها وتقديم الدعم لتمكينه من ذلك. ← 11.3.3

10.6.2
الرعاية والدعم الاجتماعيين

قد يجد المسن الذي يعاني من أعراض الاكتئاب صعوبة في تدبير الأنشطة اليومية وقد يحتاج إلى الرعاية والدعم الاجتماعيين. ويمكن أن يبدأ ذلك بتقديم المساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، والتواصل مع الأسرة وأشكال أخرى من الدعم الاجتماعي.

ومن المهم تحديد ومناقشة القضايا ذات الصلة التي تضع ضغطًا على الشخص أو تؤثر في حياته، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، مشاكل الأسرة والعلاقات، والإسكان، والحالة المالية، والوصول إلى الخدمات الأساسية والأمن، والوصمة الاجتماعية، والتمييز، والإساءة (إساءة معاملة المسنين بما في ذلك الإهمال). ← 11.4

10.6.3
دعم مقدمي الرعاية ← 12

يجب تقديم المعلومات ونصائح لمقدمي الرعاية للأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب، بما في ذلك من خلال التدخلات التثقيفية النفسية. وقد تُنتج التدخلات التثقيفية النفسية مجموعة واسعة من الآثار الإيجابية، بما في ذلك تقليل أعراض الاكتئاب لدى مقدم الرعاية، إذا كانت موجودة، وتقليل عبء الرعاية والتوتر والقلق؛ بالإضافة إلى زيادة الرفاه وجودة الحياة الصحية.

يمكن للعاملين الصحيين دعم مقدمي الرعاية من خلال:

- مساعدتهم في فهم أن أعراض الاكتئاب هي أمرٌ شائع. توضيح أنها ليست علامة على الضعف أو الكسل ولا يمكن التحكم بها بالإرادة فقط.
- تشجيع الانفتاح والتواصل بين مقدمي الرعاية والشخص الذي يقدمون له الرعاية، ومن الأمثلة على ذلك:
  - الاستماع بتعاطف دون إصدار أحكام.
  - التواجد بجانبهم وقت حاجتهم إليهم وجعلهم يشعرون أنهم ليسوا وحدهم وأنهم مفهومون.
  - الاعتراف بمشاعرهم.
- توفير معلومات حول أعراض الاكتئاب وخدمات الصحة النفسية.
- شرح أن أعراض الاكتئاب غالبًا ما تكون مصحوبة بأفكار سلبية غير واقعية عن الأنفس والحياة، ولكن من المرجح أن تتحسن هذه الأفكار مع تحسن الأعراض.
- دعم ما يمكن لمقدمي الرعاية القيام به لمساعدة الشخص على الالتزام بالعلاج (مثل المساعدة في تحديد المواعيد).
- تثقيف مقدم الرعاية حول خطط الأزمات وما يجب فعله في الحالات الطارئة، بما في ذلك عندما يُظهر الشخص الذي يعتنون به أفكارًا أو أفعالًا مثل إيذاء النفس أو الانتحار.
- شرح أهمية احترام كرامة وحقوق الشخص الذي يعاني من أعراض الاكتئاب.

من المهم أيضًا الاعتراف بأن رعاية شخص يعاني من أعراض الاكتئاب يمكن أن تكون تحديًا، وقد يحتاج مقدم الرعاية إلى الدعم من أجل صحته ورفاهه الشخصي. ويجب تقييم الأثر النفسي الاجتماعي واحتياجات مقدم الرعاية لضمان تقديم الدعم المناسب.



11

الرعاية والدعم الاجتماعيين

مسار الرعاية بشأن الرعاية والدعم الاجتماعيين

قد يحتاج جميع المسنين إلى الرعاية والدعم الاجتماعيين في مرحلة ما لتمكينهم من العيش حياة كريمة ذات معني. وقد تنشأ هذه الحاجة بغض النظر عن قدرتهم الأساسية، وقد تتغير مع مرور الوقت. قد تنشأ احتياجات الرعاية والدعم الاجتماعيين من تغييرات في القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية، على سبيل المثال الحاجة إلى الدعم في الأنشطة اليومية الأساسية والأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية، لكن تختلف احتياجات وتفضيلات الدعم وقبول كيفية تقديمه، على المستوى الفردي والثقافي الاجتماعي. يتيح تقديم الرعاية والدعم الاجتماعيين للمسنين الاستمرار في القيام بالأشياء التي تهمهم في المكان الذي يختارونه.

والشخص الأنسب لطرح أسئلة حول احتياجات الرعاية والدعم الاجتماعيين في معظم الحالات هو المُسن نفسه. ومع ذلك، قد توجد حالات يجب توجيه الأسئلة فيها إلى شخص آخر. على سبيل المثال،إذا كان المُسن يعاني من تدهور معرفي، يُستحسن طرح الأسئلة المتعلقة بالأنشطة اليومية الأساسية والمالية على شخص يعرف المسن جيدًا مثل فرد من أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع طرح أسئلة لتحديد احتياجات الدعم الاجتماعي.
- إن التدخلات ونصائح من قطاعات متعددة، مثل الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل، والمالية، والخدمات القانونية، مهمة لدعم المسنين.
- قد يحتاج المسنون الذين يعانون من فقدان كبير في قدرتهم الذاتية إلى مساعدة شخصية لأداء المهام اليومية، مثل الاستحمام، وارتداء الملابس، واستخدام المرحاض، وتناول الطعام.
- يجب على العاملين الصحيين في الرعاية الأولية وأصحاب المصلحة في المجتمع ملاحظة العلامات المحتملة لتعرض المسنين لإساءة المعاملة والإهمال واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- أصحاب المصلحة في المجتمع هم مقدمو الرعاية والدعم الاجتماعيين الأساسيين، وغالبًا ما يشاركون في تنظيم وإدارة برامج الرعاية المنزلية والأنشطة المجتمعية.

11

الرعاية والدعم الاجتماعيين

مسار الرعاية لتوفير الرعاية والدعم الاجتماعيين

* هذه أمثلة عن الأسئلة التي يمكن طرحها. يُرجى تعديلها وفقًا للسياق.

اسأل*

البيئة المنزلية

هل لديك مشاكل في منزلك، مثل حالة المنزل، الموقع، أو السلامة؟

نعم ← هل لديك مخاوف بسبب:

- السلامة والأمان
- حالة السكن، بما في ذلك الصيانة
- الموقع
- العيش باستقلالية
- حجم المنزل

الوضع المالي

هل غالبًا ما تجد صعوبة في دفع تكاليف الطعام، والإسكان، والرعاية الصحية؟

نعم ←

- هل تستطيع إدارة أموالك وشؤونك المالية؟
- هل ترغب في الحصول على مشورة بشأن المخصصات المالية أو الإعانات؟

العزلة الاجتماعية والوحدة

هل غالبًا ما تشعر بالوحدة؟

نعم ←

- هل لديك علاقات وثيقة (مثل زوج/زوجة، عائلة، أصدقاء)؟
- هل أنت على علم بالأنشطة الاجتماعية وفرص المساهمة في المجتمع؟
- هل تستطيع الاستمرار في التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الهاتف أو الكمبيوتر وما إلى ذلك؟

الانخراط والمشاركة في المجتمع

هل تواجه صعوبة في ممارسة الأنشطة الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي تهمك؟

نعم ← أنت غير قادر على متابعة... بسبب:

- التكلفة
- وسائل النقل
- المسافة
- قلة الفرص

طرح أسئلة إضافية 1

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم المشورة بشأن الصحة ونمط الحياة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بفرص المشاركة الاجتماعية ← 11.1
- إعادة السؤال بصفة منتظمة

تقييم

أ و ب

إذا كانت الإجابة "نعم" على سؤال واحد أو أكثر،
أو في حال وجود فقدان في القدرة الذاتية، الاستمرار في التقييم

أ

تقييم

خطر التعرض لسوء المعاملة

من خلال ملاحظة السلوك والبحث عن علامات الإهمال أو سوء المعاملة ← الجدول 11.1

في حال الاشتباه في سوء المعاملة 2

إذا كان هناك تهديد مباشر للحياة أو السلامة الجسدية، يُحال الشخص لتقييم متخصص، أو لحماية البالغين، مثل توفير مأوى مؤقت أو اللجوء إلى أنظمة إنفاذ القانون

ب

في حالة فقدان القدرة الذاتية

تقييم

الحاجة إلى المساعدة الشخصية في الأنشطة اليومية (على سبيل المثال: الأنشطة الأساسية والأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية): ← 11.5

- الانتقال، مثلًا من السرير إلى الكرسي
- العناية الشخصية مثل استخدام المرحاض أو الاستحمام أو ارتداء الملابس
- تحضير الوجبات وتناول الطعام
- استخدام الأدوية والالتزام بالعلاج
- القدرة على استخدام الهاتف وتدبير وسائل النقل

3

الأنشطة الأساسية والأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية

تشمل الأنشطة الأساسية في الحياة اليومية المهارات الأساسية المطلوبة للعناية بالنفس بشكل مستقل، مثل: الاستحمام، وارتداء الملابس، واستخدام المرحاض، والانتقال، والتحكم في الإخراج، وتناول الطعام.

تشمل الأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية الأنشطة الأكثر تعقيدًا التي تُسهم في العيش المستقل، مثل: القدرة على استخدام الهاتف، والتسوق، وإعداد الطعام، والأعمال المنزلية، وغسل الملابس، والانتقال، واستخدام الأدوية، وإدارة الشؤون المالية.

إعادة التقدير

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

تشمل الرعاية والمساندة الاجتماعية العديد من القطاعات بجانب القطاع الصحي، مثل الإسكان، والتمويل، والنقل، وإنفاذ القانون، والتي يمكنها تقديم الخدمات من أجل:

- إجراء التعديلات أو الإصلاحات الكبيرة في المنزل وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات، أو الحصول على استشارة قانونية بشأن نزاعات السكن مثل السلامة والتكلفة (11.3.1)
- الدعم المالي وتقديم نصائح المالية، بما في ذلك الأهلية والاستحقاقات لمدفوعات الحماية الاجتماعية مثل: المعاشات، المخصصات، المنح (11.3.2)
- تقييم الحاجة إلى تفويض لاتخاذ القرارات المالية والرعاية الصحية وضمان الحماية القانونية (11.3.2)
- تقديم نصائح بشأن فرص التوظيف والتعليم والتطوع، ومجموعات الدعم، والحقوق (11.3.3)
- تقييم خطر سوء المعاملة وتوفير الحماية وإنفاذ القانون (11.4)
- تقييم الأهلية للحصول على خدمات الرعاية طويلة الأجل وتوفيرها (11.6)
- تقييم الحاجة إلى المنتجات المساعِدة، وضمان الوصول إليها، وتقديم نصائح بشأن استخدامها وصيانتها (4.2.2)

1 الدعم الاجتماعي ← 11.3

البيئة المنزلية ← 11.3.1

- النظر في تعديل المنزل
- النظر في خيارات سكن بديلة
- النظر في الإحالة إلى برامج الرعاية الاجتماعية أو الإسكان المجتمعي أو شبكات الدعم

الوضع المالي ← 11.3.2

- النظر في الإحالة إلى الخدمات الاجتماعية للحصول على الحماية الاجتماعية مثل المعاشات، المنح، المخصصات
- النظر في الإحالة للحصول على استشارات مالية
- تقديم نصائح بشأن تفويض اتخاذ القرارات المالية مع ضمان الحماية من الاستغلال المالي عند الحاجة

العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة ← 11.3.3

- تقديم الدعم للتعامل مع العلاقات الشخصية الصعبة
- تقديم قائمة بالفرص المتاحة للأنشطة الاجتماعية، والتطوع، والعمل والتعليم في المجتمع
- تقديم نصائح والدعم في استخدام التكنولوجيا الرقمية للبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة

التفاعل والمشاركة الاجتماعية ← 11.3.4

- مناقشة الاهتمامات والتفضيلات الشخصية
- تقديم قائمة بالخدمات المجتمعية المحلية مثل المرافق الترفيهية، والأندية، وبرامج التعليم للكبار، وخدمات الاستشارة التطوعية والتوظيف
- تقديم نصائح بشأن الخدمات التي تدعم المشاركة، مثل وسائل النقل المدعومة، والأنشطة المجانية والخصومات للمسنين
- تقديم الدعم للبقاء على اتصال مع المنظمات والمؤسسات الموثوقة، بما في ذلك الشبكات الدينية أو الروحية والقادة

2 سوء معاملة المسنين ← 11.4

- الإحالة لتقييم إضافي من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية
- عرض المتابعة الوثيقة للموقف، على سبيل المثال، عبر زيارات من العاملين في مجال الصحة المجتمعية أو الأخصائيين الاجتماعيين وتشجيع الشخص على زيارة مرفق صحي أو جهة أخرى للحصول على الدعم
- النظر في الإحالة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مثل الاستشارات
- إذا كان هناك تهديد فوري للحياة أو السلامة الجسدية، يجب الإحالة إلى أنظمة إنفاذ القانون وتوفير مأوى مؤقت إذا كان ذلك ممكنًا

3 الرعاية الشخصية والمساعدة في الأنشطة اليومية ← 11.6

- تعديل بيئة المنزل لتحسين القدرة على الحركة وتجنب السقوط (4.2.5)
- النظر في استخدام المنتجات المساعِدة (مثل كراسي الاستحمام، وأدوات المساعدة في ارتداء الملابس، والأدوات المعدلة، والأطباق والكؤوس، ومنظمات الأدوية) مع توفير معلومات حول الوصول إليها وصيانتها (4.2.2)
- تقييم الحاجة إلى خدمات التأهيل وضمان الوصول إليها في حال توافرها (4.2.1)
- تقييم الدعم من الزوج/الزوجة أو الأسرة أو مقدمي الرعاية الآخرين، وتحديد احتياجات مقدمي الرعاية
- مراجعة احتياجات الدعم من عمال الرعاية (12.3)
- ربط الشخص بالخدمات المتاحة محليًا مثل الرعاية المنزلية، والرعاية اليومية، أو مرافق الرعاية طويلة الأجل السكنية، حسب توفرها وتقبلها ثقافيًا

11.1
نصائح حول الدعم الاجتماعي وفرص المشاركة

إذا كانت إجابات المسن على الأسئلة الأولية المتعلقة بالدعم الاجتماعي تشير إلى أنه قد يحتاج إلى دعم من الآخرين، يمكن للعامل الصحي المجتمعي أو أي من أصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع تقديم نصائح والتوجيه في انتظار التقييم المُعمَّق أو في حالة إذا كان التقييم المُعمَّق غير متاح. وتشمل هذه الإرشادات ما يلي:

- التعديلات البسيطة التي يمكن إجراؤها على البيئة المنزلية، مثل إزالة العوائق التي قد تسبب التعثر. ← **4.2.5**
- نصائح الأساسية حول الدعم المالي المتاح، مثل حقوق الضمان الاجتماعي أو المنظمات التي تدعم الأنشطة المدرة للدخل.
- التشجيع على التواصل مع الأصدقاء والعائلة والجيران.
- اقتراحات حول كيفية المشاركة في المجتمع، على سبيل المثال، من خلال الانضمام إلى ناد للمسنين.
- المعلومات والموارد على مستوى المجتمع لمن يحتاجون إلى رعاية شخصية ومساعدة في الأنشطة اليومية.

11.2
تقييم احتياجات الدعم الاجتماعي

يجب أن يُدرج الدعم الاجتماعي كجزء من خطة رعاية مُشخصنة.
قد يركز الدعم على تمكين المسن من المشاركة في الحياة المجتمعية والاجتماعية لتقليل العزلة الاجتماعية والوحدة، ومعالجة العوامل الرئيسية في حياتهم مثل بيئة المنزل والوضع المالي. وهناك العديد من الفرص لتحديد الحاجة إلى الدعم الاجتماعي، بما في ذلك أثناء التقييم الأساسي في المجتمع أو كجزء من التقييم المُعمَّق في مرفق الرعاية الأولية. يجب أيضًا مراعاة خطر سوء المعاملة، حيث قد يواجه بعض المسنين مخاطر أكبر من غيرهم (**الجدول 11.1**، الصفحة 122).

يستفيد المسن الذي يعاني من فقدان كبير في القدرة الذاتية أيضًا من إجراء تقييم كامل لاحتياجات الرعاية والدعم الاجتماعيين، لتحديد ما إذا لم يعد بإمكانه العناية بنفسه دون مساعدة الآخرين. ويتضمن هذا التقييم الأسئلة الأربعة الأولية متبوعةً بتقييم خطر سوء المعاملة واحتياجات المسنين للرعاية الشخصية والمساعدة في الأنشطة اليومية.

تعتمد القضايا التي تُعالَج من خلال هذه الأسئلة والتقييمات، والتحديات المحددة التي قد يواجهها المسنون، على السياق بشكل كبير. ويجب تكييف الأسئلة المقدمة في مسار الرعاية والدعم الاجتماعيين بما يتناسب مع السياق.

11.3 تدبير احتياجات الدعم الاجتماعي

ستحتاج العديد من القطاعات إلى العمل معًا لتقديم التدخلات لمعالجة التحديات مثل خدمات الإسكان، والخدمات الاجتماعية، والصحة المهنية، وخدمات الاستشارة المالية (إن وجدت)، والجهات الفاعلة الإنسانية استجابةً للحالات الطارئة والكوارث التي قد تؤدي إلى التهجير.

يشمل الدعم الاجتماعي الدعم المتعلق ببيئة المنزل، والأمن المالي، والعزلة الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والانخراط في الأنشطة، بما في ذلك الوصول إلى المرافق العامة والخدمات المجتمعية. يجب أن يكون العاملون الصحيون على دراية بالفرص المحلية والخدمات والدعم المتاح، بما في ذلك المجموعات المجتمعية التي غالبًا ما تكون من مقدمي الخدمات الرئيسيين. ← **4.1.3** ويجب على العاملين الصحيين أيضًا تيسير الروابط مع ذوي المعرفة المتخصصة، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية، والتوظيف، والتعليم، والخدمات التطوعية، وخدمات النقل، ورجال الدين. وتعد برامج المجتمعات والمدن الصديقة للمسنين مصدرًا جيدًا لهذه المعلومات.

11.3.1 البيئة المنزلية

يمكن أن تؤثر البيئة التي يعيش فيها المسن على صحته، ورفاهه، واستقلاله، ومشاركته الاجتماعية، خاصة إذا كانت هناك تحديات تتعلق بحجم المنزل، والوصول، والحالة، والموقع، والسلامة والأمن.

ويمكن التخفيف من مشاكل البيئة المنزلية من خلال إدخال تدابير أمنية جديدة، مثل وجود رقم للاتصال في حالة الطوارئ، وإجراء تعديلات لتهيئة بيئة أكثر أمانًا للحفاظ على الاستقلالية في العيش. ← **4.2.5** وقد تتوفر مزايا مالية لدعم تكاليف السكن، والصيانة والإصلاح. وإذا لم تساعد هذه التدابير، يجب النظر في الانتقال إلى سكن أكثر ملاءمة إذا كان ذلك ممكنًا.

11.3.2 الوضع المالي

يرتبط الوضع المالي للشخص ارتباطًا وثيقًا بالصحة والاستقلالية والرفاه في مرحلة الشيخوخة. يمكن أن تشمل المشاكل المالية قلة الإمكانيات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية أو المشاركة الكاملة في المجتمع، والقلق من نفاد المال. وقد يَقلق المسنون أيضًا من فقدان القدرة على إدارة شؤونهم المالية.

ويمكن التخفيف من المشاكل المالية، بما في ذلك عدم القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية، من خلال نصائح المستقلة بشأن التخطيط والإدارة المالية، والأهلية للحصول على الحماية الاجتماعية المتاحة، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، ومِنح الإعاقة، وبدل مقدمي الرعاية. وقد يحتاج الشخص إلى نصائح من ذوي المعرفة المتخصصة في هذه المجالات، بما في ذلك خدمات استشارات الفوائد، وخدمات التوظيف، والمنظمات التي تقدم الدعم للأنشطة المدرة للدخل، والأخصائيين الاجتماعيين. يمكن وضع ترتيبات لتفويض السلطة إلى طرف ثالث موثوق لإدارة الشؤون المالية،شريطة وجود حماية قانونية تمنع الاستغلال المالي، لا سيما في حالات التدهور المعرفي.

يجب تقديم المعلومات ونصائح لمقدمي الرعاية الذين الدعمون المسنين ماليا أو يتكبَّدون تكاليف بسبب دورهم في الرعاية، ، بما في ذلك المعلومات ونصائح حول كيفية تغير تكاليف الرعاية عند تدهور القدرة الوظيفية للمسن وزيادة حاجته للرعاية والدعم.

11.3.3
العزلة الاجتماعية والوحدة

تشيع العزلة الاجتماعية والوحدة بين المسنين الذين يعانون من نقص في الشبكات الاجتماعية، ويُقر ثلث المسنين تقريبًا عن شعورهم بالوحدة *(55)*. تُعد الوحدة تجربة ذاتية ويُقاس مستواها من خلال سؤال الأشخاص عن مشاعرهم. وترتبط العزلة الاجتماعية والوحدة بزيادة احتمال حدوث وفيات يمكن تجنبها، والأمراض والحالات النفسية مثل الأمراض القلبية الوعائية، والسكتات الدماغية، والقلق، والاكتئاب، والخرف. ومن المهم أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار والتحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات ذات الصلة بالقدرة الذاتية من خلال التقييم المُعمَّق عندما يكون ذلك ضروريًا، إذا تم تحديد الوحدة على أنها مشكلة محتملة. ← 5 9 10

من المهم مناقشة القضايا بحساسية، مع مراعاة أن كيفية طرح الأسئلة والمكان قد يؤثران على الردود. يجب طمأنة المسن على سرية النقاش، لمساعدته في التغلب على أي مخاوف بشأن كشف طبيعة العلاقات الشخصية.

إذا كشف المسن عن شعوره بالوحدة أو وجود عدد قليل من الروابط الاجتماعية، فهناك أسئلة متابعة يمكن أن تحدد الحاجة إلى الدعم والتدخلات المناسبة. وغالبًا ما ترتبط الوحدة بوصمة اجتماعية، وقد يكون السبب في شعور الشخص بالوحدة مرتبطًا بالعلاقات الشخصية المعقدة. أن تكون وحيدًا (أو تعيش بمفردك) ليس مماثلًا لأن تكون وحيدًا عاطفيًا؛ فقد يشعر المسن بالوحدة حتى عندما يكون محاطًا بأشخاص آخرين، إذا كانت جودة علاقاته المعقدة ضعيفة.

وقد يكون من المفيد سؤال المسن الذي يشتكي من الوحدة، إذا كان التواصل الاجتماعي المتزايد مع الأسرة والأصدقاء أو مقابلة آخرين ذوي اهتمامات مشابهة سيساعد في تقليل شعوره بالوحدة، وكذلك لمعرفة ما إذا كان على دراية بالأنشطة الاجتماعية المحلية. ويجب أن تُوجِّه هذه المناقشات التدخلات التي يجب تضمينها في خطة الرعاية.

ويجب تشجيع استخدام المرافق المجتمعية مثل الأندية، والمجموعات الدينية، والمراكز النهارية، والخدمات الرياضية، والترفيهية أو التعليمية. وقد تكون هناك فرص للمساهمة من خلال العمل التطوعي أو المدفوع. يمكن أيضًا زيادة الروابط الاجتماعية من خلال الفرص التي تتيح التفاعل مع الأشخاص من أجيال مختلفة. وامتلاك حيوان أليف أيضًا يقلل من الوحدة لدى العديد من المسنين *(56)*. ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم الدعم من خلال تنظيم الفعاليات وتيسير وصول المسنين إلى الأنشطة التي تحد من العزلة الاجتماعية. ← **4.1.3**

11.3.4
الإندماج والمشاركة في المجتمع

كل مسن له شخصيته الفريدة وله أولويات وقيم واهتمامات مختلفة يحب أن يفعلها. من المهم معرفة الأشياء التي يستمتع بها المسنون ويجدونها ذات مغزى من خلال فهم حياتهم وأولوياتهم وتفضيلاتهم، مثل هواياتهم، الأنشطة الترفيهية، العمل، التعلم والأنشطة الروحية. ويجب أن توجِّه هذه المعلومات عملية وضع خطة الرعاية المشخصنة فيما يتعلق بالإندماج والمشاركة الاجتماعية.

ويمكن طرح أسئلة إضافية لتحديد أي عوائق أمام المشاركة الاجتماعية مثل التكلفة، والوصول (المسافة ووسيلة النقل) والفرص المتاحة. يجب على العاملين الصحيين معرفة الفرص المحلية للمشاركة والإندماج، ومناقشة ما إذا كانت هذه الفرص قد تحظى باهتمام المسن ودعمه للمشاركة فيها. وقد يتم دعم تكاليف بعض هذه الخدمات للسماح للمسنين والأشخاص ذوي الدخل المحدود بالمشاركة.

11.4
سوء معاملة المسنين

يعاني شخص واحد من بين كل ستة مسنين من شكل ما من أشكال سوء المعاملة (57)، وهو رقم من التقديرات السابقة (58). وقد تتخذ إساءة المعاملة أشكالاً عديدة، بما في ذلك الإهمال، والإيذاء النفسي، والإيذاء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والإيذاء المالي (بما في ذلك الممتلكات وحقوق الإرث). يمكن لأي شخص أن يتعرض لسوء المعاملة، لكن هناك عدد من عوامل الخطر التي تجعل المسن أكثر عرضةً لها، وخاصة التدهور المعرفي، وضعف الصحة النفسية أو الجسدية، والإعاقة. ومن بين عوامل الخطر الأخرى: العزلة الاجتماعية، وتاريخ سوء المعاملة، والعنف أو النزاع الأسري، والخلفية العرقية والدخل المنخفض أو المعيشة في فقر. ويستمر العنف ضد النساء في سن الشيخوخة، على الرغم من أنه أمر لا يُعترَف به كثيراً أو لا يُعالَج بشكل كاف. ففي عام 2018، كانت نسبة انتشار العنف الجسدي والعنف من الشريك الحميم مدى الحياة لدى النساء اللواتي يبلغن 60 عامًا فأكثر 23% (59).

وتماشيًا مع عوامل الخطر تلك، يجب إجراء تقييم للمسن الذي يعاني من فقدان القدرة الذاتية للكشف عن علامات سوء المعاملة. نظرًا للعلاقة بين سوء معاملة المسنين والعُزلة الاجتماعية والدخل المنخفض، يجب أيضًا إجراء تقييم لأي مسن يتبيَّن أنه يعاني من مشاكل بسبب بيئته المنزلية، أو وضعه المالي، أو العزلة الاجتماعية والوحدة أو المشاركة الاجتماعية. ويجب إيلاء اهتمام خاص لتقييم علامات إساءة المعاملة للمسنين الذين يعانون من التدهور المعرفي، حيث قد تكون التغيرات في السلوك مرتبطة بحالتهم الصحية بدلاً من كونها ناتجة عن إساءة محتملة.

يجب استخدام المعلومات الرصدية المستنِدة إلى سلوك المسن وسلوك مقدمي الرعاية أو أقاربه، أو علامات الإيذاء الجسدي لتحديد الإساءة المحتملة (**الجدول 11.1**، الصفحة 122).

ينبغي على العامل الصحي المجتمعي، أثناء أي تفاعل مع المسن، البحث عن علامات اليأس، والخوف وضعف التواصل البصري، وملاحظة المظهر الجسدي والنظافة الشخصية للمُسن، مثل حالة أظافره، وبشرته، والعناية الشخصية. ← **3.5**

بالإضافة إلى ذلك، أثناء الفحص البدني في مرفق الرعاية الأولية، يجب على العامل الصحي البحث عن علامات إيذاء جسدي. وإذا لوحظت إصابات، ينبغي على العامل الصحي فحص مرحلة الشفاء، وحجم الكدمات، وتناسق الإصابة مع السبب المُبلغ عنه. إن التعرف على التجفاف، وسوء التغذية، وعدم الامتثال للأدوية أو مواعيد الرعاية الصحية يؤدي إلى زيادة الشكوك حول الإهمال.

إذا كان هناك أي مؤشر على إساءة المعاملة، فسيكون من الضروري إجراء مزيد من التقييم والتدبير. ويجب على العامل الصحي إبلاغ المسن بمخاوفه وإعلامه بأنه سيطلب المساعدة المتخصِّصة، على سبيل المثال من أخصائيين اجتماعيين أو خدمات إنفاذ القانون. وينبغي عليهم أيضًا تسجيل مخاوفهم والإجراءات المتخذة، ومراقبة الوضع عن كثب أثناء انتظار الإحالة. إذا لاحظ العامل الصحي تهديدًا مباشرًا للحياة أو السلامة الجسدية، يجب عليه إحالة المسن إلى التقييم المتخصص والإجراءات اللازمة (مثل، المأوى المؤقت)، أو خدمات الحماية للبالغين أو الجهات المعنية بإنفاذ القانون. يجب أيضًا النظر في الإحالة إلى الخدمات النفسية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على نصائح، إذا كانت متوفرة.

مزيد من المعلومات

إساءة معاملة المسنين: حقائق رئيسية. WHO; 2024 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people)

الجدول 11.1

الأدلة الرصدية على الإساءة المحتملة

سلوك المسن	سلوك مقدم الرعاية	الإيذاء الجسدي	الإهمال
• الخوف من مقدم الرعاية أو السلوك العدائي تجاهه • عدم الرغبة في الإجابة عن الأسئلة، أو النظر بقلق إلى مقدم الرعاية قبل الرد • تغير السلوك عند دخول مقدم الرعاية أو خروجه من الغرفة • الاشارة إلى مقدم الرعاية بعبارات مثل "قوي الإرادة" أو "متعب" أو "سيء المزاج"، أو سرعة الغضب أو القلق أو التوتر الشديد • إظهار احترام مبالغ فيه أو تملق شديد اتجاه مقدم الرعاية، أو قلق شديد أو اللامبالاة في وجوده	• عرقلة أو منع العامل الصحي والمسن من التحدث على انفراد، أو الاستمرار في إيجاد مبررات لمقاطعة سير التقييم. • مقاطعة الأسئلة الموجهة إلى المسن أو الاصرار على الإجابة عليها بدلًا عنه • تقديم رواية متضاربة للأحداث مقارنة مع ما يقوله المسن • إيجاد أعذار لمنع العاملين الصحيين أو الأخصائيين الاجتماعيين من زيارة المنزل لتقديم المساعدة للمسن • اظهار مستوى عالٍ من التذمر بشأن ضرورة رعاية المسن • محاولة إقناع العامل الصحي بأن المسن "مجنون" أو "معتل عقليًا"، أو أن الشخص لا يعرف ما يقول بسبب الارتباك، رغم أن هذا غير صحيح • الإنشغال، أو التشتّت، أو الارهاق، أو الاحباط، أو السلوك العدائي، أو الغضب، أو التعب أو قلة الصبر أثناء المقابلة • وجود دلائل تشير إلى أن مقدم الرعاية (أو المسن) يعاني من مشاكل تعاطي الكحول أو المخدرات	• إصابات (الجروح، والحروق، والكدمات والخدوش) يُرجَّح أنها حدثت عن عمد • الإصابات التي لا تتطابق مع التفسيرات المُقدَّمة • الإصابات والجروح في أماكن خفية أو محمية (مثل الإبطين) • الكدمات التي تكون على شكل أصابع نتيجة التعامل العنيف (غالبًا في الأذرع العلوية) • إصابات متعددة في مراحل شفاء مختلفة، بما في ذلك الإصابات غير المعالجة • نقص أو إفراط في استخدام الأدوية • زيارات متكررة إلى مرفق الرعاية الصحية، لا سيما قسم الطوارئ، لإصابات مماثلة	• سوء التغذية، والتجفاف، وقُرح الفراش • سوء النظافة الشخصية والفموية • الملابس المتسخة والمهترئة بشدة، وعدم تغيير فُوَط أو سراويل السَّلَس البولي • عدم الالتزام بالأدوية أو المواعيد أو توجيهات العامل الصحي • التأخير بين ظهور المرض أو الإصابة وطلب الرعاية الطبية

11.5 تقييم احتياجات الرعاية الاجتماعية

(الرعاية الشخصية والمساعدة)

تتوقف احتياجات كل فرد من الرعاية الشخصية والمساعدة على كيفية تعويض فقدانه للقدرة الذاتية من أجل تحسين قدرته الوظيفية (أي تلبية احتياجاته الأساسية؛ التعلم والنمو واتخاذ القرارات؛ القدرة على الحركة؛ بناء وصيانة العلاقات؛ والمساهمة)، جنبًا إلى جنب مع تفضيلاته واختياراته وأهدافه.

يمكن إجراء تقييم معمَّق لتحديد الاحتياجات من خلال فهم قدرات المسن فيما يتعلق بالأنشطة اليومية الأساسية والأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية. وتشمل الاستبيانات المستخدمة بشكل متكرر لقياس الأداء، مؤشر كاتز للاستقلالية في أنشطة الحياة اليومية ومقياس لوتون للأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية. وهناك عدة عوامل تؤثر على القيود المتعلقة بالأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية ومنها الجنس والثقافة والمعايير الاجتماعية.

يجب أن يشمل التقييم وتقديم الرعاية الشخصية، دون أن يقتصر على:

- **النقل:** يشمل ذلك عددًا من الأنشطة، مثل الانتقال من السرير إلى الكرسي. تزيد محدودية القدرة على الحركة من خطر السقوط والحاجة إلى الرعاية الشخصية لأداء هذه الأنشطة.

- **النظافة الشخصية:** استخدام المرحاض، والاستحمام، وارتداء الملابس، والقدرة على الوصول إلى المرحاض واستخدامه، والاغتسال، وارتداء الملابس والعناية الشخصية بما في ذلك تفريش الأسنان وتمشيط الشعر وقص الأظافر. قد يكون هذا الأمر أكثر وضوحًا لدى المسنين الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة أو التدهور المعرفي.

- **تحضير وجبات الطعام والتقوُّت:** قد تتأثر القدرة على شراء المواد الغذائية، وإعداد وجبات الطعام، والأكل بشكل مستقل بمحدودية القدرة على الحركة، والتدهور المعرفي، وضعف البصر. وقد يكون ذلك أيضًا نتيجة وعاملًا لسوء التغذية.

- **استخدام الأدوية:** القدرة على الالتزام بالعلاج الموصوف للأمراض بما في ذلك الأدوية والمنتجات المساعِدة (مثل مساعِدات السمع) أمر حاسم للمسنين الذين يعانون من تعدد الأمراض. ويشمل الاستخدام الآمن للأدوية تذكر تناول الأدوية كما هو موصوف، وتناوُل الدواء الصحيح، والجرعة الصحيحة، في الوقت المحدد. وقد تتأثر فعالية الدواء أيضًا بأي تحديات تتعلق بإعداد الطعام والأكل. قد يصعُب الالتزام بالعلاج عل الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي أو ضعف البصر.

- **القدرة على استخدام الهاتف وتدبير وسائل النقل:** قد يؤثر ذلك على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بسبب الصعوبات التي يواجهها المسن في تحديد المواعيد، سواء عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو بشكل شخصي، وفهم المراسلات مع مقدمي الرعاية الصحية بشأن المواعيد القادمة أو السابقة والوصول إلى المنشآت والعودة منها. وقد يمثِّل هذا تحديًا للمسنين الذين يعانون من محدودية الحركة، وفقدان السمع أو ضعف البصر، والتدهور المعرفي.

قد تصعُّب تأدية هذه المهام على المسنين الذين يعانون من أعراض الاكتئاب. وقد يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بأداء هذه الأنشطة، وليس إلي عدم القدرة البدنية علي أدائها.

مزيد من المعلومات

الرعاية طويلة الأجل للمسنين من منظمة الصحة العالمية: حزمة التغطية الصحية الشاملة. WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376585).

11.6 تدبير احتياجات الرعاية الاجتماعية

لا يرغب الكثير من المسنين في الاعتماد على الآخرين للمساعدة في المهام اليومية، ويجب توفير الدعم والتدريب لهم لتمكينهم من القيام بما يستطيعوا فعله. على سبيل المثال، قد يحتاج المسن إلى المساعدة في الاستحمام، لكنه قد لا يزال قادرًا على غسل بعض أطرافه، ويجب تشجيعه على فعل ذلك. وبالمثل، قد يكون الشخص الذي لا يستطيع الانحناء لارتداء حذائه، قادرًا على ارتداء ملابسه الأخرى. يجب دعم مقدمي الرعاية بالمعلومات ونصائح حول كيفية تقديم الرعاية الشخصية، وكذلك أهمية أن يحتفظ المسن بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. وعندما يكون مقدم الرعاية متعبًا ومرهقًا، قد يبدو من الأفضل إنجاز المهام بسرعة، لذلك يجب أن يوضِّح العاملون الصحيون، بما في ذلك العاملون في الرعاية الاجتماعية، فوائد منح المسن بعض الوقت، وتشجيعه على فعل ما يستطيع.

وقد يستفيد المسنون الذين يعانون من فقدان كبير في القدرة الذاتية وصعوبات في أداء الأنشطة اليومية الأساسية والأنشطة المساعِدة في الحياة اليومية من خدمات التأهيل (← 4.2.1)، وتوفير المنتجات المساعِدة (← 4.2.2) والتعديلات البيئية لتحسين القدرة الوظيفية. ويمكن أن يساعد الوصول إلى هذه الأنواع من الدعم المسن في أداء المهام اليومية وتخفيف العبء على مقدم أو مقدمي الرعاية.

بالإضافة إلى الرعاية الشخصية التي يوفرها مقدم الرعاية في منزل المسن، يجب أيضًا البحث عن خدمات أخرى ودعم حسب الحاجة. ويشمل ذلك الرعاية المنزلية، وخدمات الرعاية اليومية، والرعاية في المنشآت الأخرى المتاحة والمقبولة ثقافيًا. ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم المعلومات ونصائح وربط المسنين ومقدمي الرعاية بالخدمات الرسمية للرعاية طويلة الأجل. يمكنهم أيضًا دعم الرفاه النفسي والاجتماعي لمقدمي الرعاية من خلال تيسير فترات الراحة ودعم الأقران. ← 12

يمكن أن يكون الوصف الاجتماعي بمثابة آلية لتقديم الرعاية والدعم الاجتماعيين لضمان تقديم الخدمات من خلال علاقات رسمية مع أصحاب المصلحة في المجتمع (إطار 11.1).

المربع 11.1 الوصف الاجتماعي

الوصف الاجتماعي هو وسيلة لربط الأفراد بمجموعة من الخدمات غير السريرية في المجتمع لتحسين صحتهم ورفاههم، ويمكن استخدامه كوسيلة لمعالجة احتياجات الرعاية والدعم الاجتماعيين. ويمكن أن يتخذ الوصف الاجتماعي أشكالًا مختلفة ويمكن تكييفه في المجتمعات والسياقات المختلفة. على سبيل المثال، يحيل العاملون الصحيون في مرافق الرعاية الأولية المسن إلى عامل صحي خاص / عامل صحي شخصي أو "منسق رعاية" يعمل مع المسن لتحديد احتياجاته من الرعاية والدعم الاجتماعيين وتطوير خطة شخصية. ويقوم العامل الصحي الخاص/ الشخصي أو منسق الرعاية أيضًا بمتابعة المسن بانتظام. ويمكن تضمين الوصف الاجتماعي كجزء من خطة الرعاية المشخصنة. ← 3.3

إن تحديد الخدمات المحلية والجمعيات والمنظمات في المجتمع خطوة مهمة في الوصف الاجتماعي لتوجيه الإحالات المحتملة. ويجب أن تتضمن عملية تحديد وتوثيق الخدمات المتعلقة بالرفاه، والدعم القانوني، والدعم المالي، ودعم الإسكان وأمن الغذاء؛ خدمات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك دعم الصحة النفسية والإعاقات؛ ودعم الناجين من سوء المعاملة؛ والأنشطة الاجتماعية؛ وخدمات التوظيف؛ والأنشطة للتعليم والتثقيف مدى الحياة؛ وخدمات الرعاية الصحية وتعزيز الصحة بما في ذلك النشاط البدني والتغذية؛ وفي المناطق الحضرية، الفرص لقضاء الوقت في الهواء الطلق؛ والأنشطة الثقافية؛ وفرص التطوع.

ومع الدعم والإشراف المناسبين من العاملين الصحيين، يمكن لأحد أعضاء منظمات المجتمع المدني أن يعمل كعامل صحي خاص/ شخصي أو منسق رعاية يعمل عن كثب مع العاملين الصحيين متعددي التخصُّصات. وغالبًا ما يكون أصحاب المصلحة في المجتمع في كثير من الأحيان هم الأقدر على تحديد وتوثيق الخدمات المتاحة.

مزيد من المعلومات

- *مجموعة أدوات حول كيفية تنفيذ الوصف الاجتماعي.* WHO; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/354456).
- *الوصف الاجتماعي.* WHO Academy; 2025 (https://whoacademy.org/coursewares/course-v1:WHOAcademy-Hosted+H0116EN+2025_Q1?from=discovery&source=edX).



12

دعم مقدمي الرعاية

مسار الرعاية لدعم مقدمي الرعاية

يمكن أن تؤثر متطلبات وضغوط رعاية المسنين الذين يعانون من فقدان مهم للقدرة الذاتية والقدرة الوظيفية على صحة ورفاه مقدمي الرعاية. وغالبًا ما يكون الدور الذي يلعبه مقدمو الرعاية غير معترف به أو غير مقدر بشكل كافٍ أو غير مدعوم بشكل جيد، مما يزيد من التحديات المرتبطة بتقديم الرعاية. وقد يؤدي كون الشخص مقدمًا غير مأجورًا للرعاية إلى تقليص فرصه في العمل مدفوع الأجر، خاصة بالنسبة للنساء. يجب تحديد احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين ويجب تضمين التدخلات لدعمهم في خطة رعاية مُشخصنة.

النقاط الرئيسية

- يمكن للعاملين الصحيين في المجتمع تحديد احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين وطرق دعم صحتهم ورفاههم.
- هناك مجموعة من التدخلات مثل نصائح، والتدريب، والرعاية المؤقتة، والدعم المالي، والتدخلات النفسية، يمكن أن تساعد مقدمي الرعاية في الحفاظ على علاقة رعاية مُرضية وصحية وتقديم رعاية ذات جودة مع الحفاظ على صحتهم ورفاههم.
- في الحالات التي يكون فيها مقدم الرعاية غير المأجور مسنًا، يُوصى بإجراء تقييم لصحة مقدم الرعاية نفسه، بما في ذلك القدرة الذاتية.
- يجب أن يكون العاملون الصحيون، بما في ذلك العاملين الصحيين المجتمعيين، على دراية بعلامات سوء المعاملة التي يجب البحث عنها أثناء إجراء تقييم للمسن أو مقدم الرعاية.
- يجب الاعتراف بدور مقدم الرعاية غير المأجور وتقييمه ودعمه، ويجب بذل الجهود لإعادة توزيع العمل الرعائي. ويمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع الدعوة لهذا التقييم مع تقديم التدريب المستمر، بما في ذلك التدريب التحديثي والدعم لمقدمي الرعاية.

12

دعم مقدمي الرعاية

مسار الرعاية لدعم مقدمي الرعاية

إذا كان مقدم الرعاية مسنًا،
يمكن نُصحه بالحصول على تقييم أساسي في إطار نهج الرعاية المتكاملة للمسنين وتلقي الدعم

اسأل

عند التحدث مع مقدم الرعاية، القيام بذلك على انفراد، في غرفة منفصلة عن المسن

هل تشعر أنك مدعوم في دورك كمقدم رعاية غير مأجور؟

هل تشعر بالثقة في قدرتك على تقديم الرعاية؟

لا إذا كانت الإجابة "لا" (على أي من السؤالين)

نعم إذا كانت الإجابة "نعم" على السؤالين

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لمقدم الرعاية غير المأجور، بما في ذلك نصائح لتعزيز الرعاية الذاتية ← 12.1
- إعادة السؤال بانتظام

- تقديم الدعم لمقدم الرعاية غير المأجور: ← 12.4
  - التدريب على المهارات والمعرفة الخاصة بتقديم الرعاية (1)
  - الرعاية المؤقتة
  - الموارد المجتمعية الأخرى مثل برامج المتطوعين، ومجموعات الدعم بين الأقران
- يجب الوضع في الاعتبار خطر إرهاق مقدم الرعاية والإساءة المحتملة (2)

قدِّر

تقييم تأثير دور مقدم الرعاية

إذا كان له تأثير سلبي على:

الرفاه الاجتماعي
- توفير الرعاية المؤقتة
- تقديم المشورة والدعم لزيادة المشاركة الاجتماعية

الوضع المالي
- تعزيز الارتباط بنظام الرعاية الطويلة الأجل الرسمي والدعم المجتمعي
- استكشاف خيارات الدعم المالي المحلية

الصحة البدنية
- تعزيز الرعاية الذاتية
- تشجيع مقدم الرعاية على إجراء فحص صحي

الصحة النفسية
- تقييم أعراض الاكتئاب ← 10
- تقييم القلق
- تقديم التدخلات النفسية والاجتماعية ← 12.4.3
  - التعامل مع الضغط النفسي ← 10.2
  - التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية
  - التثقيف النفسي
  - العلاج النفسي / الاستشارات
  - التدخلات متعددة المكونات

إعادة التقدير

1

التدريب ونصائح اللازمة لمقدمي الرعاية ← 12.4.1

يجب دعم مقدمي الرعاية من خلال تدريب وإرشادات محددة لتمكينهم من تقديم رعاية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى كيفية التعرف على التدهور في علامات القدرة على الأداء، وتدبير الأدوية، والتعامل مع خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية والأنظمة، وكذلك إدارة احتياجاتهم الخاصة، فإن نوع التدريب والمعلومات سيعتمد على فقدان القدرة الذاتية لمتلقي الرعاية.

- **التدهور المعرفي:** أهمية الحفاظ على روتين يومي، وكيفية استخدام وسائل دعم الذاكرة، وكيفية التعامل مع السلوكيات الصعبة، وكيفية الرد عندما/إذا لم يتذكرهم الشخص الذي يعتنون به.
- **محدودية القدرة على الحركة:** كيفية مساعدة الشخص على التحرك بأمان، مع حماية أنفسهم من الإصابات، وكيفية الوصول إلى المنتجات المساعِدة واستخدامها.
- **سوء التغذية:** كيفية الوصول إلى المنتجات المساعدة واستخدامها (أو مساعدة الشخص المسن في استخدامها)، وعلى وجه الخصوص تناول الطعام، وأنواع وكميات الطعام والسوائل المطلوبة وكيفية تحضيرها بشكل أفضل.
- **ضعف البصر:** كيفية مساعدة الشخص على التنقل، وتعديل البيئة المنزلية لجعلها أكثر أمانًا، وكيفية المشي مع شخص يعاني من ضعف البصر ومساعدته في تحديد معالم بيئته، وكيفية تعديل أساليب وطرق التواصل، وكيفية استخدام المنتجات المساعِدة.
- **فقدان السمع:** كيفية التواصل بشكل أفضل مع الشخص، وكيفية استخدام وصيانة مساعِدات السمع والمنتجات المساعِدة.
- **الأعراض الاكتئابية:** كيفية التواصل بشكل مفتوح مع المسن، وما يجب القيام به إذا كان هناك خطر وشيك لإيذاء النفس، وكيفية الوقاية من العزلة الاجتماعية.
- **السَّلَس البولي:** كيفية المساعدة في الرعاية الشخصية، واستخدام الفُوَط والمنتجات الخاصة بالسَّلَس البولي، وتشجيع التذكير المنتظم بالتبول، وتنظيف الملابس الملوثة وأغطية السرير وفوط السَّلَس البولي والتخلص منها بأمان.

2

خطر سوء المعاملة

العلاقة الثنائية بين متلقي ومقدم الرعاية قد تكون معقدة. يستطيع مقدّمو الرعاية الأصحاء والسعداء تقديم دعم استثنائي، ولكن قد تواجه علاقة الرعاية أحيانًا صعوبات، بما في ذلك عدم رغبة أحد الطرفين أو كليهما في هذه العلاقة. ودون دعم كافٍ، قد يصاب مقدمو الرعاية بالإحباط والارهاق. ويزيد ذلك من خطر سوء معاملة الشخص مُتلقي الرعاية.

يمكن أن تكون سوء المعاملة في شكل إهمال، أو إساءة مالية أو مادية أو إيذاء بدني، أو عاطفي أو جنسي. وقد يكون الإهمال مُتعمدًا أو قد يحدث بسبب نقص المهارات أو المعرفة بشأن كيفية تقديم الرعاية أو نقص الدعم أو الإشراف الخارجي.

وقد يتعرض مقدمو الرعاية أيضًا للإساءة، بما في ذلك من الشخص الذي يقدمون له الرعاية. يمكن أن تأخذ هذه الإساءة نفس الأشكال المذكورة أعلاه، وقد تحدث لأسباب مشابهة. وقد يواجه مقدّم الرعاية لشخص مصاب بالخرف مخاطر خاصة بسبب السلوكيات التي تأخذ طابع التحديّ المرتبطة بالخرف لدى بعض الأشخاص.

قد لا يقوم المسن ولا مقدم الرعاية بالإفصاح عن حالة إساءة إلى العامل الصحي. لذلك، تعتبر المعلومات الملاحَظة المستندة إلى سلوك المسن أو مقدمي الرعاية أو العائلات أمرًا مهمًا، وكذلك ملاحظة أي علامات تدل على الإيذاء الجسدي (جدول 11.1).

في حال الاشتباه في وجود سوء معاملة، يجب إجراء تقييم أكثر تفصيلًا، مع اتباع مسارات الإحالة المحلية، إذا كانت موجودة، ويجب تفعيل الخدمات ذات الصلة والمتاحة. في العديد من الحالات، قد يكون توفير الدعم الإضافي لمقدمي الرعاية أكثر فاعلية في معالجة سوء العلاقة من التدابير العقابية. ويجب على العاملين الصحيين السعي للحصول على مشورة قانونية.

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- توفير الدعم لمقدم الرعاية الذي يعاني من الاكتئاب أو القلق
- مقدمو الرعاية الذين يعانون من فقدان كبير في القدرة الذاتية أو أمراض متعددة
- خطر وشيك من إيذاء النفس أو الانتحار لمقدمي الرعاية (10.4.4)
- يُشتبه في سوء العلاقة (11.4)
- توفير التدخلات النفسية المنظمة الوجيزة (10.4.2)
- الدعم المالي وتوفير نصائح المالية، بما في ذلك الأهلية والحقوق المتعلقة بالرعاية (11.3.2)

العوامل التي تزيد من احتمالية التعرض للإساءة:

أن يكون متلقي الرعاية
- معتمدًا بشكل كبير على الرعاية
- تظهر عليه أعراض سلوكية ونفسية للخرف
- منخفض الدخل أو يعيش في فقر

العوامل التي تزيد من احتمالية أن يصبح الشخص مرتكبًا للإساءة:

أن يكون مقدم الرعاية
- يعاني من خلل في الصحة النفسية
- يتعاطى المخدرات ومصاب بالإدمان
- يواجه ضغطًا نفسيًا وإرهاق
- يعتمد ماليًا على متلقي الرعاية

العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من احتمالية وجود علاقة مُسيئة تشمل وجود تاريخ من العنف العائلي أو العنف بين الشركاء، وعلاقة سيئة طويلة الأمد.

12.1
نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة لتعزيز رفاه مقدمي الرعاية

يمكن أن يكون تقديم الرعاية مُرهقًا ومُجهدًا، خاصة بالنسبة لمقدمي الرعاية من الأسرة الذين يعيشون مع الشخص الذي يقدمون له الرعاية، مما يؤثر على صحة ورفاه مقدمي الرعاية. ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين وأصحاب المصلحة في المجتمع تقديم نصائح لدعم رفاه مقدمي الرعاية غير المأجورين، بما في ذلك:

- بدء الأنشطة التي كانت ممتعة من قبل أو مواصلة القيام بها.
- الحفاظ على روتين نوم منتظم.
- الحفاظ على النشاط البدني قدر الإمكان.
- الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن وتناول الوجبات بشكل منتظم.
- قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.
- المشاركة في الأنشطة المجتمعية والاجتماعية الأخرى.
- أخذ فترات راحة منتظمة.

12.2
الرعاية الصحية المجتمعية لتعزيز رفاه مقدمي الرعاية

قد يوفر مقدمو الرعاية غير المأجورين الرعاية بانتظام (بما في ذلك يوميًا)، أو بشكل متقطع أو روتيني، أو يكونوا مشاركين في تنظيم تقديم الرعاية من قبل الآخرين. وفي البلدان التي تتوفر فيها السياسات، قد يحصل مقدمو الرعاية على مزايا اجتماعية مثل الإجازات المدفوعة وتحويلات نقدية مقابل تقديم الرعاية. وبناءً على احتياجات مقدم الرعاية، يجب النظر في أنواع مختلفة من الدعم، سواء لرفاه مقدم الرعاية أو لتمكينه من تقديم رعاية عالية الجودة.

ويمكن للمنظمات المجتمعية أن تلعب دورًا في تحديد مقدمي الرعاية الذين قد يحتاجون إلى الدعم. ويمكنهم إنشاء مجموعات دعم الأقران وتوفير أماكن مثل قاعات المجتمع لمقدمي الرعاية للاجتماع ومشاركة تجاربهم. وقد يتمكنون من تنظيم رحلات أو اجتماعات صباحية لتقديم فرصة لمقدمي الرعاية غير المأجورين لمنح أنفسهم بعض الوقت للقيام بشيء ممتع ومشاركة تجاربهم ومشاعرهم وخبرتهم مع الآخرين.

ويجب أيضًا توفير الموارد المتاحة والمعلومات حول كيفية وأين يمكن طلب الدعم في المجتمع مثل خدمات الرعاية المؤقتة في المنزل أو من خلال مركز رعاية نهارية، إذا كانت متوفرة ومقبولة ثقافيًا. يمكن للمنظمات التي تدير أو تنظم برامج الرعاية المنزلية، سواء بالتعاون مع عمال رعاية مدفوعي الأجر أو متطوعين، أن تقدم المعلومات ونصائح، وإذا أمكن، توفر الرعاية للمسن، مما يمنح مقدم الرعاية من العائلة فترة من الرعاية المؤقتة.

وإذا تبيَّن أن مقدم الرعاية يتأثر سلبًا بدوره، ولم يتوفر تقييم معمَّق على الفور، هناك إجراءات يمكن أن يتخذها العاملون الصحيون المجتمعيون لتقديم الدعم. إلى جانب نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة، يمكنهم تقديم إرشادات حول تقليل التوتر والاسترخاء (← 10.2)، وبعض تقنيات اليقظة الذهنية البسيطة.

12.3 تقييم احتياجات مقدمي الرعاية

من المهم تقييم احتياجات مقدمي الرعاية غير المأجورين للدعم، بما في ذلك صحتهم ورفاههم، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتقديم الرعاية، وثقتهم في أداء دورهم كمقدمي رعاية.

يجب إجراء هذه التقييمات بشكل روتيني، حيث قد تتغير احتياجات مقدم الرعاية للدعم بمرور الوقت، وقد يكون من الضروري تقديم آليات دعم مختلفة وفقًا لتغير حالته.

12.3.1 سؤال مقدم الرعاية غير المأجور

يجب أن تتم المناقشة حول احتياجات مقدم الرعاية بعيدًا عن الشخص الذي يقدمون له الرعاية، لتقليل إحراج مقدم الرعاية أو تردده في التحدث بصراحة. ويمكن أن يتم ذلك إما في نفس الوقت مع التقييم الذي يتم للمسن، ولكن في غرفة أو مكان منفصل، أو قد يتطلب تحديد موعد منفصل. وقد تختلف روايات المسن ومقدم الرعاية لعدة أسباب، بما في ذلك مشاكل الذاكرة لدى المسن، إذا كان يعاني من التدهور المعرفي، لذلك يجب أخذ نتائج التقييمات الأساسية والدقيقة للمسن في الاعتبار.

يوفر مسار رعاية مقدمي الرعاية غير المأجورين سؤالين نموذجيين لتحديد كيف يشعر مقدمو الرعاية والدعم الذي يتلقوه حاليًا أو قد يحتاجوه. إذا كانت إجابة أي من السؤالين تشير إلى أن مقدم الرعاية يواجه صعوبة أو تحديات، ينبغي تقديم الدعم العملي، بما في ذلك التدريب، والرعاية المؤقتة، وتوصيلهم بالموارد المجتمعية. ويجب أيضًا أن يخضع مقدم الرعاية غير المأجور لتقييم معمَّق حول تأثير دوره، بما في ذلك صحته النفسية والجسدية، ورفاهه الاجتماعي والمالي. وقد تشير الردود من مناقشة الرفاه النفسي إلى الحاجة لإجراء تقييم معمَّق لأعراض الاكتئاب والقلق، ويجب ترتيب اجتماع منفصل مع مقدم الرعاية لهذا الغرض.

يجب توفير أمثلة حول كيفية الوصول إلى نصائح والدعم المالي لأولئك الذين يؤثر تقديم الرعاية عليهم ماليًا بشكل سلبي.

وعند التحدث مع مقدم رعاية، يجب على العامل الصحي مراقبة أي علامات تدل على الإرهاق أو الغضب أو الإحباط أو عدم الاحترام. وإذا بدا على مقدم الرعاية التوتر أو الإنهاك، يجب الانتباه إلى أي علامات تشير إلى سوء معاملته أو إهماله للشخص متلقي الرعاية. ← 11.4 يجب أن يكون أيضًا على دراية بالعلامات المحتملة التي تشير إلى أن مقدم الرعاية قد يكون ضحية لإساءة المعاملة من مُتلقّي الرعاية. وقد لا يكشف مقدم الرعاية غير المأجور عن هذه المواقف، لذا من المهم أن يلاحظ العامل الصحي ما يجري (2) ، الصفحة 127).

12.3.2 تقييم الاكتئاب والقلق

يرتبط تقديم الرعاية بنتائج صحية نفسية أسوأ لمقدمي الرعاية غير المأجورين مقارنةً بعامة السكان، حيث يعد الاكتئاب والقلق من الحالات الشائعة على وجه الخصوص. وقد يتعقد الأمر أيضًا بسبب مشاعر الفجيعة الناجمة عن التغير في العلاقة السابقة بين المسن ومقدم الرعاية، لا سيما إذا كان مقدم الرعاية هو الزوج أو الزوجة. من المهم أن يُدرك العاملون الصحيون أن تقديم الرعاية يمكن أن يكون أمرًا مُحبطًا ومُرهقًا للغاية. ويجب على العاملين الصحيين النظر فيما إذا كان مقدم الرعاية غير المأجور بحاجة لإجراء تقييم له لاكتشاف الاكتئاب و/أو القلق، وما إذا كان بحاجة إلى أي رعاية أو دعم. ← 10

12.4 تقديم الدعم لمقدمي الرعاية

قد تكون هناك حاجة إلى تقديم مجموعة متنوعة من أشكال الدعم، بما في ذلك المساعدة المباشرة والدعم من العاملين في الرعاية المأجورة والمنظمات، والمنتجات المساعِدة، وتعديلات المنزل لتيسير تقديم الرعاية، خاصةً إذا كان مقدم الرعاية يعيش مع الشخص الذي يتلقى الرعاية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لمعالجة القلق أو الاكتئاب، والرعاية المؤقتة.

كما يُعد توفير المعلومات والتدريب لمقدمي الرعاية غير المأجورين أمرًا مهمًا. ويمكن للعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة في المجتمع إنشاء شبكة لتبادل الموارد المتاحة لتدريب مقدمي الرعاية غير المأجورين وأماكن الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي وأشكال الدعم الأخرى. ويمكن تضمين مجموعات دعم الأقران لمقدمي الرعاية غير المأجورين أو دمجها مع تدخلات أخرى كجزء من التدخلات متعددة المكونات لدعم مقدمي الرعاية. ويمكن أن تكون المنتجات الرقمية المساعِدة مفيدة في دعم مقدمي الرعاية في دَورهم، سواء من خلال تمكين الأشخاص الذين يتلقون الرعاية من مواصلة القيام بالأنشطة بأنفسهم أو من خلال تزويد مقدمي الرعاية بأدوات لتحسين جودة الرعاية التي يقدمونها (إطار 12.1).

المربع 12.1 المنتجات الرقمية المساعِدة

يمكن للمنتجات الرقمية المساعِدة المبتكرة، مثل المراقبة عن بُعد والروبوتات المساعِدة، أن تعزز القدرة الوظيفية لدى المسنين، مما يحسن جودة حياتهم وحياة مقدمي الرعاية غير المأجورين. كما تسهم في زيادة الخيارات، وتعزيز الأمان، والاستقلالية، والشعور بالتحكم، مما يمكنهم من التقدم في العمر في بيئتهم المألوفة. يجب أن يستند استخدام هذه المنتجات إلى احتياجات وتفضيلات المسنين ومقدمي الرعاية لهم، بالإضافة إلى توفر الموارد والتدريب المناسب.

12.4.1 التدريب

يجب أن يقوم العاملون في الرعاية، الذين يحصلون على الدعم والإشراف من خلال نظام الرعاية الصحية والاجتماعية أو من المنظمات الموفرة للخدمات، بدعم مقدمي الرعاية غير المأجورين من خلال التدريب والتوجيه. ولفهم احتياجات مقدم الرعاية من التدريب، يمكن للعاملين الصحيين، بما في ذلك العاملين في الرعاية، أن يسألوا عن المهام المطلوبة في الرعاية بناءً على فقدان القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى المسن الذي يتلقى الرعاية، ومدى تواتر أداء هذه المهام. ويمكنهم أيضًا ملاحظة الجوانب التي يمكن تحسينها في الرعاية من خلال التدريب، والإرشاد، والدعم العملي. يجب أن يعكس الدعم خيارات مقدمي الرعاية غير المأجورين، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية ورفاه مقدم الرعاية نفسه.

قد تشمل موضوعات التدريب لمقدمي الرعاية غير المأجورين، ولكن لا تقتصر على ما يلي: رعاية المسنين الذين يحتاجون إلى المساعدة، وكيفية تحديد تراجع علامات الأداء، وتجنب السقوط والاستجابة له، وإدارة الأدوية، وإدارة الألم، والتعامل مع خدمات وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية، وكيفية التواصل الفعّال مع الشخص الذي يتلقى الرعاية، وتدبير احتياجاتهم الخاصة. ويعتمد نوع التدريب الذي يجب أن يتلقاه مقدم الرعاية على احتياجات الرعاية الخاصة بالشخص الذي يقوم بدعمه. ويتم اقتراح موضوعات تدريبية محددة تتعلق بفقدان القدرة الذاتية والسَّلَس البولي (1 i، الصفحة 127). ويجب توفير فرص التدريب والتثقيف لمقدمي الرعاية غير المأجورين الذين يرغبون في اكتساب مهارات رسمية أكثر، والتي قد تُترجم إلى فرص عمل مستقبلية.

يُعد برنامج *iSupport* التابع لمنظمة الصحة العالمية برنامجًا للتدريب واكتساب المهارات الذاتية لمقدمي الرعاية غير المأجورين للأشخاص المصابين بالخرف، ويهدف إلى الوقاية أو الحد من المشاكل الصحية النفسية والجسدية المرتبطة بتقديم الرعاية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية للأشخاص المصابين بالخرف.

12.4.2 الرعاية المؤقتة

تشير الرعاية المؤقتة إلى الإعفاء المؤقت من مهام تقديم الرعاية من خلال توفير رعاية بديلة على شكل رعاية منزلية، أو رعاية نهارية، أو الإقامة المؤقتة للشخص الذي يتلقى الرعاية في إحدى المرافق المتخصصة. وقد تساعد فترات الاستراحة من تقديم الرعاية في الحفاظ على علاقة الرعاية بشكل صحي ومستدام، وإذا تم تنظيمها وتدبيرها بشكل صحيح، فلا ينبغي أن يكون لفترات الغياب المؤقت لمقدم الرعاية تأثير سلبي على الشخص الذي يتلقى الرعاية.

عندما تصبح مهام الرعاية مرهقة للغاية، ينبغي التفكير في الرعاية المؤقتة. ويجب على العامل الصحي استكشاف إمكانية أن يُشرف شخص آخر مؤقتًا على المسن ويُقدم له الرعاية والدعم خلال هذه الفترة. يمكن أن يكون هذا الشخص فردًا آخر من العائلة أو أحد أفراد المنزل، أو أحد العاملين في الرعاية الاجتماعية المدربين، سواء كانوا محترفين أو متطوعين، سواء في المنزل أو في إحدى مرافق الرعاية.

كما أن إتاحة الفرصة للمسن لحضور مركز رعاية نهارية أو تلقي الرعاية النهارية في المنزل يمكن أن يخفف العبء عن مقدم الرعاية غير المأجور الرئيسي، مما يتيح له فرصة للراحة أو القيام بأنشطة أخرى. وتعد الرعاية النهارية نوعًا من خدمات الدعم المجتمعي، حيث توفر رعاية شخصية (مثل الاستحمام، والتغذية، والحلاقة، واستخدام المرحاض)، وبرامج ترفيهية واجتماعية، ووجبات طعام، وخدمات نقل، لعدة ساعات يوميًا على مدار عدة أيام في الأسبوع. كما تقدم الرعاية النهارية خدمات دعم لمقدمي الرعاية غير المأجورين، مثل الزيارات المنزلية، والأنشطة العائلية، ومجموعات الدعم، والتدريب.

قد لا تعتبر الرعاية النهارية مناسبة أو مقبولة ثقافيًا في بعض السياقات، وقد لا تتماشى مع تفضيلات المسن. في هذه الحالة، يمكن أن توفر أشكال أخرى من الرعاية والدعم المجتمعي فرصًا مماثلة للرعاية المؤقتة، مثل نوادي الغذاء، والتجمعات الاجتماعية، والأنشطة المخصصة للمسنين.

مزيد من المعلومات

دليل البرنامج المعني بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية (mhGAP) للاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المواد، [الطبعة الثالثة]. منظمة الصحة العالمية؛ 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/374250).

12.4.3 التدخلات النفسية

يمكن للعامل الصحي التعامل مع التوتر النفسي لمقدم الرعاية من خلال التدخلات النفسية والاجتماعية، بما في ذلك التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية، والتدخلات متعددة المكونات، والتعليم النفسي والعلاج النفسي/الإرشاد.

وقد يكون هذا مفيدًا على وجه الخصوص عندما تكون الرعاية المقدَّمة معقدة ومكثفة، ويكون العبء الواقع على مقدم الرعاية غير المأجور كبيرًا. يمكن استخدام أساليب مختلفة لتقديم التدخلات النفسية والاجتماعية، مثل التدخلات المباشرة وجهًا لوجه أو التدخلات الرقمية/عن بُعد، والتي ثبت أنها فعالة. وغالبًا ما تكون التدخلات الجماعية أكثر فاعلية.

وتشمل التدخلات النفسية والاجتماعية ما يلي:

- **التدخلات المستندة إلى اليقظة الذهنية**، مثل التأمل الواعي، والتأمل، وتقنيات اليوغا، وكذلك العلاج المعرفي والحد من التوتر القائم كلاهما علي اليقظة الذهنية.

- **التثقيف النفسي**، والذي يشمل برامج تعليمية تقدم معلومات موحدة، وتركز على زيادة معرفة مقدمي الرعاية غير المأجورين بالحالات الصحية الشائعة في مرحلة الشيخوخة، وتطوير مهارات التكيف الخاصة للتعامل مع تحديات تقديم الرعاية.
← 10.4.1

- **العلاج النفسي/الإرشاد**، والذي يركز على التدخُّلات التي تنطوي على تنفيذ أشكال محددة من العلاج الفردي أو الجماعي أو الإرشاد، بما في ذلك العلاج السلوكي، والعلاج المعرفي، والعلاج السلوكي المعرفي التقليدي، والتوجهات النظرية الحديثة مثل برامج القبول والالتزام. عادةً ما يتم تقديم هذه التدخلات من قبل أخصائيين صحيين ذوي معرفة متخصصة، مثل الأطباء أو المعالجين النفسيين، مع التركيز بشكل كبير على تطوير واستغلال العلاقة العلاجية كجزء من عملية العلاج.

- **التدخلات متعددة المكونات**، والتي تستخدم نهجًا متعددًا يشمل الإرشاد، مجموعات الدعم، والرعاية المؤقتة، ضمن برنامج واحد دون أن يكون أي منها هو النهج المهيمن.

12.4.4
التدخلات لدعم الصحة الجسدية والرفاه الاجتماعي

يجب تقديم نصائح لمقدمي الرعاية غير المأجورين حول ضرورة الاهتمام بصحتهم، بما في ذلك إجراء فحوص صحية منتظمة، وتقييم قدرتهم الذاتية إذا كانوا من المسنين. كما ينبغي تزويدهم بنصائح والدعم للتعامل مع الشعور بالوحدة والعُزلة، ومساعدتهم في الحفاظ على مشاركتهم الاجتماعية أو زيادتها. ← 11.3.3, 11.3.4

12.4.5
الدعم المالي

إذا كان تقديم الرعاية يؤثر سلبًا على الوضع المالي لمقدمي الرعاية غير المأجورين، يجب على العامل الصحي تقديم نصائح وتوصيل مقدم الرعاية بالمصادر المتاحة للمعلومات والدعم، بما في ذلك نصائح المالية والدعم المتاح من خلال أنظمة الرعاية طويلة الأجل الرسمية. قد يكون مقدم الرعاية نفسه مؤهلًا للحصول على دعم مالي من خلال برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك بدلات مقدمي الرعاية والمعاشات غير القائمة على الاشتراكات. وقد يوفر أصحاب العمل بعض التسهيلات لمقدمي الرعاية، مثل إجازات مدفوعة أو ترتيبات عمل مرنة.

مزيد من المعلومات

- *الرعاية طويلة الأجل للمسنين: حزمة التغطية الصحية الشاملة (الملحق 6).* WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376585)
- *دليل منظمة الصحة العالمية iSupport للخرف: دليل التدريب والدعم لمقدمي الرعاية غير المأجورين للأشخاص المصابين بالخرف.* WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/324794)

13

السَّلَس البولي

مسار الرعاية لمعالجة السَّلَس البولي

يشيع السَّلَس البولي بين المسنين،والنساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنةً بالرجال *(11)*، لكنه ليس نتيجة طبيعية أو حتمية للشيخوخة. وغالبًا ما يكون غير مُعترف به وغير مُبلغ عنه. وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الوصمة الاجتماعية واعتقاد المسنين بأنه أمر طبيعي مع التقدم في العمر. يرتبط السَّلَس البولي بالاكتئاب، وفقدان القدرة على الحركة، والتدهور المعرفي، والأمراض المصاحبة مثل التهابات المسالك البولية، والسمنة، والسكتة الدماغية، ومرض السكري. كما أن له تأثيرًا كبيرًا على جودة الحياة والرفاه. ويمكن أن يؤثر السَّلَس البولي على تقييم الذات وثقة المسن في الخروج والمشاركة الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى العزلة والشعور بالوحدة *(60)*.



النقاط الرئيسية

- يجب أن يبادر العاملون الصحيون بطرح موضوع السَّلَس البولي، مع الانتباه إلى طريقة طرح الأسئلة نظراً لحساسية الموضوع وشعور البعض بالحرج أو التردد في إجراء التقييم.
- هناك استراتيجيات وتدخلات سلوكية فعالة، مثل تمارين تقوية عضلات قاع الحوض، لتدبير السَّلَس البولي.
- يمكن أن يساعد اعتماد نهج دورة الحياة للسَّلَس البولي في تحديد عوامل الخطر في وقت مبكر من الحياة، بما في ذلك السمنة، والتي يمكن معالجتها للوقاية من حدوثه.
- يمكن أن تساعد المنتجات المساعِدة، مثل كراسي المرحاض، والمباول، ومنتجات احتواء التسرب، في التعامل/ معالجة السَّلَس البولي وتحسين جودة الحياة.
- يمكن أن يعمل أصحاب المصلحة في المجتمع على رفع الوعي بأن السَّلَس البولي ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ودعم المسنين الذين يعانون من السَّلَس البولي من خلال إنشاء مجموعات دعم الأقران.

13

السَّلَس البولي

مسار الرعاية لإدارة السَّلَس البولي



استفسر عن السلس البولي (1)

هل تواجه أي مشاكل في التحكم بالمثانة، مثل تسرب البول غير المقصود؟

لا

بغض النظر عن النتيجة:

- تقديم نصائح حول الصحة ونمط الحياة بما في ذلك نصائح للوقاية من السَّلَس البولي ← 13.1
- إعادة السؤال بانتظام

نعم

كيف يؤثر السَّلَس البولي على حياتك؟

- تدريب المثانة لمعالجة السَّلَس البولي
- الإحالة إلى الرعاية الأولية

تقييم "أ" و"ب" و"ج"

أولاً، يتم تحديد وعلاج الأسباب المحتملة ("ب")

تقييم
السَّلَس البولي

- تقييم الحالة البولية ← 13.3
- تدريب المثانة مع منبهات المثانة ← 13.2
- تدريب عضلات قاع الحوض (للنساء) ← 13.4.1
- إذا كان هناك تراجع معرفي، على التذكير المنتظم بالتبول ← 13.4.2

أ

ب

ج

تقييم
البيئات الاجتماعية والمادية

- الوصول إلى المرحاض
- الحاجة إلى منتجات التحكم في التسرب
- احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية (استخدام المرحاض، الاستحمام، توفير القفازات والصابون)
- احتياجات دعم مقدمي الرعاية
- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (3)

تقييم
الأمراض وعوامل الخطر

- توازن السوائل*
- الإمساك
- الأدوية غير المناسبة
- التهاب المسالك البولية
- الهذيان
- أعراض الفرج (للنساء)
- التهاب الجلد المرتبط بالسَّلَس البولي
- داء السكري والسمنة

- أخذ التدخُّلات المحتملة في الاعتبار (2)

إعادة التقدير

دمج التدخُّلات، مع الأخذ في الاعتبار نتائج "أ" و"ب" و"ج"

وضع خطة رعاية

التنفيذ والمراقبة

* **توازن السوائل**
توخي الحذر بشأن التوازن المناسب للسوائل، حيث إن تقليل تناول السوائل قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية والتجفاف. ← 7.3.2

1 طرح الأسئلة حول السَّلَس البولي

قد يكون السَّلَس البولي موضوعًا حساسًا، حيث يشعر الأشخاص بالحرج من طرح القضايا بأنفسهم أو الإجابة على الأسئلة عندما يتم طرحها. من الأفضل أن يقوم عامل صحي من نفس جنس المسن بإجراء المحادثة.

عند مناقشة السَّلَس البولي:

- البحث عن مكان خاص للتحدث
- تخصيص وقت كاف لبناء الثقة والاطمئنان
- الاستماع باهتمام وتجنُّب استخدام لغة قد تُفهَم على أنها أحكام أو تقييمات
- استخدام لغة بسيطة إذا لزم الأمر، مثل "تبليل نفسك"

يجب أن تتضمن المناقشة أيضًا التأثير السلبي للسَّلَس البولي على حياة الشخص، لتحفيز وتشجيع المزيد من التقييم وتوضيح التدخلات المحتملة. ومن المهم ملاحظة أن العديد من المسنين يرون أن السَّلَس البولي أمر طبيعي، وقد يؤثر هذا الرأي على تقييمه وتأثيره المُدرَك.

سؤال المسن إذا كان السَّلَس البولي يؤثر على سلوكياته وأنشطته اليومية، بما في ذلك:

- الخروج من المنزل
- التفاعل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع
- ممارسة الهوايات والمشاركة الاجتماعية
- النشاط البدني بما في ذلك التمارين
- تناول السوائل
- نوع الملابس التي يختار ارتداءها
- الحياة الجنسية
- الحالة النفسية: الحرج، القلق، الثقة بالنفس
- الحاجة إلى المنتجات المساعِدة، بما في ذلك منتجات التحكم في التسرب مثل الفُوط

الحاجة إلى المعرفة المتخصصة والتدريب

- التقييم الكامل والتعامل مع الحالات البولية المحتملة (13.3) التي تشير إليها:
  - المثانة الملموسة
  - الكتلة الحوضية
  - البيلة الدموية الكبيرة (يكون الدم مرئيًا بالعين المجردة في البول)
  - التهابات المسالك البولية المتكررة مع الأعراض
  - تضخم البروستاتا (الرجال)
  - تدلي الأعضاء (هبوط الرحم أو عنق الرحم أو جدران المهبل) (النساء)
  - الشك في وجود ناسور (النساء)
- السَّلَس البولي مع تاريخ من العلاج الإشعاعي الحوضي والجراحة
- إذا لم تنجح التدخلات في التعامل مع السَّلَس البولي بعد 3–6 أشهر (13.4)

2 التدخُّلات المتعلقة بالأمراض وعوامل الخطر ← 13.5

- **توازن السوائل** ← التشجيع على الحفاظ على التوازن الطبيعي للسوائل وتجربة تقليل استهلاك الكافيين (13.5.1)
- **الإمساك** ← علاج الإمساك بما في ذلك من خلال الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والنشاط البدني (13.5.2)
- **الأدوية غير المناسبة** ← مراجعة الأدوية وسحبها أو وصف بدائل (13.5.3)
- **التهاب المسالك البولية** ← علاج التهابات المسالك البولية **إذا كانت مصحوبة بأعراض** (13.5.4)
- **الهذيان** ← تحديد السبب وعلاجه (5.5.1)
- **أعراض الفَرْج (النساء)** ← وصف مرطبات مهبلية موضعية (13.5.6)
- **التهاب الجلد المرتبط بالسَّلَس البولي** ← الحفاظ على نظافة البشرة وعلاج العدوى الثانوية (13.5.7)
- **مرض السكري والسمنة** ← التعامل مع الأمراض وعوامل خطر الأمراض القلبية الوعائية (13.5.8)

3 التدخُّلات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والمادية ← 13.6

- **الوصول إلى المرحاض** ← إجراء تعديلات في المنزل لتسهيل الوصول (13.6.1)
- **الوصول إلى المرحاض** ← النظر في المنتجات المساعِدة (مثل مقعد مرحاض مرتفع، أو مرحاض محمول، أو كرسي) (13.6.1)
- **الحاجة إلى منتجات التحكم في التسرب** ← دعم الوصول إلى منتجات التحكم في التسرب (13.6.2)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← تقديم المساعدة في استخدام المرحاض، والاستحمام، وارتداء الملابس، ومنتجات النظافة والمنتجات الصحية (القفازات، المناديل، الصابون) (13.6.3)
- **احتياجات الرعاية والمساندة الاجتماعية** ← تقديم الدعم النفسي والاجتماعي (13.6.3)
- **احتياجات دعم مقدمي الرعاية** ← تقديم التدريب على التذكير المنتظم بالتبول والاستخدام المناسب لمنتجات التحكم في التسرب (13.6.4)

13.1
نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة للوقاية من السَّلَس البولي

يظل السَّلَس البولي موضوعًا موصومًا اجتماعيًا وغالبًا ما يُعتبر من المُحرَّمات، مما قد يؤدي إلى عدم سعي الأفراد للحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها. ويمكن أن يوفر أصحاب المصلحة في المجتمع نصائح بشأن الصحة ونمط حياة لجميع المسنين، بمن فيهم من يعانون من السَّلَس البولي، لتقليل المخاطر وتدبيره، مع التأكيد على أهمية ما يلي:

- الحفاظ على عادات شرب جيدة، أي شرب ما لا يقل عن 1.6-2 لتر (6-8 أكواب) يوميًا، ما لم يكن هناك توجيه من أحد العاملين الصحيين بسبب أمراض مستبطنة مثل أمراض القلب أو الكلى. تقليل شرب السوائل قد يؤدي إلى انخفاض سعة المثانة وتفاقم السَّلَس البولي، كما يمكن أن يسبب التجفاف. ← 7.3.2
- تقليل استهلاك الكافيين والكحول، خاصةً في الليل، حيث يمكن أن يزيد استهلاكها من الحاجة إلى التبول. يمكن استبدال القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين بأنواع من المشروبات المنخفضة الكافيين.
- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الألياف للحد من خطر الإمساك، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد عند استخدام المرحاض إلى إضعاف عضلات قاع الحوض وتفاقم السَّلَس البولي.
- الحفاظ علي الوزن، يمكن أن تؤدي السمنة إلى إضعاف عضلات قاع الحوض. ← 7.3.3
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث يمكن أن تساعد في تقوية العضلات، مما يساهم في تحسين السَّلَس البولي. استشارة مختص للحصول على إرشادات فردية حول أنواع التمارين الأكثر فائدة.
- الإقلاع عن التدخين، حيث إن التدخين يُضعف المثانة، والسعال المستمر يمكن أن يضغط على عضلات قاع الحوض.

يمكن أن تكون حملات التوعية مفيدة في مكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالسَّلَس البولي، وتشجيع الأفراد على طلب الرعاية الصحية.

13.2
الرعاية الصحية المجتمعية للتعامل مع السَّلَس البولي

13.2.1
تدريب المثانة

إذا كان المُسن يعاني من السَّلَس البولي ولم يكن هناك تقييم معمَّق متاح على الفور، يمكن أن يدعم العاملون الصحيون المجتمعيون المسن ومقدم الرعاية من خلال تدريب المثانة. استخدام منبه المثانة لتتبع أنماط استخدام المرحاض، مما يساعد على توجيه التدخلات المناسبة وتعديل السلوك. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز تعلم عادات جديدة. ويمكن أن يكون جدول التفريغ التدريجي فعالًا، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من السَّلَس البولي الإلحاحي، من خلال إفراغ المثانة كل ساعتين في البداية، ثم زيادة الفاصل الزمني تدريجيًا، إلى جانب تقنيات الإلهاء، مثل الجلوس على سطح صلب أو ممارسة نشاط يتطلب التركيز. ومن المهم تجنب فرض نمط محدد على الجميع، مع مراعاة حدود وقدرات كل فرد. ويجب تنفيذ تدريب المثانة باستخدام منبه المثانة لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

منبه المثانة

التاريخ، الوقت	مدخول السوائل		البول		التسرب		
	النوع	الكمية (مل)	الحجم (مل أو ص/م/ك)*	إلحاح الحاجة للتبول (5–1)	الحجم (ص/م/ك)	النشاط المؤدى	تغيير الحفَّاضة

* إذا لم يكن من الممكن قياس أو تقييم الكمية بالمليلتر، يُسجل الحجم باستخدام عبارات قليل أو متوسط أو كثير.

13.3 تقييم السَّلَس البولي والحالات البولية

السَّلَس البولي هو التسرب غير الإرادي للبول. وهو ليس فقط نتيجة اضطرابات المسالك البولية السفلية ولكن أيضًا نتيجة لفقدان القدرة على الحركة، والتدهور المعرفي، وأمراض أخرى. وهناك خطوة مهمة قبل إجراء تقييم معمَّق للسَّلَس البوليّ، ألا وهي تحديد أي أسباب قابلة للعلاج والتعامل معها (◆). ← 13.5

يمكن التعرف على السَّلَس البولي المحتمل من خلال السؤال عن حالات التسرب المفاجئ للبول مع الإلحاح الشديد و/أو الناتجة عن السعال أو رفع الأشياء الثقيلة. ويجب جمع معلومات حول شدة السَّلَس البولي وكمية البول المفقودة، وتكرار نوبات السلس، ومدة المشكلة. هناك أنواع مختلفة من السَّلَس البولي (إطار 13.1)، ولكن تشخيص النوع ليس ضروريًا في مستوى الرعاية الأولية للبدء في تقديم التدخلات.

المربع 13.1 أنواع السَّلَس البولي

- **السَّلَس البولي الإلحاحي:** يحدث السَّلَس البولي مباشرة بعد الشعور بإلحاح شديد للتبول. وهو الأكثر شيوعًا بين المسنين.
- **السَّلَس البولي الإجهادي:** يحدث السَّلَس البولي نتيجة زيادة مفاجئة في الضغط داخل البطن (مثل، السُعال أو رفع الأشياء الثقيلة)، بسبب ضعف عضلات قاع الحوض أو ضعف المصرة البولية. وهو يرتبط بالسمنة والنساء اللواتي خضعن لولادات مهبلية.
- **السَّلَس البولي المختلط:** مزيج من السَّلَس البولي الإجهادي والإلحاحي.
- **السَّلَس البولي الناتج عن فرط امتلاء المثانة:** يحدث السَّلَس البولي بسبب امتلاء المثانة بشكل مفرط نتيجة ضعف وظيفة انقباض المثانة أو انسداد مخرج المثانة أو كليهما. وهو شائع لدى الرجال.
- **السَّلَس البولي المرتبط بالإعاقة:** ناتج عن التدهور المعرفي، أو محدودية القدرة على الحركة، أو الأمراض المصاحبة.

يجب أن يتولى تقييم الحالات البولية عامل صحي مدرب، ويشمل ذلك الفحوص المذكورة أدناه. في معظم الحالات، لا يكون التقييم البولي ضروريًا خلال التقييم الأوَّلي، ولكن يجب تحديد الأسباب القابلة للعلاج ومعالجتها:

- فحص البطن لتحديد وجود مثانة ملموسة.
- الفحص الرقمي للمستقيم للكشف عن وجود كتلة في الحوض، أو تضخم في البروستاتا (عند الرجال بحجم كرة تنس الطاولة تقريبًا، أي أكبر من 40 سم³)، أو انحشار البراز (الإمساك).
- تحليل البول للكشف عن البيلة الدموية والتهابات المسالك البولية. يجب الانتباه إلى محدودية شريط تحليل البول حيث لا يميز بين الهيموغلوبين والميوغلوبين. يوصى بالفحص المجهري (إذا كان متاحًا) لتأكيد وجود البيلة الدموية.
- بالنسبة للنساء، يتم فحص الأعضاء التناسلية الخارجية للتحقق من وجود هبوط في الأعضاء التناسلية (نزول الرحم أو عنق الرحم أو جدران المهبل) أو ناسور (ثقب بين المهبل والمثانة)، والذي قد يُشتبه به في حال وجود إفرازات مهبلية غير طبيعية، أو فقدان مستمر للبول، أو رائحة البول الكريهة.

ويجب أيضًا التحقق من نتائج التقييم الأساسي للمجالات الأخرى المرتبطة بالقدرة الذاتية، مثل التدهور المعرفي، ومحدودية القدرة على الحركة وأعراض الاكتئاب، وإجراء تقييم مُعمَّق عند الضرورة. ← 5 6 10

13.4 معالجة السَّلَس البولي

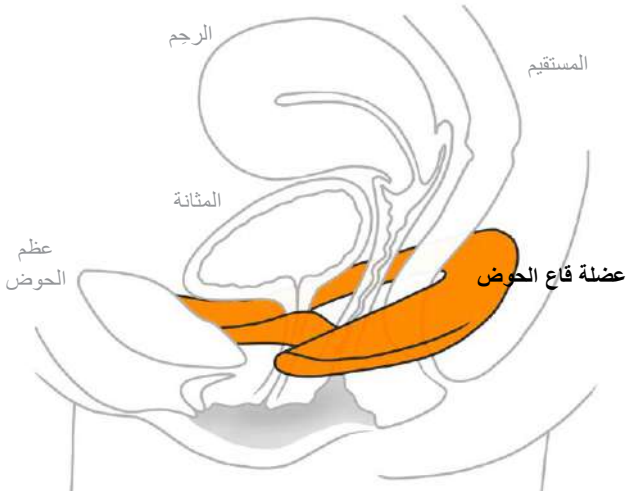
يجب تقديم تدخُّلات لمعالجة السَّلَس البولي دائمًا كجزء من خطة رعاية شاملة ومشخصنة. تستجيب للعوامل المستبطنة، إلى جانب التدخلات التي تستهدف مجالات أخرى من القدرة الذاتية. بالإضافة إلى تدريب المثانة، هناك عدة طرق لإدارة السَّلَس البولي، بما في ذلك تمارين تقوية عضلات قاع الحوض للنساء، والتذكير المنتظم بالتبول للأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي.

13.4.1 تمارين تقوية عضلات قاع الحوض

يمكن التوصية بتمارين تقوية عضلات قاع الحوض للنساء المسنات اللواتي يعانين من السَّلَس البولي. ونظرًا لأن هذه التمارين تُقدَّم عادةً ضمن خدمات الرعاية الصحية كجزء من رعاية ما بعد الولادة، فإنه إذا حصل العاملون الصحيون على التدريب والموارد الكافية، فيجب أن يكونوا قادرين على تقديم المعلومات والدعم للنساء المسنات (إطار 13.2). أداء ثلاث مجموعات مكونة من 10 انقباضات يوميًا، مع فترات استرخاء كافية بين كل انقباضة وأخرى. ولتحسين وظيفة عضلات قاع الحوض، يجب الاستمرار في ممارسة هذه التمارين لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

تمتد عضلات قاع الحوض عبر أسفل الحوض وتدعم الأعضاء الحوضية (المثانة والأمعاء، والرحم عند النساء) (الشكل 13.1).

الشكل 13.1
عضلات قاع الحوض



المربع 13.2 كيفية ممارسة تمارين عضلات قاع الحوض

يمكن للعاملين الصحيين تزويد النساء المسنات بالمعلومات حول تمارين قاع الحوض. من المهم أن تتعلم النساء المسنات أداء التمارين بشكل صحيح، وأن يتحققن بشكل دوري من استمرار ممارستها بالطريقة الصحيحة. ويمكن للعاملين الصحيين مساعدة النساء المسنات على فهم التمارين من خلال استخدام المخططات التوضيحية، والرسومات، والنماذج، ومشاركة النصائح التالية:

- في وضع الجلوس، يجب أن تجلس المرأة بشكل مريح مع إبقاء القدمين والركبتين متباعدتين. يمكنها أيضًا الاستلقاء على ظهرها مع إبقاء الساقين متباعدتين قليلًا، إذا كانت تفضل ذلك. ويجب أن تتذكر أن تستمر في التنفس طوال التمرين، وأن تحافظ على استرخاء عضلات المعدة والساقين والأرداف.
- يجب أن تتخيل المرأة أنها تحاول منع خروج الغازات من الأمعاء، وفي الوقت نفسه تحاول إيقاف تدفق البول من المثانة. يجب أن تشعر برفع وشد في منطقة المهبل والشرج.
- قد لا تتمكن النساء في البداية من تنفيذ عملية انقباض وإرخاء عضلات قاع الحوض بشكل كافٍ.
  حيث يحتاج ذلك إلى الممارسة، ولكن مع مرور الوقت ستتمكن غالبية النساء من أداء التمرين بشكل صحيح إذا أُتيحت لهن الفرصة للتجربة.

13.4.2 التذكير المنتظم بالتبول

قد تكون هذه الإجراءات صعبة إذا كان المسن مصابًا بالخرف أو لديه قدرة محدودة على التعاون، أو إذا كان هناك حاجة لأكثر من شخصين لنقله.

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي إلى دعم خاص لإدارة السَّلَس البولي. يجب أن يشمل هذا الدعم، التذكير المنتظم بالتبول لزيادة استخدامهم للمرحاض وتقليل عدد نوبات السَّلَس البولي. ويجب أن يقترح مقدم الرعاية على المسن الذهاب إلى المرحاض كل ساعتين خلال اليوم، ومساعدته على القيام بذلك. ويمكن لمقدم الرعاية تعزيز السلوك الإيجابي المتعلق باستخدام المرحاض بشكل متكرر من خلال قضاء بعض الوقت في المرحاض مع المسن، والتحدث معه، وعدم الاستعجال العملية. يجب أيضًا أن يسأل مقدم الرعاية المسن عما إذا كان يشعر بأنه مبتل، لتشجيعه على ملاحظة الأمر والتصرف بناءً عليه. إذا كان المسن غير قادر على الإبلاغ عن حالته بشكل موثوق، يجب أن يقوم مقدم الرعاية بفحص ما إذا كان هناك بلل أثناء زيارات المرحاض، وتسجيل كل فحص في مفكرة المثانة، للمساعدة في تحديد نمط التبول الذي يمكن أن يساعد في توقع نوبات السَّلَس البولي ومنعها.

يجب متابعة تأثير كل من التدخلات المذكورة أعلاه لمدة 3-6 أشهر. وإذا لم يطرأ أي تحسُّن، يجب إحالة المسن إلى رعاية متخصصة.

13.5 تقييم الأمراض المصاحبة وعوامل الخطر ومعالجتها

يجب أن يبدأ تقييم الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بالسَّلَس البولي بتحديد الأسباب المحتملة وعلاجها، بما في ذلك اختلال توازن السوائل، والإمساك، والأدوية، والتهابات المسالك البولية، والهذيان. ويتطلب تحديد الأسباب القابلة للتصحيح للسَّلَس البولي، إجراء فحص تشخيصي شامل في منشأة الرعاية الأولية. وقد يكون من الضروري استكشاف عدة تشخيصات محتملة للأعراض، للوصول إلى نهج دقيق لخطة الرعاية.

13.5.1 توازن السوائل ◆

يمكن أن يكون الإفراط في تناول السوائل أحد عوامل خطر الإصابة بالسَّلَس البولي. يجب التحقق من توازن السوائل لتحديد الأسباب المحتملة لزيادة إنتاج البول. وقد تعمل بعض المشروبات والأطعمة، مثل الكافيين، كمدرات للبول، مما يؤدي إلى زيادة كمية البول المنتَجة. ويجب تشجيع الحفاظ على توازن السوائل الطبيعي، مع توضيح مخاطر تقليل تناول السوائل، والتي تشمل زيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية والتجفاف. يمكن تقليل استهلاك الكافيين لمدة 6 أسابيع على سبيل التجربة. ← 7.3.2

13.5.2 الإمساك ◆

يمكن أن تكون قلة تكرار التبرز أو صعوبة إخراج البراز، بسبب انخفاض حركة الأمعاء، سببًا أو عاملًا مسهمًا في السَّلَس البولي. ويمكن تحديد انحشار البراز من خلال الأعراض، ومفكرة البراز، والتقييم البدني مثل الفحص الرقمي للمُستقيم. ويمكن أن تساعد النُظم الغذائية الغنية بالألياف، وتناول السوائل بشكل كافٍ، والنشاط البدني المنتظم، والاعتياد على التبرز في نفس الوقت يوميًا (مثل بعد الإفطار) في معالجة الإمساك.

13.5.3 الأدوية غير المناسبة ◆

يجب مراجعة الأدوية لتحديد أي أدوية قد تؤدي إلى السَّلَس البولي.

الأدوية التي قد تسبب السَّلَس البولي هي:

- مدرات البول
- مضادات مستقبلات الألفا الأدرينالية
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين
- مضادات قنوات الكالسيوم
- أدوية العلاج النفسي (مثل كلوزابين، ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، والبنزوديازيبينات، والليثيوم)
- الأدوية المضادة لمرض باركنسون
- مضادات الهيستامين

بعد استعراض الأدوية، يمكن إيقاف بعضها أو استبدالها بأدوية بديلة إذا رأى العامل الصحي أن ذلك مناسبًا.

13.5.4 التهاب المسالك البولية ◆

يجب الاشتباه في وجود التهاب المسالك البولية الحاد بناءً على تحليل البول. فقد يسبب أعراضًا مثل الحاجة الملحة أو المتكررة للتبول، والإحساس بالحرقان أثناء التبول، ووجود دم في البول. ويمكن أن يظهر التهاب المسالك البولية بشكل شائع على هيئة هذيان أو ارتباك حتى في غياب الحمى. يُوصى بعلاج البيلة الجرثومية فقط عند وجود أعراض أو عند وجود دليل على أنها قد تكون سببًا للسَّلَس البولي. وتتطلب التهابات المسالك البولية المتكررة المصحوبة بأعراض (حالتان أو أكثر خلال 6 أشهر، أو ثلاث حالات أو أكثر سنويًا) الإحالة إلى الرعاية المتخصصة.

13.5.5 الهذيان ◆

الهذيان هو فقدان مفاجئ ومتقلب للقدرة على توجيه، وتحويل، والحفاظ على، وتركيز الانتباه، ويمكن أن يكون سببًا للسَّلَس البولي. فقد يكون الشخص المصاب بالهذيان غير مدرك لامتلاء المثانة أو الحاجة إلى التبول. ← 5.5.1

13.5.6 أعراض الفَرْج (النساء)

تشمل أعراض الفَرْج الشعور بعدم الراحة (مثل الحكة، أو الجفاف، أو الإحساس بالحرقان، أو الألم) حول الجزء الخارجي من الأعضاء التناسلية الأنثوية كجزء من متلازمة الجهاز البولي التناسلي المرتبطة بانقطاع الطمث. ولها تأثير سلبي عميق على جودة الحياة. يجب توعية النساء بهذه المشاكل وعلاجها، بما في ذلك استخدام مرطبات المهبل الموضعية والإستروجين، إذا كان ذلك مناسبًا، ومتوافرًا، ويمكن الوصول إليه.

13.5.7 التهاب الجلد المرتبط بالسَّلَس البولي

يجب إجراء فحص للأعضاء التناسلية الخارجية لتقييم احتمالية التهاب الجلد الناتج عن التلامس المطول مع البول. فقد يؤدي الاستخدام المطول لمنتجات التحكم في التسرب، مثل سراويل أو فُوَطُ السَّلَس البولي، إلى التهاب الجلد والعدوى. ويَظهر التهاب الجلد المرتبط بالسَّلَس البولي في مراحله الأولية على شكل احمرار، والذي يختلف حسب لون البشرة: على البشرة الفاتحة: يتراوح اللون من الوردي إلى الأحمر، وعلى البشرة الداكنة: قد يظهر أفتح أو أغمق من لون الجلد الطبيعي، أو أرجواني أو أحمر داكن أو أصفر.

وعادةً ما تكون حواف المنطقة المصابة غير محددة بوضوح، وقد تظهر بشكل متقطع أو ممتد على مناطق كبيرة. يظهر التهاب الجلد المرتبط بالسَّلَس البولي في مراحله المتقدمة على شكل تآكل سطحي في الجلد مصحوب بألم. وإذا تم اكتشاف إصابة بالتهاب الجلد، يُنصح باستخدام منظفات لطيفة لحماية الجلد، وتطبيق منتجات موضعية واقية مناسبة، مثل الكريمات أو الأفلام الحاجزة، وعلاج أي عدوى ثانوية، والتوصية باستخدام منتجات احتواء مناسبة.

13.5.8 السكري والسمنة

يرتبط داء السكري بالسَّلَس البولي بسبب زيادة إنتاج البول والتغيرات في وظيفة عضلات المثانة. وتُعد السمنة عامل خطر قوي للسَّلَس البوليّ، حيث يرتبط ارتفاع معدل انتشار السَّلَس البولي بين النساء المسنات ارتباطًا خطيًا بزيادة مؤشر كتلة الجسم *(61)*. ومع زيادة الضغط داخل البطن بسبب السمنة، يؤدي ارتفاع ضغط المثانة إلى إضعاف عضلات قاع الحوض. ويجب معالجة الأمراض القلبية الوعائية وعوامل الخطر المرتبطة بها من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، بما في ذلك التمارين الرياضية، إلى جانب العلاج الدوائي. وبالنسبة للمسنين، يجب الموازنة بين فوائد فقدان الوزن والمخاطر المحتملة، مثل انخفاض كتلة العضلات المصاحب لذلك. ← 7.3.1

13.6 تقييم البيئات الاجتماعية والمادية ومعالجتها

13.6.1 الوصول إلى المرحاض

يجب إجراء تقييم لإمكانية وصول المسن إلى المرحاض، بما في ذلك المسافة داخل المنزل للوصول إليه، وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون مرافق مرحاض مشتركة خارج المنزل، يجب أيضًا تقييم المسافة، وطبيعة المسار، والسلامة والأمان. ويجب أيضًا أخذ مدى سهولة استخدام المرحاض في الاعتبار، بما في ذلك نوع المرحاض (جالس أو قرفصاء)، والحاجة إلى مقابض إمساك، والمساحة المتاحة للأشخاص الذين يستخدمون المنتجات المساعِدة على الحركة للتنقل. قد تكون كراسي المرحاض (الكومود) والمباول مفيدة إذا كانت المسافة إلى المرحاض طويلة جدًا أو إذا كان الشخص لا يستطيع استخدام المرحاض. توفير إضاءة إضافية في المرحاض، واستخدام شرائط متباينة اللون للإشارة إلى وجود أي درجات، ووضع علامة ملونة على زر السيفون يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. وقد يكون ارتداء ملابس يسهل فكها أو خلعها مفيدًا أيضًا.

ويمكن أن يكون من المفيد أيضًا تقييم إمكانية الوصول إلى مرافق المرحاض في المجتمع المحلي. قد يؤدي نقص الوصول للمرافق إلى إعاقة قدرة المسن أو رغبته في الخروج والمشاركة في الأنشطة، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة.

يمكن لأصحاب المصلحة في المجتمع توفير خرائط توضِّح مواقع المراحيض العامة، والتواصل مع المتاجر المحلية والمقاهي وغيرها من الأعمال التجارية لطلب إتاحة مرافقها الصحية للمسنين.

13.6.2 منتجات التحكم في التسرب

إذا كان علاج السَّلَس البولي غير ممكن أو غير فعال، يمكن أن يساعد استخدام منتجات التحكم في التسرب في تحسين جودة الحياة. وتشمل منتجات التحكم في التسرب الماصة، السراويل وفُوَطُ السَّلَس البولي، حيث يجب استخدام منتجات مختلفة في أوقات مختلفة ولأنشطة مختلفة. على سبيل المثال، يمكن استخدام منتج بمقاس أصغر خلال النهار، بينما قد يكون هناك حاجة إلى منتج بمقاس أكبر أثناء الليل. وقد تكون منتجات التحكم في التسرب قابلة لإعادة الاستخدام أو للاستعمال مرة واحدة. يجب غسل المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام وتجفيفها بعناية. قد تكون هذه المنتجات باهظة الثمن، ولكن في بعض السياقات، يمكن أن تُدعَم ماليًا من خلال آليات مختلفة.

ويمكن أن يدعم أصحاب المصلحة في المجتمع إمكانية الوصول إلى منتجات التحكم في التسرب من خلال التعاون مع السلطات المحلية والعاملين الصحيين لجعل هذه المنتجات متاحة (وبأسعار معقولة) ومحاسبة الجهات المعنية على التزاماتها في هذا المجال.

يجب تجنب القسطرة البولية الدائمة، حيث إنها قد تسبب التهابات ومضاعفات أخرى، مثل وجود دم أو ترسبات في أنبوب القسطرة، مما قد يؤدي إلى انسداد نظام التصريف.

مزيد من المعلومات

التدريب على المنتجات المساعِدة على الرعاية الذاتية والمنتجات الماصة (منتجات التحكم في التسرب).
TAP; 2024 (https://www.gate-tap.org/)

13.6.3

الرعاية والدعم الاجتماعيين ← 11

قد تشمل احتياجات الرعاية والدعم الاجتماعيين، المساعدة في استخدام المرحاض، والاستحمام، وارتداء الملابس. إذا كان الشخص المصاب بالسَّلَس البولي الذي يستخدم منتجات التحكم في التسرب بحاجة إلى دعم من مقدم رعاية للذهاب إلى المرحاض وارتداء الملابس، فيجب أخذ سهولة استخدام منتجات التحكم في التسرب في الاعتبار، بما في ذلك إمكانية تغييرها دون الحاجة إلى إزالة الملابس الخارجية. ويجب أن تضمن مرافق الرعاية النهارية وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل في المجتمع توفير مساحة كافية لمساعدة المسنين في استخدام المرحاض وتغيير ملابسهم عند الحاجة.

قد يستفيد المسنون الذين يعانون من السَّلَس البولي من الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك دعم الأقران. ويمكن أن يعمل أصحاب المصلحة في المجتمع على إنشاء مجموعات الدعم، لمنح المسنين فرصة لمشاركة تجاربهم وطلب نصائح من الآخرين الذين يمرون بتجارب مماثلة. يمكن أن يساعد ذلك في تمكين المسنين المصابين بالسَّلَس البولي من التعبير عن احتياجاتهم وطلب المساعدة عند الحاجة.

13.6.4

دعم مقدمي الرعاية ← 12

يمكن أن يكون الاعتناء بشخص مصاب بالسَّلَس البولي تحديًا جسديًا ونفسيًا. يجب أن يحصل مقدمو الرعاية، بمن فيهم أفراد الأسرة الذين يقضون اليوم كله مع المسن، على تدريب حول أفضل الطرق لتقديم الرعاية، بما في ذلك كيفية مساعدة المسن بأمان على المشي والانتقال من وإلى المرحاض، وكيفية تقديم الرعاية الشخصية، مثل التنظيف والعناية بالجلد لتجنب العدوى، والاستخدام المناسب لفوط السلس البولي وغيرها من المنتجات لتجنب الاعتماد عليها إن لم تكن ضرورية، وكيفية تشجيع المسن على شرب السوائل دون الحد من تناولها، وتشجيع التبول المنتظم من خلال التذكير المستمر، بالإضافة إلى كيفية تنظيف الملابس والفراش المتسخ والتخلص الآمن من فُوَطُ السَّلَس البولي.

من المهم أيضًا توفير الدعم ونصائح لمقدمي الرعاية غير المأجورين حول كيفية التعامل مع أي مشاعر إحراج أو قلق مرتبطة بتقديم الرعاية الشخصية. وقد يجد مقدمو الرعاية صعوبة في مناقشة المسائل المتعلقة بالسَّلَس البولي مع الشخص الذي يعتنون به، وقد يشعرون بعدم الارتياح عند تقديم الرعاية الشخصية. لذا، يجب تزويدهم بنصائح والمعلومات حول كيفية التعامل مع المحادثات الحساسة وكيفية تقديم الرعاية الشخصية بطريقة تعزز الكرامة والاستقلالية.

14 اعتبارات تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين

يمكن أن تساهم الرعاية المتكاملة للمسنين في إحداث تحوُّل في نُظم وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لتقديم رعاية متكاملة ومتمركزة على الشخص بهدف تحسين القدرة الوظيفية. يمكن أن يدعم نهج الرعاية الشاملة في إطار الرعاية المتكاملة للمسنين ضمن نظام الرعاية الصحية الأولية، تحديد احتياجات السكان المسنين وتقديم الخدمات المناسبة لهم (**الشكل 1.1**، الصفحة 5). ويجب أن يتماشى تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين بشكل وثيق مع الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، من خلال الاستفادة من أدوات الرعاية الصحية الأولية الواردة في *الإطار التشغيلي المشترك للرعاية الصحية الأولية* الصادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

لقد تم تجريب الرعاية المتكاملة للمسنين في العديد من البلدان حول العالم عبر مستويات دخل مختلفة، ومع هياكل وقدرات متنوعة داخل أنظمتها للرعاية الصحية والاجتماعية. وتُسلط الدروس المستفادة من هذه البرامج التجريبية الضوء على اعتبارات رئيسية ذات صلة بتنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، والتي تَهم مديري المشروعات والنظم الصحية.

النقاط الرئيسية

- قبل تنفيذ مسار الرعاية المتكاملة للمسنين، يُوصى بإجراء تقييم لمستوى الجاهزية على مستوى الخدمة والنظام.
- يبدأ تكييف وتطوير مسالك الرعاية المحلية بتحديد الموارد المتاحة ونقاط البدء والفرص لتنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.
- يعد إشراك المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين عنصرًا أساسيًا لتنفيذ الرعاية المتكاملة بنجاح وبطريقة مستدامة.
- يبدأ تحسين القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى المسنين من داخل المجتمع. ويجب أن تدعم نُظم الرعاية الصحية والاجتماعية تقديم خدمات على مستوى المجتمع من خلال تعزيز الرعاية الأولية والتعاون مع أصحاب المصلحة في المجتمع.
- يجب أن يحصل العاملون الصحيون على التدريب والدعم والمكافآت المناسبة لتمكينهم من تقديم رعاية متكاملة مشخصنة للمسن ضمن الممارسات الروتينية.
- تتطلب الرعاية المتكاملة للمسنين دمج الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل. ويمكن تقديم الرعاية من خلال عدة قطاعات وبالتعاون بينها وفي مختلف البيئات. ويعد التنسيق والتعاون الفعال بين القطاعات والبيئات والخدمات أمرًا بالغ الأهمية.

14.1
تكييف الرعاية المتكاملة للمسنين مع السياقات المحلية

يجب تكييف نهج الرعاية المتكاملة للمسنين لضمان إمكانية تنفيذ خطوات مسار الرعاية بفعالية ضمن الخدمات والبيئات القائمة، بطريقة مُستدامة وملائمة ثقافيًا.

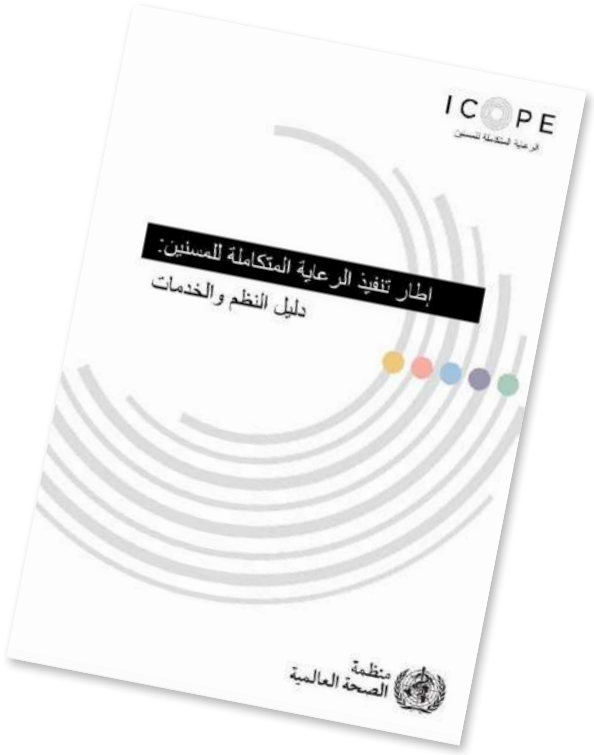
قبل تنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين على نطاق واسع، ينبغي أن تُجري البلدان تقديرًا للاستعداد لتقديم الرعاية المتكاملة لتوجيه عملية تكييف النهج مع السياق المحلي. يوفر *إطار عمل تنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين* التابع لمنظمة الصحة العالمية بطاقة تقييم، لتوجيه عملية تقييم القدرة العامة لخدمات ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية على تقديم الرعاية المتكاملة في الرعاية الأولية، كما يُوجّه خطط العمل الخاصة بالتنفيذ بناءً على مستوى الاستعداد للتنفيذ (منعدم إلى محدود، أو في مرحلة البدء، أو في مرحلة الاستدامة). ويمكن أن تسلط نتائج التقييم الضوء على مجالات الفرص، وتُستخدم لمتابعة التقدم المستمر في التنفيذ.

تُعد هذه الخطوة مهمة نظرًا لاختلاف جميع نظم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تتباين طرق تقديم الخدمات، وهياكل القوى العاملة، واللوائح التنظيمية، و مسارات الإحالة، وقدرات الموارد. ومن الممكن بدء تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين من خلال تجريب النهج وتكييفه في سياق مجتمعي أو سريري، مع إشراك أصحاب المصلحة المحليين المعنيين.

لتوجيه عملية التكييف على المستوى المحلي أو الوطني، ينبغي إجراء تمرين شامل لتحديد الوضع (**المربع 14.1**، الصفحة 145) بمشاركة المسنين، ومقدمي الرعاية غير المأجورين، والعاملين في ميدان الصحة والرعاية الاجتماعية من بيئات مختلفة، والسلطات الصحية العامة، وأصحاب المصلحة في المجتمع. ويمكن استخدام عملية تحديد الوضع لبناء الدعم والتعاون لتنفيذ هذا النهج.

كما ينبغي أن تسهم المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذا التمرين في تطوير مسارات رعاية تتماشى مع السياق المحلي. يجب أن يركز هذا التمرين على العمل وفقًا للممارسات الروتينية الحالية والاستفادة من أدوات التقييم الأساسية والمعمَّقة المتاحة والمُعتمدة، والتي تُعنَى بالقدرة الذاتية والقدرة الوظيفية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة والحوافز، ودعم الخدمات حيثما دعت الحاجة. ويجب ترجمة مسارات الرعاية المُكيّفة إلى اللغات ذات الصلة وتجريبها لاختبار مدى قابليتها للتنفيذ ومدى قبولها.

يمكن للعاملين الصحيين تنفيذ تمارين مماثلة لتحديد الموارد المتاحة في بيئة الرعاية الصحية الخاصة بهم، من خلال بناء فريق متعدد التخصُّصات، وإنشاء آلية تعاون بين مختلف خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحديد نقاط البدء لدمج مسار الرعاية المتكاملة للمسنين في الممارسة السريرية الروتينية. ويمكن أن توفر هذه العملية معلومات حول مكان وكيفية ومع من يمكن البدء في تجريب النهج. ويجب أن تركز المرحلة الأولى من التجربة على تقييم مدى إمكانية تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، وتحديد العوائق والعوامل المساعدة لتنفيذه.



المربع 14.1 عناصر التحديد الشامل لتوجيه تكييف الرعاية المتكاملة للمسنين

المسنون ومقدمو الرعاية:

- تحليل وضع الصحة والرفاه لدى المسنين، بالاستناد إلى مقابلات مع مصادر رئيسية واستبيان يستند إلى السكان أو المرافق الصحية.
- محو الأمية الصحية لدى المسنين ومقدمي الرعاية.
- تحديد أماكن تواجد المسنين الذين يحتاجون إلى الرعاية، بمن فيهم غير القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، مما يستدعي تقديم الرعاية لهم في المنزل أو ضمن المجتمع.

نماذج الرعاية: يشير نموذج الرعاية إلى تصور كيفية تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك عمليات الرعاية، وتنظيم مقدمي الخدمات، وإدارة الخدمات. يتم دعم النموذج من خلال تحليل وتحديد ما يلي:

- توفر الخدمات الصحية للمسنين، وإمكانية الوصول إليها (التكلفة، والمسافة، ووسائل النقل، وملاءمتها للمسنين)، ومدى قبولها وجودتها على مختلف مستويات النظام الصحي.
- مسارات الرعاية، بما في ذلك نقطة الاتصال الأولى والدورية المعتادة، وآليات الإحالة.
- نقاط الدخول لتنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين ضمن تقديم الخدمات الحالية (مثل العيادات الخاصة بالأمراض غير السارية أو خدمات التوعية المتنقلة).
- البنية التحتية المتاحة، بما في ذلك التشخيص، وآليات جمع ومشاركة بيانات الصحة والرعاية، والمساحات المخصصة لإجراء التقييمات.
- أدوات التحري والتقييم للكشف عن القصور في القدرة الذاتية.
- الأدوية، واللقاحات، والمنتجات الصحية الأساسية، بما في ذلك المنتجات المساعِدة.
- توفر خدمات الرعاية الاجتماعية وإمكانية الوصول إليها ومدى قبولها، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل، والخدمات المجتمعية المخصصة للدعم الاجتماعي.

الشراكة:

- إقامة تعاون منظم بين قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية عبر مختلف البيئات، بالإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة في المجتمع.
- وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية.
- الاعتراف بدور أصحاب المصلحة في المجتمع، وتوفير التدريب والدعم لهم.

التنسيق:

- وجود آليات للتعاون بين الخدمات الصحية والاجتماعية والعاملين في كلا القطاعين.
- تبنّي أساليب عمل تُمكّن من تطبيق نهج الفريق متعدد التخصُّصات.
- هيكلة وتعزيز قدرات خدمات الرعاية طويلة الأجل والعاملين بها.
- الاستفادة من الدعم الاجتماعي مثل الوصفات الاجتماعية التي تربط الأفراد بالخدمات المجتمعية لتعزيز صحتهم ورفاههم.
- الشراكات القائمة مع قطاعات أخرى، بما في ذلك المواصلات، والتعليم، والتوظيف، والعدالة، وإنفاذ القانون.

الموارد البشرية:

- تحديد العاملين الصحيين في الرعاية الأولية، بما في ذلك العاملين الصحيين المجتمعيين، ومدى قدرتهم من حيث الوقت والمعرفة والمهارات والتعويض المالي، بالإضافة إلى تكوين الفرق متعددة التخصُّصات (في حال وجودها).
- نوع التدريب الذي يتلقونه حاليًا، والمعرفة الضرورية التي لم يتم توفيرها بعد.
- أدوار ومسؤوليات العاملين الصحيين عبر مختلف مستويات الرعاية الصحية (الأولية، والثانوية، والثالثية)، وفي بيئات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مرافق الرعاية طويلة الأجل.
- الموارد البشرية الأخرى، بما في ذلك المتطوعون وأصحاب المصلحة في المجتمع.

الموارد المالية:

- تحديد الميزانية المتاحة حاليًا والتي يمكن استخدامها لتعزيز الرعاية المتكاملة عالية الجودة المتمركزة على المسنين.
- تقييم تكلفة تقديم الرعاية المتكاملة والفجوات في الميزانية.

ملاحظة: يمكن تنفيذ تحليل شامل للعوامل المؤثرة في تكييف الرعاية المتكاملة للمسنين بأي ترتيب وفقًا للسياق المحلي.

المربع 14.2 ملخص للإجراءات الواردة في إطار عمل تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين

الإجراءات على مستوى النظم (المستوى الكلي)

✔ **تعزيز الحَوكمة وأنظمة المساءلة**

إشراك أصحاب المصلحة في تطوير السياسات والخدمات؛ ووضع سياسات ولوائح تدعم الرعاية المتكاملة والاستجابات لحالات سوء معاملة المسنين؛ وتنفيذ عمليات ضمان الجودة والتحسين المستمر؛ ومراجعة القدرة على تقديم الرعاية بعدالة وبصفة منتظمة.

✔ **دعم تقوية النُظُم**

تطوير قدرات القوى العاملة، وآليات التمويل، وإدارة الموارد البشرية؛ واستخدام التكنولوجيا لتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات؛ وجمع البيانات حول القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية والإبلاغ عنها؛ واستخدام التقنيات الرقمية لدعم الإدارة الذاتية للرعاية.

الإجراءات على مستوى الخدمات (المستوى المتوسط)

✔ **إشراك وتمكين الأفراد والمجتمعات**

إشراك المسنين وأُسَرهم والمجتمع المدني في تقديم الخدمات؛ ودعم وتدريب مقدمي الرعاية لتعزيز قدراتهم.

✔ **دعم تنسيق الخدمات المُقدمة من قِبَل الفرق متعددة التخصُّصات**

تحديد المسنين في المجتمع الذين يحتاجون إلى الرعاية، وإجراء تقييمات شاملة، ووضع خطط رعاية متكاملة؛ وإنشاء شبكات للعاملين في ميدان الصحة والرعاية الاجتماعية لتعزيز التعاون والتنسيق.

✔ **توجيه الخدمات نحو الرعاية المجتمعية**

تقديم رعاية فعالة ومقبولة تركز على القدرة الوظيفية، من خلال العاملين في الرعاية المجتمعية والخدمات المدعومة ببنية تحتية ملائمة للمسنين.

14.2 اعتبارات التنفيذ

بعد إجراء تقييم الاستعداد وتكييف نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، هناك عدد من الاعتبارات الإضافية لتنفيذه. يوفر *الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية* الصادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف آليات مترابطة ومتكاملة (استراتيجية وتشغيلية) لتوجيه جهود البلدان نحو تعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية.

يحدد *إطار عمل تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين* 19 إجراءً مكمِّلاً لآليات الرعاية الصحية الأولية، لدعم الدول الأعضاء، مع التركيز على مستوى النظام الكلي - (Macro) ومستوى الخدمات المتوسط - (Meso) (**المربع 14.2**). وتستهدف المكونات على المستوى الكلي دعم صانعي السياسات، ومخططي النظام الصحي، والممولين، وصانعي القرار، في حين تركز الإجراءات على المستوى المتوسط على مديري الخدمات والبرامج وصانعي القرار. وتماشيًا مع الآليات التشغيلية للرعاية الصحية الأولية، مثل نماذج الرعاية، وقوى العمل في الرعاية الصحية الأولية، والتكنولوجيا الرقمية، والرصد والتقييم، تهدف الاعتبارات التالية المستمدة من إطار التنفيذ والدروس المستفادة من برامج تجريبية لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين، إلى دعم تنفيذها على مستوى الخدمات.

14.2.1 دمج الخدمات الصحية مع إعطاء الأولوية للرعاية الأولية

تم تصميم معظم النُظم الصحية حول العالم لعلاج الأمراض والشفاء منها، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال خدمات رأسية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مُجهَّزة لتقديم رعاية متكاملة متمركزة على الشخص، حيث يتطلب ذلك نهجًا أفقيًا شاملاً يسمح بالمرونة والعمل متعدد التخصُّصات. لذلك، يجب إعطاء الأولوية لخدمات الرعاية الأولية باعتبارها نقطة الاتصال الأولى والدورية، والعنصر الأساسي في الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على تقديم رعاية متكاملة مستمرة كهدف رئيسي، مما يسمح بتوفير رعاية عالية الجودة، بما في ذلك تنفيذ مسار الرعاية المتكاملة للمسنين. ويمكن دعم ذلك من خلال إدراج تدخلات الرعاية المتكاملة للمسنين ضمن حزمة الخدمات الأساسية في الرعاية الأولية.

ينبغي مراعاة مستوى التنسيق بين النُظم الصحية، بما في ذلك مدى ملاءمة البنية التحتية للمسنين، وتوافر الأدوات والتقنيات المناسبة، مثل الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية، وكذا المنتجات المساعدة، مع ضمان وجود آليات إحالة فعالة، سواء داخل الخدمة الصحية، شاملاً الإحالة إلى الرعاية المتخصصة في المستويات الثانوية والثالثية، أو بين الخدمات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء وتعزيز نُظم جمع البيانات ومشاركتها.

14.2.2 الموارد البشرية والمالية

من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى استثمارات إضافية لدعم تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية، لضمان اتباع نهج أكثر فعالية وكفاءة مع تحسين التوافق مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية. وعادةً ما يتضمن بناء قدرات العاملين الصحيين متعددي التخصُّصات، توفير تدريب قائم على الكفاءات على جميع المستويات، وخاصة في الرعاية الأولية، من أجل تعزيز الفهم لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين وكيفية تطبيقه بفعالية.

يجب أن تُمكّن الفرق متعددة التخصصات من تقديم رعاية متكاملة ومستدامة متمركزة علي الشخص. ويتم ذلك من خلال تحسين مزيج مهارات العاملين.

في العديد من السياقات، يؤدي العاملون الصحيون المجتمعيون دورًا متزايد الأهمية في تقديم الخدمات الصحية، ولكنهم قد يفتقروا إلى التدريب والدعم، وغالبًا ما يعملوا بصفة تطوعية أو غير مدفوعة الأجر، مما يؤثر على استدامة الخدمات (مثل التوظيف والاحتفاظ بالكوادر). لذلك، فإن توفير الأمن الوظيفي، والإشراف الداعم، ومسارات التطور المهني تعد أمور بالغة الأهمية. وقد تكون هناك حاجة إلى تكوينات بديلة للقوى العاملة بناءً على السياق وتوافر الموارد، للاستجابة للاحتياجات الصحية المتغيرة للسكان. يمكن أن يدعم تقاسم المهام بين العاملين الصحيين تقديم الرعاية المتكاملة، وقد يتطلب ذلك أيضًا تعديل اللوائح التنظيمية، والاعتراف بأدوار جديدة، ووضع آليات تعويض محددة.

إن بناء الحوافز للصحة العامة، وتقديم مكافآت للعاملين الصحيين على تقديم الرعاية المتكاملة، إلى جانب آليات التمويل ورصد الأداء، يمكن أن يشجع التحول نحو تحسين جودة الرعاية المقدَّمة للمسنين. كما يمكن للجهات المسؤولة عن تطوير التدريب والمناهج الدراسية وتوفير الاعتماد، إلى جانب الجمعيات المهنية الوطنية والمحلية، أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف.

14.2.3 التنسيق بين قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية

يتطلب تقديم الرعاية المتكاملة وجود هياكل وآليات على مستوى الخدمات تُمكّن من الإحالة بين الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وتُعزز التعاون بين العاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين، ويتم تيسير ذلك من خلال منسق رعاية كجزء من فريق متعدد التخصُّصات. ويجب أن يشمل هذا التنسيق خدمات الرعاية طويلة الأجل، بالإضافة إلى دمج نُظم المعلومات وضمان جودة الخدمات.

يوفر *دليل الرعاية طويلة الأجل للمسنين: حزمة للتغطية الصحية الشاملة* الصادر عن منظمة الصحة العالمية، قائمة بتدخلات الرعاية طويلة الأجل والتي يمكن أن تقوم الدول بدراستها وتحديد أولوياتها وتنفيذها. في بعض البلدان، يتم تنظيم آلية تقييم الأهلية لخدمات الرعاية طويلة الأجل وتقديم الرعاية من قِبل قطاعات مختلفة. وبغض النظر عن الترتيبات المحلية، تظل مبادئ النهج المتكامل المتمركز على الشخص ثابتة، رغم أن تطبيقها قد يتطلب كوادر مختلفة (سواء في المجتمع أو في البيئات السكنية) بالإضافة إلى مهارات متخصصة. وسيكون قطاعا الرعاية الصحية والاجتماعية أكثر قدرة على تَبنّي وتطبيق نهج الرعاية المتكاملة للمسنين عندما تدعم السياسات الوطنية نهجًا متكاملاً بين الرعاية الصحية والاجتماعية. ويجب أن تراعي هذه السياسات كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والقائمين عليها، بما في ذلك دور القطاع الخاص في توفير الرعاية طويلة الأجل، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ هذا النهج بفعالية.

14.2.4 التكنولوجيا الرقمية

برز استخدام التكنولوجيا الرقمية كعامل تمكيني محتمل استنادًا إلى الدروس المستفادة من البرامج التجريبية لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين، حيث أظهرت هذه التجارب أن استخدامها يُسهم في تحسين كفاءة وفعالية الرعاية المتكاملة.

ويمكن أن تدعم الأدوات الرقمية العاملين الصحيين في الوصول إلى التدريب عبر التعلم الإلكتروني، وإجراء التقييمات الأساسية والمعمَّقة ضمن مسار الرعاية المتكاملة للمسنين، ورصد وتحليل نتائج التدخلات لتعزيز جودة الرعاية المُقدَّمة. يمكن أن تُسهم التقنيات الرقمية أيضًا في تعزيز وتحسين التواصل مع المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين، من خلال الرعاية الصحية عن بُعد والصحة المتنقلة، واستخدام الفيديو ووسائل الإعلام الرقمية الأخرى لنشر الوعي حول الرعاية المتكاملة وتقديم نصائح بشأن الصحة ونمط الحياة. ويمكن استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم القدرة الوظيفية، وتقليل الحاجة إلى الرعاية، ومساعدة مقدمي الرعاية غير المأجورين في أداء دورهم (المربع 12.1، الصفحة 130).

يُساعد التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل السجلات الصحية الإلكترونية، في تيسير مشاركة البيانات في الوقت الفعلي بين العاملين الصحيين، بما في ذلك العاملين الصحيين المجتمعيين والعاملين في الرعاية الاجتماعية، كما تدعم تجميع البيانات لرصد وتحسين استهداف الجهود في الصحة العامة.

يجب التصدي للافتراضات التمييزية على أساس العمر التي تفترض أن المسنين لا يستطيعون أو لا يرغبون في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وعند النظر في استخدام التكنولوجيا الرقمية، ينبغي مراعاة التحديات المحتملة، بما في ذلك محو الأمية الرقمية لدى المسنين، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، وقابلية التشغيل البيني، وسلامة البيانات، وحوكمتها، والأمن السيبراني، وسهولة الاستخدام.

14.2.5 الرصد والتقييم

في سياق الرعاية الصحية الأولية، ستحتاج الدول إلى تقييم الفجوات، وتحديد الأولويات، ووضع الخطوط الأساسية والأهداف، ومتابعة التقدم والأداء نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر نظم الرعاية الصحية والاجتماعية.

يُعد رصد التقدم الصحي وتقييمه ومراجعته أمرًا أساسيًا لضمان تنفيذ الإجراءات والقرارات ذات الأولوية وفقًا للخطة المتفق عليها وتحقيق الأهداف والغايات المحددة للمسنين. ويجب أن يشمل الرصد والتقييم الفعّال للرعاية المتكاملة للمسنين التركيز على الحالة الصحية، بما في ذلك القدرة الذاتية والقدرة الوظيفية لدى المسنين على المستوى الفردي والجماعي، كجزء من عملية الرصد والتقييم الأوسع. ويُعد بناء القدرات لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها في اتخاذ القرارات المحلية أمرًا بالغ الأهمية، لضمان التخطيط الفعّال وتحسين جودة الرعاية المُقدَّمة. تدعم البيانات الموثوقة على مستوى الخدمات، التي يتم جمعها من خلال مؤشرات مُوحَّدة، فهم فعالية الرعاية المتكاملة للمسنين، كما تسهم في تحديد الأولويات وإجراء التعديلات على تقديم الخدمات، مما يساعد في ضمان المساءلة، بما في ذلك تجاه المسنين ومقدمي الرعاية غير المأجورين.

يمكن أن يلعب أصحاب المصلحة في المجتمع دورًا في تعزيز المساءلة، من خلال: تحميل النظم الصحية مسؤولية تلبية احتياجات المسنين، والمساهمة في المساءلة المتعلقة بحوكمة الرعاية الصحية والتخطيط وتقديم الخدمات وتقييمها.

يمكن أيضًا تطوير نهجًا لرصد الرعاية المتكاملة للمسنين ضمن آلية الرصد والتقييم في الرعاية الصحية الأولية، ليكون جزءًا من عملية أوسع لرصد وتقييم الشيخوخة الصحية، مسترشدًا بإطار عمل منظمة الصحة العالمية ومؤشراتها لقياس التقدم والأثر في إطار عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية (2021-2030).

مزيد من المعلومات

- ***الأدلة، السياسات، التأثير: دليل منظمة الصحة العالمية لاتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.*** WHO; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/350994)
- ***إطار تنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين: دليل النظم والخدمات.*** WHO; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/325669)
- ***الرعاية طويلة الأجل للمسنين: حزمة التغطية الصحية الشاملة.*** WHO; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376585)
- ***الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية: تحويل الرؤية إلى عمل.*** WHO and UNICEF; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/337641)
- ***المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن دعم السياسات والنظم الصحية لتحقيق الأداء الأمثل للبرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين.*** WHO; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/275474)

المراجع[1]

1. World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015 (https://iris.who.int/handle/10665/186463). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2. World population prospects 2024: probabilistic population projections. New York : United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2024 (https://population.un.org/wpp/). Licence: CC BY 3.0 IGO.

3. World population prospects 2024: summary of results. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2024 (https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2024_Key-Messages.pdf). Licence: CC BY 3.0 IGO.

4. Global report on ageism. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/340208). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

5. Integrated care for older people handbook: guidance on person-centred assessment and pathways in primary care. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/326843). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

6. Global strategy and action plan on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://iris.who.int/handle/10665/329960). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

7. Long-term care for older people: package for universal health coverage. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376585). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

8. Universal health coverage (UHC). Key facts [website]. Geneva: World Health Organization; 2023 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)).

9. Global Burden of Disease 2021: findings from the GBD 2021 Study. Seattle WA: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME); 2024 (https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-burden-disease-2021-findings-gbd-2021-study).

10. World population prospects 2024: demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950–2100. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2024 (https://population.un.org/wpp/). Licence: CC BY 3.0 IGO.

11. Batmani S, Jalali R, Mohammadi M, Bokaee S. Prevalence and factors related to urinary incontinence in older adults women worldwide: a comprehensive systematic review and me¬-ta-analysis of observational studies. BMC Geriatr. 2021; 21:212 (https://doi.org/10.1186/s12877-021-02135-8).

12. Todhunter-Brown A, Hazelton C, Campbell P, Elders A, Hagen S, McClurg D. Conservative interventions for treating urinary incontinence in women: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2022;9(9):CD012337 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD012337.pub2).

13. Health literacy development for the prevention and control of noncommunicable diseases: volume 2: a globally relevant perspective. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/364204). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

14. Table 1: summary of WHO position papers - recommendations for routine immunization [website]. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://www.who.int/publications/m/item/table1-summary-of-who-position-papers-recommendations-for-routine-immunization).

15. Global Health Observatory: global health estimates: leading causes of death [website]. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death).

16. Qu C, Liao S, Zhang J, Cao H, Zhang H, Zhang N et al. Burden of cardiovascular disease among elderly: based on the Global Burden of Disease Study 2019. Eur Heart J. 2024;10(2):143–153 (https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcad033).

17. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million partic¬i-pants. Lancet. 2021;398:957–80 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1).

18. Community engagement: a health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/334379). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

19. Integrated care for older people (ICOPE) implementation pilot programme: findings from the 'ready' phase. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/353553). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

20. Global status report on the public health response to dementia. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/344701). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

21. Rampengan DDCH, Gunawan FA, Rampengan JAH, Ramadhan RN, Iqhrammullah M, Yufika A. Effectiveness of Tai Chi as a non-invasive intervention for mild cognitive impairment in the elderly: a comprehensive review and meta-analysis. Narra J. 2024;4(1):e724 (https://doi.org/10.52225/narra.v4i1.724).

22. Li Z, Guo H, Liu X. What exercise strategies are best for people with cognitive impairment and dementia? A systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2024;124:105450 (https://doi.org/10.1016/j.archger.2024.105450).

23. Liu X, Liu L, Liu C. Summary of the effect of an exercise inter-vention on elderly with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. Medicine. 2024;103(24):e38025 (https://doi.org/10.1097/MD.0000000000038025).

24. Sanses TV, Kudish B, Guralnik JM. The relationship between urinary incontinence, mobility limitations, and disability in older women. Curr eriatr Rep. 2017;6(2):74–80 (https://doi.org/10.1007/ s13670-017-0202-4).

[1] Accessed 2 December 2024.

41. Goswami AK, Kalaivani M, Gupta SK, Nongkynrih B, Pandav CS. Usefulness of mid-upper arm circumference in assessment of nutritional status of elderly persons in urban India. Int J Med Public Health. 2018;8(1):34–37 (https://pdfs.semanticscholar.org/0ceb/7bca7a43da3b664d85cf396446d112cedc3d.pdf).

42. Dawed A, Mekonnen TS, Genetu M, Tadesse SE, Dewau R, Muche A et al. Comparing the validity of anthropometric meas¬urements in identifying malnutrition status of older age people in Borena district, North Central Ethiopia: a cross_sectional study. BMC Geriatr. 2022;22:776 (https://doi.org/10.1186/s12877–022–03467–9).

43. International Classification of Diseases 11th Revision [website]. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://icd.who.int/en).

44. Hooper L, Abdelhamid A, Attreed NJ, Campbell WW, Channell AM, Chassagne P et al. Clinical symptoms, signs and tests for identification of impending and current water-loss dehydration in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2015;4:CD009647 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD009647.pub2).

45. Malenfant JH, Batsis JA. Obesity in the geriatric population – a global health perspective. J Glob Health Rep. 2019;3:e2019045 (https://doi.org/10.29392/joghr.3.e2019045).

46. van Wijngaarden JP, Wojzischke J, van den Berg C, Cetinyurek-Yavuz A, Diekmann R, Luiking YC et al. Effects of nutritional interventions on nutritional and functional outcomes in geriatric rehabilitation patients: a systematic review and meta-analysis. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(9):1207–1215.e9 (https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.04.012).

47. Khor PY, Vearing RM, Charlton KE. The effectiveness of nutrition interventions in improving frailty and its associated constructs related to malnutrition and functional decline among com-mu¬nity-dwelling older adults: a systematic review. J Hum Nutr Diet. 2022;35(3):566–582 (https://doi.org/10.1111/jhn.12943).

48. Gaddey HL, Holder KK. Unintentional weight loss in older adults. Am Fam Physician. 2021;104(1):34–40 (https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/0700/p34.html).

33. painHEALTH Pain Management [website]. East Perth: Department of Health, Western Australia; 2024 (https://pain-health.csse.uwa.edu.au/pain-management/).

34. Sanses TV, Kudish B, Guralnik JM. The relationship between urinary incontinence, mobility limitations, and disability in older women. Curr Geriatr Rep. 2017;6(2):74–80 (https://doi.org/10.1007/s13670–017–0202–4).

35. Bautmans I, Knoop V, Thiyagarajan JA, Maier AB, Beard JR, Freiberger E et al. WHO working definition of vitality capacity for healthy longevity monitoring. Personal view. Lancet Healthy Longev. 2022;3(11):E789–E796 (https://doi.org/10.1016/S2666–7568(22)00200–8).

36. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019;38(1):10–47 (https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024).

37. Parkinson E, Hooper L, Fynn J, Wilsher SH, Oladosu T, Poland F et al. Low-intake dehydration prevalence in non-hospitalised older adults: systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2023;42(8):1510–1520 (https://doi.org/10.1016/j.clnu.2023.06.010).

38. de van der Schueren MAE, Jager-Wittenaar H. Malnutrition risk screening: new insights in a new era. Opinion paper. Clin Nutr. 2022;41(10):P2163–2168 (https://doi.org/10.1016/j.clnu.2022.08.007).

39. Norman K, Haβ U, Pirlich M. Malnutrition in older adults – recent advances and remaining challenges. Nutrients. 2021;13(8):2764 (https://doi.org/10.3390/nu13082764).

40. Tang AM, Chung M, Dong KR, Bahwere P, Bose K, Chakraborty R et al. Determining a global mid-upper arm circumference cut-off to assess underweight in adults (men and non-pregnant women). Public Health Nutr. 2020;23(17):3104–3113 (https://doi.org/10.1017/S1368980020000397).

25. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instru¬ments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. J Appl Gerontol. 2022; 41(4):1222–1231 (https://doi.org/10.1177/07334648211056230).

26. Reisinger M, Reininghaus EZ, De Biasi J, Fellendorf FT, Schoberer D. Delirium-associated medication in people at risk: a systematic update review, meta-analyses, and GRADE-profiles. Acta Psychiatr Scand. 2023;147(1):16–42 (https://doi.org/10.1111/acps.13505).

27. Veronese N, Honvo G, Thiyagarajan JA, Rizzoli R, Cooper C, Bruyère O. Attributes and definitions of locomotor capacity in older people: World Health Organisation (WHO) locomotor capacity working group meeting report. Aging Clin Exp Res. 2022;34(3):481–483 (https://doi.org/10.1007/s40520–022–02080–5).

28. Promoting physical activity for older people: a toolkit for action. Geneva: World Health Organization; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/373332). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

29. Short Physical Performance Battery (SPPB) [website]. National Institute of Aging; 2023 (https://www.nia.nih.gov/research/labs/leps/short-physical-performance-battery-sppb).

30. Vivifrail. Materials for professionals responsible for the prescription of a program of physical exercise [website]. University of Navarra; 2024 (http://www.vivifrail.com/resources).

31. American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2015 updated Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2015;63(11):2227–46 (https://doi.org/10.1111/jgs.13702).

32. Chiarotto A, Maxwell LJ, Ostelo RW, Boers M, Tugwell P, Terwee CB. Measurement properties of Visual Analogue Scale, Numeric Rating Scale, and Pain Severity Subscale of the Brief Pain Inventory in patients with low back pain: a systematic review. J Pain. 2019;20(3):245–263 (https://doi.org/10.1016/j.jpain.2018.07.009).

49. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/364538). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

50. Vision and eye screening implementation handbook. Geneva: World Health Organization; 2023 (https://iris.who.int/handle/10665/375590). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

51. World report on vision. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/328717). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

52. Dawes P, Völter C. Do hearing loss interventions prevent dementia? Z Gerontol Geriatr. 2023;56(4):261–268 (https://doi.org/10.1007/s00391-023-02178-z).

53. World report on hearing. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/339913). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

54. Rizk HG, Lee JA, Liu YF, Endriukaitis L, Isaac JL, Bullington WM. Drug-induced ototoxicity: a comprehensive review and reference guide. Pharmacotherapy. 2020;40(12):1265–1275 (https://doi.org/10.1002/phar.2478).

55. Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/343206). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

56. WHO Evidence and gap maps for the UN Decade of Healthy Ageing [website]. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing/evidence-gap-map).

57. Rosen T, Stern ME, Elman A, Mulcare MR. Identifying and Initiating intervention for elder abuse and neglect in the emergency department. Clin Geriatr Med. 2018;34(3):435–451 (https://doi.org/10.1016/j.cger.2018.04.007).

58. Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, Wilber KH. Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2017;5(2):e147–e156 (https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30006-2).

59. Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://iris.who.int/handle/10665/341337). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

60. Yip SO, Dick MA, McPencow AM, Martin DK, Ciarleglio MM, Erekson EA. The association between urinary and fecal incontinence and social isolation in older women. Am J Obstet Gynecol. 2013;208(2):146.e1–7 (https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.11.010).

61. Chen X, Jiang S, Yao Y. Association between obesity and urinary incontinence in older adults from multiple nationwide longitudinal cohorts. Commun Med. 2023;3(142) (https://doi.org/10.1038/s43856-023-00367-w).

قائمة المصادر الإضافية

The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition. Malnutrition Universal Screening Tool [website]. 2003 (https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_full.pdf).

Continence Product Advisor [website]. 2024 (https://www.continenceproductadvisor.org).

De Looze C, Feeney J, Seeher KM, Thiyagarajan JA, Diaz T, Kenny RA. Assessing cognitive function in longitudinal studies of ageing worldwide: some practical considerations. Age Ageing. 2023;52(4):iv13-iv25 (https://doi.org/10.1093/ageing/afad122).

Dementia & Alzheimer's Australia Ltd. Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) [website]. 2004 (https://www.dementia.org.au/professionals/assessment-and-diagnosis-dementia/rowland-universal-dementia-assessment-scale-rudas).

Dementia Collaborative Research Centre – Assessment and Better Care. General practitioner assessment of cognition (GPCOG) [website]. 2016 (https://gpcog.com.au/index/downloads).

Department of Health and Social Security. Improving care for people with long term conditions: personalised care planning, an 'at a glance' guide for healthcare professionals. United Kingdom Government [website]. 2010 (https://www.gov.uk/government/publications/improving-care-for-people-with-long-term-conditions-at-a-glance-information-sheets-for-healthcare-professionals).

Dutta C, Pasha K, Paul S, Abbas MS, Nassar ST, Tasha T et al. Urinary tract infection induced delirium in elderly patients: a systematic review. Cureus. 2022;14(12):e32321 (https://doi.org/10.7759/cureus.32321).

Eammons-Bell S, Johnson C, Roth G. Prevalence, incidence and survival of heart failure: a systematic review. Heart. 2022. 108(17):1351-1360 (https://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-320131).

Elwyn G, Laitner S, Coulter A, Walker E, Watson P, Thomson R. Implementing shared decision making in the NHS. BMJ. 2010;341:c5146 (https://doi.org/10.1136/bmj.c5146).

Food and Agriculture Organization. International Network of Food Data Systems. FAO/INFOODS Food Composition Databases [website]. 2024 (https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/).

Forman DE, Maurer MS, Boyd C, Brindis R, Salive ME, McFarland Horne F. Multimorbidity in older adults with cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol. 2018;71(19):2149-2161 (https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.03.022).

Government of BritishColumbia, Canada, Patient Health Questionnaire (PHQ9) [website] 2024 (https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/depression_patient_health_questionnaire.pdf).

Hopkins S, Gajagowni S, Qadeer Y, Wang Z, Virani SS, Meurman JH. Oral health and cardiovascular disease. Review. Am J Med. 2024;137(4):304-307 (http://doi.org/10.1016/j.amjmed.2023.11.022).

Huang W, Zhu W, Chen H, Li F, Huang J, Zhou Y et al. Longitudinal association between depressive symptoms and cognitive decline among middle-aged and elderly population. J Affect Disord. 2022;303:18-23 (https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.01.107).

International Urogynecological Association. Pelvic floor exercises [website]. No date (https://www.yourpelvicfloor.org/media/Pelvic_Floor_Exercises_RV2-1.pdf).

Jeyasingam N, McLean L, Mitchell L, Wand APF. Attitudes to ageing amongst health care professionals: a qualitative system¬atic review. Eur Geriatr Med. 2023; 14(5): 889-908 (https://doi.org/10.1007/s41999-023-00841-7).

Katz S. Assessing self-maintenance: activities of daily living, mobility, and instrumental activities of daily living. J Am Geriatr Soc. 1983;31(12):721-7 (https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1983.tb03391.x).

Kawahara T, Ito H, Yao M, Uemura H. Impact of smoking habit on overactive bladder symptoms and incontinence in women. Int J Urol. 2020;27(12):1078-1086 (https://doi.org/10.1111/iju.14357).

Kwok M, McGeorge S, Mayer-Coverdale J, Graves B, Paterson DL, Harris PNA et al. Guideline of guidelines: management of recurrent urinary tract infections in women. BJU Int. 2022;130 (Suppl 3):11-22 (https://doi.org/10.1111/bju.15756).

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179-86 (https://doi.org/10.1093/geront/9.3_Part_1.179).

Lloyd-Sherlock P, Beard J, Minicuci N, Ebrahim S, Chatterji S. Hypertension among older adults in low- and middle-income countries: prevalence, awareness and control. Int J Epidemiol. 2014;43(1):116-128 (https://doi.org/10.1093/ije/dyt215).

Mini Cog © Mini Cog Quick screening for early dementia detection [website]. 2024 (https://mini-cog.com/download-the-mini-cog-instrument/).

MoCA Test Inc. MoCA Cognition test [website]. 2024 (https://mocacognition.com/paper/).

Muchna A, Najafi B, Wendel CS, Schwenk M, Armstrong DG, Mohler J. Foot problems in older adults associations with incident falls, frailty syndrome, and sensor-derived gait, balance, and physical activity measures. JAPMA. 2018;108(2) (http://doi.org/10.7547/15-186).

Musa IR, Omar SM, Adam I. Mid-upper arm circumference as a substitute for body mass index in the assessment of nutritional status among adults in eastern Sudan. BMC Public Health. 2022;22:2056 (https://doi.org/10.1186/s12889-022-14536-4).

National Institute of Aging. What's on your plate? Smart food choices for healthy aging. Bethesda: US Department of Health and Human Services; 2022 (https://order.nia.nih.gov/publication/whats-on-your-plate).

Older adult nutrition screening. Screen 14 Seniors in the community risk evaluation for eating and nutrition questionnaire [website]. 2024 (https://olderadultnutritionscreening.com/screen-tools/).

PAR Inc. Mini-Mental State Examination [website]. 2024 (https://www.parinc.com/products/MMSE).

Perini G, Cotta Ramusino M, Sinforiani E, Bernini S, Petrachi R, Costa A. Cognitive impairment in depression: recent advances and novel treatments. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019;15:1249-1258 (http://doi.org/10.2147/NDT.S199746).

Ungar A, Cherubini A, Fratiglioni L, De La Fuente-Núñez V, Fried L, Krasovitsky MS et al. Carta of Florence against ageism. No place for ageism in health care. Eur Geriatr Med. 2024;15(2):285-290 (https://doi.org/10.1007/s41999-024-00938-7).

United Nations. Sustainable Development Goals [website]. 2024 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/).

Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nourhashemi F, Bennahum D, Lauque S et al. The mini nutritional assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition. 1999;15 (2):116-122 (https://doi.org/10.1016/S0899-9007(98)00171-3).

Wijnhovena H, Schilpa J, van Bokhorst-de van der Schuerenb M, de Vet H, Kruizengaa H, Deeg D et al. Development and validation of criteria for determining undernutrition in com¬munity-dwelling older men and women: The Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+. Clin Nutr. 2012;31(3):351-358 (https://doi.org/10.1016/j.clnu.2011.10.013).

World Health Organization. Declaration of Astana: Global Conference on Primary Health Care: Astana, Kazakhstan, 25 and 26 October 2018. 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/328123). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. Global age-friendly cities: a guide. 2007 (https://iris.who.int/handle/10665/43755). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. Human Rights [website]. 2023 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health).

World Health Organization. Immunization Agenda 2030: a global strategy to leave no one behind. 2020 (https://www.who.int/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. Musculoskeletal health [website]. 2022 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions).

World Health Organization. Quick guide to avoid ageism in communication. 2021 (https://www.who.int/publications/m/item/quick-guide-to-avoid-ageism-in-communication). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. Social isolation and loneliness. [website] 2024 (https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/social-isolation-and-loneliness)

World Health Organization. WHO Clinical Consortium on Healthy Ageing 2023 meeting report, 5–7 December 2023. 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/378710). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. World Osteoporosis Day. Simple ways to prevent osteoporosis [website]. WHO Western Pacific Region; 2019 (https://www.who.int/westernpacific/articles/item/simple-ways-to-prevent-osteoporosis).

Yan F, Xiao LD, Zhou K, Li Z, Tang S. Perceptions and help-seeking behaviours among community-dwelling older people with urinary incontinence: a systematic integrative review. 2022:78(6):1574-1587 (https://doi.org/10.1111/jan.15183).

الملحق: مثال على خطة رعاية مُبسَّطة

هذا مثال على خطة رعاية مبسطة يمكن مشاركتها من قِبل مدير الحالة أو منسق الرعاية مع المسن.
لا تهدف هذه الخطة إلى توثيق التاريخ الطبي الكامل أو أن تكون بمثابة سجل طبي

.

التاريخ: يوم/شهر/سنة **الموقع:** عيادة الرعاية الأولية xxx

المعلومات الشخصية

تاريخ الميلاد (العمر): (75) **النوع الاجتماعي:** ذكر **رقم البطاقة:** XXX

الأهداف المتمركزة على الشخص

(على المدى القصير): أود حضور مباراة كرة القدم المدرسية لحفيدتي الشهر المقبل. لتحقيق ذلك، أريد أن أكون قادرًا على المشي إلى المدرسة.

(على المدى الطويل): أود أن أستمر في القدرة على المشي إلى مكان التعبد خلال العام المُقبل. لكن هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة.

ملخص التقييم

القدرة الذاتية

– محدودية في القدرة على الحركة مع ألم في الركبة

– فقدان سمع متوسط بدون مؤشرات خطرة

الأمراض وعوامل الخطر

– ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم المنضبطان

– التهاب مفاصل الركبتين

البيئة الاجتماعية والمادية

العيش مع شريك الحياة في الطابق الثالث بدون مصعد. يعيش الابن وزوجة الابن والأحفاد في المنطقة نفسها ويزورون المسن أسبوعيًا.

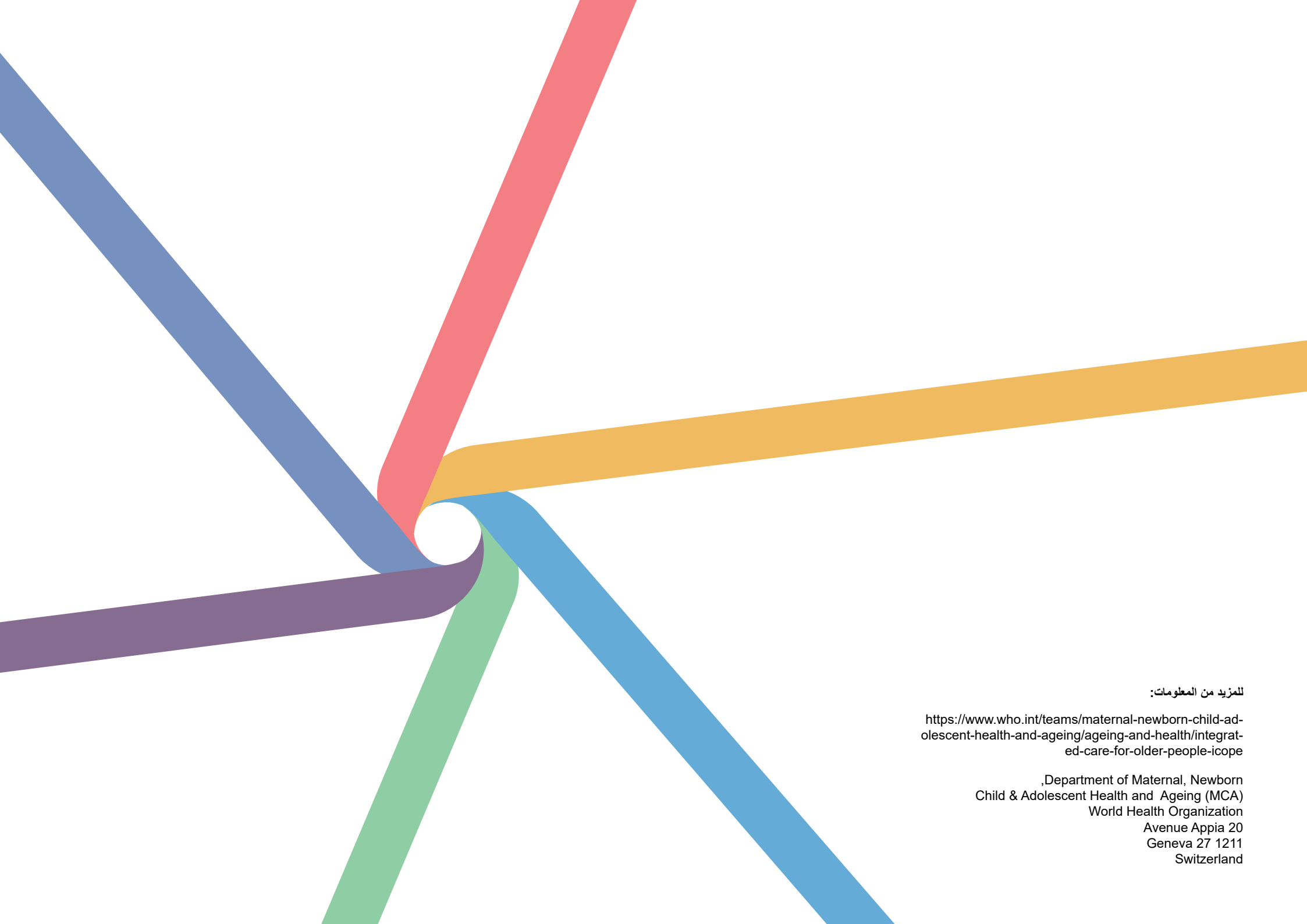
والمشاركة بانتظام في الأنشطة المجتمعية، بما في ذلك تناول القهوة مع الأصدقاء، ولكن محدودية القدرة على الحركة بدأت تؤثر على مستوى المشاركة مؤخرًا، أو مواجهة صعوبة أحيانًا في متابعة المحادثات إذا كان المكان صاخبًا.

التدخلات المقترحة والمتفق عليها

التدخلات المقترحة	المُتَّفق عليها من قِبل المسن	الإجراءات
برنامج تمارين متعددة الأنماط مع الإحالة إلى خدمة التأهيل	نعم	إعداد خطاب الإحالة لتحديد موعد مع خدمة التأهيل
الإحالة إلى رعاية السمع	نعم	إعداد خطاب الإحالة لتحديد موعد مع رعاية السمع
تقييم الألم وتدبيره	لا	رفض الإحالة لتقييم الألم. تسجيل الأوقات التي يشعر فيها بالألم وشدته على مقياس (من 0 إلى 10)
المعالجة المستمرة المستمر للأمراض (ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم)	نعم	الاستمرار في قياس ضغط الدم في المنزل تناول الأدوية كما هو موصوف وإجراء تحليل الدم التالي خلال شهرين
النصائح الغذائية لزيادة مدخول البروتين	لا	التصريح بعدم الرغبة في زيادة استهلاك البروتين. محاولة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين المتوفرة محليًا.
تقييم خطر السقوط في المنزل	لا	نصائح حول كيفية جعل المنزل ومحيطه أكثر أمانًا
تقييم احتياجات مقدم الرعاية (شريك الحياة)	نعم	تحديد موعد لإجراء تقييم مع مقدم الرعاية (شريك الحياة)
المنتجات المساعِدة على الحركة	نعم	إعداد خطاب الإحالة لتحديد موعد مع خدمة التأهيل

اسم المُقيِّم: xxx

التاريخ المُوصى به للموعد التالي: يوم/شهر/سنة



للمزيد من المعلومات:

https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/ageing-and-health/integrated-care-for-older-people-icope

,Department of Maternal, Newborn
Child & Adolescent Health and Ageing (MCA)
World Health Organization
Avenue Appia 20
Geneva 27 1211
Switzerland